“十三五”国家重点出版物出版规划项目
国家自然科学基金重大项目

应对老龄社会的基础科学问题研究丛书

主编　彭希哲

老年友好型社会的创新与实践

胡　湛　朱　勤　高俊岭　等/著

科学出版社
龍門書局

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
国家自然科学基金重大项目

应对老龄社会的基础科学问题研究丛书

主编 彭希哲

老年友好型社会的创新与实践

胡 湛 朱 勤 高俊岭 等/著

科学出版社
龍門書局
北京

内 容 简 介

本书是国家自然科学基金重大项目的集体研究成果。随着人口老龄化成为人类社会的常态，国际社会相继涌现出若干治理框架，“老年友好型社会”即其一，其得到诸多推广。本书立足于中国情境，对老年友好型社会的研究实践创新予以系统审视，在正视现有认知误区的基础上，着力探讨老年友好型社会的基础环境建设、社区养老服务创新、家庭政策与卫生政策、老年社会参与和数字融入、智慧养老及社会治理等议题，对于正处于人口老龄化深化期和社会转型加速期的当代中国社会具有特定的理论与实践意义。

本书适合中国老龄社会研究领域的学者、高等院校师生、政府官员和社会公众阅读参考。

图书在版编目（CIP）数据

老年友好型社会的创新与实践/胡湛等著. —北京：龙门书局，2021.8

（应对老龄社会的基础科学问题研究丛书 / 彭希哲主编）

“十三五”国家重点出版物出版规划项目　国家出版基金项目　国家自然科学基金重大项目

ISBN 978-7-5088-5875-3

Ⅰ. ①老… Ⅱ. ①胡… Ⅲ. ①老年人-社会工作-研究-中国 Ⅳ. ①D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 233248 号

责任编辑：魏如萍　陈会迎 / 责任校对：贾娜娜

责任印制：霍　兵 / 封面设计：无极书装

科学出版社
龙门书局　出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

三河市春园印刷有限公司　印刷

科学出版社发行　各地新华书店经销

*

2021 年 8 月第　一　版　开本：720 × 1000　1/16

2021 年 8 月第一次印刷　印张：16

字数：350 000

定价：160.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

丛书编委会

主　编：彭希哲

副主编：（以姓氏笔画为序）

左学金　何文炯　曾　毅　翟振武

编　委：（以姓氏笔画为序）

于景元　左学金　李树茁　李善同

杨　泽　吴开亚　何文炯　汪寿阳

胡　湛　彭希哲　辜胜阻　曾　毅

翟振武

作者名单（依章节顺序排列）

胡　湛	复旦大学老龄研究院	教授
高俊岭	复旦大学公共卫生学院	副教授
彭希哲	复旦大学人口与发展政策研究中心	教授
郭德君	重庆医科大学医学人文研究中心	教授
周新宏	复旦大学人口与发展政策研究中心	博士
朱　勤	复旦大学人口与发展政策研究中心	研究员
卢　敏	上海立信会计金融学院国际经贸学院	讲师
苏忠鑫	复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地	助理研究员
黄蛟灵	上海交通大学医学院公共卫生学院	助理研究员
宋靓珺	复旦发展研究院	助理研究员
王雪辉	复旦大学社会发展与公共政策学院	青年副研究员
彭　聪	上海社会科学院社会学研究所	助理研究员
沈凯俊	复旦大学人口与发展政策研究中心	博士
檀榕基	复旦大学人口与发展政策研究中心	博士

主要作者简介

胡湛，复旦大学老龄研究院教授。主要从事人口与公共政策领域的跨学科研究。获第七届和第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、上海市哲学社会科学优秀成果奖一等奖、上海市决策咨询研究成果奖等奖项，其专著入选“经典中国国际出版工程”。入选国家“万人计划”青年拔尖人才和上海市青年拔尖人才。任中国老年学和老年医学学会教学研究分会副主任委员、中国社会学会老年社会学专业委员会常务理事等。

朱勤，复旦大学人口与发展政策研究中心研究员。主要研究领域为人口与资源环境、人口老龄化与社会保障、公共政策模拟分析等。出版专著《中国人口、消费与碳排放研究》和《人口老龄化与碳排放：劳动供给与消费模式的影响》。在《中国人口科学》、《人口研究》、《数量经济技术经济研究》和 *Ecological Economics* 等期刊发表论文 30 余篇。获中国人口科学优秀成果奖一等奖、二等奖，《资源科学》创刊 40 周年“十大高影响力论文奖”。

高俊岭，复旦大学公共卫生学院副教授。主要从事健康教育、健康促进和社区慢性病防治等领域的教学与科研工作，研究领域为慢性病自我管理、社会资本与健康促进、健康城市等。近年来先后主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、教育部人文社会科学研究等多项科研项目，发表论文 30 余篇，参与编写健康教育和健康促进专业教材 3 部。

“应对老龄社会的基础科学问题研究丛书”序

人口老龄化是一个世界性议题，它是人口再生产模式从传统型向现代型转变的必然结果，也是当今社会经济发展和社会现代化的一个重要趋势，并已成为中国社会的常态。在目前的社会经济制度安排下，我们仍对这种前所未有的人口学变化及其所带来的影响缺乏必要和及时的反应、适应和调整，中国人口老龄化的特殊进程亦使得这种挑战更显严峻。

人口老龄化首先表现为人口问题，我们不仅要对人口进行更深入的研究与调控，更要考虑到社会、经济、环境等多元要素对老龄化进程的制约。老龄化的影响已经逐渐渗透到中国社会的各个方面，并与各种历史的、当前的和未来的社会发展要素不断地相互影响，形成一个超复杂的经济社会系统问题。因此，应对老龄社会需要统筹中国社会的各种资源以形成合力，对整个社会的组织和运行进行改革和再设计，以使中国社会在老龄化的背景下继续健康、协调地运行和发展。

为此，国家自然科学基金委员会经过两年的论证，于 2014 年启动了重大项目“应对老龄社会的基础科学问题研究”（71490730）的招标工作。其主要目标有两方面。

其一，立足中国经济、社会和环境的现实，针对中国老龄社会的自身特征，在全球化、市场化、信息化的时代背景下，充分考虑中国人口转变和社会转型的进程，响应城乡统筹、代际和谐发展的时代要求，深入研究面向社会整合和可持续发展的应对中国老龄社会的重大基础科学问题，进行理论创新和前瞻性研究，提出符合中国实践的新理论和新方法。

其二，根据我国转变经济发展方式、保障和改善民生的重大需求，针对老龄化的发生发展规律、现在及未来老年人群体的新特征、老龄社会的社会支持系统与经济形态，以及相关制度安排和政策重构等科学问题展开系统研究，支撑国家宏观决策和治理实践需求，并造就一支在国内外有影响的跨学科研究队伍。

最终，经过选拔和评审，以复旦大学作为牵头单位并联合中国人民大学、北京大学、浙江大学、上海社会科学院所组成的跨学科研究团队承担了这一重大项目，首席科学家为复旦大学的彭希哲教授，经费量 1800 万元，执行期自 2015 年起至 2019 年止。项目涵括 5 个相互独立却又紧密关联的专项课题：

课题一“特征、规律与前景——老龄社会的人口学基础研究”（71490731）由中国人民大学承担，负责人为翟振武教授；课题二“健康老龄化——老年人口健康影响因素及有效干预的基础科学问题研究”（71490732）由北京大学承担，负责人为曾毅教授；课题三“代际均衡与多元共治——老龄社会的社会支持体系研究”（71490733）由浙江大学承担，负责人为何文炯教授；课题四“公平、活力与可持续——老龄社会的经济特征及支持体系研究”（71490734）由上海社会科学院承担，负责人为左学金研究员；课题五“整体性治理——应对老龄社会的公共政策和公共管理体系重构研究”（71490735）由复旦大学承担，负责人为彭希哲教授。整个项目的核心团队成员超过 50 人，聚集了一批人口学、管理学、经济学、社会学、心理学、医学、生物学、数学、环境科学、信息科学、政治学等领域的一流专家学者，其中不乏教育部长江学者、新世纪百千万人才工程专家等顶尖人才。经过团队成员五年多的鼎力合作，产生了一大批高质量的科研成果，在《中国社会科学》、*The Lancet*、*Demography*、*Governance* 等国内外重要学术期刊发表论文近 400 篇，由其形成的决策咨询报告多次得到国家领导人批示，获得第八届中华人口奖、第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、第七届中国人口科学优秀成果奖、第三届中国老年学奖、第七届钱学森城市学金奖等各类国家及省部级奖项近 60 种，并参与资助了两项大型老龄社会追踪调查：CLASS（China Longitudinal Aging Social Survey，中国老年社会追踪调查）和 CLHLS（Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey，中国老年健康影响因素跟踪调查）。

为了推动这些成果在更大的范围内共享，促进相关学科领域的发展和高水平研究队伍的建设，为老龄社会相关的制度、政策与法规的设计、制定和运行提供理论指导与方法支撑，项目组和科学出版社合作，论证设计了“应对老龄社会的基础科学问题研究丛书”出版计划，并于 2018 年入选“十三五”国家重点出版物出版规划项目，2020 年获得国家出版基金支持。丛书计划持续出版系列老龄科学研究领域的学术专著，并于 2021～2022 年推出第一批 17 部。

作为国家自然科学基金重大项目“应对老龄社会的基础科学问题研究”的重要研究成果集群，本丛书的出版是多方通力合作、协同努力的结果。我们首先衷心感谢国家自然科学基金委员会的大力支持，感谢吴启迪、何鸣鸿、李一军、高自友、杨列勋、刘作仪等基金委时任领导的鼓励与指导，感谢于景元、辜胜阻、汪寿阳、李善同、李树茁、杨泽等学术领导小组专家的指点与建议，感谢吴刚、霍红、方德斌、卢启程、杜少甫、张江华等基金委工作人员的细致工作和周到服务，感谢原新、丁金宏、李娟、林义、黄鲁成、凌

亢、冯帅章等专家学者的帮助，感谢复旦大学、中国人民大学、北京大学、浙江大学、上海社会科学院的支持及在管理上提供的便利，感谢复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地、复旦大学人口与发展政策研究中心、中国人民大学人口与发展研究中心、北京大学国家发展研究院、浙江大学老龄和健康研究中心、上海社会科学院经济研究所的团队支持，感谢全国老龄工作委员会、中国老龄协会、国家卫生健康委员会、民政部、人力资源和社会保障部、国家统计局及各级政府部门的帮助，感谢兄弟院校和合作科研机构及团队的帮助，感谢项目组全体成员和参与项目工作的博士后及研究生们的辛勤劳动。此外还要感谢科学出版社的认可及支持，尤其是马跃和魏如萍老师对于我们申报“十三五”国家重点出版物出版规划项目和国家出版基金的鼎力协助。我们将再接再厉，为推动建设一个“不分年龄人人共建共治共享”的社会而奋斗。

“应对老龄社会的基础科学问题研究”项目组

2020 年 12 月

前　言

人口老龄化已经成为人类社会的常态（彭希哲和胡湛，2011）。它不仅是人口再生产模式由传统型向现代型转变的必然结果，也是经济社会发展的必然趋势。尽管老龄化首先表现为一种人口现象，却不断和社会、经济与文化的各个领域相互作用，并对它们的发展产生越来越深远的影响。派弗等曾断言，“老龄化继续发展下去所产生的冲击将不亚于人类历史上任何一次伟大的经济与社会运动”（Pifer and Bronte，1986）；吉登斯则认为，“老龄化与全球化的叠加，将在21世纪很长的时间里重塑人们的生活”（Giddens，2006）。

在这样的背景下，国际社会已相继涌现出若干治理框架和行动方案，建设“老年友好型社会”即其一，并且其已得到诸多推广及研究实践。本书由此立足于中国情境，对老年友好型社会的本土化研究实践创新予以系统审视，在正视现有认知误区的基础上，着力探讨老年友好型社会的基础环境建设、社区养老服务创新、家庭政策与卫生政策、老年社会参与及数字融入、智慧养老及社会治理等议题，对于正处于人口老龄化深化期和社会转型加速期的当代中国社会具有特定的理论与实践意义。

本书是国家自然科学基金重大项目“整体性治理——应对老龄社会的公共政策与公共管理体系重构研究”（71490735）的集体研究成果，并得到了国家自然科学基金面上项目（71874031）和教育部人文社会科学研究项目（18YJC840017）等的支持。经过团队全体成员的共同努力，课题组按照既定方案取得了诸多高水平成果，并围绕“老年友好型社会”这一主题对成果进行了遴选，从而形成本书。全书共包括11章：第1章为对老年友好型社会的再认识，由胡湛、高俊岭执笔；第2章为对老年人和老龄社会的认知误区，由胡湛、彭希哲、郭德君执笔；第3章为老年友好型社会的环境建设，由高俊岭执笔；第4章为老年友好型社会的社区养老服务创新，由周新宏、朱勤、卢敏、苏忠鑫执笔；第5章为老年友好型社会的家庭政策重构，由胡湛、彭希哲执笔；第6章为老年友好型社会的基层卫生政策创新，由黄蛟灵、胡湛执笔；第7章为老年友好型社会的老年社会参与，由宋靓珺、王雪辉执笔；第8章为老年友好型社会的智慧养老发展，由彭聪执笔；第9章为中老年数字融入现状及数字能力提升，由王雪辉、沈凯俊执笔；第10章为老年友好型社会治理中的融合创新，由檀榕基执笔；第11章为总结与展望，由朱勤执笔。贾鲁晶、王尚慧、杨晶、龚遥、王伟、吕明阳、吴敏捷、葛伊妮等

一批博士后、研究生和科研助理参与了大量资料收集、数据分析、成果整理和文字润色工作。

我们特此衷心感谢国家自然科学基金委员会管理科学部的全力支持，感谢各级老龄工作部门、兄弟院校及科研机构的帮助，感谢课题组全体成员及参加课题研究工作的博士后和研究生。我们将继续聚焦于“中国思考”，为推动新时代中国老年友好型社会建设发展而不断努力。

目　录

第 1 章　对老年友好型社会的再认识 …… 1
1.1　问题的背景 …… 1
1.2　“老年友好型”概念的提出 …… 4
1.3　重新认识老年友好型社会 …… 6
第 2 章　对老年人和老龄社会的认知误区 …… 9
2.1　当前研究实践中亟待商榷的认知倾向 …… 9
2.2　现有认知误区的主要机制分析 …… 13
2.3　老年友好型社会观念及治理理念转型的思考 …… 18
第 3 章　老年友好型社会的环境建设 …… 22
3.1　环境对健康的影响 …… 22
3.2　老年友好型环境的概念和特征 …… 26
3.3　老年友好型环境建设 …… 28
第 4 章　老年友好型社会的社区养老服务创新 …… 44
4.1　社区养老服务的现状与存在问题 …… 44
4.2　“整合式”社区养老服务体系 …… 46
4.3　嵌入社区的居家健康照护机构 …… 50
4.4　作为社区养老服务资源链接者的老年社工 …… 52
4.5　作为社区养老服务信息中枢的数据平台 …… 55
4.6　“整合式”养老服务体系的社区实践要点 …… 57
第 5 章　老年友好型社会的家庭政策重构 …… 59
5.1　家庭老龄化与老年人居住模式 …… 59
5.2　对当代家庭变迁及政策实践的反思 …… 84
5.3　老年友好型社会的家庭政策重构要点 …… 91
第 6 章　老年友好型社会的基层卫生政策创新 …… 96
6.1　基层卫生政策的本土化实践 …… 96
6.2　基层卫生机构人力资源状况分析 …… 103
6.3　家庭医生的健康与费用管理成效分析 …… 123

第 7 章 老年友好型社会的老年社会参与 …… 133
7.1 老年社会参与的定义与理论 …… 134
7.2 老年社会参与的现状与困境 …… 135
7.3 老年社会参与影响因素的实证分析 …… 138
7.4 促进老年社会参与的对策与建议 …… 154
第 8 章 老年友好型社会的智慧养老发展 …… 158
8.1 人口老龄化下智慧养老发展背景 …… 158
8.2 信息通信技术在老年人生活保障中的作用 …… 161
8.3 技术赋能进程中的养老服务供给模式动态演进 …… 165
8.4 中国智慧养老发展中存在的问题及对策建议 …… 170
第 9 章 中老年数字融入现状及数字能力提升 …… 177
9.1 问题提出与研究现状 …… 177
9.2 中老年群体的数字融入状况分析 …… 183
9.3 中老年群体数字融入面临的挑战 …… 193
9.4 中老年群体数字能力提升路径与策略 …… 195
第 10 章 老年友好型社会治理中的融合创新 …… 198
10.1 老年友好型社会治理的理论支撑 …… 199
10.2 老年友好型社会治理共同体的基本内涵 …… 209
10.3 老年友好型社会治理下政策工具的选择 …… 212
第 11 章 总结与展望 …… 220
参考文献 …… 227

第 1 章　对老年友好型社会的再认识

胡　湛　高俊岭

中国社会于 2000 年进入老龄化阶段，国家和社会对此高度关注。习近平指出，“有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉”[①]。2012 年，第十一届全国人民代表大会常务委员会修订通过的《中华人民共和国老年人权益保障法》便明确提出“积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务”；2019 年，中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》[②]重申应对人口老龄化的重要性，并特别提出“建设老年友好型社会”；2020 年党的十九届五中全会公报更进一步要求“实施积极应对人口老龄化国家战略”[③]。在凝聚共识、转变理念的基础上整合资源、创新制度，推动老年友好型社会建设，进而形成“不分年龄，人人共建共治共享”的社会情境，这已成为我们实现国家与社会治理现代化道路上的必经之事。

1.1　问题的背景

在人口寿命普遍延长与生育率迅速下降的双重作用下，中国人口的老龄化水平也在不断提高。历次全国人口普查的数据显示：65 岁及以上人口所占比重，1953 年为 4.4%，1964 年为 3.6%，1982 年为 4.9%，1990 年为 5.6%，2000 年上升至 7.0%，2010 年则达到 8.9%（中华人民共和国国家统计局，2009）。中国社会目前已经全面进入老龄化阶段[④]，这场空前的人口革命具有以下特征。

其一，老龄化现象的普遍性。人口的老龄化现象是一种必须面对的客观现实，任何国家和地区都不能例外，差别只在于出现之早晚与进程之快慢。2010 年 65

---

①《习近平：加强顶层设计完善重大政策制度 及时科学综合应对人口老龄化》，http://www.xinhuanet.com//politics/2016-02/23/c_1118132709.htm[2016-02-24]。

②《中共中央 国务院印发〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉》，http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/21/content_5454347.htm[2019-11-21]。

③《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》，http://www.12371.cn/2020/10/29/ARTI1603964233795881.shtml[2021-02-24]。

④ 国际上通常将 60 岁及以上人口占总人口的比重达到 10%，或者 65 岁及以上人口占总人口的比重达到 7% 作为一个国家或地区进入老龄社会的标准。

岁及以上老年人口比例超过7%的国家有76个，而到2050年则可能超过150个。中国已于2000年进入老龄社会，根据第六次全国人口普查资料，在中国的31个省区市（不包括港澳台地区）中，已有28个地区的65岁及以上老年人口占常住人口的比例超过7%；若按户籍人口计算，老龄化程度最高的上海已经达到20%以上。

其二，老龄化进程的持久性。人口老龄化绝不是一种短期现象。按照联合国2015年所公布的预测结果，2010～2030年，中国老年人口（65岁及以上）比例将增加1倍以上，平均每2年便提高近1个百分点。预计2050年中国65岁及以上老年人口的比例将达到26%以上，2060年以后的人口老龄化速度会有所放慢，在2070～2075年达到峰值后甚至会有所回落，但总的趋势是2100年的老龄化水平仍将保持在28%以上。在整个21世纪之内，老龄化现象将持续存在。

其三，老龄化速度不断加快。相对于中国的经济发展水平而言，其人口老龄化速度明显过快。1953～2010年，中国老年人口（65岁及以上）的年平均增长率约为2.8%。其中，1953～1964年的平均增长率为0.01%，1964～1982年为3.83%，1982～1990年为3.20%，1990～2000年为3.23%，2000～2010年为3.17%。自第二次全国人口普查以来，80岁及以上高龄人口的增长率又明显快于一般老年人口。2010年的65岁及以上老年人口规模是1964年的4.75倍，而同期的高龄（80岁及以上）人口规模却大约是1964年的12倍，如表1-1所示。据测算，2050年的中国老年人口（65岁及以上）和高龄人口（80岁及以上）将分别达到3.31亿人和0.98亿人。在一个相当长的时期内，中国人口老龄化过快的趋势在大体上是难以逆转的。

表1-1　历次全国人口普查年份的人口老龄化和高龄化态势

历次全国人口普查	65岁及以上老年人口/万人	老龄化程度	80岁及以上老年人口/万人	老年人口的高龄化程度[1)]
1953年第一次全国人口普查	2 496.77	4.4%	185.47	7.4%
1964年第二次全国人口普查	2 500.49	3.6%	181.26	7.2%
1982年第三次全国人口普查	4 919.18	4.9%	505.01	10.3%
1990年第四次全国人口普查	6 330.86	5.6%	767.64	12.1%
2000年第五次全国人口普查	8 698.29	7.0%	1 199.11	13.8%
2010年第六次全国人口普查	11 883.17	8.9%	2 098.93	17.7%

资料来源：历次全国人口普查数据

注：全国人口普查登记的对象为普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的港澳台居民和外籍人员

1）老年人口的高龄化程度是指80岁及以上的高龄人口占65岁及以上老年人口的比例

不难看出，中国已经处于人口老龄化成为常态的社会情境之中。作为一种新的社会形态，老龄化所导致的人口构成变动必然影响现有社会结构的稳定性（陆学艺，2010；姜向群，1999），亟须社会与制度的变迁以与新的人口年龄结构重新适应。而在目前的社会经济制度安排下，中国社会仍然对老龄化缺乏必要和及时的反应、适应和调整，学界的研究也集中在应对养老压力以及针对老年群体的各种支助措施上。它们经常忽视与之密切相关的其他问题或者同一问题的其他方面，难以反映老龄化问题的复杂性与多样性，不足以全面应对诸多挑战。从某种意义上讲，这些挑战并不完全来自老龄化本身，更源于老龄化的人口结构与现有社会结构的不匹配所产生的矛盾，即目前的社会制度安排无法满足老龄社会的发展需求。

正是在这种整个社会对人口老龄化尚不适应且未及时反应的背景下，人们才将老龄化视为一种重要挑战，并尤其关注其所带来的健康和社会服务压力。囿于现有制度和资源的结构性限制，人口老龄化不仅与疾病负担增加、慢性病高发、依赖率增加、卫生服务需求增加有关，而且可能影响到社会经济发展的诸多方面。目前，我国约 33%的疾病总负担可归因于 60 岁及以上老年人的健康问题，并估计有超过 2000 万 60 岁及以上的老年人需要日常照护服务。尽管老年人群体仍面临诸多健康挑战，但是当前老年人口特征演化也趋于更加多样和多元，并呈现出较强的个体差异。例如，一些 80 岁及以上高龄老年人的体力和脑力水平可能并不弱于很多年轻人，而与此同时又有很多人却在相对年轻的阶段即已出现明显的能力衰退现象，已经有不少 60 岁左右的老年人必须在他人的帮助下才能从事基本活动。从生物学角度看，衰老与分子及细胞水平多种损伤的积累相关，尤其是随着时间的推进，这些损伤将逐渐造成机体生理储备的下降、诸多疾病风险的升高以及内在能力的降低，并最终导致死亡。失能及死亡大多是由老龄相关的听力、视力、行动能力的丧失以及心脏病、中风、慢性呼吸系统疾病、癌症、阿尔茨海默病等非传染性疾病造成的。然而，这些变化既非线性，也非一致，与个体年龄仅表现出一定程度相关，且上述健康问题的存在也并不能阐明其对老龄个体造成的实际影响程度。例如，相当一部分患有严重听力障碍的老年人可以采用助听器来维持正常机能。这些个体差异一定程度上受到遗传因素的影响，但更多源自我们所处的物理和社会环境的差异，包括我们的家庭、邻里和社区，这些因素可以直接影响健康，或者作为促进因素或阻碍因素影响我们的机遇、决策和行为。此外，老龄通常还会伴随其他一些重要变化，包括社会地位和角色的改变，以及亲人去世的打击等。因此，一方面，人口老龄化的问题不仅是老年人的问题，其应对将涉及全社会和全人口的系统议题，并且应采取综合性和系统性策略；另一方面，在制定针对老年人口群体的具体政策或项目时，除了需要弥补老年人因生理年龄增长而自然出现的功能损失外，还应促进个体适应能力的提高和加强社会心理方

面的支持。为此，国际社会相继涌现出若干治理框架，“老年友好型社会”即是其一，并得到诸多推广。

1.2　“老年友好型”概念的提出

基于国际社会对于老年人和老龄化认识的不断发展，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）于20世纪90年代提出了“健康老龄化”[①]的概念框架，即“发展和维护老年健康、幸福生活所需的功能发挥的过程”。2015年，世界卫生组织还发布了《关于老龄化与健康的全球报告》。与健康老龄化密切相关的两个概念是“内在能力”和“功能发挥”，前者是指个体在任何时候都能动用的全部体力和脑力的组合，这只是决定老年人能做什么的因素之一。而另外一个重要的决定性因素则是老年人居住的生活环境以及老年人与生活环境的相互关系。对于处于任一能力水平的老年人，能否完成自己认为重要的那些事情，最终要取决于其生活环境中存在的各种资源和障碍。所以即使老年人内在能力有限，如果能够得到抗炎药物、辅助器材（如拐杖、轮椅、助力车）或者居住在可负担的、易用的交通设施附近，他们仍然能够去商场购物。这种个体与环境的结合及其相互关系就称为“功能发挥”。健康老龄化的提出有深厚的生活基础，即许多老年人希望自己健康、长寿、快乐，这是人朴素情感诉求的正常反应，其实这也是家人和社会的共同期盼。由其概念内涵可知环境对于健康老龄化的重要性，而且这里的环境不仅仅指物质环境，也包括社会环境和政策环境，它是一个非常宽泛的概念。

随着健康老龄化研究与实践的不断发展，其内涵与外延也在不断变化，老年人不仅要健康地活着，还要在力所能及的情况下参与到家庭和社会生活中以充分展现老年人存在的价值。世界卫生组织因而又在2002年提出了“积极老龄化”（active aging）[②]的概念及行动框架，即“尽可能增加健康、参与和保障机会的过程，以提高人们老年时的生活质量”（WHO，2002），联合国将其推广为全球行动纲领并不断发展之。“积极老龄化”是以“健康老龄化”（healthy aging）为基础发展而来的，内建“健康”、“保障”和“参与”三支柱，该转换过程反映出国际社会对于人口老龄化认知的深化。从本质上讲，有效的“参与”必以“健康”和“保障”为基础，而同时“参与”的成果则又以更好的“健康”和“保障”为

① “健康老龄化”的概念最早出现于1987年5月的世界卫生大会；1990年9月在哥本哈根召开的第40届世界卫生组织欧洲地区委员会会议，第一次将其作为战略目标提出。

② “积极老龄化”的概念出现于2002年，世界卫生组织是时在马德里向第二届世界老龄化大会提交了以“积极老龄化”为题的书面建议书。

诉求。这一方面使“积极老龄化”不再局限于老年人群体而成为一个全人口、全生命周期的议题；另一方面，对于老年人群体而言，“积极老龄化”也不仅重视“老有所养”或“老有所依”，更强调“老有所用”和“老有所为”。“积极老龄化”提供的概念内涵相对全面地回应了历来的若干老龄认知误区或理解偏差，目前已逐渐成为国际社会最具共识的老龄社会政策框架。

在健康老龄化和积极老龄化的基础上，世界卫生组织进一步整合提出了“老年友好型世界”（age-friendly world）的概念，其在研究与实践中更多地被称为“老年友好型社会”，即“一个所有年龄段的人都能积极参与社区活动，尊重各个年龄段的每个人的地方；一个让老年人更容易和对他们重要的人保持联系的地方；尽可能地帮助老年人保持健康和活跃，并为那些需要日常照护和帮助的老年人提供适当的支持的地方”。就其概念框架而言，老年友好型社会的建设或建立需要从政策、环境、服务和个体四个层面同时采取措施才可以实现。①政策层面：考虑到老年人需求的重要性以及随着年龄的增长人口需求的变化，主要涉及在健康老龄化中发挥作用的各个部门的政策协调，以及与财政资源相关的挑战。它还将涉及老年人实际上是如何影响政策、项目和其他政府决策的，以及这些决策如何影响老年人的自主性和健康老龄化。所以，政策层面的目标是探索和讨论如何协调各个部门，如何管理资源，以及如何与老年人协商，以促进老年的自主性和健康老龄化的实现。②环境层面：主要关注当地的物质环境和社会环境。它还涉及社区（村庄、区和市）参与。了解社区环境和社区参与对社区中个人的自主性和实现健康老龄化能力的影响。③服务层面：主要涉及为老年人及其照护者提供的卫生和社会服务，包括从评估到整合式服务的多项活动，如预防、增权、支持、康复和补偿等。这些活动要基于以个人及其家庭需求为中心的全面评估，通过协作和共享决策而制定。这些来自评估和服务计划的数据可以为临床、组织和政策决策提供可靠的数据库。④个体层面：主要涉及个人的知识、态度、动机和技能等相关因素。需要强调的是政策、公共卫生信息、临床和管理实践等的整体一致性，以及这种一致性如何影响个人参与，换言之，在临床和管理实践中引入、实施、更新的政策是如何被人视为一致整体的一部分的。这种整体一致性有助于人们有参与感并有动力做出选择，并对他们的生活方式、自主性和健康采取改变，且成为积极参与的公民。这将使他们明白，通过他们的选择和行动，他们可以发起变革，并发挥他们的社会创新能力。

中国政府较早即对老年友好型社会做出了反应和本地化解读，甚至“和谐社会”、“包容性增长”与“共建共治共享”等宏观治理理念也涵盖其逻辑内涵，尤其是随着人口老龄化成为我们新的基本国情，“构建老年友好型社会，积极应对人口老龄化”已经成为一项长期发展战略。在这样的社会中，人们在进入老年时，身体、心理和社会功能均保持完美状态，整个社会将努力为老年人提供所需

要的支持和保障，老年人也能够基于其权利和自身能力并根据需要与爱好而继续为社会发展做出自己的贡献（WHO，2002）。

1.3　重新认识老年友好型社会

老龄化问题常常被只看作老年人的问题，老龄社会的应对也常常被视为如何为老年人提供经济赡养和公共服务。如果人们能够认识到老龄化已经成为中国乃至人类社会的常态，是一种正常的社会形式，便不难理解仅仅调整对老年人的公共政策无法应对老龄社会的众多挑战。事实上，人生的不同年龄阶段是一个相互关联、彼此重叠的过程，只有将个体发展的各个阶段和人口结构的各个层次联系起来考虑，才能够夯实老龄化政策设计的基础。“健康老龄化”和“积极老龄化”作为应对老龄社会的战略性目标有其固有的丰沛内涵：“健康老龄化”侧重成长的延续性，强调晚年的生活能力取决于早年生活的积累；“积极老龄化”则重视参与，它使老龄化问题不再局限于老年人，而成为全民参与的主题。这些目标显然无法通过仅仅关注老年人的社会政策来实现。老年人的健康和医疗保健支出问题往往可以通过对年轻人的健康投资以及全社会生活、行为方式的转变来改善[①]；老年人的养老金问题也需要通过提高年轻人的劳动生产率和推动老年劳动力的经济参与来缓解[②]。个体在不同年龄阶段有着不同的潜在可塑性，不同年龄的群体在生存和发展中必须通过不断选择与相互补偿来推进社会的现实性发展。

在这种背景下，“老年友好型社会”作为一种整合性概念应运而生，它首先系统性地关注老年人的健康、保障与社会经济参与，以及其所需要的环境与制度安排。从本质上讲，个体的老化是一种逐步的、因人而异的过程。尽管老年人的劳动能力会随着年龄的进一步增大而急剧减弱，但却不会因为 60 岁或 65 岁的到来而立即消失。事实上，人的各项能力在其生命周期各个阶段的发展是不平衡的，没有哪个年龄阶段群体的各项能力都高或都低，也没有哪项能力在人的毕生发展

① 已有越来越多的研究表明，许多慢性疾病（如糖尿病和心脏病）的初始危险，在童年早期甚至更早便已经出现；而长寿的生活方式，以及身体、知识和情绪基础，也多是在青年和孩童时期建立的。老年人的健康状况在很大程度上与其在年轻时代的生活与行为方式相关，因而降低老年人口医疗保健支出的一个重要途径是以青少年人口为对象，提倡健康的生活方式与保健观念，以有效推迟人体功能退化的起始点，减少整个生命周期中的非健康的生命历程。

② 目前一些大城市所面临的养老金缺口问题，需要更多地通过国有经济对保障基金进行补偿性投入而得到缓解。

过程中一直上升或一直下降[①]。不仅如此，老年个体之间、老年群体之间在不同的时间点上也有着显著的异质性。今天的老年人口主体与过去的老年人口主体已经表现出许多完全不同的特征，而这种差异在未来将由于大量 20 世纪 50 年代出生人群的加入可能会变得更加显著，相关的公共政策设计应当对此有充分的考虑。换言之，公共政策对于老年人的社会角色应当有着灵活的定位，而不是把他们一律视为需要被供养、被照顾、被救助的对象。当我们的公共政策不再机械地将“老年人”与“被供养的人”画上等号，人们自立自强的意识就可能会增强，不良的生活方式就可能会减少，平均健康水平就会提高，社会运行的成本才有可能降低，从而形成“积极应对老龄化”的良好环境。然而遗憾的是，现有的社会制度安排并没有致力于营造这种环境。例如，目前的就业体制就将老年人口排斥在正规的就业市场之外，现行法定退休年龄仍在较多延续 20 世纪 50 年代以来的制度设计，而当时我国人口的平均预期寿命尚不足 50 岁，今天这一数字已经提高到 77 岁，其中城市（尤其是东部沿海地区）人口的预期寿命延长得更多。与此同时，迈入老年也不再必然意味着衰退与病痛，老年人口中蕴含着巨大的、不断扩充的、可供开发的人力资本与社会资本，而我们现有的制度安排却限制了这些资源的发挥，并人为地加重了社会应对老龄化的负担。为了缓解人口老龄化和“现收现付”制度所带来的养老金支出压力，欧美发达国家和新兴工业化国家普遍采取了推迟劳动力退休年龄的措施。对经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）国家的研究也表明，影响老龄人口实际退休年龄和劳动参与率的因素很多，依靠推迟刚性的法定退休年龄并不必然带来人们实际退休年龄的提高（原新和万能，2006）。我国近年来由于就业形势严峻，为减少名义下岗和失业数量，一些地方单位存在强制或鼓励职工提前退休的情况，这使得国内城市户籍人口的实际平均退休年龄仅为 53 岁。而在经济压力等多方面因素的作用下，老年人口退休后再就业的比例却一直保持在较高的水平。在这样的背景下，为老年人口提供继续参与经济活动的机会将成为必然的政策选择。必须承认，并不是所有的老年人都适合推迟退休，老年人参与社会发展的途径也不仅仅包括就业。但不可否认的是，就业是人们参与社会发展的较佳途径之一，而且在现有制度背景下还可以考虑扩大公共政策中关于老年人“就业”的内涵，将老年人可以灵活就业的工作和某些无报酬社会劳动也包括进来。据调查，很多中国的老年人都愿意在原有岗位上多待一段时间，甚至可以义务工作，不收取任何报酬；而在那些非政府组织和志愿者团体中，老年人的比例很高，而且相当活跃，

① 例如，个体的综合体能大多在 28～32 岁之后开始逐渐下降，但其各项社会能力却随着年龄增长呈现上升趋势；又如，生理机能的老化（如大脑血流量减少、血压升高或脑损伤概率增高等）会使老年人的流体智力（知觉速度、记忆力等）下降，而其晶体智力（习得性技能、语言能力等）却随着年龄增长有所增强。

他们已经成为社会进步的巨大推力（穆光宗，2002）。对老年人的社会角色重新定位，不仅能帮助老年人更好地参与社会发展，也能使他们更好地共享社会经济发展的诸多成果。“参与”与“分享”是老年人基本权利不可分割的两个方面，任何人都不能剥夺他人得益于发展的权利，而我们今天的公共政策体系却没能很好地保障老年人的这种权利[①]。老年人绝不全是被供养的对象，他们不仅是消费者，而且是生产者，更是历史的创造者。公共政策所要做的，正是将这些角色统筹起来。

与此同时，“老年友好型社会”在注重老年人群体的前提下，同时强调人在一生中始终能发挥体力、社会、精神等方面的潜能，按自己的权利、需求、爱好、能力参与社会活动，并得到充分的保护与照料。与此同时，联合国也把建立一个“不分年龄人人共享的社会”[②]作为“国际老年人年”的主题。“共享”表明了社会的包容与平等，是所有人给其他所有人以机会，它包含着对老年人重新定位、让老年人有机会继续参与社会发展的目标。这些目标使老龄化战略的能动性增强，并为政策制定提供了思路。

历史一次次地证明，机遇往往与挑战共存。如果我们以一种全新的理念看待人口老龄化并以创新的思维来应对它，那么人口老龄化将更多地体现为未来社会发展的机遇。应对人口老龄化的当务之急并不是过分担忧现代社会的养老成本，而是使社会各阶层行动起来，对老年人与老龄社会从观念上重新进行认识，并以此作为公共政策制定的出发点。事实上，家家都有老人，人人都会变老，每个人都是老龄社会的组成部分，研究老龄化问题其实就是在研究我们自己（德克尔，1986）。老年友好型社会首先应该成为一个“不分年龄人人共享的社会”。在这样的社会里，人们“不再把老年人仅仅看作领取退休金的人，而是社会发展进步的主体和受益人”，应对人口老龄化的根本之道也在于此。

基于此，本书致力于突破一些研究对“老龄社会”和“老年友好型社会”的狭义性解读，而在老龄社会整体性应对的框架下识别老问题和发现新问题，剖析当前研究实践中对老年人和老龄社会的认知误区，重点对老年友好型社会的环境建设、社区养老服务、家庭政策、基层卫生政策、老年社会参与、智慧养老与数字融入、社会治理的融合创新等议题进行探索性研究，以期抛砖引玉，推动老年友好型社会研究的创新与实践。

---

① 需要说明的是，除了宏观的公共政策，微观和中观层面上的政策安排也是帮助老年人口更好地参与社会发展过程、分享社会发展成果的重要保证。例如，老年友好型的城市规划、老年社区的设计与建设、惠及全体社会成员但又特别关注老年人群体的卫生保健模式等，目前相关的研究与实践仍存在缺位。

② “不分年龄人人共享的社会”这一概念源于1995年在哥本哈根通过的《社会发展问题世界首脑会议行动纲领》。1999年，联合国将其作为“国际老年人年”的主题。

第 2 章　对老年人和老龄社会的认知误区

胡　湛　彭希哲　郭德君

在人类发展的历史长河中，人口结构以年轻化为主，老年人口比例在相当长的时期内处于 3%～5%的水平（Weeks，1999）。直至 19 世纪 60 年代到 70 年代法国的老年（65 岁+）人口比例达到 7%，成为历史上首个步入老龄化的国家，随后不到百年间，西方发达国家悉从其势（UNDP，2005），这种现象自 20 世纪后半叶起在发展中国家及地区也趋于蔓延。在此背景下，中国于 2000 年进入了老龄社会[①]，至今已 20 多年。这意味着我们对于老龄化已形成直观认识，相应研究与实践也日趋深广。然而，整个社会对于老年人乃至老龄化却仍存在诸多认知误区或理解偏差，倾向于将老年人视为一种负担和将老龄化视为一种危机，相当多的学术探索委身于此框架之下寻求防止或延缓老龄化的种种途径，大量的政策探讨也过度聚焦于养老压力以及针对老年人的各类支助措施上，不少工作于今已显得杯水车薪，这不仅不利于老年友好型社会的构建，更可能导致我们对于老龄社会发展路径的误判。在此背景下，厘清对老年人和老龄社会的认知误区，引导以形成新的公共理念和社会氛围，无疑是推动建设老年友好型社会的首要任务。

2.1　当前研究实践中亟待商榷的认知倾向

随着老龄化成为中国社会的常态，学界已展开系统探索并形成较丰富成果，为正视老龄化挑战进行了必要的理论铺垫。而对于老龄化的具体应对措施与治理模式而言，描述性研究仍相对较多，单单针对老龄化或者它的某一方面进行论证和建议的研究取向相对普遍，且它们在不同程度上存在着将老龄化视为“问题”或“挑战”的倾向，这使研究成果相对聚焦于单项或局部的政策调整或调节，有一定工具理性特征，而与老龄化密切相连的其他问题或者同一问题的其他方面则经常被忽视，对整个老龄社会基本规律的系统研究和对政策体系的整合性研究仍相对欠缺。事实上，人口老龄化及其影响具有较大的弥散性和渗透性，在人口老

① 《第五次全国人口普查公报(第 1 号)》，http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/200203/t20020331_30314.html[2008-01-15]。

龄化的常态化背景下构建老年友好型社会，将涉及一系列跨越功能边界的非结构化公共事务，并形成诸多超复杂系统问题，对其应对的治理模式与政策安排必须基于这一特征展开。然而所有的治理与政策变迁都不可能在一夜之间完成，其间更需要政府治理理念和社会主流观念的不断调适。因此尽管老龄议题在近年已引起社会各界高度关注，政府出于民生大计也对其极为重视，但对其共识仍未普遍达成，尚存在若干亟待商榷的认知倾向。随着老龄化的进一步深化和社会转型的加速，识别并厘清当前研究和实践中的认知误区与理解偏差正变得越加重要和必要，这将是构建新型老年友好型社会的前提条件之一。

2.1.1　对老年人和老龄化的固有刻板印象

人口老龄化从本质上讲没有好坏之分，甚至在某种意义上还可被视为现代化的重要标志乃至社会发展的重要成果（胡湛和彭希哲，2018）。然而遗憾的是，当前老龄研究与实践中仍充斥着不少负面乃至悲观的情绪。这一方面源于社会大众在心理上的不适应，大众观念中习惯性地将“老”与“弱”画上等号，尤其是随着传统文化的转型乃至式微，现代社会不同社会群体对老年人的主观评价以及他们对老年人生存现状的客观评价，都存在一定的老年歧视（ageism）倾向（吴帆，2008）。另一方面则是目前以中青年为核心形成的社会架构对老年人比例增多这一现实仍存在不同程度的不匹配。这些“不匹配”更因“不适应”而被主观夸大，因而老龄化被与“悲观”、“危机”及“负担”和“压力”画上了等号，尤其是人们对于人口老龄化将造成经济发展延缓忧心忡忡。事实上，不少西方发达国家在尚未达到中国现有人均经济水平时已为应对老龄化而建立起相对健全的全民社保体系（陈友华，2012），因而用“未备先老”或“慢备快老”来形容中国当前的老龄化应对现状可能更为准确（胡湛和彭希哲，2018）。此外，也有相当多的证据揭示老龄化给宏观经济发展并未带来不可逾越的挑战，在一些西方发达国家，老龄化甚至与其经济增长显现出一定程度的正相关，中国最近几十年间的经济高速增长也与其人口老龄化的发展进程相同步。这恰恰说明人口与发展之间的关系不是线性的，不需要无谓的自我设障。正如戴利和汤森（2001）所指出的“人们经常议论老年人口的保守性和反动特征，以及年轻人的进步和活力，这都是无稽之谈”。

2.1.2　忽视或漠视人口老龄化的常态化

进入 20 世纪后，在现代化和现代性的逻辑作用下，人类寿命大幅延长而生育水平显著下降，两者叠加使得不同国家与地区的人口年龄分布普遍向老龄化倾斜。

因而从本质上讲，老龄化是人类再生产模式转型和经济社会发展的必然结果，它在任何国家和地区概莫能外，差别只在于出现之早晚和进程之快慢（彭希哲和胡湛，2011）。2015 年全球尚有 115 个国家和地区未进入老龄化阶段，但至 2050 年这一数字将可能骤降为 33 个（He et al.，2016）。从中国的情况来看，自 2000 年步入老龄社会后其人口老龄化水平便不断提高，2010 年第六次全国人口普查时达到约 8.9%（65 岁+）和约 13.3%（60 岁+）[①]，而至 2018 年末这一数字已变为 11.9%（65 岁+）和 17.9%（60 岁+），其中 60 岁及以上的人口规模近 2.5 亿人[②]。学界对于未来中国老龄化发展趋势的整体判断也基本趋同，老龄化已经成为一种长期不可逆转的基本国情。

从本质上讲，人口老龄化带来的“问题”或“挑战”不完全来自老年人或者老龄化本身，更多源于变化了的人口年龄结构与现行社会经济架构之间的不匹配所产生的矛盾（彭希哲和胡湛，2011），即现有以中青年为核心而形成的社会体制与机制尚不适应老年人比例增多这一现实人口变动趋势。然而现有社会认知对此仍存有诸多误区，习惯性地将其当成一种不正常的人口和社会态势，相当多的研究也都是在传统的逻辑框架内探讨防止或延缓老龄化的种种途径，这在很大程度上是用农耕时代或工业时代的思路和方法来应对后工业时代与信息时代的挑战，其治理空间与政策效能捉襟见肘。在这样的背景下，相当多的对策研究将老龄化的应对较多地视为一个技术性问题，如寄希望于调整生育政策而逆转老龄化进程。必须承认，计划生育政策的实施在规范我国人口生育行为乃至推动人口转变的过程中发挥了巨大功用，许多研究自然而然地将应对老龄化的希望也寄托于人口政策的改革完善，近期对于放开生育政策乃至鼓励生育的解读也大多聚焦于此。通过人口政策及其相关福利政策的适度调整的确能够在一定程度上改变人们的生育行为，并借此延缓老龄化的速度，为未来世代赢得应对老龄化问题的时间。然而，人口老龄化是人类寿命延长与生育水平下降共同作用的结果，其进程不可能因生育政策的调整而得到根本性逆转。

2.1.3　将老龄问题等同于老年人问题乃至养老问题

老龄化的挑战常常被视为由老年人数量增多所引发的，老龄化的应对问题也常常被只当作解决老年人的问题甚至只是养老问题，将这些议题过度聚焦于特定群体显然违背了现实逻辑。人口老龄化尽管暗含老年人口增多等数量性议题，但

① 《2010 年第六次全国人口普查主要数据公报（第 1 号）》，http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110428_30327.html[2011-07-25]。

② 《2018 年国民经济和社会发展统计公报》，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html[2010-02-10]。

它在本质上是一个结构性问题，即人口年龄分布的结构性变动。老龄社会的老年人口比例尽管相较于传统为多，但依然是一个不同年龄阶段的人口群体共存共生的社会。而对于个体而言，老龄是其生命周期的必然阶段，这一年龄阶段与其他阶段的关联性在老龄社会的背景下更显其意义。已有大量研究表明老年人的健康水平取决于其年少时的健康行为积累（WHO，2015），养老金的收支平衡依赖于当前劳动力群体的劳动产出（彭希哲和邬民乐，2009），老龄社会的可持续发展因而需要通过对不同生命周期人口的持续投资和引导而夯实。将老龄化议题过度聚焦于老年人群体既会造成不必要的社会焦虑和社会恐慌情绪，也不符合代际公平和共建共治共享的治理理念。

出于这些片面的认知及解读，当前老龄社会治理研究与实践也较多关注老年工作的开展和老龄事业的发展，而非老龄社会的整体性应对。老年工作与老龄事业聚焦于如何为老年人口提供经济赡养、公共服务及精神慰藉等支助，这当然是政府重视民生并为应对当前的现实养老压力而产生的一种自然选择，然而老龄化所意味的年龄结构变迁将涉及人口结构的各个层次和个体发展的各个阶段，仅仅关注老年人口显然无法全面应对老龄社会的诸多挑战。人生的不同年龄阶段是一个相互关联、彼此重叠的过程，只有将个体发展的各个阶段和人口结构的各个层次联系起来考虑，重视老龄社会的全民性和整体性，才能够夯实老龄社会治理模式的基础。然而囿于体制资源等现实约束，较多的老龄理论研究与政策探讨都聚焦于单一政策或部门政策的调整。然而在现实中，不同的部门往往专注于各自的功能和职能定位，部门之间职责交叉但界限不明确的情况时有发生，由于缺乏整合，出现政策冲突或政策衍生问题的例子并不少见，这更加剧了现有政策体系的碎片化与空心化，对其政策效能发挥反而产生负面影响，并在一定程度上加剧社会对老龄化压力的焦虑。

2.1.4　较多推崇“拿来主义”，忽略中国特性乃至优势

中国进入老龄社会相对较晚，在应对经验相对缺乏的情况下，参照或参考国际社会的通用性思路或一般性对策无可厚非。然而随着老龄研究的不断深化和实践经验的不断积累，我们必须清醒地认识到，人口老龄化在不同国家和地区的发展有其共性，但更多的则是其个性及差异，国际社会的应对经验固然存在普遍性，但具体国家的具体治理格局则必须基于其各自基本国情。西方发达国家大多于20世纪上半叶进入老龄化阶段，其当时处于工业时代的尾声，纵观其治理经验，研究者极为关注西方社会日益深重的养老压力及其所引发的一系列发展困境（Lee and Mason，2011；Schultz，2001），而由于福利刚性并囿于制度结构，这些研究往往聚焦于制度安排中市场与国家的二分。实践表明，市场追求效率，那种经济

发展自动惠及所有社会成员的现象并没有出现；福利国家虽由政府提供相对完善的社会养老保障，却较大磨损了家庭养老功能，并招致财政危机与代际冲突，“找回家庭”反而成了重要的制度安排（Mishra，1984；Rose，1986；O’Connell，1991；Midgley and Tang，2001）。制度安排有着鲜明的国家特征，虽然这些提前进入老龄化的西方发达国家为后进者提供了丰富的“前车之鉴”，但对于中国这样的人口大国，基本国情、社会架构、发展阶段和文化特征等方面的差异使得我们无法生搬硬套西方国家制度及政策模式，何况不少西方发达国家自己也正因此陷入债务泥潭而至今不拔。

与西方发达国家不同，中国是在信息时代进入了老龄社会，这为应对其挑战提供了全新的可能和机遇，但也同时面临经济未发达、就业未充分和社会保障未完善等约束条件。如何在尚未全面实现现代化的条件下应对老龄社会的诸多挑战，中国目前尚无系统的他国经验可资借鉴，而只能基于我国的基本国情和社会现实形成中国方案。客观而言，当代中国在老龄社会治理中具备一定特殊性乃至优势。例如：①新中国成立后的长期发展，尤其是改革开放后逐步积累形成的海量发展红利，为老龄社会治理提供了稳固的经济基础。②事实已反复证明，中国政府在处理一些事关全局和涉及长期发展的复杂问题上，具有其他国家难以比拟的动员力和灵活性，这是老龄社会治理中最坚强可靠的主体力量。③以孝道为核心的传统文化为中国老龄社会治理提供了特殊的资源，将为老龄社会治理提供强大的文化伦理支撑和稳定的价值理念输出。④中国的大国优势与区域多样性可能会为老龄化治理腾挪出宝贵的时间与空间，这一国家禀赋性优势将较大提高老龄政策体系的灵活性。⑤从更长远来看，以信息技术和生命科学为代表的科技革命正在深度改变现有的生产生活方式、产业格局、社会结构，并将可能成为中国经济增长的新引擎，同时为老龄社会治理提供更多的创新可能与技术支撑。

不难看出，正是因为片面强调人口老龄化带来的压力与挑战，而有意或无意地漠视老龄化的常态化、忽略中国所特有的治理资源及禀赋优势，才使得一些认知误区及理解偏差长期存在，并逐渐影响我们对于老年人的态度和行为，甚至影响我们对于老龄社会的整体判断和治理选择。

2.2　现有认知误区的主要机制分析

就人类认识发展的客观规律而言，社会需求永远是社会科学乃至科学发展的原动力。然而现实社会始终是变动不断的，尽管在任何一个具体的时点或视角下，人们或许会根据“经验”或“常识”得出所谓的客观认知，但随着认知主体的发展与重构，这些认识和理解也需要继续深化乃至于出现革命性颠覆，人类的科学发展史中对此有无数印证。罗素（1982）就认为在认识过程中不能过度依赖经验，

同时还需借助分析的思维和方法。从这个意义上讲，对于人口老龄化这样一个相对较新的议题，出现认知误区和理解偏差是无可厚非的，然而具体到当前我国社会经济发展的现实情境和老龄社会治理的现实诉求，我们有必要在新的历史时期对这一问题进行分析性的认识总结，以清源正本、承前启后。

2.2.1 形成老龄化消极认知的认识论困境

出于实用主义，现有研究倾向于将老龄化置入具体情境中而将其识别为一个相对独立的认知对象，遵循“问题—答案”式的思维路径，从而将老龄化的具体应对转化为一系列线性的技术性问题。例如，将老龄化压力等同于老年人压力乃至养老金压力、将老龄社会治理等同于老年人工作开展和老龄事业发展均属此列。无论是在自然科学领域还是在社会科学领域，这种问题意识诚然是推动认识前进和发展的不竭动力，其积极作用毋庸置疑，然而对于许多超复杂结构或非结构化的认识问题，这种线性路径则往往趋于片面而不能从整体上对相关问题进行更为深入的研究。人口结构是一切社会结构的基础构件，更是社会变迁和科技发展的先决条件之一（Weeks，1999），因而人口结构的老龄化将涉及一系列超复杂系统问题，其影响更具有较大的弥散性，将可能渗透到人类社会生活的方方面面。尤其是人口老龄化本身也仍在不断发展之中，其认识边界呈现动态性，未来社会经济和科学技术的发展以及老年人群体的演化都有可能超出人类现有历史经验，更为老龄社会的发展可能性增添了迷思。这不仅决定了我们不可能一劳永逸地解决老龄化带来的所有压力，更意味着我们必须在研究和实践的过程中不断修正我们的认识，而这种认识还将反过来不断调整乃至重构老龄化议题的内涵与外延。在这样的背景下，社会上有些人对于老龄化这一相对较新的议题因不甚了解而望文生义或断章取义，拒绝承认老龄化的常态化，乃至形成恐慌和恐惧的心理都是可以理解的，社会共识的形成本就是一个逐渐以及逐段发展的长期过程。

此外，对老龄化消极认知的背后还涉及一个认识和评价主体的问题。尽管老龄社会的老年人口比例有所提高，但社会的主体构成依然是非老年人群体。在这样的结构形态下，对老龄化的认知其实主要反映的是非老年人群体的态度与观念。当然，其中也不排除老年群体自身的态度和观念（甚至有些老年人还可能对老龄化及老年人存在负面认知），但因其所占人口比例相对较低而对整体社会认知的影响有限。假如我们互换认识和评价主体，其结果可能将截然不同，这不仅折射出认识主体对于认识活动的重要影响，也说明新现象、新事物、新议题本就很少会伴随掌声呈现。

2.2.2　治理逻辑较多囿于“以人口适应制度”模式

中国是一个人口大国。一方面，人口发展在中国社会经济文化等各项发展事业中起到基础性支撑作用；另一方面，人口调控作为政策工具也在治理转型和制度变迁中发挥出若干决定性影响，计划生育政策及项目的实施就是典型一例。它在相对较短的时间内实现了对中国人口生育行为的规范并较快推动了中国人口转变进程，为当时的经济社会发展创造出相对较好的人口条件。这种双重机制的影响再加上若干“案例驱动”，致使现行治理模式中对于人口议题的处理常常习惯于强调人口要素的重要性，或倾向于通过干预人口发展而满足治理目标或政策诉求，即所谓的以人口变动适应制度模式（胡湛和彭希哲，2018）。甚至当某些制度或具体政策安排的可持续性出现滞碍时，也趋于将其包装为所谓的人口问题予以探讨。事实上，任何社会中都不存在绝对意义上的人口问题，所谓的人口问题必须置于具体的社会经济及文化背景下才表现出相对的意义（翟振武和李建新，2005）。出于这样一种思维定式和逻辑惯例，当前对于人口老龄化的应对及治理也未跳出“以人口变动适应制度”的窠臼。近期关于进一步调整生育政策乃至“鼓励生育”的讨论便循此惯性，期望通过延迟退休年龄而维持养老金系统收支平衡也同出一辙。人口老龄化已成为中国社会的常态，尽管生育政策的进一步调整可能会带来生育率适度回升，进而在一定程度上缓和老龄化速度，但老龄化的进程并不会因此而停滞乃至扭转，甚至中短期内的社会抚养比反而会因出生数增加而略感压力；养老金系统的本质也是一种靠年轻人支持老年人的制度设定，其可持续性源于劳动力在业时间的稳定性，随着以互联网和人工智能（artificial intelligence，AI）为代表的科技革命深化，传统劳动和就业模式正经受冲击并面临重构，未来劳动力的平均在业时间将不可避免地趋于缩短。传统“以人口变动适应制度”的治理调节模式正显现其不足，随着人口规模和结构的进一步适时变迁，老龄社会的治理调节模式势必向“以制度变动适应人口”转型。

此外还不难看出，“以人口变动适应制度”的治理调节模式也易使当前的老龄化研究实践倾向于聚焦一系列线性的技术性问题。例如，将老龄化压力等同于老年人压力乃至养老金压力、将老龄社会治理等同于老年人工作开展和老龄事业发展均属此列。这些工作的积极作用毋庸置疑，然而对于人口老龄化这一超复杂结构或非结构化议题，其影响又具有较大的弥散性，线性干预路径则往往趋于片面而对其欠缺整体把握。在这样的背景下，“以人口变动适应制度”的治理调节模式也容易使社会认知将老龄化应对的关键归因于人口的技术性调节，而非制度的整体性适配，对此也应格外重视。

2.2.3　制度资源储备相对缺位引发若干社会焦虑

前已论及，人口老龄化本身并不构成“问题”，但其与现行以中青年为核心而设计运行的社会治理架构与制度结构相互不适应所产生的矛盾则多以“挑战”或“压力”的面貌呈现。从这个意义上讲，人口老龄化应对与老龄社会治理的关键在于制度及政策安排的适应、适配乃至重构。然而中国社会是在经济尚未发达、就业尚未充分以及保障系统尚未完备的条件下迎来的人口老龄化，且相对于我们的社会经济发展水平而言，老龄化发展速度又明显过快，更将当前制度资源的相对缺位在短时期内予以放大。根据国家统计局发布的数据并进行适度推算，60 岁及以上老年人口占中国人口的比重在 2000 年首次突破 10%，在 2010 年、2015 年和 2018 年分别升至 13.3%、16.2%和 17.9%，老年人口的规模及比重还将在未来几十年持续快速增长，2035 年之后的高龄化（80 岁+）趋势将趋于凸显，2050～2055 年的人口老龄化可能会达到峰值，其后将略有回落并进入长期的高位平台期。在这样的背景下，现有制度安排架构下的劳动就业市场和社会保障体系都将经受结构性冲击，而伴随政府和媒体的某些过度渲染，社会上有些人因不甚了解而望文生义或断章取义，拒绝承认老龄化的常态化，乃至形成焦虑、恐慌和恐惧的心理都是可以理解的，社会共识的形成本就是一个逐渐以及逐步发展的长期过程。尤其是人口老龄化本身也仍在不断演化之中，其认识边界呈现动态性，未来社会经济和科学技术的发展以及老年人群体的演化都有可能超出人类现有的历史经验，更为老龄社会的发展可能性增添了迷思。利用当前老龄化发展的波动期和窗口期以尽快完成相关治理及制度资源储备，跳出传统制度和政策工具的束缚，与国家其他发展战略相融合，使之不局限于为老年人提供保障和服务，而是涉及社会保障、劳动就业、医疗健康、科技教育等体系的重大持续变革等已成为重中之重。

2.2.4　社会变迁对代际关系和社会观念的影响

剧烈的社会变迁及家庭变动不断重塑着当代的代际关系及相关伦理价值，进而影响社会对于老年人和老龄化的社会认知。在中国传统社会，孝文化广泛普及，孝亲敬老的理念深入人心并得到制度性支持，不仅较大地规范了代际伦理，也使得老年人较易获得相对较高的家庭和社会地位。但必须指出的是，历史上孝文化的深入普及并不总是源于民众自发性的认可与接受，也有出于统治的实际需要等动因，在很多历史时期，封建统治阶级就将以血缘为基础的孝伦理扩及政治领域以维护其统治，因而在一些特定的历史时期，传统孝文化出现过趋于权威主义的极端倾向，孝文化中对等级秩序的过度强调以及对年轻人个性发展的压制等方面

在近代以来受到一些知识精英的激烈批判（肖群忠，2001）。然而抛开这些衍生的问题，我们依然可以发现，孝亲敬老在传统社会中得以主流价值化的重要原因在于其坚实的伦理基础。一方面，人是任何文化演进过程中的主导性机制和主体性存在，从个体情感到群体意识中的孝文化渗透均有其内在的伦理依据；另一方面，传统社会出于个体和家族发展以及国家治理等外在的实用价值，也将孝伦理道德化和制度化。在内外因素共同作用下，老年人才由此获得了较高的家庭地位，而孝亲敬老理念也在社会上持续传承。

从这个意义上讲，当下社会对于老龄化的一些误解误读和种种负面评价其实刻画出老年人地位的变迁路径，而这种变迁在很大程度上受到现有社会价值观的影响。随着社会经济文化转型的演化，传统社会价值和家庭伦理也随之重塑，甚至在现代化理论和现代性的话语框架下，“传统”有时还被视为“现代化”的障碍之一。当道德力量在社会整体发展中的地位和作用不断削弱，当过度强调个性发展而不可避免带来个人至上和利己主义盛行，当功利主义在和道义相博弈的过程中日占上风的时候，秉持老年人的社会贡献逐步减少以及其会给家庭和社会带来负担的观点已不鲜见，甚至不少地方还呈现出若干老年歧视现象，在这些担忧和疑虑的背后，渗透出将老龄化等同于压力、负担、危机的观念乃至于将其妖魔化的倾向亦不足为怪。

2.2.5　传统生死观及其文化伦理影响

中国传统文化伦理所隐含的若干理念和思维模式对当前老龄观和老年观的形成也有不可忽略的影响。“未能事人，焉能事鬼？”“未知生，焉知死？”（《论语·先进》）（刘琦，1999）对此提供了很好的注脚。《论语》中“死”的出现频率要远多于“生”，孔子尽管没有避开死，但在对待生死的态度上却明显体现出其对于现世生命的高度关注。《吕氏春秋》也明确表明了“贵生”的立场，其中明确指出“圣人深虑天下，莫贵于生”（张双棣等，1987）。这些对现世关注远高于来生的“贵生”思想体现在诸多方面，并充分渗透进传统的生命观和死亡观之中。“贵生”思想在历史上产生了积极的社会效应，并通过伦理规范进而要求人们珍惜生命和当下的生活。

然而，人终究不可避免地要走向死亡。生与死构成生命之两极，在生与死不断抗衡的过程中，无论从哪一极入手都将提供深刻理解另一极的境域。对死亡的透彻体悟其实是顿悟生命的一把钥匙，海德格尔（1999）的“向死而在”就从生存论和本体论的角度对死亡赋予了更为积极的内涵。而相比较而言，中国传统文化伦理中的“贵生”思想使中国人在日常生产生活中很少论及死亡，死亡在本土文化语境中往往携带着莫名的禁忌和无端的恐惧。这种死亡忌讳具有引申性，作

为距离死亡最近的群体，普通民众“讳老”和“忌老”的心理在很大程度上也由此而来，并在生活中习惯性地将“老”与“衰弱”画上等号。在此背景与情境下，尽管医疗与科技的进步正使人口健康水平不断提高、寿命延长的可能性不断得以扩大，然而我们却常常忽略对于生命末期的关怀，我们对老年人最后生命历程的理论储备和现实经验由此显得不足。随着老龄化的加剧和老年人口的增多，这些传统规训无疑将经受越来越多的伦理诟病。

2.3 老年友好型社会观念及治理理念转型的思考

所有社会的治理模式及其政策安排都是政府治理理念和社会主流价值的具体体现。人们观念的转变和政策安排形态的演变都需要过程并会产生惯性，从而使治理理念和价值立场的匡正成为治理转型的首要条件。立足于对当前人口老龄化及其治理研究中的认知误区归纳，以及对形成这些误区的认识机制的剖析，并联系当前的实际，在构建老年友好型社会的过程中将不可回避下述议题。

2.3.1 支持和引导“积极老龄观”的构建

世界卫生组织在2002年向联合国提交了“积极老龄化”行动框架，即“尽可能增加健康、参与和保障机会的过程，以提高人们老年时的生活质量”（WHO，2002），联合国将其推广为全球行动纲领并不断发展之。“积极老龄化”以“健康老龄化”为基础发展而来，内建“健康”“保障”和“参与”三支柱，该转换过程反映出国际社会对于人口老龄化认知的深化。从本质上讲，有效的“参与”必以“健康”和“保障”为基础，而同时“参与”的成果则又以更好的“健康”和“保障”为诉求。这一方面使“积极老龄化”不再局限于老年人群体而成为一个全人口全生命周期的议题；另一方面，对于老年人群体而言，“积极老龄化”也不仅重视“老有所养”或“老有所依”，更强调“老有所用”和“老有所为”。“积极老龄化”所提供的概念内涵相对全面地回应了历来的若干老龄认知误区或理解偏差，目前已逐渐成为国际社会最具共识的老龄社会政策框架。

中国政府较早即对“积极老龄化”做出了反应和本地化解读，甚至“和谐社会”、“包容性增长”与“共建共治共享”等宏观治理理念也涵盖其逻辑内涵，尤其是随着人口老龄化成为我国的基本国情，“积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务”[①]。“积极”首先框定了应对人口老龄化的价值定位，其要务在于“积极老龄观”的构建：①积极应对老龄社会。老龄社会并不是不正常的社

① 《中华人民共和国主席令 第七十二号》，http://www.gov.cn/flfg/2012-12/28/content_2305570.htm[2012-12-28]。

会态势，其发展可能性并不注定弱于传统非老龄化的社会。人口老龄化导致储蓄增加而加速资本积累进而形成第二次人口红利（Harvey et al.，2004）、随着经济禀赋更好的人口梯队进入老龄阶段而刺激消费形成“银发经济”、因“老年产业”发展而创造出新的行业与职业进而重振就业市场，这些可能性都客观存在。②积极看待老年人。人类发展至今的重要伦理保障之一即代际的传承有序，年轻世代所得享的发展成果凝结着老一代的劳动创造，而老年人在知识经验和社会资本方面更有独到优势，尤其是随着人类健康水平的进一步提高和相关制度障碍的逐步消除，越来越多的老年人正在参与社会发展，也理应分享其成果。③积极面对老年生活。老年只是人生生命周期的自然阶段之一，它并不注定与“衰弱”和“凄凉”相关联，老年人群体自身也需自立自强，切勿妄自菲薄。简单一例，在当今的大量中国家庭中，如果没有老年人放弃闲暇而参与孙子女抚育，不仅难以充分释放年轻一代的生产力，更使未来劳动力在年幼时欠缺呵护，老年人仅以此所创造的间接效益便绝难估量。

2.3.2　转变主流观念中对老年人的刻板认识

发展与变迁是事物存在的恒律，老年人群体也不例外。在现代社会中，老年人是否注定风烛残年、步履维艰？又或者普遍卧床不起、难离侍候？这显然已与事实不符。在新的历史时期，我们理应将老年人置于一个更宽泛的生命周期谱系中予以重新审视，对老年人重新认识乃至重新定义事实上是深化老龄认知的必然过程以及其核心内容，并需以此为基础不断调适与之相应的战略与战术设置。

事实上，现有对于老年人和老龄化的认知误区及排斥情绪，均植根于传统的老龄定义之上，其对老年人群体的认知也大多以传统的刻板印象为依据。传统老年和老龄定义均以简单的时钟年龄（或生理年龄）为基线，即将 60 岁或 65 岁及以上人口视为老年人。该标准由联合国自 20 世纪中叶起推行，当时的中国人口预期寿命尚不足 50 岁，而截至 2018 年这一数字已达到 77.0 岁[①]，尤其是随着健康水平的提升以及社会经济和技术条件的变化，老年人群体的属性及特征一直在发生着潜移默化的改变，而社会的主流观念却仍未随之及时更新，目前已经到了亟待重塑之时。当我们真的能够从根本上颠覆掉我们对传统老年人以及老龄化的刻板印象之后，就有可能看到一场完全不同的图景：“人们在进入老年时，身体、心理和社会功能均保持完美状态，整个社会将努力为老年人提供所需要的支持和保障，老年人也能够基于其权利和自身能力并根据需要与爱好而继续为社会发展

① 《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》，http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201905/9b8d52727cf346049de8acce25ffcbd0.shtml[2019-06-01]。

做出自己的贡献。”（WHO，2002）。

2.3.3 在改革中重构传统文化价值体系

千百年来中华民族历经沧海桑田，但传统孝道的发展却未曾中断，并不断演化而成为中华传统美德的核心要件。孝道的传承不仅留下了丰厚的伦理遗产，也留下许多动人的文化记忆。尤为可贵的是，孝道在推行的过程中并未走向狭隘化，反而从微观逐渐向宏观涌现，孟子的“老吾老，以及人之老”（《孟子·梁惠王上》）（万丽华和蓝旭，2006）就是对此之良解。孝道尽管始于家庭，但在其被引导和推行时却未局限于内，而是外化为治理资源，其目的是使整个社会形成良好风尚。随着现代社会的转型和老龄化的深化，我们不应摒弃这一优秀传统，反而更需要构建与之相适应的伦理价值体系以充分彰显我们对于老年人和老龄社会的价值立场。

当然，传统孝道中确有与现代社会发展不相适宜的理念和要求，孝道要在老龄社会中发挥价值和功能，重构就成为不可或缺的过程（彭希哲和郭德君，2016），即在借鉴传统并立足现实的基础上构建与时俱进的现代孝伦理体系（彭希哲和郭德君，2018）。事实上，自近代以来，孝道在家庭及社会生活中的地位不断滑落，这一过程尽管与其在漫长历史中的主导地位和深远影响相比而较为短暂，但若从变化的剧烈程度来讲，则未有如近现代以来变化之大者。正是在这种历史和现实的反差不断扩大之际，我们更需以谨慎冷静的姿态重新审视传统文化，如此方能真正把握传统文化中具有较大恒定性和影响力的要素及工具，这既是老龄社会治理创新中所急需的优质文化伦理资源，也是中华文化复兴乃至中华民族伟大复兴的应有之义。

2.3.4 推动新型生命观和死亡观的形成

“贵生轻死”等思想在传统生命伦理学中占据了相对主导的地位。事实上，生命的有限性至少在当下仍然无法突破，我们应当理性地看待生命全程，生与死都是生命必须经历的不同环节。尤其是作为距离生命终端相对较近的群体，老年人更需在生命的下半场直面死亡，这是无法逃避的现实。但是，现有的政策落脚点和社会注意力仍主要放在“生”上，哪怕“健康老龄化”和“积极老龄化”等宏观政策框架也不外如是，这对于消解人们对于老龄化的疑虑和恐惧自有其重大的积极意义。虽然如此，这毕竟在一定程度上折射出整个社会对于“死”的关注仍然不够，因为完整的生命观不可避免地内含着死亡观。从更深远的意义来讲，死亡意识的培养同时能使人在一个更为完整的视野下把控生命的具体节奏，从而过

上一种更有意义的生活。因此，在老龄社会中，若每个人在内心深处拒斥死亡、在理性思考中悬置死亡则显然是不适宜的，从这个角度而言，实现从“贵生轻死”到“优生优死”的转型，使人们能够积极地面对生命、平静地接受死亡，这也应是“积极老龄化”框架的进一步拓展。

此外，理性生命观和死亡观的培育并不特定于老年人，而应覆盖不同年龄群体以及贯穿人的整个生命周期。将生命观和死亡观的教育及引导置入个体的成长与社会的发展过程之中，使我们的专业/职业教育体系、宣传系统和临终关怀制度适时跟进，以构建“老年友好型”及“生命友好型”的社会环境，才会真正营造起积极应对老龄社会的理性社会氛围，并由此发现乃至创造出若干新的应对资源与工具。生命观与死亡观的完善并不仅旨在提升老年人的生活和生命质量，更通过更新社会价值和社会观念而对传统文化伦理进行升级，并反过来重新诠释“老”、诠释“生”乃至生命全程。正如帕斯卡尔（1985）所言：“给岁月以生命，而不是给生命以岁月。”

第 3 章　老年友好型社会的环境建设

高俊岭

环境对人们的行为生活方式和健康具有重要的影响。老年人往往患有各种慢性病，而且其移动功能、视听功能、感觉功能及免疫功能等衰退，对社区环境的依赖程度更大，社区环境对其健康和幸福感影响也更大。因此，建设老年友好型社区环境对于实现健康老龄化具有重要意义。本章主要阐述环境的概念及其对健康的影响，老年友好型环境的特征及其建设路径。

3.1　环境对健康的影响

3.1.1　环境的概念

环境（environment）是指围绕人群的空间及其中能直接或间接影响人类生存和发展的各种因素的总体，是人类赖以生存与发展的物质基础。按环境要素的属性及特征，可将人类环境分为物质环境（physical environment）和社会环境（social environment），其中物质环境又可以分为自然环境以及生活和生产环境。

1. 自然环境

自然环境是指围绕在人类周围，能直接或间接影响人类生活与生产的一切自然形成的物质和能量的总体，如水、空气、土壤及其他生物等。自然环境是人类生存的必要条件。

2. 生活和生产环境

生活和生产环境是指人类为从事生活及生产活动而建立起来的居住、工作和娱乐环境以及有关的环境因素，如家用化学品等。生活和生产环境与人类的关系最密切，对人类健康的影响最直接。生活和生产环境是人类聚集、人际交往频繁的地方，自然环境是生活环境建立的基础。生活和生产环境中与人群健康，特别是老年人的健康关系最为密切的是建成环境。建成环境是指为人类活动而提供的包括居住、生活和工作环境在内的人工建造环境，是在城乡规划基础上所建筑的

人居环境，包括建筑密度和强度，土地混合利用，街道规模、密度和衔接性，目的地的可达性，居住环境美化和安全情况等组成因素。

3. 社会环境

社会环境是指在自然环境基础上，人类通过长期有意识的社会劳动，创造的物质生产体系、积累的文化等所形成的环境。社会环境由社会的政治、经济、文化、教育、人口、风俗习惯等社会要素构成。

3.1.2　环境影响健康的机制

正如《渥太华宪章》指出的那样："健康由人们在其日常生活、学习、居住、玩耍、相爱的场所内创造；人们可以控制并创造自己生活的环境，并确保环境中的每一个成员获得健康……"研究者很早就认识到环境（如气候变化、空气污染、社区绿化及室内环境等）对人类健康的影响无处不在（Stock，2013）。医学之父希波克拉底在《论风、水和地方》中指出，医生进入一个城市的时候，首先要注意到这城市的方向、土壤、气候、风向、水源、水质、饮食习惯、生活方式等，因为这些都会对人体健康造成影响。

大量研究证实：环境不仅可以影响人们的躯体健康和心理健康，诱发如肿瘤、心血管疾病、糖尿病、焦虑、抑郁等；而且会影响人们的行为生活方式，如吸烟、饮酒、饮食和身体活动，从而影响人们的死亡情况，如一项 meta 分析结果显示贫困社区居民的总死亡率是富裕社区居民的 1.07 倍。

环境影响人们健康的路径是非常复杂的，但对老年人来说社区是其活动的主要场所，对其健康的影响最为重要。社区环境主要通过如图 3-1 所示的路径对人的健康产生影响，社区人口构成、社会环境和物质环境相互影响。首先社区人口构成，如年龄、受教育水平、职业等会影响社会规范、社区安全、社区凝聚力等

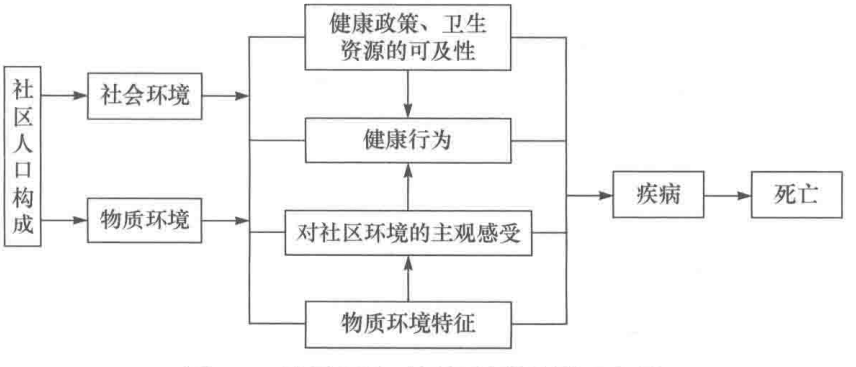


图 3-1　社区环境对居民健康的影响路径

社会环境，同时也会影响商铺、工作场所、公共服务场所等，进而影响社区的物质环境。反之，社区社会环境和物质环境也会影响社区居民的健康行为及其对环境的主观感受，进而影响健康、导致疾病发生。社区人口构成与环境的交互作用，最终通过以下四条途径影响居民的健康。

第一，健康政策、卫生资源的可及性。预防服务、健康教育、筛查项目，以及医院、诊所、医生在当地政府的管理和分布情况的差异，可能导致健康行为和健康状况的差异。例如，丹麦的哥本哈根从 1991 年开始就对女性进行乳腺癌钼靶筛查，但在其他地区直到 2007 年才开始这项筛查项目。而乳腺癌钼靶筛查可降低 25%～29%的乳腺癌死亡率。

第二，健康行为。社区环境可以影响居民的吸烟、饮酒、饮食、身体活动等对健康存在影响的行为生活方式。社区的物质环境特征可以通过获得促进健康和损害健康的商品来影响个人的健康行为。例如，研究表明，居住在麦当劳、肯德基等快餐店较多社区的居民，肥胖的发生率也较高；居住在超市附近或者健康食品可得性较高社区的居民，肥胖发生率较低。此外，社区绿化、道路连接性等均可影响居民身体活动水平。社会环境对行为也有重要影响，有研究显示，吸烟、饮酒、身体活动可以在人群中彼此传播，而且邻居间的彼此影响是最大的。此外，社区安全、社区凝聚力等可以促进社区居民的身体活动。而且，社区物质环境和社会环境也是相互影响的，如绿化率高、休闲娱乐设施可及性高的社区，居民间的社会支持、社区凝聚力也很高。

第三，对社区环境的主观感受。能够满足居民住房、工作和生活等需求，且安全、管理良好的社区可以增进人们的福祉。通过对周围环境的积极感受，居民会感到更舒适，心理问题和与周围环境有关的压力会减少，使居民的生活方式更健康，发病率降低，预期寿命延长。社区物质环境，如社区连接性、基础设施、公共交通、美观度等会影响人们对其所在社区的主观感受。

第四，物质环境特征。物质环境特征主要包括空气污染、地面污染、辐射、交通噪声、水质以及缺乏供暖、卫生设施和基础设施等，传统的影响人群健康的因素。由图 3-1 可知，这条路径也是相互影响的，如健康政策可以影响健康行为、物质环境特征会影响居民对环境的主观感受。因此，建设健康支持性环境要综合考虑彼此间的关系。

3.1.3 环境对老年人的影响

2016 年世界卫生组织提出新的“健康老龄化”的内涵是“发展和维护老年人健康生活所需的功能发挥的过程”。这一过程由个人内在能力与相关环境特征以及两者之间的相互作用构成，其核心是促进老年人的功能发挥。根据世界卫生组

织提出的健康老龄化概念模型，促进老年人功能发挥有两个基本途径：一是促进和保持内在能力，即帮助个体在任何时候都能动用全部身体机能和脑力的组合。例如，降低健康风险、鼓励健康行为、减少潜在障碍，以及提供服务和培养相关能力等。二是提供环境支持，即优化构成个体生活背景的外界因素，包括建成环境、社会交往、社会政策和其他支持系统。当个体与环境契合良好时，他们便能更好地维持内在能力和发挥功能。例如，通过提供可及的公共交通服务和建立安全的居住环境等手段，缩小老年人在现有内在能力水平下完成各项任务和在有利环境条件下所能完成的任务之间的差距。人的活动和行为是个体内在能力与环境因素之间协调的结果，生理健康因素决定了内在能力的阈值，而环境因素则决定了在内在能力受损的情况下，是否在特定建成环境条件下实现正常的功能发挥。换言之，老年人的功能发挥不仅取决于个体自身的生理健康水平，也取决于环境因素的制约。

根据老年学的环境压力理论模型，压力是环境因素导致的需求强度与个体内在能力交互作用的结果，其进而影响老年人的活动行为。个体的内在能力包括身体机能、认知能力、社会交往能力等。建成环境的适宜性表现和参与活动的结果即为两者协调或失调的表现（于一凡和胡玉婷，2017；于一凡，2020）。如图 3-2 所示，在环境压力理论模型中，纵轴表示个体的内在能力，横轴表示环境支持度。产出是个体的内在能力和环境支持度交互作用下的区间。阴影区域表明个体内在能力最舒适区和环境支持度的绩效最优区，即个体内在能力与环境绩效匹配最优。当环境支持度与个体内在能力匹配度较高，环境对于个体的功能发挥便起到积极的支持作用，同时环境的功能性绩效也较高。反之，当环境支持度与个体内在能力匹配度较低，无论是环境挑战性过高，还是挑战性不足，即出现个体内在能力与环境绩效失配，环境的功能性绩效也随之变差。

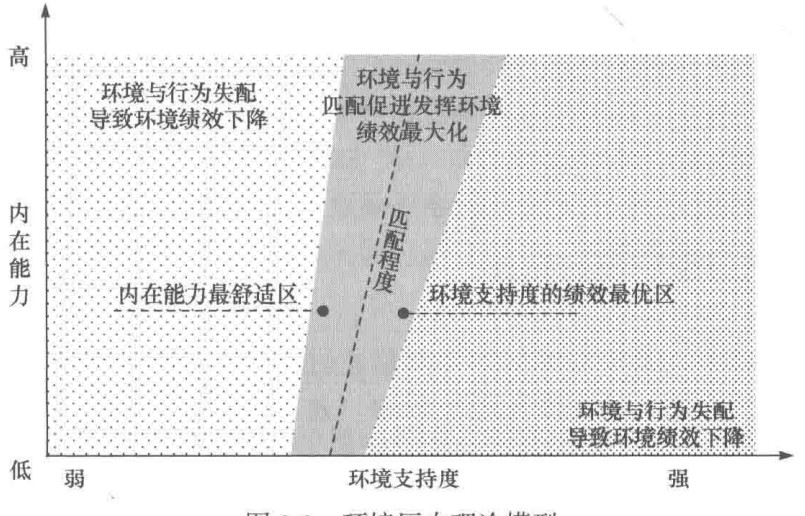


图 3-2　环境压力理论模型

3.2　老年友好型环境的概念和特征

3.2.1　老年友好型环境的概念

老年人往往患有各种慢性病，而且其移动功能、视听功能、感觉功能及免疫功能等衰退，对社区环境的依赖程度更大，社区环境对其健康和幸福感影响也更大，因此，建设老年友好型环境是实现健康老龄化的重要措施。早在 2005 年世界卫生组织就提出了老年友好型社区（age-friendly community）的概念（WHO，2015），以指导各国在城市规划、建设和管理。我国于 2009 年开展了首批“老年友好型城市（城区）”“老年宜居社区”建设试点活动。随后，在 2011 年，全国范围“老年友好型城市（城区）”和“老年宜居社区”建设工作全面铺开。2016 年，《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》正式颁布，从适老居住环境、适老出行环境、适老健康支持环境、适老生活服务环境、敬老社会文化环境五个方面对老年宜居环境的建设内容进行了阐释。

除了老年友好型城市、老年宜居社区外，近年来全球各国在老年友好型医院、老年友好型学校、老年友好型家庭等方面开展了大量的研究实践工作。为此，2017 年世界卫生组织欧洲区在环境老年学中人–环境适应理论的指导下，提出了老年友好型环境的概念。人–环境适应理论指的是一个人的健康和独立老化的能力取决于其内在能力与环境之间的关系。例如，一个老年人由于视力或听力的下降而无法外出进行正常的社交活动，但通过佩戴眼镜和助听器可以实现正常的社交活动。再比如，一些老旧社区没有安装电梯使得老年人无法下楼进行日常活动。

老年友好型环境（age-friendly environment）（WHO，2018），是指能够促进和保持人们的内在能力，以及帮助内在能力受损的人群实现其更大的功能发挥，从而促进健康老龄化和积极老龄化的环境，如建设老年友好型家庭、建设老年友好型社区、建设老年友好型城市。

3.2.2　老年友好型环境的特征

在实践过程中，老年友好型环境就是通过政策、系统、服务、产品和技术支持，消除影响老年人的物质和社会障碍。老年友好型环境的主要特征包括以下几项。

1. 促进健康，在整个生命过程中促进和保持内在能力

老龄化的问题不仅仅是老年人的问题，而是包括儿童青少年和成年人在内的全人类的问题。此外，老年人出现的各种健康问题不仅仅是由老年阶段的因素引起的，而是在整个生命过程中的暴露所致。因此，老年友好型环境建设必须从生命全程的角度出发，提高社区中每个人在生命全程的健康和内在能力。

2. 促进老年人做他们希望做的事情

老年友好型环境建设不仅仅是维持或提高老年人的健康水平，更重要的是提升老年人的幸福感、获得感，保证每个老年人按照自己的意愿做自己想做的事情，这是提升幸福的重要内容，也是老年友好型环境建设的重要组成部分。

3. 识别老年人的各种能力和资源

尽管随着年龄的增加老年人的健康状况和能力呈现下降的趋势，但不同老年人的健康状况和能力的差异更大，所以不能武断基于年龄对老年人进行分类，即年龄歧视。这种做法忽视了在任何特定年龄时内在能力的巨大差异，可能导致根据对该年龄所意味情况的成见采取简单化的应对措施。清除这些限制性的社会障碍，可以强化一种观点：虽然老龄化常常会造成损失，但也可以是充满个人发展、创造力和富有成效的阶段。消除年龄歧视的另一个重要措施是，从新的经济模式出发，总结关于老年人当前的作用和需求的证据，全面评估老年人做出的总贡献、护理的费用（不仅涉及公立部门的服务，而且包括常常提供护理的非正式照护者）以及促进健康老龄化的干预措施对老年人功能发挥的收益。

4. 预测并灵活地应对老年人相关的需求和偏好

随着年龄的增长，老龄群体会出现长期而复杂的健康和服务需求。卫生系统针对老年人的多方面的需求提供整合性的服务，其效果要优于提供简单应对具体疾病的服务。这将需要范围广泛的各种服务部门之间的协调，其中包括健康促进和疾病预防，筛查、早期发现和急救护理，慢性病的持续管理，康复和姑息治疗。不同级别服务部门之间的协调以及各种卫生和社会服务部门之间的协调将是至关重要的。因此，鼓励老年人自己参与制订服务计划，围绕老年人的需求和偏好设计服务设施。

5. 尊重老年人的决定和生活方式选择

自主权是老年健康幸福的一个核心部分，对他们的尊严、人格的完整性、自由和独立具有巨大的影响。老年人有权做出选择并自主控制一系列问题，包括他

们居住的地方，他们维持的关系，他们穿的衣服，他们如何安排自己的时间，以及他们是否开始接受一种治疗。

6. 消除不公平、保护脆弱人群

保证每个人都公平享有健康老龄化的机会，不因社会和经济水平而不同，不因出生地和居住地而不同，不因其他社会因素而不同。

7. 促进老年人融入社区生活的各个领域并为社区生活做出贡献

老年人在发展过程中的参与可以有助于建设团结、和平、公平和安全的社会。把他们排除在这些过程之外，不但影响到他们的福祉和贡献，而且可以严重影响其他几代人的福祉和生产能力。例如，老年人对家庭、社区和社会做出众多社会和经济贡献，如帮助朋友和邻居、指导同辈人和年轻人、照顾家庭成员和更广泛的社会，而且他们还是消费者、劳动者和志愿者。因此，促进老年人的参与、确保他们能够参与并受益于这些过程对老年友好型环境建设是至关重要的。

3.3　老年友好型环境建设

3.3.1　老年友好型环境建设的内容

根据影响老年健康的环境因素，老年友好型环境可以分为物质环境、社会环境和信息与服务三个方面（WHO Regional Office for Europe，2018），现分述如下。

1. 物质环境

物质环境在减少物理性和结构性障碍，降低老年人失能门槛、促进社会参与方面具有重要作用。因此，支持性物质环境旨在降低失能的门槛，帮助老年人找到应对功能下降的新方法。此外，物质环境也可通过鼓励健康行为和社会互动，提高生命全程中的健康和恢复力。老化和健康状况下降的早期是否会导致不良健康结局和残疾，在很大程度上取决于人居住的物质环境。例如，即使由于视力受损而感到驾驶不安全，但如果道路的连接性好，安全性高，老年人也可以步行到附近的商店或咖啡馆，或者如果公共交通工具方便使用、标识明确、价格合理且与当地连接良好，老年人也可以使用公共交通工具拜访朋友、家人，进行正常的社交活动。老年友好型物质环境包括室外环境、公共交通和活动性、住房条件三个维度。

室外环境主要指室外环境和建筑物。室外环境对人们的健康行为及健康具有重要影响，而老年人更容易受到室外环境的影响。欧洲每年有 4.6 万名 70 岁老年人死于跌倒，其中 26%的跌倒是由环境因素导致，如住房条件差、公共设施和娱乐设施可及性差等。52%的英国老年人由于室外缺少公共厕所而减少外出活动。在大多数情况下，城市已有的建筑和基础设施、法规、文化、历史已经塑造了任何特定社区的老龄化体验。因此，老年友好型环境建设并不是完全从头开始，为了使城市更适合老年人，了解现有室外环境的障碍、限制和优势是至关重要的，以便在保留已有特征的基础上，对其进行改造和减少障碍。

室外环境的建设需要遵循以下原则：①增加无障碍公共空间和建筑物的可及性与适用性。随着人们年龄的增长，他们通常会对看似很小的物理特征有更大的敏感度，这些特征可能会妨碍或降低他们对室外环境的安全感和信心，从而影响他们的外出活动。例如，缺少公共设施或公共设施密度太低，如长椅、公共厕所、电梯等密度太低，可减少老年人外出活动。此外，公共环境的设计和改造要遵守包容性设计或通用性设计的原则，即公共环境应对所有的人都是可及、适用和有益的。②支持社区互动和个人独立。当周围环境有休息的地方、有趣的街头生活和安全感时，老年人可能会经常去户外活动，去散步和结识人，参与日常生活。相反，在房子前面是一条繁忙的街道，尤其是没有红绿灯或穿越绿灯的时间短，会造成令人害怕的情况，从而阻碍一些老年人外出活动。对于老年人来说，社区周围有方便可及的商店、服务和便利设施是至关重要的。③建设户外活动场所。人们的外出不仅是去完成一件事情或从一个地方到另一个地方的行为。在公共场所和开放空间也让人们有更广泛的参与社区生活及社交活动的感觉。公共长椅和其他休息机会，以及足够可及的公共厕所，对于提升身处公共空间、功能受限的老年人的自信心是必不可少的。需要在老年人经常活动的社区建立娱乐、体育活动和其他休闲活动的地方，从而提升老年人外出活动的自信心，增加社会活动和社交活动的机会。此外，良好的绿化、公园等与社会美观度有关的因素不但可以促进老年人的身体活动，而且可以改善其生理和心理健康水平。④建设增进归属感、连续性和自我意识的城市环境。家庭周围的空间不仅仅是一个地理单元和物理属性，它对于居民来说还具有特征、历史、意义和价值。老年人希望在特定的地方变老，这与一种连续性和熟悉一个地方的感觉有关。然而，一个社区的快速变化可能会让人觉得它是新的、陌生的，并威胁到老年人对它的连续性和依恋的感受。依恋和归属感是通过生命全程中邻里间的无障碍体验、社会联系、感觉、记忆、想法与日常生活来形成的。在一个地方的经历会影响老年人对它的主观判断以及他们在这种环境中的参与能力。那些能够保存和回忆对一个地方的意义、价值观和集体记忆的方法，有助于老年人保持一种连续性的感觉，并支持一种归属感。因此，对于城市规划者和决策者来说，认识到这个地方如何影响老年人户

外活动的自信心、归属感、连续性是很重要的。

公共交通是生态系统和人口可持续发展的关键战略之一。对于老年人来说，“走出去”的室外活动能力对他们的幸福和健康至关重要。交通对于维持老年人与家庭、朋友和邻居的社会联系，以及保持其更广泛的社交活动和参与社会，包括获得卫生和社会服务至关重要。例如，在美国、英国等发达国家，12.1%的老年人不能按时接受卫生服务的原因是交通不便，低收入国家这一比例达到 29.1%。

社区提供的活动（包括老人之家、睦邻点、日间活动中心、教堂和公园）、必要的服务（包括医院、诊所和杂货店）和社交网络，有助于补偿活动性下降对老年人的影响。有研究显示：如果老年人不能便捷地到达对其生活有重要意义的目的地，也会导致老年人的挫折感和不良健康后果。因此，帮助老年人增加活动性不仅有助于减少其孤独感和孤独，而且可以防止或减缓其健康和日常功能的进一步下降。

公共交通和活动性的建设需要遵循以下原则。①增加具有积极活动性和可步行性的基础设施。应该提倡老年人步行出行，因为它是具有身体活动和活动性的“双赢”结果。它使老年人能够独立地做他们想做的事情、参与社会生活。维护和设计良好的人行道、步道和自行车道对促进老年人的身体活动至关重要。如果干预措施能够减少机动车交通量、降低交通速度和提高道路安全性，则可以提高老年人对积极活动的自信心。②大力发展公共交通。有证据表明，对公共交通的干预可以减缓老年人参与活动的减少。这些活动包括参观展览、博物馆和图书馆，去餐馆，锻炼或运动，旅行，与晚辈玩耍或帮助他们，参加社区或志愿组织，参加专业活动或工会会议，去上课或听报告。人口老龄化也可以被视为发展公共交通的重要机会。因此，城市需要坚定地执行无障碍标准和指南，通过调整现有的公共交通系统来克服老年人出行障碍。可采取的措施有：使公共交通易于使用，如提供换乘信息、简化自动售票机操作方法等；在考虑老年人需求的同时，采用包容性设计原则规划公共交通服务，如地铁–公交换乘系统，为老年人和失能人员减免公共交通费用。提升公共交通服务人员的服务意识和技能、增加服务信息也可促进老年人使用公共交通。③提供“一门式”服务和按需服务。老年人由于功能下降，外出活动能力减少，积极活动的意愿不高，如果为老服务的流程太复杂、涉及部分很多，会进一步影响其外出办事、减少活动。而“一门式”的应用就是为了简化办事流程，方便办事人员，让办事的居民或单位少跑腿，这种看似鼓励老年人多活动的服务形式，反而更容易鼓励老年人利用各种服务，增加其活动性。此外，对于特定的社区或人员也可按照他们的特点提供必要的服务，如为行动不便的老年人提供接送服务，提高他们接受社区健康筛查的可能性。

住房条件对人们的健康具有重要影响。在家里，许多环境危害（如霉菌、噪声、寒冷、拥挤和事故）都会影响健康。此外，随着年龄的增长，功能受限越发

严重，老年人在家中活动的时间更多，对家庭环境的安全性、可及性、位置及独立性要求更高。不适应老年人需求的家庭环境会引发一系列不良后果，包括事故和伤害的风险，以及在日常生活活动中的困难，这可能意味着老年人需要进入更昂贵的医疗环境。中国人的养老观念倾向于选择居家养老，因此住房环境对于促进老年人的健康更为重要。

老年友好型住房需遵循以下原则：①通过改善住房条件来减少不公平。确保为老年人提供公平的住房对于减少健康不公平和保护社会经济压力下的老年人免受严重健康影响至关重要。有研究显示，拥有房产是防止 75 岁以上老年人功能受限的重要保护因素。②支持家庭评估、维修、维护和改造。大约一半的跌倒发生在室内，因此家庭环境对预防跌倒至关重要。以下四个家庭活动领域对老年人来说最为关键——进出家庭、在家里走动、爬楼梯、使用卫生设施和厨房设施。研究证据表明，家庭安全干预措施，如危险评估和积极改造家庭，可以降低老年人跌倒的风险。我国《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》明确指出“建立社区防火和紧急救援网络，完善老年人住宅防火和紧急救援救助功能，鼓励发展老年人紧急呼叫产品与服务，鼓励安装独立式感烟火灾探测报警器等设施设备。对老年人住宅室内设施中存在的安全隐患进行排查和改造，有条件的地方可对于特困老年人家庭的改造给予适当补助。引导老年人家庭对日常生活设施进行适老化改造”。③制定和执行新的房屋建设标准。我国《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》明确指出“在城镇住房供应政策中，对开发老年公寓、老少同居的新社区和有适老功能的新型住宅提供相应政策扶持。鼓励发展通用住宅，注重住宅的通用性，满足各年龄段家庭成员，尤其是老年人对居住环境的必要需求。在推进老（旧）居住（小）区、棚户区、农村危房改造中，将符合条件的老年人优先纳入住房保障范围。加大对住宅小区消防安全保障设施建设力度，完善公共消防基础设施建设”。

2. 社会环境

老年友好型社会环境对于鼓励人们进行积极健康的生活以及降低健康和积极老龄化的障碍非常重要，尽管这些障碍有时比缺乏长椅或拥堵的人行道等物质环境要素表面上看起来更不明显。社会环境是老年人健康的一个重要决定因素：加强社会环境建设有助于解决健康老龄化的障碍，并有助于大幅改善人口健康状况。例如，社会网络和支持可以缓冲健康水平下降对生活质量与福祉的影响，使那些健康状况不佳的人仍能以有意义的方式做出贡献，并帮助他们做对他们来说重要的事情。相比之下，社会障碍和排斥会导致老年人被非自愿地孤立，并感到孤独；这些对老年人的生活质量有重大影响，并导致健康和积极老龄化中的不平等。在制定有证据的干预措施并对其进行评估的同时，更好地理解晚年社会关系和全面

参与障碍的性质，对于今后加强老年人的社会参与和社会关系至关重要。老年友好型社会环境包括社会参与、社会包容和非歧视、公民参与和就业三个维度。

社会参与是指一个人参与社会或社区中与其他人互动的活动。它不仅包括参与正式结构活动和休闲活动，如参加社会、文化和休闲活动，参加会议和宗教活动，也包括参加非正式社交活动和交流，如通过电话或其他信息手段与人联系，以及拜访朋友和家人等。老年人的社会参与可以积极影响身心健康和生活质量。

如果社会参与受到社会生活障碍的限制，老年人可能会变得社会孤立。社会孤立和孤独有很强的联系，也常常被互换使用，但是二者并不完全相同。社会孤立是指个人与他人，如家庭成员、朋友、邻居或其他人缺乏联系。从这个意义上讲，它常常被视为衡量个人社会关系的客观指标。孤独通常被视为一种主观和消极的体验，是个人对个人社会关系的感受。因此，孤独常常被理解为个人社会交往的实际和期望的质量与数量之间的不匹配。

社会孤立和孤独可以彼此独立存在。虽然有些人可能有很多社会交往，但仍然感到孤独，而另一些人可能很少接触，也不会感到孤独。有些老年人可能满足于自己的交往，甚至主动寻求远离他人的生活，他们可能不会觉得缺乏社会交往对他们的生活质量有负面影响，因此他们可能不愿意参加社会活动。其他人可能更喜欢与人接触，或者与亲近的人有更多的接触，这可能导致孤独感。

社会孤立和孤独可能是非支持性社会环境的结果，并可能导致个人和社区的不良结果。社会孤立往往伴随着其他不良健康的风险因素（如健康问题、功能受限、经济困难和政治或邻里排斥）而发生。这可能增加活跃老年人和非活跃老年人之间的差异，从而影响旨在促进积极老龄化和在地老龄化的政策的效果。

我们可通过以下途径促进老年人的社会参与：①增加老年人社会参与机会。老年友好型社区要通过各种途径开展一些适合老年人参与的活动，并提高其对活动的知晓度。当地政府也可以利用现有的社区资源、志愿者和项目，支持老年人的社会参与。利用已参与者的人际传播途径和新的信息技术，招募新的参与者并提高老年人对活动的知晓度。②建设社会交流的支持性社区环境。社区可以为老年人组织的活动提供场地和设施，如老年活动室、社区文体活动中心等。③终身学习。社区为老年人提供终身学习的机会，如老年大学等。

无论性别、年龄、残疾与否、精神是否健康、社会地位和种族，每个人都有权享有健康。然而，社会排斥、孤立、有害的刻板印象、歧视和虐待威胁着健康老龄化，并增加对待老年人不公平的现象。社会排斥和孤立会使老年人，尤其是高龄老年人、妇女和少数群体处于弱势地位，并可能阻止他们参与社会。

社会参与活跃的人可以获得资源——经济资源、社会资源和个人资源，并利用这些资源。他们可以积极参与社会和家庭，在面对环境压力和健康问题时更有弹性。相比之下，被社会排斥或边缘化的个人或群体会经历多重不利因素，这些

不利因素会限制人们获得健康所需的社会、文化、经济、政治和环境资源，并降低他们的生活质量。

我们可通过以下途径，促进社会包容和非歧视：①尊重和非歧视。公众、媒体、地方企业以及地方政府和服务提供商的通信与出版物中不得出现年龄歧视问题。识别和打击服务提供者、媒体和雇主的年龄歧视；跨部门合作制定老年人权利和长期护理质量标准章程。提高老龄化的积极形象，提高人们对老龄化问题的认识。加强对虐待、忽视和欺诈老年人的预防。促进代际技能、经验和知识交流。②预防或消除社会排斥。通过补贴、社会援助、打折等措施预防经济排斥。通过社会参与或心理健康服务预防社会孤立和孤独。对照顾者和有需要照顾的老年人家庭给予支持，如经济支持、技能培训、服务项目等。③针对弱势群体的活动。为弱势群体提供针对性的服务或社会活动，如家庭病床服务。④加强代际交往，理解和交流价值观、技能与经验。

除了经济上的需要外，积极参与是一种个人选择，不仅对身心健康和幸福感有许多好处，对老龄社会可持续发展也至关重要。志愿服务支持老年人生活的不同方面，如休闲活动（文化/体育）、社会和医疗保健服务、政治参与、参与教育/辅导及社区生活的其他方面。在某些情况下，志愿服务具有很强的传统，志愿者的参与变得更加正式。例如，在北欧国家，招募志愿者在某些情况下已成为当地服务（如养老院）规划过程的一部分。

公民参与意味着努力改变我们社区的公民生活，发展知识、技能，使价值观和动机结合。它意味着通过政治和非政治进程来提高社区的生活质量。①参与政治生活和决策。赋予公民发言权，使社区居民在地方决策中发挥积极作用，如改变组织架构，赋予老年人参与决策的权利；建立跨学科工作组，让老年人共同计划、领导和实施社区行动。设立委员会/理事会，代表地方当局特殊群体（如妇女、老年人、儿童、青年人或残疾人）的利益。通过焦点小组、社区论坛、参与性研究等方法咨询老年人，确定老年友好型环境建设的问题和行动方案。②参与经济生活与就业。第一，鼓励社会、政府为不同年龄的劳动力提供就业机会。例如，延迟退休年龄；或鼓励企事业单位为已退休老年人继续提供工作机会；为老年人提供更多的灵活就业机会；建设老年友好型工作场所。第二，创造新的就业和创业机会。例如，为老年人创造特殊的小工作机会和职业发展与培训机会（家政服务、信息服务）；提供创业和自营培训课程，鼓励退休后继续从事专业活动。③参与公共事务。第一，让老年人参与设计和提供影响他们生活的服务。例如，让老年人参与为老服务的设计和评价;加强老年人组织领导社区活动的能力培训。第二，鼓励其参与社区志愿者组织，促进社会包容。例如，推广或传播志愿服务的益处及相关机会，建立义工银行、睦邻点、自我管理小组，等等。

3. 信息与服务

各类政府部门向老年人提供的医疗、保健和社区服务对于促进健康老龄化与实现体面生活至关重要。为了使这些服务不给老年人造成不必要的高要求，需要很好地整合来自社区所有不同部门和参与者的服务，因此各部门之间的沟通和协调至关重要。

能够提供适应老年人的需要和偏好的关于社区新闻、活动与机会的可靠信息，对于老年人来说至关重要，尤其是对于那些单独生活在社区中的人，以及那些可能减少了社会联系的老年人来说。我国《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》明确指出："构建适老信息交流环境。进行信息无障碍改造，提升互联网网站等通信设施服务老年群体的能力和水平，全面促进和改善信息无障碍服务环境，消除老年人获取信息的障碍，缩小'数字鸿沟'。"缩小"数字鸿沟"的措施主要包括：①建立老年友好型信息系统。首先，保证信息的可及性。例如，为当地的活动和服务提供详细信息，特别是在农村地区；发放免费当地报纸；建立老年友好型互联网；保留面对面服务或人工服务柜台。其次，确保信息的有效传播。例如，定时更换各种媒体上的信息，为老年人制作针对性的信息，避免使用自动拨打电话信息系统，鼓励老年人进行口头交流。最后，采用老年友好型版面设计。例如，基于老年人的特征设计各种传播材料（如大字体），增加 LED 显示屏的可读性，使用清晰、简洁的格式和简单的语言。②创建健康信息中心。为老年人及其家人和护理者提供一站式健康信息服务，如健康小屋。提供有关社会参与、志愿服务机会及老年友好型服务等与健康老龄化有关的综合信息平台。提供跨部门信息咨询服务，增加利用计算机和在线信息的机会。③提高自我管理能力。通过讲座、报告、工作坊、讨论会、技能培训、现代信息手段等提高老年人自我管理能力。④提高健康素养。监测健康素养水平、分析信息获取的障碍因素；加强卫生保健和服务提供者的能力建设与沟通培训；开展培训和宣传活动，以提高老年人了解健康相关信息的能力；通过跨部门合作，提高那些信息获取有困难的群体的信息获取能力，建立健康老龄化数据指标监测系统；增加老年友好型环境建设策略和计划的可及性；开发更人性化的智能手机应用程序，以提高信息的可及性和安全性；为老年人提供信息技术相关培训，提高信息技术使用技能；增加互联网和新技术的可及性。

随着年龄的增长，老年人的服务需求更加多样化，而且呈现出长期且复杂的需求。研究显示，针对老年人群多层次需求的整合性的医疗卫生服务，效果要强于简单针对单独疾病的措施。然而老年人常常面临的服务是专门针对急性疾患或症状的治疗，此种治疗采用独立、分离的方式处理各种健康问题，使得不同的卫生保健提供者、医疗机构缺乏协同，不同时点、不同情况下的服务也缺乏一致性。

因此，需要通过以下途径，提高服务的整合性。

（1）社区协调行动，提供整合式服务。良好的协调和整合服务，特别是在老年人健康和社会服务（包括长期护理）之间的界限，已被认为是提高为老服务效率和效力的关键。整合式服务的重要措施包括以下几项：建立公共信息系统，用于监测和评估社区中老年人的生活状况、健康和幸福感；为老年人及其家庭提供一站式信息服务；建立日托中心和临时护理中心，日托中心可以和住宅设施整合在一起；建立社区信息系统，用于监测和控制护理机构的不良事件；制定或调整针对老年病问题的服务质量标准；提高老年人及其亲属和志愿者支持网络工作人员的健康素养和增权能力，开展以“患者为中心”的自我管理项目。

（2）提供卫生服务、健康促进服务、预防服务。老年人无法获得可负担的、高质量的卫生和社会服务是当前全球各国面临的共同问题。卫生服务利用的不公平依然存在。尽管经济困难的老年人对卫生保健服务的需求更大，但与富裕的老年人相比，经济困难的老年人的卫生需求得不到满足的程度更严重。经济困难的老年人与富裕的老年人对卫生服务利用的情况存在差异，后者所获得的门诊服务是前者的 1.6 倍，而获得的住院服务则是 3.8 倍。因此需要将以社区和人口为基础的公共卫生服务重点放在老年人问题上；支持社区提供（如租赁）辅助设备，包括现代移动技术；提高预防保健服务，包括疫苗接种和家访；改善社区老年人获得精神卫生服务的机会；解决老年人康复和姑息治疗方面的差距。

（3）加强家庭护理和非正式护理。提供家庭护理服务的社区，它们有重要的责任监督家庭护理，提高家庭护理的可及性和质量，以及为非正式护理提供支持，特别是提供连续性服务。为使家庭成员和朋友提供的非正式照顾能够持续下去，通过公共资金资助的非正式照顾基本服务包支持至关重要。它既有助于改善需要照顾者的健康和福祉，又有助于保护非正式照顾者的健康和福祉。这种公共资金支持包括对老年人的自理培训和对非正式照顾者的培训。提供家庭护理的社区，他们在提高护理质量和增加护理可及性方面同样具有重要的作用与任务。这包括吸引具有足够的老年人问题知识和适当技能的工作人员。阿尔茨海默病患者护理中的质量问题在许多情况下尤为严重和普遍，人们越来越意识到解决这些问题的必要性。

（4）居家护理。居家护理主要包括以下方面：为独立生活和需要长期照顾的人提供连续的服务；通过提供尽可能长时间的“日常”生活环境，提供个性化的生活空间，包括（尤其是）阿尔茨海默病患者的生活空间，使居家护理非制度化——这可以包括带综合护理服务的共享公寓，嵌入社区的生活；支持创建促进健康的居家护理，提供全面的服务，包括促进健康和预防疾病（如适当的体育活动、高质量的营养和对跌倒的预防）；培训和留住在老年学和老年病问题上具有足够技能的员工，并减少员工流动；促进与卫生保健部门的合作，以避免可预

防的住院护理，如提供充足的营养和护理，以防止出现压力性溃疡，这可能导致需要长期强化护理；实施护理质量战略并持续监测其执行情况，包括在当地老年人组织的参与下，更加关注利用居家护理的老年人的心理和福祉等方面。

（5）环境辅助生活和信息通信技术服务。环境辅助生活、信息通信技术（information communications technology，ICT）、电子/移动健康（e/mHealth）在未来建设老年友好型环境方面将发挥重要作用。例如，远程安全警报，从家庭到护士、医生或医院的通信技术解决方案，远程活动传感器，开发新服务的虚拟病房（如家庭医院项目）。

（6）应急计划和备灾。制订预案和方案，以便在紧急情况下与弱势老年人接触。制订极端天气事件和紧急情况应急预案。通过易受伤害和脆弱老年人登记处的监测系统，实时监测老年人的状况。确保突发公共事件发生时，如传染病暴发，当地政府可及时安排有效的应对方案。

3.3.2　老年友好型环境建设的步骤

老年友好型环境建设是促进健康老龄化的一个重要战略政策。随着越来越多的国家或地区加入世界卫生组织老年友好型城市/社区全球网络，世界卫生组织欧洲区域办事处于 2016 年出版了《老年友好型环境建设指南》，用于指导各地决策者和规划者制定、实施和评估老年友好型的政策和干预措施以支持积极老龄化和健康老龄化。

如图 3-3 所示，老年友好型环境建设进程分为 4 个阶段（参与和理解、战略性规划、行动和实施、评估）20 个步骤，同时交叉贯穿 5 项战略原则以达成老年友好型环境建设的决策目标。其中，这 4 个阶段可以循环的方式重复进行，且可以根据本地区的实际情况对每个阶段的实际工作进行修改。

1. 参与和理解阶段

参与和理解阶段是在所有利益相关方之间建立政治承诺和所有权的重要阶段，这一阶段的主要内容是进行背景分析和评估所在环境的老年友好程度，要确保任何老年友好的倡议在多个利益相关方之间不限于单一利益。下面是指导这个阶段活动的具体步骤。

（1）成立委员会或工作组。成立老年友好的地方工作组或委员会以及建立地方利益相关方网络。

（2）进行参与式评估。征求老年人的意见以评估老年人的需求，了解健康老龄化存在的挑战和机会。

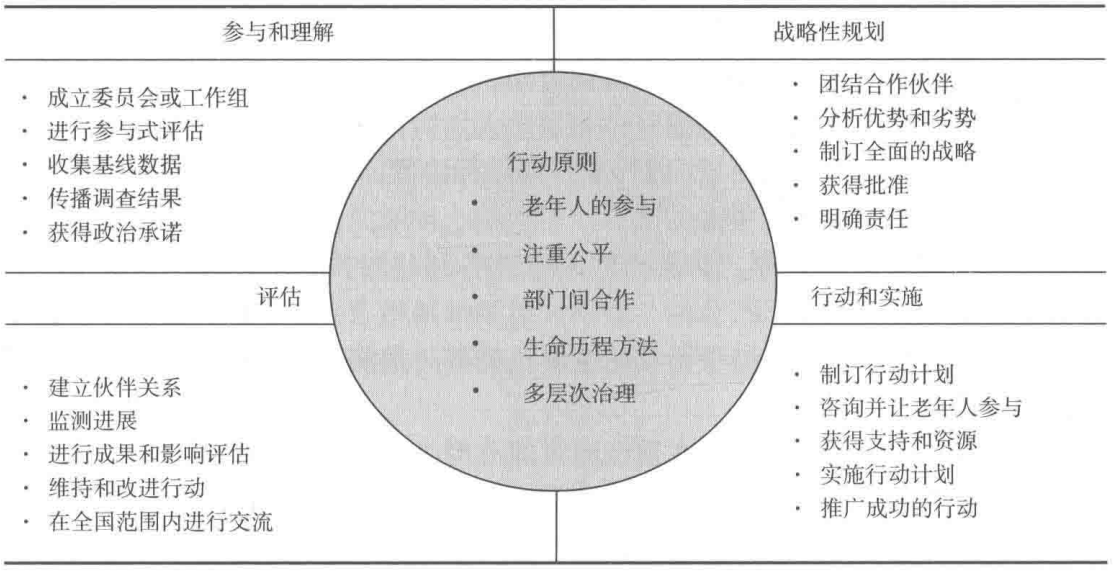


图 3-3　老年友好型环境的建设步骤

（3）收集基线数据。评估和了解物质环境、社会环境和老年服务三个方面当前情况，建立和传播一个所有利益相关方都参与的老年友好的机制。

（4）传播调查结果。介绍和传播评估结果，倡导更有利于老年人生活的环境。

（5）获得政治承诺。开发领导层，增加领导对健康老龄化的认知，获得当地政府的政治承诺。

2. 战略性规划阶段

战略性规划阶段的主要目标是制订一份战略文件来确定共同愿景和优先事项，并将其用于指导所有相关部门的行动，旨在应对主要挑战和促进健康老龄化。下面是指导这个阶段活动的具体步骤。

（1）团结合作伙伴。将利益相关方和合作伙伴团结在一个共同愿景下。

（2）分析优势和劣势。分析社区的优势和劣势，确定行动的优先次序。

（3）制订全面的战略。各利益相关方共同参与制订全面的战略文件。

（4）获得批准。各利益相关方确定共同的目标、目的和指标，并以文件的形式报告给当地政府，并获得政府的批准。

（5）明确责任。确定相关合作伙伴的责任。

3. 行动和实施阶段

在行动和实施阶段，所有利益相关方和合作伙伴制订计划和目标，以实现现实世界的变化。行动计划是将战略计划转化为具体行动的重要工具，界定了指导所有行为体日常工作的责任、资源和时间表。下面是指导这个阶段活动的具

体步骤。

（1）制订行动计划。制订一个行动计划，明确各项行动的参与对象、内容、时间进度安排、主要负责部门。

（2）咨询并让老年人参与。就行动计划进行协商，并让老年人参与所有阶段，保证各项活动都能满足老年人的需求。

（3）获得支持和资源。获得当地政府及各利益相关方在政策和资源方面的支持。

（4）实施行动计划。各项行动的主要负责部门及利益相关方按照行动计划开展各项行动。

（5）推广成功的行动。在本地区更大的范围内推广成功的行动计划，扩大成功的行动计划的规模。

4. 评估阶段

根据计划采取的行动进行有力的监测和评估能显示老年友好型环境建设计划的成功与可持续性，并由此指导以决定老年友好型环境建设的改进方向和改进目标。因此在评估阶段的早期就应成立一个评估小组，并就考虑今后如何更新和修订建设行动计划达成一致。下面是指导这个阶段活动的具体步骤。

（1）建立伙伴关系。与大学和研究机构建立伙伴关系。

（2）监测进展。持续监控流程。

（3）进行成果和影响评估。对第三个阶段的工作进行成果评估和影响评估。

（4）维持和改进行动。维持和改进有证据支持的行动。

（5）在全国范围内进行交流。从国家和国际网络的成功行动中学习。

3.3.3　老年友好型环境的评价

1. 老年友好型环境的评价框架

由于不同国家或地区的政治体制和社会发展背景情况不同，且各地区老年友好型环境内涵界定存在一定的差异性，老年友好型环境建设并没有统一的指标体系。但是，各地区均围绕 2015 年世界卫生组织发布的《衡量城市关爱老人的程度：核心指标使用指南》中提出的投入—产出—结果—影响的逻辑顺序，根据各自的实际情况建立评价指标体系。

1）投入

投入是对成功地启动、发展和维持关爱老年人城市行动至关重要的资源和机构。例如，在长时间内追踪资源的可得性、调配和使用等方面，投入指标是有用

的。投入指标可以产生数据并将其用于成本效益分析。这些指标还可用于倡导利益相关方更大程度的参与和贡献。可以在可得性（即二选一的是或否指标）或者可得性程度（适当规模）方面对投入指标进行衡量。一个例子是市长签署的承诺书可以用作高级别政治承诺的一种二选一的定性指标；另一个例子是，市长办公室承诺的财政支持的绝对或相对金额可以用作政治承诺和财政资源两方面水平的定量指标。当考虑把投入指标纳入老年友好型城市的一套有限指标时，应当首先考虑对一系列产出将产生广泛影响的投入指标，如政治承诺。其次才是考虑按设计意图仅会产生有限影响的投入指标，如用于多项干预措施之一的财政资源。

2）产出

产出主要涉及为实现期望的结果和影响而实施的干预措施。干预措施的侧重点是创建老年友好型环境，所以这些干预措施可以采取的形式为旨在改变物质环境和社会环境的政策、服务或规划。这不仅限于新实施的干预措施，也可以包含对现有干预措施的调整。老年友好型环境行动的领导机构或协调机构可以是地方政府，但必须认识到包括民间社会和私立部门在内的非政府部门可起到重要的作用，其常常会填补政府干预措施的空白或强化这些干预措施。

确定产出指标时要注意其范围和规模应涵盖不同部门的一系列活动。这方面的一个例子是新建或改建后符合相关方便使用（如包容性设计）标准的公共交通设施（如公交车站、火车站）的数量或比例。直接负责实施干预措施的机构或部门可衡量范围广泛的指标，以便密切监测和评价干预措施的过程和结果。但是，为了制定一套简明指标用于全面评估全市范围的多方位老年友好型环境，最好把产出指标局限于与城市各管理部门及其利益相关方所采取的主要干预措施密切相关的指标。

3）结果

老年友好型环境行动的结果指标，是可以反映干预措施（即产出）使社区在社会环境和物质环境方面实现的短期至中期变化的指标。结果指标将主要涉及城市生活各主要方面方便使用和包容性的问题，如方便使用的公共设施（卫生和社会服务、交通、娱乐设施），体面住房的可负担性，社会参与的机会，以及信息的方便获取。按上文产出的一个例子，增加符合方便使用标准的公共交通设施的数量（干预措施，即产出），预计将改进“方便使用公共交通”（一项结果）。此外，指标选取时，还必须考虑干预措施对社区整个人群的影响，而不仅是对老年人的影响，尤其是强调老年人的积极贡献及老年友好城市对更广泛社区的益处。这方面的例子包括老年人的捐赠，志愿者活动和指导，交通系统的整体联通，以及残疾人、孕妇及幼儿家庭预计可方便使用的公共设施。把结果指标纳入指标集时，应当考虑到的基本原则是，老年友好型环境涵盖涉及政府和社会各部门的一系列物质环境与社会环境因素。因此，这套指标应当包括一系列结果指标，涉及社会

环境和物质环境两方面的问题，以及政府和非政府部门干预措施的作用。结果指标的选择应当与老年友好行动的目标和期望结果直接相关，并密切涉及实际干预措施及其预期影响。重要的是应当考虑到，干预措施除了产生预定的结果之外，还常常会产生超出其主要预期结果的意外结果。例如，交通部门为改进公共交通方便使用程度采取的干预措施，可能也会间接地提高老年人的社会参与水平。另外，一项干预措施可能会占用原本用于加强老年人娱乐规划的干预措施资源，从而降低他们的社会参与水平。因此，在选择结果指标时，必须考虑到直接和间接以及预期和意外的结果。这意味着产出指标的数量和类型不一定与结果指标的数量和类型一一对应。理想的情况是，有效的规划将通过较少的产出产生多项结果。

4）影响

影响是人体健康（身体、认知和情感功能）及福祉方面的长期变化，预期可通过提高物质环境和社会环境老年友好的程度产生这种变化（至少有一部分）。因此，影响指标应当与结果指标充分对应。在有些情况下，老年友好型环境行动的重点干预措施可以作为一项人权来提高环境的老年友好程度，并考虑到在不明确表示希望改善人口健康或福祉的情况下创建老年友好型环境的内在价值。但是，如果环境更适合老年人日益增长的需求，使他们能够长期保持高度的身体功能、社会参与和心理满足，就可以有理由期望获得人口健康效益以及对更广泛社区的其他好处（如经济价值、可持续性）。如果这些效益能够得以表现，并至少可以部分归因于社会环境和物质环境方面实现的变化，就将显著提升老年友好型环境行动的价值。影响指标被各种因素所影响，很难明确应归因于老年友好型环境的工作，有必要把这些指标纳入老年友好型环境的指标集，以便涵盖改变环境的长期影响。这也可为不同的部门提供通过协调努力争取达到的共同大目标和具体目标。

2. 老年友好型环境的评价指标

根据老年友好型环境建设的三个方面，可以从以下八个维度考虑选择指标对老年友好型环境进行评价。

1）室外环境

室外环境干预的目标是规划和设计建成环境与公共空间，创造适合老年人居住的户外环境，以满足老年人多元化的需要，支持就地老龄化。除了遵循新社区设计的良好做法外，还注重对现有社区进行改造。可用于评价室外环境的指标包括社区可步行性、公共空间和建筑的可达性及公共安全性等。

2）公共交通和活动性

公共交通和活动性干预的目标是提供安全、无障碍、适当与可靠的交通服务

和改善基础设施，以便促进老年人积极地生活，从而使人们能够在老年化的过程中保持流动性、独立性和良好的人际联系。可用于评价公共交通和活动性的指标包括公共交通的可用性与可达性、公共交通车站的可达性、公共停车场的可达性、公共交通换乘系统的可达性等。

3）住房

住房干预的目标是提供充足、无障碍、安全和负担得起的住房；提供便捷的住房选择；通过改变现有住房存量和使新建住房更好地适应老年人的需要，支持健康老龄化。可用于评价住房的指标包括住房供应和负担能力、住房无障碍、住房项目和资源、在地老龄化能力、家庭安全等。

4）社会参与

社会参与干预的目标是促进老年人参与社会生活，消除孤独和孤立。这可以通过创造、维持和改善有助于社会互动与积极生活方式的支持性环境，以及通过提供有意义的社会活动机会，鼓励老年人离开家庭并维持支持性的社会网络来实现。可用于评价社会参与的指标包括参与社会文化活动、参加休闲身体活动、终身学习、参与的机会及参与机会的可获得性等。

5）社会融入和非歧视

社会融入和非歧视干预的目标是创造具有包容性的环境，使所有人不论年龄、性别、社会地位、健康或残疾都能得到尊重，并有机会参与和做出贡献。为了加强公平性，必须强调以人群为基础的干预措施，并覆盖健康状况不佳和受到排斥的人，了解他们的具体需要，并采取针对性的措施，提高他们的健康水平和生活质量。可用于评价社会融入和非歧视的指标包括对老年人的积极社会态度、代际活动的可达性、社区归属感、老年人在社区中的影响力等。

6）公民参与和就业

公民参与和就业干预的目标是通过为老年人创造更多更好的机会参与政治、经济与公共生活，以及增加老年人的就业、社会参与和志愿服务机会，更好地利用老龄社会的潜力。可用于评价公民参与和就业的指标包括从事有偿就业、参与志愿活动、参与地方决策、培训与支持政策等。

7）交流与信息

交流与信息干预的目标是通过人际交流、传统媒体或信息技术的使用，帮助老年人获得关于社区、参与方式、现有服务和健康主题的及时、可靠、相关与可理解的信息。可用于评价交流与信息的指标包括信息的适用性、信息材料的可用性、互联网可用性、援助的可用性等。

8）社会与卫生服务

社会与卫生服务干预的目标是提高社会服务与卫生服务的可及性。这些服务包括预防服务、营养指导和心理健康服务、负担得起的膳食和帮助日常活动、家

庭护理安排和以人为中心的保健服务与住宅护理设施。可用于评价社会与卫生服务的指标包括获得卫生和牙科护理、支持性保健服务、提供基于家庭或社区的服务、应急准备等。

3. 老年友好型环境评价指标的选择原则

因为各地区或国家的实际情况不同，所以开展的老年友好型环境建设的内容、方法和策略也可能不同，因此无法确定统一的评价指标体系和具体测量方法。必须通过经深思熟虑的系统方法选择指标，不但要考虑到指标与衡量的系统或工作主要目标的相关性，而且要考虑到这些指标必须是可衡量的、技术上可靠的并对目标受众有意义。另外一个重要的实际考虑是要利用常规数据机制和现有数据库来选择、收集和分析各项指标。这将有助于减轻数据管理的负担并提高可持续性。衡量老年友好程度的必要指标范围很广，但很可能不同的城市部门、研究机构、社区组织及其他利益相关方在日常工作中正在收集许多此类指标，或者从现有指标可以派生或经过调整产生此类指标。但是，需要谨慎地避免过多依赖常规使用的指标，因为这可能会阻碍制定创造性和理想性的指标。此外，行政部门报告的数据常常不同于当地居民在调查中以及重点问题小组在讨论中报告的感受，也不同于通过现场调查观察到的实际情况。因此，使用不止一种数据来源，可以有助于提高数据的质量和数量，并促进对指标进行更全面和准确的评估。选择指标时，需遵守如下原则。

（1）可获得原则。可获得原则要求指标在当地可以方便地获得，具有统一的计算方法和计算口径。

（2）相关性原则。相关性原则要求指标与当地社会经济发展规划具有联系，与老年友好型环境的建设工作密切关联。

（3）普遍认同性原则。普遍认同性原则要求是指国内外各地区建立的指标体系标准或者相关文献在该指标的合理性上是普遍认可的，且被当地相关部门、社区和老年人所接受。

（4）有效性和可靠性原则。有效性和可靠性原则要求指标需能够反映其所希望衡量的问题，在收集数据的方法上需考虑到数据和分析过程有较好的科学性与可信度。

（5）敏感性原则。敏感性原则要求指标在不同测量客体之间存在差异性，以便能够探测到二者之间的区别，特别是能反映具体干预活动的变化效果。

（6）可分解性原则。可分解性原则要求指标可以按性别、民族、社会经济地位、年龄组或不同社区进行分解。

（7）可重复性原则。可重复性原则要求指标能够以同样的方法，在不同的时间点进行测量，并能够对评价客体进行持续性的追踪。

老年友好型环境建设是实现健康老龄化的重要策略，但老年友好型环境建设需要决策者、不同政府部门、社区和非政府组织等多部门进行跨部门合作才能顺利开展。由于不同国家或地区的政治体制和社会发展背景情况不同，且各地区老年友好型环境内涵界定存在差异性，老年友好型环境建设并没有统一的指标体系。对老年友好型环境进行评估以及使用指标监测变化是推进老年友好型环境建设的重要工具。然而，评价和监测进展以及选择其中需要的各种测量工具需要大量的资源，且需要合理的规划。因此各国和地区需要以世界卫生组织的八个领域的具体指标和评价框架为指导并结合各自的实际情况，制定符合本国老年友好型环境建设的评价指标。

第 4 章　老年友好型社会的社区养老服务创新

周新宏　朱　勤　卢　敏　苏忠鑫

本章以“整合式”社区养老服务体系的构建为例，诠释老年友好型社会的社区服务创新。以社区为基础的“整合式”养老服务体系，是集健康、医疗和福利为一体的综合福利供给体系，将有效引导医、养、护结合和各部门资源的整合与释放。该方案整合各部门投放到社区的养老服务资源，统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的养老服务功能，依托老年社工对社区养老服务的全程导引，推行居家健康照护机构的社区嵌入，构建信息整合的社区养老服务数据平台以助力老年人需求和服务资源的精准对接，建立资源整合、多元协同、供需匹配、数据融合的社区养老服务体系，为社区居家老年人提供全方位、多层次、专业化和精准化的养老服务，使社区成为养老服务资源的链接和组织平台。

本章介绍“整合式”社区养老服务体系的缘起、目标与理念，描述其资源整合框架，阐述作为社区养老服务资源链接者的老年社工的制度设计，给出社区养老服务数据平台的设计方案，并总结“整合式”社区养老服务体系的实践要点，为进一步完善社区养老服务的政策设计与体系构建提供理论和实践支撑。

4.1　社区养老服务的现状与存在问题

社区养老服务是指以家庭为基础，以城乡社区为依托，以社会保障和社会服务制度为支撑，由政府提供基本公共服务，企业、社会组织提供专业化服务，基层群众性自治组织和志愿者提供公益互助服务，满足居住在家的老年人社会化服务需求的养老服务模式。现阶段，我国各地机构养老床位一般按老年人口的 3% 比例配置，意味着依托社区居家养老的老年人比例在 97%左右，加快构建和完善社区养老服务体系是我国应对人口老龄化的必然趋势与迫切要求。

我国自从 2000 年步入老龄社会以来，老年人口规模和比重加速上升，未来我国人口老龄化趋势还将进一步深化。同时，高龄、失能失智、独居和空巢老年人数量将进一步增加，老年人在养老、医疗、照护、福利等方面的需求将持续增长，全社会用于为老服务供给的支出也将持续增加，不论是从政府、社会层面还是家庭、个人层面而言为老服务的供需矛盾及收支不均衡压力将日益凸显。“未备先

老”是中国面临的基本国情，即以中等收入国家的资源储备现状迎来了快速进展的人口老龄化危机。因此，有效的社会政策必须以较小的政府经济承担，取得尽可能大的资源再分配的社会公平效果（杨团，2000）。

十九大报告提出了“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的要求[①]。目前政府各部门及市场、社会各方在社区为老服务领域实际上投入了大量的政策与资源，尤其是政府各部门以部门主导形成的各种老年福利公共政策。然而，现有体制下不同的政府部门由于各自的职能与功能定位不同，不同部门出台的养老政策之间出现权责交叉、界限不明确、资源投入重叠与缝隙并存等现象。政策的碎片化导致为老服务资源的分散化，造成大量的资源投入却无法切实有效满足社区老年人的需求。一方面是碎片化、低水平、重复化的社区为老服务资源供给，另一方面是老年人对集约化、专业化、多样化为老服务的需求希冀，为老服务资源配置上的不效率导致供需双方错位这一结构性问题是为老服务供需矛盾的主要方面，也是构建并完善整体性为老服务体系政策网络亟须解决的关键问题。调查研究发现，目前社区养老服务的存在问题主要表现如下。

（1）现行体制下社区养老服务资源条块分割严重，资源碎片化，资源浪费与资源短缺并存。民政部门在社区设立了综合为老服务中心、老年人日间服务中心、长者照护之家、社区老年人睦邻点等基层为老服务组织机构，并为老年人提供服务；卫生健康部门在社区设置了社区卫生服务中心、家庭医生制度、健康档案等，主要为老年人口提供医疗卫生健康服务；人力资源和社会保障部门主持的居民养老保险、高龄补贴等为老服务资源也是落地在社区的。还有以老龄委为代表的老龄部门[②]、司法部门[③]、教育部门[④]等其他政府职能部门均有相关的为老服务资源投入在社区。然而，由于条块分割体制的制约，政府各部门的为老服务和管理难以形成部门间的联动与合力，社区为老服务的资源不足和资源浪费并存，服务设施的重复建设与空置闲置现象同时存在，资源的整合利用效率不高。同时，对政府而言，也会造成其老年福利相关的财政负担日益加重。可见，现行体制制约下的社区为老服务体系呈现出主体多元割裂、资源碎片化的特征。一些地方的社区养老服务以娱乐活动、家政服务居多，而需要长期照护的失能失智高龄老年人所能享受的生活照料与医疗护理资源相对有限。

（2）养老服务的市场参与和社会参与不充分，服务专业化程度不高。近年来

① 《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm[2021-05-24]。

② 老龄部门是指全国老龄工作委员会办公室及各省市的老龄工作委员会。

③ 司法部门有专门面向老年人的法律援助服务。

④ 教育部门有专门面向老年人的老年学校、社区学校等老年教育服务供给。

社区养老服务的硬件设施有较大投入，但包括社区养老服务中心、日间照料中心、长者照护之家在内的社区小微型托养机构的环境和设施的适老性有所欠缺，服务人员队伍老化。社区干部和服务人员虽尽职尽力，但往往力所不及。由于养老服务行业存在投资大、经营利润空间小、回收周期长等问题，市场主体或社会力量介入社区养老服务领域的动机动因缺乏，养老服务的市场参与和社会参与不充分，服务专业化程度不高。现有进入社区的服务组织和机构在养老服务方面所能提供的以家政类服务居多，对居家失能老年人的专业健康护理服务需求的匹配程度不高。

（3）专业养老机构对社区的辐射能力不强，机构、社区、居家养老服务的有机联结薄弱。社区内的养老机构在内部一般都配置一定的医疗卫生资源，在一定程度上符合医养结合的政策要求。但这些资源一方面并未在机构内部得到充分利用，另一方面其也未能很好地服务周边社区居民。社区养老服务需求与服务使用的匹配程度不高，服务递送的可达性差。仅仅依靠社区卫生机构往往不能满足家庭护理需求。机构、社区、家庭服务资源的联结有待进一步打通。

（4）社区养老服务信息资源条块分割，存在一定的碎片化现象。在社区落地的不同养老服务项目分别对应民政、卫生健康、人力资源与社会保障、老龄工作委员会、妇女联合会等部门，相关服务资源有待整合；现有的养老服务信息系统种类繁多，但在数据信息与功能应用上难以互联互通。不少系统需要手工重复采集数据，很容易造成信息冗余、数据不一致、更新不及时等问题。

上述问题一方面与社区的人口、经济、社会发展状况的自身特点相关，另一方面也涉及当前政策、制度与机制层面的一些制约因素，有必要从整体性政策设计的角度探讨如何整合协调落实到社区层面的各部门、各方面资源，通过专业化的团队高效对接社区各种养老资源与老年人之间的供需匹配，特别是针对社区内不同老年人自身的经济水平、受教育程度和身体健康状况等特征为他们引导提供与养老有关的政策信息、项目参与、入住设施等服务，从而在保障基本养老公共服务供给的基础上，逐步实现对多层次、多样化养老服务需求的满足。

4.2　“整合式”社区养老服务体系

4.2.1　社区福利与社区养老

“社区”概念最早是由德国社会学家滕尼斯（Ferdinand Tonnies）于 19 世纪末提出（江立华等，2008）。20 世纪 20 年代，英国率先开始发展社区福利（community welfare），主要内容包括社区照顾、居家照顾、福利非营利组织发展

等社区福利政策。到 20 世纪 60 年代，美国、日本等其他发达国家受到英国的影响也开始推行社区福利。20 世纪 80 年代，在西方“福利国家”纷纷遭遇危机的背景下，福利多元主义（welfare pluralism）思潮开始兴起，社区化（communitization）、去机构化（deinstitutionalization）、市场化（marketization）等社会福利模式的新策略被提出来。进入 21 世纪以来，各国在发展社区福利这一工作领域均积累了一定的经验，社区福利的发展逐步走向成熟。

社区福利是在人口老龄化、家庭核心化、福利社会化的多重背景下应运而生的。社区福利的目的是对那些生活不能自理的个人及家庭，通过社区的社会力量对社会资源的协调和整合，提供家政、保健、护理并包括精神文化生活在内的社会性福利服务，解决他们在生活上遇到的问题，创造一个使社区居民能够实现自主、自立生活的环境（沈洁，2007）。福利社区化促使由政府部门、企业部门和非营利部门共同参与的合作机制得以自然形成，给予社区以最大可能的施展空间，通过社区内各种人力、物力和财力资源的整合利用，促进公共资源在社区内的充分流动，以较低的政府投入获得较高的社会生活保障质量，同时兼顾多元化的市场需求保障与一元化的最低生活保障。近年来，福利社区化（welfare communization）正日渐成为国内外社会福利制度改革发展的新趋势。

从 OECD 国家的经验来看，社区养老服务更契合老年人的养老意愿，统计表明，约有 70%需要长期照护服务的老年人更愿意接受社区支持下的居家养老服务而非居住在养老机构（Wolff et al.，2008；Keenan，2010）。养老机构会培养依赖性而非独立性（Welford et al.，2010），使其为老年人提供个性化服务比较困难。而且，机构养老很有可能比居家和社区养老的成本更高（Kaye et al.，2010）。因此，养老机构往往是在需要更专业护理时的最后一种选择（葛蔼灵和冯占联，2019）。社区养老服务可以让老年人获得持续的社会支持网络，更有效地满足以人为本的服务需求尤其是个性化需求。同时，移动互联网、人工智能等新技术的发展也为在社区居家环境中延伸专业照护服务提供了更大的可能性。

社区是中国社会保障制度的基本落脚点，将来形成社区化社会保障新体系的实践可能会证明这是符合中国国情的一条路子（杨团，2000）。探讨福利社区化有助于对社区研究的深入，也可以推进我国社会保障制度的改革。我国社区福利的发展始于 1993 年政府提出的《关于加快发展社区服务业的意见》[①]，之后其经历了社区服务（community service）和社区建设[②]的发展阶段，逐步向社区福利发展阶段演进。在养老服务供给上，社区具有天然的地缘优势。国家“十二五”和“十三五”期间出台的《社区服务体系建设规划（2011—2015 年）》及《城乡社

① 《关于加快发展社区服务业的意见》，http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=56708[1993-08-27]。

② 《关于在全国推进城市社区建设的意见》，http://theory.people.com.cn/GB/40746/3491444.html[2000-11-03]。

区服务体系建设规划（2016—2020 年）》均对加强社区公共服务体系建设提出了具体要求，其中包括养老服务、社区照料服务、病患陪护服务和家政服务等囊括框架之内的社区为老服务体系的建设完善。社区养老是我国解决人口老龄化问题的重要举措和必然趋势，在社区层面构建整体性的养老服务体系是发展社区养老和福利社区化的必然路径。

4.2.2　“整合式”社区养老服务体系的目标与理念

“整合式”社区养老服务体系整合各部门投放到社区的养老服务资源，统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的养老服务功能，以整合式服务平台精准对接养老服务的供需双方，综合各种社会力量为社区老年人提供全方位、多层次、专业化和精准化的养老服务，使社区成为养老服务资源的链接和组织平台。

“整合式”社区养老服务体系的主要目标包括资源整合、多元协同、供需匹配和数据融合。资源整合是指整合各部门投放到社区的养老服务资源，解决政策碎片化、供给重叠与缝隙。多元协同是指统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的养老服务功能，打通居家、社区、机构养老服务，形成合力。供需匹配是指老年社工嵌入社区，以整合式服务平台精准对接养老服务的供需双方，资源下沉，解决供需矛盾。数据融合是指以统一共享的微观人口数据为核心，建立社区养老服务数据平台，解决信息孤岛、数据冗余与不一致、功能碎片化问题。

“整合式”社区养老服务体系及平台的构建，遵循“四化”（简行政化、重专业化、原居老化和政产学研一体化）与“四助”（公助、共助、自助和互助）相结合的基本理念（图 4-1）。“四化”与“四助”之中蕴含着合作和参与的理念，它既强调政府、市场、社会、家庭和居民各方的参与，更要求各部门各方面形成合作机制，从而实现为老服务资源的集成与共享（沈潔和澤田ゆかり，2016）。

“四化”是指简行政化、重专业化、原居老化和政产学研一体化。简行政化是指政府应该把治理权逐渐向民间供给组织让渡，增加市场和社会力量参与的机会，实现“小政府，大社会”，同时减轻政府部门的福利负担。重专业化是指社区福利的发展必须着重专业组织、专业人才团队、专业方式方法的建立与完善，提升专业化水平。原居老化（aging in place），也叫作原居安老，吴淑琼和庄坤洋（2001）认为老年人应该在其生活的社区中自然老化，这符合多数老年人不愿离开家庭的养老心理，也与我国居家养老和社区养老的政策趋势相呼应。政产学研一体化强调政府、市场、研究机构、社会组织等多方主体的融合与协作。

“四助”是指公助、共助、自助和互助。公助强调政府行政力量对社区居民福利的援助；共助强调专业组织、专家团队等的帮助；自助是指家庭内部成员之间的自我协助，包括寻求市场的服务供给；互助是指社区居民之间（包括社区志愿

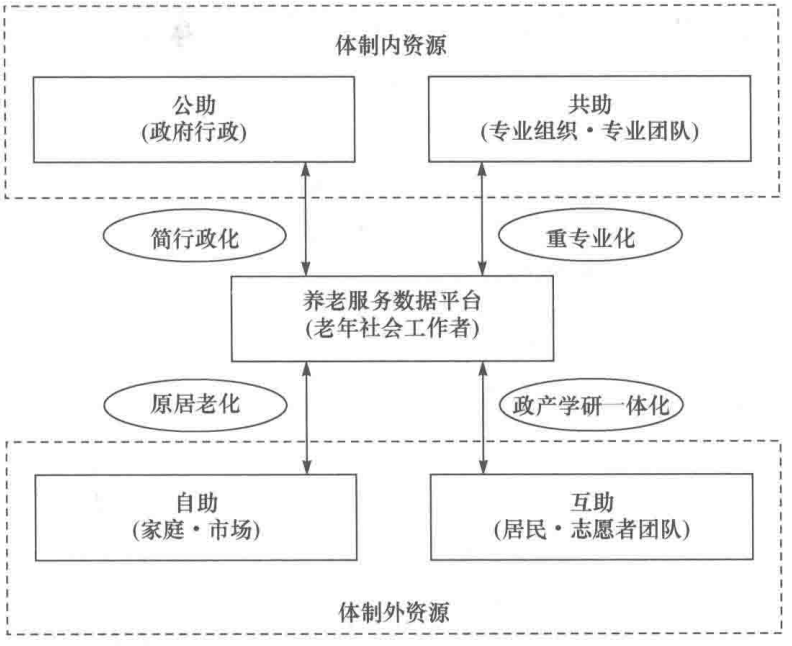


图 4-1　“整合式”社区养老服务体系的理念构建

者团队）的邻里互助。公助和共助主要代表体制内资源，而互助和自助更多代表的是体制外资源，“四助”结合要求将体制内资源和体制外资源通过协同合作机制实现资源整合。

4.2.3　“整合式”社区养老服务体系整合的资源

国外养老模式的发展历程表明，传统的家庭养老和完全依靠政府提供养老服务的模式在当代社会已经难以实现，因此促进服务主体的社会化，实现政府机构、商业机构、社会非营利机构等多元主体共同发展的社会化养老是未来养老服务的必由之路（刘晓梅，2012）。

“整合式”社区养老服务体系是一个整合了各部门各方面为老资源的有机统一政策网络，集成了所有的养老服务行动主体及资源，为社区老年人提供全方位的养老服务供给需求平衡。“整合式”社区养老服务体系整合的服务类型包括医、养、护服务，个人社工服务，志愿者服务，教育娱乐服务，等等。所整合的资源包括以政府、市场、社区、家庭等为主体的养老服务资源。

具体而言，“整合式”社区养老服务体系所整合的服务资源主要包括以下几项。

（1）社区卫生服务中心或社区卫生服务站，是向社区居民提供集预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的基本卫生服务的政府组织基层卫生机构，而全科医生团队在其中发挥着骨干作用。老年人是服务的重点人群之一，因此社区卫

生服务中心作为行动主体，是社区“整合式”养老服务体系政策网络的必要组成。

（2）社区监控中心是为社区居民特别是高龄、失能、独居和空巢老年人，提供 24 小时应答的社区养老服务一线通系统，可以为老年人提供紧急呼叫、生活援助、医疗保健等全方位服务。

（3）社区养老机构包括社区范围内的养老院、敬老院、托老所等机构。

（4）社区日间照护体系包括老年人日间服务中心、长者照护之家、社区护理站等由政府部门和社会力量投入到社区中的照护服务提供机构。

（5）老年日常活动或健康促进体系包括社区老年活动室、老年学校等。

（6）多样化的养老公寓，是指具备适老设施或经过适老化改造的各种大中小型养老公寓。

（7）老年流动性服务，是指专门为老年人或身体障碍人员提供的往来接送交通服务。例如，社区循环小巴士：在社区范围之内，帮助老年人在家和社区日间照护中心或社区卫生服务中心等机构之间移动；在社区与外部环境之间，为老年人去往医院、购物场所等提供移送援助。老年流动性服务在日本已成为相当普遍的社区养老服务项目，值得国内借鉴。

（8）养老服务信息平台，将各类老龄人口信息（包括健康档案等）、社区信息、服务信息等纳入统一的信息数据库框架，为养老服务体系提供科学精准的数据支持，同时这也符合“十三五”规划中实施“互联网+”养老信息工程的要求。

为了加快资源整合进程并提高资源整合效率，还应进一步明确列入整合目录资源的优先序，资源整合过程中应厘清政府与市场的边界，对体制内资源与体制外资源应通过协调合作机制完成整合；整合后的养老服务资源应注重放大专业的力量，服务应达到一定的标准与规范；应该进一步激发市场活力和社会创造力，调动各种社会力量参与社区养老服务。

4.3　嵌入社区的居家健康照护机构

目前我国城乡社区已逐步开展社区综合为老服务中心、日间照料中心（日托）、长者照护之家（提供喘息服务）的养老服务设施的建设与运营，而嵌入社区的居家健康照护机构则是今后需要在社区中进一步引入并完善的新型养老服务资源。如图 4-2 所示，在“整合式”社区养老服务体系中，社区护理站作为嵌入社区的居家健康照护机构，以健康管理、康复指导为核心，满足老年人不离社区的属地化养老愿望，在老年人熟悉的环境中为其提供专业的医疗护理、康复护理、生活照护等服务，实现社区和居家层面的医、养、护服务资源下沉，打通社区居家养老的最后一公里。一方面，对于有强烈居家养老意愿的失能老年人及其家庭，嵌入社区的居家健康照护机构可以有效满足其健康管理和生活护理需求；同时，“专

业的事让专业的人来做”，可以有效提升社区养老服务的专业化水平。另一方面，在专业养老机构床位不足的情况下，居家健康照护机构有效缓解了供需矛盾。

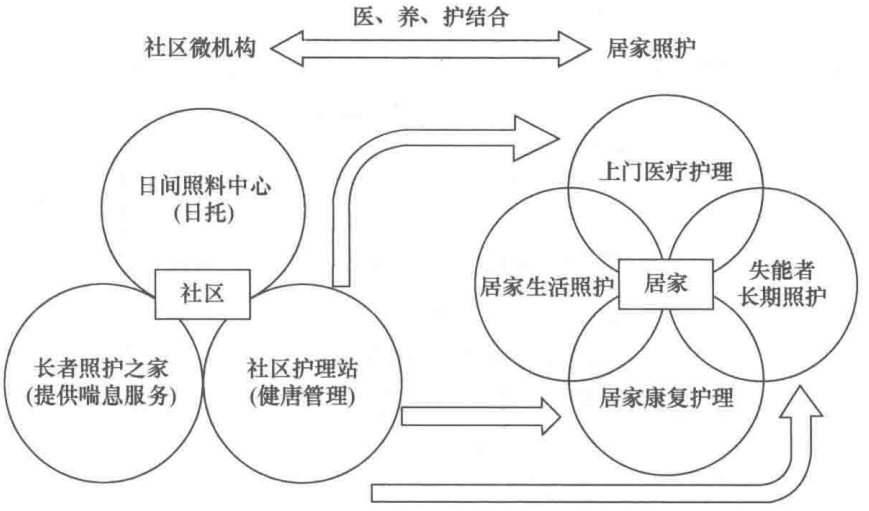


图 4-2　嵌入社区的居家健康照护机构

“整合式”养老服务体系整合社区卫生服务中心、社区养老机构、社区日间照顾体系等大多是目前已经存在于社区中的行动主体及资源，而嵌入社区的居家健康照护机构则是今后需要在社区中进一步引入完善的新型为老服务资源。此外，要注重非营利组织或社会组织在社区的培育和发展，将非营利组织引入并集成在“整合式”社区为老服务体系的行动主体网络之中，因为非营利组织具备政府和市场所不具备的组织优势，可以带动政府部门、企业部门和非营利部门形成协调合作的良好机制。

目前全国不少地方已开始尝试把类似居家健康照护机构嵌入社区，且取得了初步的成效，如上海的社区护理站、家庭照护床位等。这种服务模式的进一步推广还需要解决实践中遇到的一些问题，如居家健康照护服务的定位，是医疗护理还是生活照料？政策设计的定位一般是前者，但居家养老的失能老年人的刚性需求往往也包括后者，而如果满足后者的需求，无疑超出了医保或长期照护保险的支付范围。化解这一机制性难题，需要从进一步明确居家健康照护服务的定位出发，结合各地社区的实际情况，进行合理的政策设计与制度安排。又如，在现有由长护险支付的上门护理服务模式中，出现了护理人员与被服务家庭合谋“套保”的不良现象，服务质量的监管也难以落实到位。再如，嵌入社区的居家健康照护机构与现有体制内的社区卫生服务中心、市场化的社区家政服务公司之间如何进行角色划分、利益格局调整，以实现良性互动。此外，为实现供需匹配，居家健康照护服务如何依托养老需求评估精准对接个体化的老年照护需求；在劳动年龄人口比例及规模持续下降的背景下，居家健康照护服务机构如何加强专业人才的

吸纳与培养，实现人力资源可持续发展。这一系列问题都有待进一步探讨，以便为居家健康照护机构的社区嵌入模式的推广提供具有可操作性的解决方案。

4.4 作为社区养老服务资源链接者的老年社工

社区养老服务体系的构建和完善有赖于能够在社区层面整合各种养老服务资源、为老年人口提供政策、信息咨询和服务引导，实现资源下沉、供需匹配的养老服务管理。社工在介入社区居家养老服务管理方面具有独特的专业优势，其可以胜任资源整合和服务链接的职责。社区老年社工作为“整合式”社区养老服务的核心角色，是在社区层面整合各种养老服务资源、为老年人口提供政策、信息咨询和服务引导，实现资源下沉、供需匹配的具有社工专业资质的养老服务管理人员。

4.4.1 老年社工介入社区养老服务的必要性

政策网络理论认为，政策行为主体是构成网络的核心单元，而行动主体的数量、主体间的互动方式以及具体行为则会影响政策网络结构的特性和形态（赵德余，2017）。传统的社区为老服务模式，是各部门政策相对独立、网络结构相对松散、多元主体互动相对缺乏的碎片型政策网络，单一部门政策内部的网络结构与纵向依赖或许相对集中，但部门政策网络与其他部门政策网络之间的横向交叉互动则相对匮乏。网络中的行动主体不稳定，缺少统一的行动目标，掌握的资源与沟通渠道有限，网络整合度低，政策执行效果有限。相较于传统的碎片化的社区为老服务模式，“整合式”社区为老服务体系通过老年社工的资源链接和专业服务，有着更紧密、更频繁的行动主体互动，可调动的资源更多，服务对象老年人的需求能得到更高程度的满足。

如同家庭医生制度政策网络中处于核心位置的家庭医生一样，在社区为老服务体系中也需要有一支专业的资源整合和链接管理团队——“整合式”社区养老服务体系中的老年社工。在社区养老服务体系中，老年社工承担着重要的角色。发达国家的养老服务供给体系中，老年社工的介入是重要一环，如美国的个案管理者（case manager）和日本的福利经纪人（care manager）制度。我国香港和台湾地区也有类似的老年社会工作制度设计。

美国的个案管理者制度产生于 20 世纪 70 年代，主要针对医疗领域开展社会福利服务。根据美国个案管理协会的定义，个案管理包括评估个案的条件与需求、制订医护计划、协调各方运作、评估与监督结果、促进用户自我管理等几方面共

通的工作内容要素。个案管理者制度主要适用于医疗保健、社会工作、人性化服务等领域。在长期护理保险实施背景下个案管理者向老年照护管理（geriatric care management）领域扩展。个案管理者及相关制度的发展完善，反映了福利服务提供从全人群均等化向个案服务个性化、多样化转变的过程。个案管理者制度后来相继被许多国家借鉴并发展，被公认为是比较理想的社会福利工作制度。

日本的福利经纪人[①]制度即在美国个案管理者制度的基础上发展起来的，在内涵和外延上均有所扩展。日本的福利经纪人又称为“照护支援专门员”，是基于照护保险制度的实施照护管理（care management）的专门人员，其主要职责是对照护需求者进行评估、制订照护服务计划或照护预防计划、联络和协调服务供给机构与从业人员、跟踪监测服务实施状况和服务对象的健康状况等。根据日本照护保险制度的规定，福利经纪人的服务对象即照护保险的被保险人，包括 65 岁以上老年人（第 1 号被保险者）和 40～64 岁的医疗保险加入人员[②]（第 2 号被保险者）这两类对象[③]。在高龄化社会趋势日益显著的日本，福利经纪人的服务对象多为老年人口，其主要目的是安排不同服务提供者的养老服务最佳组合，以尽可能地延长其独立生活的时间（Tsutsui and Muramatsu，2007）。日本福利经纪人的服务领域不仅限于照护保险，还包括医疗领域、地方社会福利领域等。

美国的个案管理者制度和日本的福利经纪人制度均是在社区福利发展过程中产生并逐步成熟的，对于社区福利资源的协调、整合和供需平衡起到了重要作用。“整合式”社区养老服务体系中老年社工的引入，正是对美国的个案管理者制度和日本的福利经纪人制度在社区养老服务层面上的借鉴与扩展。

老年社工制度的引入，跟我国当前老龄化进程加速发展的宏观历史背景是分不开的，同时也是近年来我国长期服务与支持系统的现实需要以及长期护理保险试点实施的必然要求。老年社工作为社区为老服务平台的专业管理团队，将使得政府各部门落地在社区的各种为老服务资源得到有效整合与利用，是福利社区化的重要推手，将使得为老服务供给能力大幅提高、质量明显改善、结构更加合理，多层次、多样化、长期化的养老服务更加方便可及，这促进了为老服务体系的一体化、标准化、信息化、法治化和规范化。

2018 年，上海开始试点带有社区老年社工某些特征的“养老顾问”制度，北京也从 2019 年开始进行“养老顾问”制度试点。目前国内“养老顾问”的服务内容主要包括养老政策解读、养老服务资源介绍等，在发挥老年社会工作专业能力、承担包括个性化养老服务方案制订等在内的养老服务管理职能等方面还有

① 在日本照护保险法中，福利经纪人又称为“照护支援专门员”。

② 40～64 岁的对象是指患有癌症末期、关节风湿病等身体老化疾病的医疗保险被保险人。

③《介護保険制度の概要》，http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html[2020-12-28]。

待拓展。

4.4.2　老年社工的养老服务职责与服务流程

基于中国本土、服务于社区养老资源整合和供需对接的社工是一个带有前瞻性的制度设计。“整合式”社区养老服务体系中的老年社工参与的主要事务包括服务需求评测与认定、资源组织与链接、服务转介、服务监测与服务后评估、政策效果评价与反馈等。老年社工引导老年人接受“整合式”的受理评估，满足老年人的养老服务咨询、申请、服务质量投诉与建议等服务需求。老年社工将各层次社区养老服务的具体安排整合进服务对象的“个体服务计划”中，包括个体化的一站式的满足其生理和精神健康、功能性能力、社会支持、家庭环境、财政能力的各类服务，从而协助老年人及其家属得到他们可接受的、及时且合宜的服务或资源，最终达成老年人生活支持与服务的目标。老年社工链接医、养、护资源的一般服务流程如图 4-3 所示。

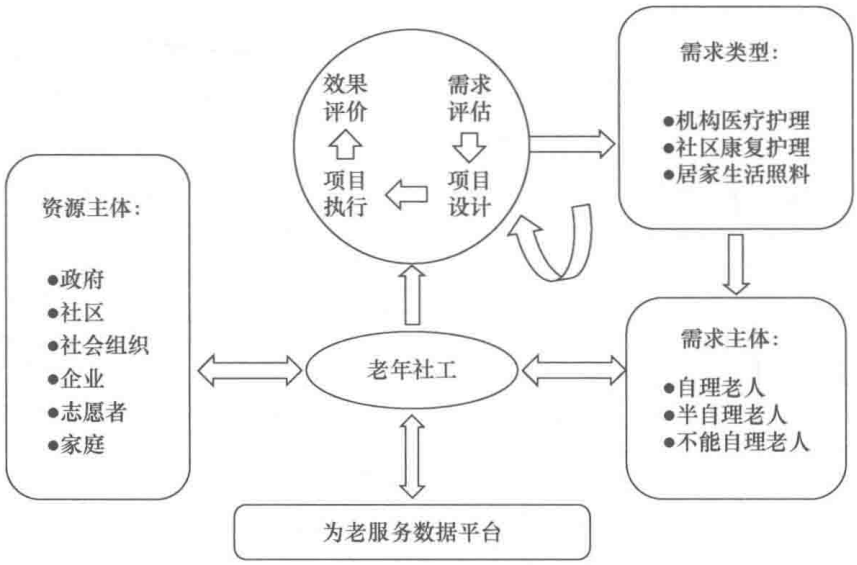


图 4-3　老年社工链接医、养、护资源的服务流程

社区养老服务体系中老年社工的角色定位至少应包括养老政策解读、需求评估与认定、资源组织与链接、供需匹配与对接、服务引导与转介、服务质量评估与反馈等；老年社工在社区居家养老服务体系中的工作机制则涉及岗位设置、责权划分、工作流程、专业技能要求及人才队伍建设等问题。

4.4.3　老年社工人才培养

老年社工是需同时具备理论与实践素养的高水平、综合性、专业化人才，在社区“整合式”养老服务体系政策网络中承担着资源整合、供需匹配的统筹角色，决定着“整合式”养老服务平台能否发挥预期效果的核心主体。老年社工应当具备为老服务相关的综合性素质与知识结构、丰富的实务经验，既熟悉养老相关的政府政策，又具备较完善的医疗知识储备。同时，老年社工还必须拥有充分的为老服务实务经验。在日本只有在医疗保健福利领域拥有五年以上实务经验，即曾经从事医生、护士、社工、照护社工等职业，且通过了相关的实务研修课程及考试的人员才能成为福利经纪人。

基于老龄社会对这一专业人才队伍的需求预测，有必要在高等教育培养体系中扩充老年社工培养方向，在专业设置与培养方向上进一步聚焦社区养老服务，培养高素质的养老服务专业管理人才。在构建社区“整合式”养老服务体系政策网络的过程中，建立并完善老年社工制度及相关人才培养配套政策是不可或缺的重要方面。

4.5　作为社区养老服务信息中枢的数据平台

社区养老服务数据平台统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的为老服务功能，整合各部门和街道的为老服务资源，实现市、区、街道、社区（村）四级信息互通、数据共享，以统一平台精准对接为老服务的供需双方，为老年人提供全方位、多层次、专业化和精准化的服务，是“整合式”社区养老服务体系构造的信息中枢与决策依据。

4.5.1　统一的数据采集与共享

社区养老服务数据平台基于微观人口信息、机构信息及服务信息，整合分散孤立的为老服务与管理的数据资源，维护一套统一的、标准的数据视图，从数据底层打通各个分散孤立的数据源，有效解决信息孤岛、数据冗余与不一致、功能碎片化问题。为基层的为老服务工作者、政府的为老服务管理者提供为老服务信息的查询、统计、评估、监管、报表生成、挖掘分析等任务。

平台依据相关标准，制定社区养老服务系统的元数据目录，在兼顾信息安全、隐私保护和高效可用的原则下，设计各级各类养老服务系统的数据共享与交换机制。在此基础上构建社区养老服务数据平台，统筹政府、社会、市场、家庭各行

动主体的养老服务资源，实现市、区、街镇、村居四级信息系统的互通互联，以统一平台精准对接养老服务的供需双方，使实现数据共享与交换的元数据库成为社区居家养老服务体系的信息中枢。

数据平台共享接入民政、卫生、人力社保、公安等各部门关于老年人户籍、医疗、社会保障等基本信息；同时，接入采集养老服务机构和养老服务社会组织基本情况、服务范围、服务项目、服务标准、日常经营情况等服务数据。平台采集和管理的基本信息包括以下几项。

（1）老年人信息，包括老年人基本信息及家庭联系人信息，老年人健康与自理能力评估信息，老年人享受惠民政策信息（如高龄补贴等）。

（2）为老服务资源信息，包括社区为老服务资源（日间照料中心、长者照护之家、护理站等）基本信息，养老机构（养老院、福利院、护理院等）基本信息及服务信息，为老服务运营机构（包括老年人健康评级机构、智能养老设备运营商等）基本信息及服务信息，政府采购为老服务包管理信息，为老服务专业人员（养老护理员等）信息，为老服务社工、志愿者信息等。

（3）养老服务信息，主要包括为老服务信息（包括长期照护服务及长护险支付等），为老服务质量评估信息等。

平台还动态采集居家养老和社区养老服务中心的科技助老设备终端（如跌倒报警器、智能定位手环、生命体征检测仪等）产生的动态数据，形成以中心–社区–居家为基础结构的养老服务信息采集共享体系，为进一步的数据挖掘和智能分析提供数据接口。

4.5.2　数据平台功能与性能设计

社区养老服务数据平台的主要功能包括养老业务管理、为老服务政策查询与待遇匹配、养老服务信息查询与统计、养老服务运营与监管、第三方评估管理、老年服务社工业务管理、科技助老设备示警数据管理、养老大数据可视化分析等。平台功能结构如图 4-4 所示。

平台的应用对象包括相关职能部门的管理和业务人员，各类养老服务机构的管理和护理服务人员，第三方评估机构的工作人员，老年人群及其家属，以及老年社工等。平台具有统一的用户权限分级管理机制，并采用包括服务器安全、数据库安全等在内的多级安全机制，保护老年人隐私。系统操作和数据更新过程将被全程记录，支持数据审计和操作回溯。

平台采用 Web 界面管理，同时支持手机 Wap、手机 App、微信 App 等接口的开发，打通系统相关消息和预警信息的移动终端推送渠道。平台将通过良好、统一、标准的应用程序接口（application program interface，API），为不同的系统

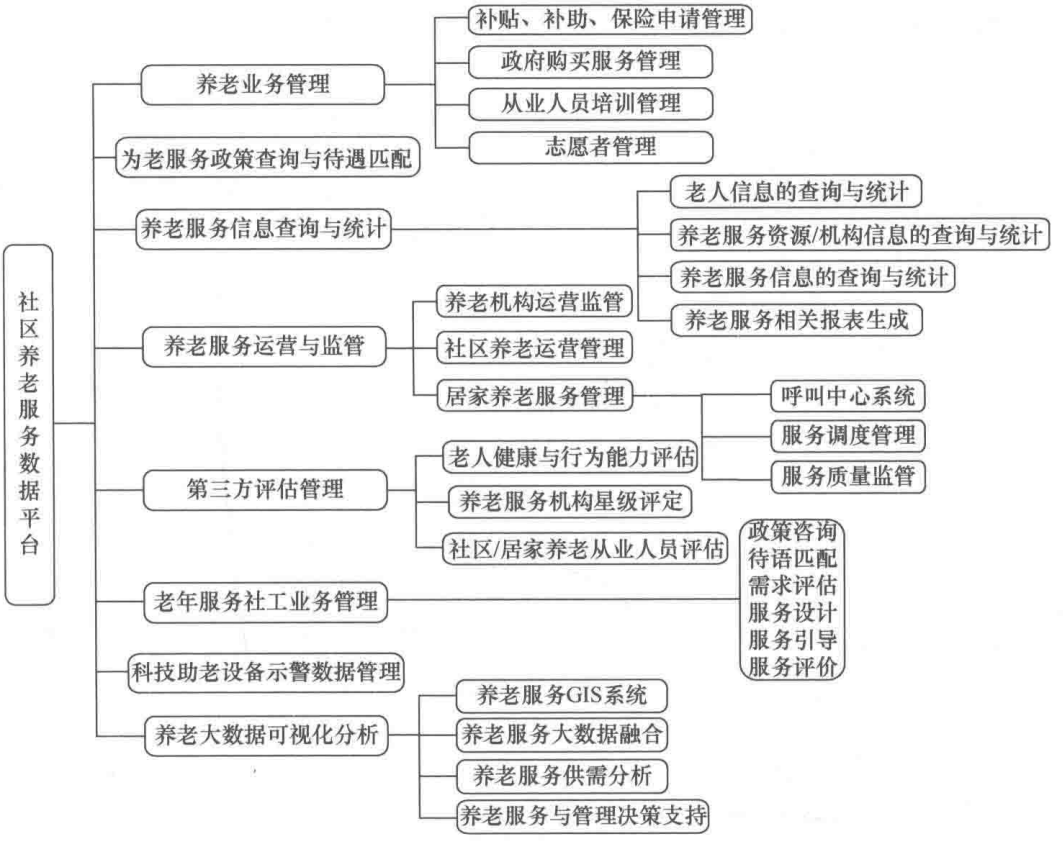


图 4-4　社区养老服务数据平台的功能结构

提供标准化的数据支持；数据字段要求粒度小、可扩展、易整合，以满足各种系统信息的切合和融合需求。

4.6　“整合式”养老服务体系的社区实践要点

“整合式”社区养老服务体系的社区实践要点包括社区养老服务基线调查、居家健康护理机构的社区嵌入、社区养老服务数据平台的信息整合、老年社工对于社区为老服务的全程导引。

（1）社区养老服务基线调查。社区养老服务基线调查主要包括养老服务资源供给与养老服务需求状况的调查。在养老供给方面包括社区养老政策措施、养老机构（包括医疗、卫生、护理等）、养老设施（长者照护之家、日间照料中心等）、养老服务提供者（专业服务公司、非营利组织、志愿者组织）等；在养老需求方面重点摸清养老需求评估等级归类，机构、社区及居家养老需求的满足程度。通过此项调查，一方面可以准确把握现状，有助于发现问题、寻找症结；另一方面，可以为项目实施一段时期后的实际效果提供对比参照。在基线调查的基础上，深

入分析试点社区养老服务供给与需求匹配程度，并提出资源整合、供需对接的解决方案。

（2）居家健康护理机构的社区嵌入。在完成对社区养老服务资源的基线调查和养老服务供需分析的基础上，引入社区综合养老服务中心运营的专业力量和社区居家健康护理机构。同时，对现有微小型托养机构的环境和设施进行适老性优化改造，同时辐射居家，有效对接社区周边居家老年人的生活照料、康复护理需求，以点带面扩大服务对象。

（3）社区养老服务数据平台的设计、开发与应用。在对现有社区各类养老服务系统的数据结构与数据来源进行分析的基础上，基于微观人口信息、机构信息及服务信息，整合分散、孤立的为老服务与管理的数据资源，设计社区养老服务数据平台的功能结构与软硬件系统，为基层养老服务工作者、政府养老服务管理者提供养老服务信息的查询、统计、评估、监管、报表生成、挖掘分析等功能。数据平台的开发一般应对接政府相关职能部门，申请获得实有人口信息数据的使用授权，基于统一的微观人口数据设计共享的数据接口和应用服务。

（4）老年社工制度的设立与运行。由于社区老年社工是一个带有前瞻性的崭新的机制设计，对于其角色定位、专业技能要求乃至收入来源等问题，无论是在理论还是在实践上，目前都处于探索阶段。作为探索的第一步，可先对现有承担养老服务的社区干部进行相关专业培训，在项目实施过程中把握时机，把老年社工制度适时导入，在实践中不断总结经验，优化改进，使“整合式”养老服务的社区实践尽快成为可持续、可复制的模式。

“整合式”社区养老服务体系构造的过程是对现有的社区存量养老资源以及围绕社区养老可以整合到体系内的各种资源以专业与非专业的标准进行整合，放大专业的力量；对于体制内资源与体制外资源通过协调合作的机制完成整合。“整合式”社区养老服务体系的作用不仅限于为社区老年人提供养老服务，更在于对老年人个人、家庭与社区之间关系的协调，对社区内的福利、医疗、卫生、保健、养老的社会资源的协调，对政府、市场、非营利社会组织等之间关系的协调。“整合式”社区养老服务的资源整合机制的研究和实践，有利于引进以社区为依托的养老服务体系建设的国际化理念和先进做法，厘清政府与市场的边界，激发市场活力和社会创造力，调动各种社会力量参与老年服务。

第 5 章　老年友好型社会的家庭政策重构

胡　湛　彭希哲

重视并支持家庭应当成为中国建设老年友好型社会乃至完善老龄社会治理的一个重点乃至特点。从某种意义上讲，家庭是最具“中国特性”的本源型传统（徐勇，2013），更是当代中国社会转型与制度变迁的历史起点和给定条件。家庭在中国不只是生产与再生产的经济单元，还是秩序单元、教化单元和福利单元，并负有社会化和保护其成员的责任。改革开放以来，中国社会经历了人口与家庭的双重变迁，稳定的低生育水平、快速的人口老龄化、剧烈的人口迁移、不断提升的城市化水平，无不冲击着当代家庭；与此同时，我国家庭变迁又内嵌于社会转型之中，转型期的中国社会赋予了家庭重要的福利与保障职责，但对家庭的支持却非常有限，家庭在整个公共政策领域中甚至曾是一个较少被提及的概念（张秀兰和徐月宾，2003）。在老龄化已成常态化的社会情境中，如何重视和支持中国家庭，使之在超越传统局限性的同时注重传统的延续性，不仅关乎老年友好型社会的构建与发展，更将直接关系到当下中国社会能否顺利完成传统与现代的历史转换。

5.1　家庭老龄化与老年人居住模式

在人口老龄已成为现代社会常态（彭希哲和胡湛，2011）的背景下，中国家庭老龄化的现象也在不断加剧，主要表现为有老年人的家庭比重上升和家庭中老年人口比重增加。尽管单老家庭户[①]（即家中有一位老年人的家庭户）仍是主流，但家庭中有多个老年人、高龄低龄老年人共存、老年空巢等现象正日趋显著，这无疑会给传统的家庭养老格局带来更多挑战，也对老年友好型社会的构建提出了更高的要求。

① 家庭户定义的核心是居住关系，即居住在同一门户里。我国人口普查对家庭户的定义为“有家庭成员关系的人口（或者还有其他人口）居住并生活在一起的作为一个家庭户；单身居住的也作为一个家庭户”。

5.1.1　老年家庭户及纯老家庭户状况

第六次全国人口普查资料显示，2010 年中国有 60 岁及以上和 65 岁及以上老年人的家庭户数量分别为 1.23 亿户和 8803.6 万户，占全部家庭户的 30.6%和 21.9%，比 2000 年有明显提升。其中，约 2/3（67.55%）的家庭户中有 1 个老年人，但有多个老年人的家庭户增长趋势明显快于有单个老年人的家庭户。值得注意的是有 3 个及以上老年人的家庭户虽然仅占有老年人口家庭户的 0.38%，但与 2000 年相比，其户数增长了 10.4 万户。此外，“纯老家庭户”（全部由老年人组成的家庭）目前也趋于增多，尤其是传统中少见的多人纯老家庭户现象凸现，且主要集中在农村地区。

从单个家庭来看，1982～2000 年的户均老年人数量稳定保持在 0.22～0.24 人，几乎没有变化，而至 2010 年陡增至 0.41 人。但与此同时，户均孩子的数量却从 1982 年的 1.48 人陡降至 2010 年的 0.51 人，平均每个家庭少了差不多 1 个孩子，如表 5-1 所示。考虑到这一期间家庭户规模的不断缩减，显然每个家庭内的老年人比重正快速上升，而孩子却越来越少，中国家庭正在经历“少子老龄化”的进程。

表 5-1　我国人口年龄结构变化与家庭户人口结构变化

年龄	人口年龄结构				户均人口规模/人			
	1982 年	1990 年	2000 年	2010 年	1982 年	1990 年	2000 年	2010 年
0～14 岁	33.6%	27.7%	22.9%	16.6%	1.48	1.10	0.79	0.51
15～64 岁	61.5%	66.7%	70.1%	70.1%	2.71	2.64	2.41	2.18
65 岁及以上	4.9%	5.6%	7.0%	13.3%	0.22	0.22	0.24	0.41
合计	100%	100%	100%	100%	4.41	3.96	3.44	3.10

资料来源：1982～2010 年全国人口普查抽样数据

不仅如此，从近几次普查资料来看，纯老家庭户大量涌现也将是中国家庭老龄化的突出特征之一。纯老家庭户是指全部由老年人组成的家庭户。随着中国老龄化进程的加剧，这一现象屡屡成为社会关注的热点，也是未来中国家庭政策的着力点之一。已有较多研究从不同角度和按不同划分标准描绘了老年家庭户的整体样貌，本节仅重点考察 60 岁及以上和 65 岁及以上纯老家庭户的状况，以期以管窥豹。

第六次全国人口普查资料显示，2010 年我国有 60 岁及以上纯老家庭户超 4500 万户，占家庭户总数的 11.60%，其中城市约 1216.5 万户，镇约 804.8 万户，乡约 2510.1 万户。我国有 65 岁及以上纯老家庭户超 3100 万户，占家庭户总数的 8.13%，

其中城市约占 27.11%、建制镇约占 17.75%、农村约占 55.14%。纯老家庭户分大区[①]、分城镇乡的分布情况如表 5-2 所示，可以发现，城镇乡 65 岁及以上纯老家庭户户数在各大区中占对应 60 岁及以上纯老家庭户户数的比重均超过 60%。我们还考察了户主年龄分布，城乡的峰值均在 65～74 岁年龄组，但 32.8%的农村纯老家庭户户主（65 岁及以上）仍处于工作状态，城市则仅有 4.1%的户主仍在工作。农村的外出务工者以中青年为主体，而他们留在农村的父母则有相当一部分还在从事农耕活动。

表 5-2　2010 年全国纯老家庭户的分布情况（单位：万户）

地区	60 岁及以上纯老家庭			65 岁及以上纯老家庭		
	城市	镇	乡	城市	镇	乡
华北	191.9	100.6	288.0	135.3	67.1	188.9
东北	203.0	75.2	154.9	142.6	49.3	96.0
华东	423.3	306.9	890.2	300.1	218.0	642.2
中南	218.6	164.2	599.1	156.0	116.0	432.8
西南	105.5	118.4	469.4	73.7	84.4	323.2
西北	74.2	39.5	108.5	53.6	28.9	68.5

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

两类不同年龄划分标准的纯老家庭户在各大区间差异显著，在城镇乡三个层面上，华东地区和中南地区的纯老家庭户户数都高于其他地区。西南地区乡一级的纯老家庭户数量占西南地区所有纯老家庭户的比例高于其他地区。西北地区在各个行政级别上的纯老家庭户户数都是六大区中最少的。

如图 5-1 所示，根据纯老家庭户占其所在地区家庭户总数的比重绘制堆积柱形图，以观察纯老家庭户的城镇乡分布差异。不难看出，农村地区纯老家庭户占农村家庭户总数的比重略高于城市和镇，这与我国快速的城镇化进程密切相关，未来对农村留守老年人的关怀需不断强化。

纯老家庭户户主的年龄分布情况如图 5-2 所示。城市、镇、乡的峰值均在 65～74 岁年龄组，城市地区较乡镇地区峰值有所延后，以 60 岁及以上纯老家庭户户主为例，前者最高峰在 70～74 岁，而后者最高峰在 65～69 岁。

① 如无特殊说明，本书中所指的六大区分别为华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区、西北地区。其中，华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁；华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、山东、江西、福建；中南地区包括河南、湖北、湖南、广东、广西、海南；西南地区包括重庆、四川、贵州、云南、西藏；西北地区包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

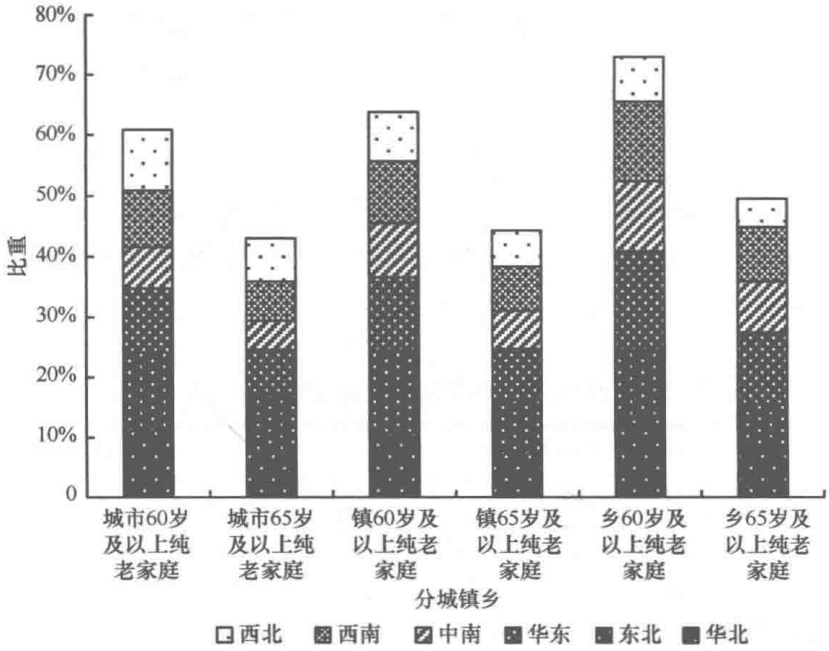
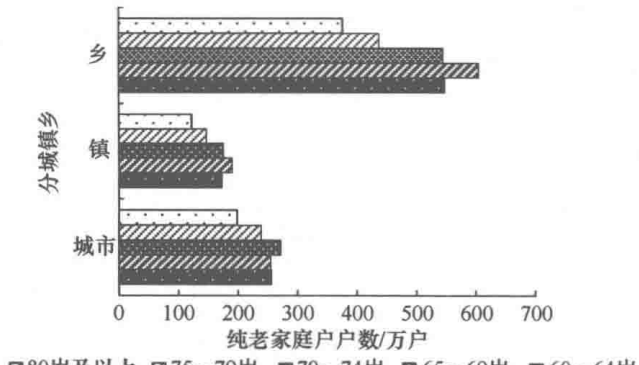
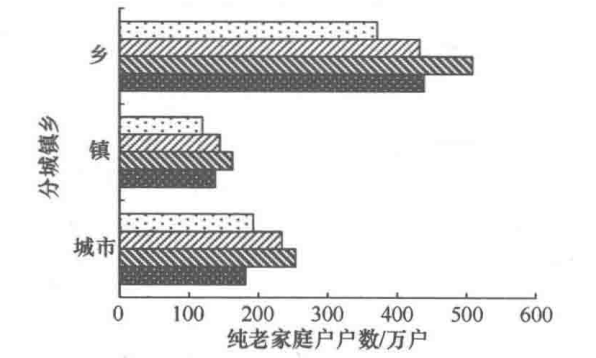


图 5-1　分大区、分城镇乡的纯老家庭户比重分布

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据



(a) 60岁及以上



(b) 65岁及以上

图 5-2　纯老家庭户户主的年龄结构

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

纯老家庭户户主的工作情况如图 5-3 所示。我们将普查长表中“工作情况”项填写“未做任何工作”（未工作）之外的受访者均计为“处于工作状态”（休假、工作），则城市分别有 7.98%（60 岁及以上）和 4.11%（65 岁及以上）的纯老家庭的户主仍然处于工作状态，镇分别为 23.56%（60 岁及以上）和 15.84%（65 岁及以上），乡分别为 44.39%（60 岁及以上）和 32.78%（65 岁及以上），城镇乡间存在显著差异。

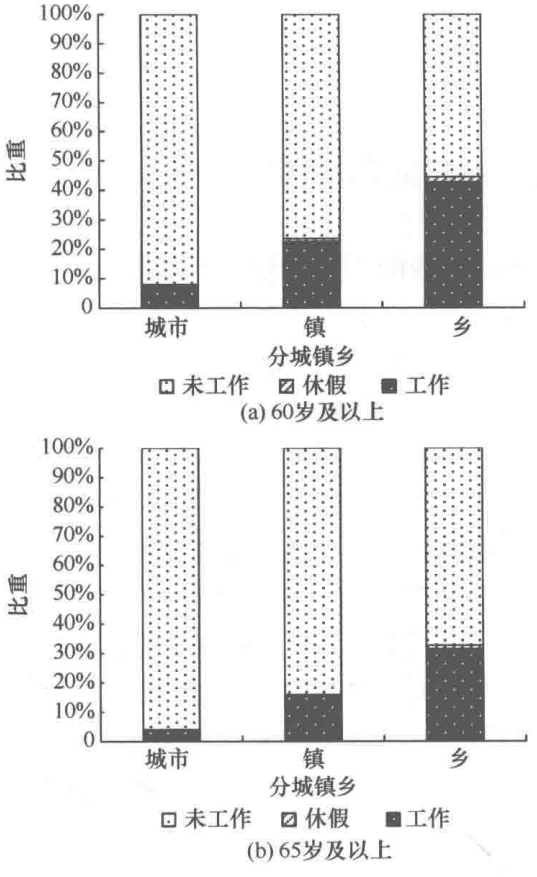


图 5-3　纯老家庭户户主的工作情况

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

此外，有两类纯老家庭户特别需要关注。一是低龄老年人与高龄老年人组成的二代纯老家庭户（一般是低龄老年人与自己的高龄父母同住），二是老年人与兄弟姐妹同住的一代纯老家庭户以及老年人与配偶及兄弟姐妹一起居住的 3 人及以上的一代纯老家庭户。这些家庭户中的老年人很多都是膝下无子或者子女常年工作在外，特别需要政府予以关注。以后者为例，老年人与兄弟姐妹同住的一代纯老家庭户在我国约有 14.9 万户，其中约有 10.8 万户集中在农村地区。更有老年人与配偶及兄弟姐妹一起居住的 3 人及以上的一代纯老家庭户约 3.6 万户，其中 2.8 万户在农村。农村地区的纯老家庭问题更显严峻。

不难看出，随着家庭老龄化的深化，传统的家庭养老模式正以新的形式继续发展，当生育资源所转化出的养老资源日渐稀释，而相关的社会保障又远未完善，老年夫妇、老年人与同龄兄弟姐妹、低龄老年人和自己的高龄父母选择生活在一起相互扶持。这意味着中国家庭在制度不健全的情况下不得不以这样或那样的方式竭力为家庭成员提供保障并帮助其抵御风险，但在生育率持续走低、人口老龄化加速、人口迁移流动加剧的背景下，这样的纯老家庭很可能会越来越多，并越来越难以应对中国转型过程中所产生的各项结构性冲击，未来的家庭政策无疑需要对此特别关注。

5.1.2　对老年人居住安排的基本判定

随着中国人口老龄化进程的不断深化，有老年人的家庭正在不断增多，2010年已有超过五分之一的家庭中至少有1位65岁及以上的老年人。与此同时，目前我国养老保障的覆盖广度和支持力度都仍然极为有限，这意味着相当多的老年人在不能工作时必须依靠自己的积蓄或其他家庭成员获得支持。不仅如此，那些高龄老年人更需要大量的日常生活照料，而目前这些照料服务或直接或间接地大多来自他们的家庭成员。在这样的背景下，识别老年人的居住安排模式，并厘清其发展趋势，将成为未来家庭政策和养老政策安排的决策基础之一。

第六次全国人口普查资料揭示了有关老年人口居住安排的若干情况。在65岁及以上人口中，老年人与子女（包括孙子女）同住的现象仍十分普遍，为57%以上，而老年人单独生活的比重大幅提升至41%以上。相比而言，在80岁及以上人口中，老年人独立生活的比例显著降低，但仍达34%以上，尤其是高龄独居老年人的比例达到了17.5%，如表5-3所示。不仅如此，从老年人所在的家庭结构类型来看，老年家庭在一代户、二代户和扩展户中的比例大致为4∶2∶4，呈哑铃形分布。

表5-3　我国老年人的居住安排模式

居住安排模式	1982年	1990年	2000年		2010年	
	65岁及以上	65岁及以上	65岁及以上	80岁及以上	65岁及以上	80岁及以上
独居老年人	12.4%	9.9%	9.6%	12.6%	12.5%	17.5%
老年夫妇（一代核心户）	13.5%	17.0%	23.8%	10.0%	29.3%	16.8%
老年夫妇与未婚子女（标准核心户）	6.9%	6.6%	5.0%	1.7%	3.6%	1.7%
单个老年人与未婚子女（缺损核心户）	4.6%	3.8%	3.2%	4.6%	2.2%	3.1%

续表

居住安排模式	1982 年	1990 年	2000 年		2010 年	
	65 岁及以上	65 岁及以上	65 岁及以上	80 岁及以上	65 岁及以上	80 岁及以上
其他二代核心户（扩大核心户等）	3.4%	2.7%	2.3%	2.1%	2.8%	2.0%
老年人与已婚子女（二代直系户）	3.5%	3.6%	5.2%	12.8%	6.9%	13.6%
老年人与孙子女（隔代户）	3.8%	3.6%	5.2%	6.2%	5.6%	5.0%
老年人与子女及孙子女（三代直系户）	47.2%	47.4%	41.4%	38.3%	32.8%	30.0%
其他扩展家庭户	3.8%	4.8%	3.6%	11.1%	3.2%	8.4%
独老和老年夫妇小计	25.9%	26.9%	33.4%	22.6%	41.8%	34.3%
老年人与子女同住小计	73.2%	72.5%	62.3%	76.8%	57.1%	63.8%

资料来源：1982～2010 年全国人口普查抽样数据

1. 与子女同住比重降幅明显，高龄老年人尤甚

来自家庭内部的代际支持仍是我国老年人保障和照料的主要来源，大部分老年人也都与他们的子女同住（包括孙子女）。1990 年老年人（65 岁及以上）与子女同住的比重同 1982 年相比变化非常小，但是 2000 年和 2010 年老年人与子女同住的比重则相继下滑了约 10 个百分点和 5 个百分点。从 2000 年到 2010 年，80 岁及以上高龄老年人与子女同住的比重分别为 76.8%和 63.8%，其中 2000 年的比重与 1982 年和 1990 年相比保持了相对稳定，但至 2010 年却骤降 13 个百分点。这一结果表明，老年父母与成年子女同住的传统家庭居住模式自 20 世纪 90 年代以来持续弱化，这一方面可能是由于较年轻和健康的老年人或老年夫妇倾向于自己单独居住，第六次全国人口普查资料显示 65～79 岁的低龄老年人中超过九成基本健康并具有生活自理能力，相对降低了他们对子女照料的依赖性；另一方面可能是由于子女因成家或工作而产生的迁移。

此外，第六次全国人口普查资料还显示，在单个老年人与子女同住的家庭户中，子女为户主的情况超过 70%，这一现象在农村尤为明显，老年人为户主的情况仅为 7.35%。在有老年人的标准核心家庭户和二代直系家庭户中，子女为户主的情况尽管只有 23.4%，但已大大高于 20 年前的比例。尽管户主的选定常常出于偶然或是一些现实考虑，但这仍能从一个侧面说明老年人在家庭中的地位可能正在趋于弱化，对于独身老年人更是如此。大量的个案研究与社会调查认为，老年人在家庭中权威的减弱似乎并未导致中国现代家庭养老方式的重大变化，无论是

住在一起还是分开居住，中国的老年人仍与他们的成年子女保持着频繁的交互关系（Whyte，2005），但在微观上却具有越来越大的随意性（邬沧萍，1999），以至于探望老年人这一基本的家庭代际交往都必须通过法律来加以规范，一些无视老年人需求、虐待老年人的现象更时有发生。

2. 独立居住比重大幅提高，“多代同堂”模式不再绝对主导

尽管与子女同住仍是老年人居住安排的最主要类型，但其比例在1990～2010年持续降低，尤其是“三代或四代同堂”的比重在2000年首次降到了半数以下，至2010年更降到了四成左右，不再是绝对主导的老年人居住安排模式。与之相对应，老年人独立生活的家庭户比重却在持续提高，2010年已超过四成。其中，老年夫妇家庭户的比例在1990～2010年提升了72.3%，是增幅最快的老年人居住类型。究其原因，一方面是越来越多的老年人倾向于独立生活；另一方面可能是由于其子女的迁移流动，这也同时导致了老年人与子女同住的比重大幅下降，特别是低龄老年人。总的来说，老年人独立居住模式和传统意味强烈的“多代同堂”模式已开始并列成为我国当前老年人居住安排的两大类型。

此外，80岁及以上高龄老年人的居住安排还表现出自有的一些特征。目前来看，80岁已经超过了我国人口的平均预期寿命，所以在这一群体中丧偶的现象较多，因此高龄老年夫妇仍住在一起的家庭户比重比低龄老年夫妇要低很多。高龄独居老年人的比重在2000年和2010年却都明显高于低龄独居老年人。与低龄老年人家庭及老年夫妇家庭相比，相当一部分高龄独居老年人的健康状况欠佳，他们不仅没有子女在身边，而且失去了配偶的相互扶持、照料，很容易成为“无人问津”的群体，他们是老年人中最需要社会关注的对象。老年人独居现象的不断增长，一方面原因是住房条件改善，从物质条件上使独居更为可能；另一方面原因是计划生育导致少子化严重，减少了家庭人口；同时，工作流动的加快，子女外出求学、务工现象也越来越多，这些因素也都加剧了独居现象。“独居老年人”问题已不仅是个人问题、家庭问题，而将成为一个亟待解决的社会政策命题。

3. 老年人居住安排模式存在性别和城乡差异

从数据上来看，女性老年人比男性更倾向于与子女同住，而且这种性别差异从2000年开始明显增大。这是因为女性老年人的预期寿命较长而更可能处于丧偶状态，以及相当一部分女性老年人在经济上有更大的依赖性。当然，她们也可能是应已婚子女的请求而与其同住以便于照料孙子女。老年女性丧偶率高也使其独居比例持续提高。

无论城乡，老年人独立居住和与已婚子女（以及孙子女）同住都是最主要的

居住类型。但相对来讲，城市老年人独立居住以及在核心家庭生活的比例明显更多。老年人独立居住的情况增多，意味着更多社会财富和公共资源需要被配置到与养老相关的领域中去，中国现有养老金制度和服务体系的完善、公共医疗卫生资源的供给都将经受严峻的考验。随着中国家庭模式的变迁和老龄化进程的加速，老年人的服务与护理已经由过去家庭承担的事务演变成现在必须正视的社会问题，而我们的社会却还没有做出及时的反应。截至 2009 年底全国各类养老机构 38 060 个，共有床位 266.2 万张，占全国老年人口总数的 1.5%，远低于发达国家 5%～7%的标准，也未达到一般发展中国家（如巴西、罗马尼亚等）2%～3%的水平（张恺悌等，2010）。与之相对应，2008 年底全国老年人口中仅失能老年人口即已达到 1400 万人，并预计在 2050 年后超过 3800 万人，此一项便显现出我国老年服务供给与需求之间的严重失衡（戴卫东，2011）。如何在居家养老的基础上建立形式多样、城乡统筹的养老服务体系，有序增加老年服务资源的供给，并合理控制公共服务费用的支出，已经迫在眉睫。

5.1.3　几类老年人居住模式的主要特征

以下以 2010 年第六次全国人口普查资料为主，并结合 1982～2000 年的三次普查数据，对当前老年人家庭户的居住安排模式予以具体分析。

1. 定义及分析框架

我们将老年人家庭户的居住模式分为独居老年人、与其他人居住的独老家庭、有子女的单老家庭、有子女的老年夫妇家庭、老年夫妇家庭和与其他人居住的老年夫妇家庭六大类。独居老年人指只有老年户主一人独居生活所形成的家庭；与其他人居住的独老家庭指只有老年户主一人与其他人共同生活所形成的家庭；有子女的单老家庭指只有一个老年人与子女共同生活所形成的家庭；有子女的老年夫妇家庭指由老年夫妻二人与子女共同生活所形成的家庭；老年夫妇家庭指只有夫妻二人组成的家庭，夫妻中至少一人年龄超过 60 岁；与其他人居住的老年夫妇家庭指由夫妻二人及其他人组成的家庭，无子女，如图 5-4、表 5-4～表 5-6 所示。

在上述六大类的基础上，本节还进一步将这六大类合并为三类，分别为老年人或老年夫妇独立居住的家庭[①]、老年父母与子女共同居住的家庭[②]和老年人与其

① 老年人或老年夫妇独立居住的家庭包含独居老年人和老年夫妇家庭。

② 老年父母与子女共同居住的家庭包含有子女的单老家庭和有子女的老年夫妇家庭。

他家庭成员同住的家庭[①]。其中，老年人或老年夫妇独立居住的家庭这一指标不仅能反映老年人的养老问题，且能体现出“空巢”家庭被社会的接受程度；同时，另一指标老年父母与子女共同居住的家庭则能充分反映当前中国社会的代际互动与支持关系，研究普遍认为，同住的模式对于代际财富转移也具有重要影响。此外，本节还将 80 岁及以上老年人口定义为高龄老年人，应对其予以特别关注。

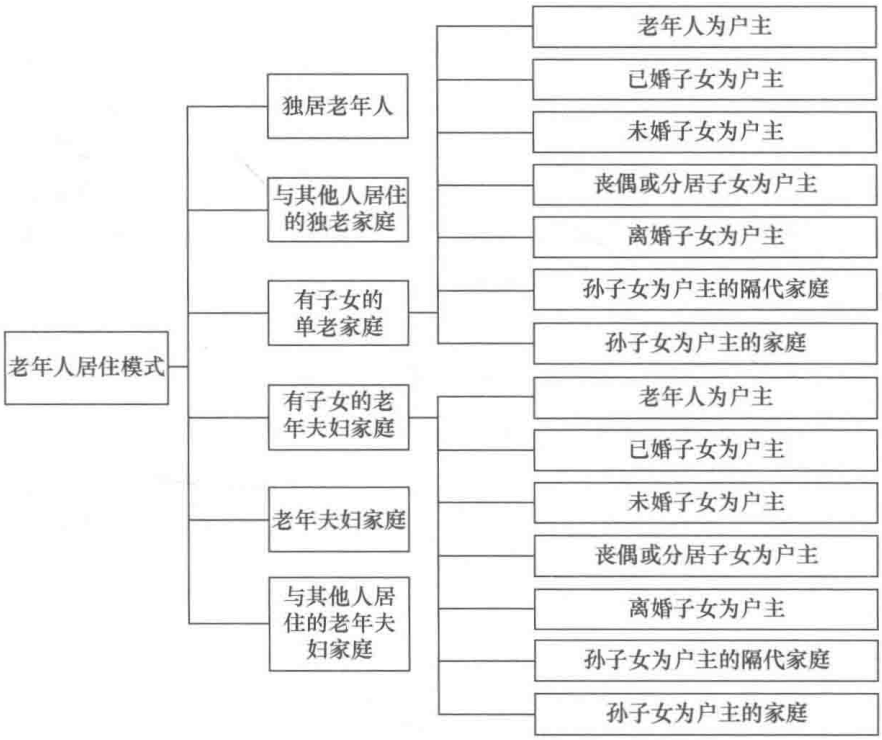


图 5-4　老年人居住模式

表 5-4　老年人居住模式分类（一级分类）

居住模式	解释
独居老年人	只有老年户主一人独居生活所形成的家庭
老年夫妇家庭	只有夫妻二人组成的家庭，夫妻中至少一人年龄超过 60 岁
与其他人居住的老年夫妇家庭	由夫妻二人及其他人组成的家庭，无子女
有子女的单老家庭	只有一个老年人与子女共同生活所形成的家庭
有子女的老年夫妇家庭	由老年夫妻二人与子女共同生活所形成的家庭
与其他人居住的独老家庭	只有老年户主一人与其他人共同生活所形成的家庭

① 老年人与其他家庭成员同住的家庭包含与其他人居住的独老家庭和与其他人居住的老年夫妇家庭。

表 5-5　有子女的单老家庭分类（二级分类）

分类		解释
有子女的单老家庭	老年人为户主	户主同子女媳婿组成的家庭，户主年龄≥60 岁
	已婚子女为户主	子女为户主，与其（岳）父母或公婆组成的家庭，父辈至少一方无配偶，且父辈年龄≥60 岁
	未婚子女为户主	子女为户主但未婚，与其父亲或母亲组成的家庭，父亲或母亲年龄≥60 岁
	丧偶或分居子女为户主	子女为户主且丧偶，与其（岳）父母或公婆组成的家庭，父辈至少一方丧偶，且父辈年龄≥60 岁
	离婚子女为户主	子女为户主但离婚，与其父亲或母亲组成的家庭，父亲或母亲年龄≥60 岁
	孙子女为户主的隔代家庭	孙子女为户主，与祖父或祖母组成的家庭，祖辈无配偶，且祖辈年龄≥60 岁
		孙子女为户主但离婚、丧偶或分居，与祖父或祖母组成的家庭，祖辈年龄≥60 岁
	孙子女为户主的家庭	孙子女为户主，与祖父或祖母及（岳）父母或公婆组成的家庭，祖辈无配偶，且祖辈年龄≥60 岁
		孙子女为户主但离婚、丧偶或分居，与祖父或祖母及父母组成的家庭，祖辈年龄≥60 岁

表 5-6　有子女的老年夫妇家庭分类（二级分类）

分类		解释
有子女的老年夫妇家庭	老年人为户主	户主与配偶同子女媳婿组成的家庭，户主年龄≥60 岁
	已婚子女为户主	子女为户主，与其（岳）父母或公婆组成的家庭，父辈至少一方完整，父辈年龄≥60 岁
	未婚子女为户主	子女为户主但未婚，与其父母组成的家庭，父亲或母亲年龄≥60 岁
	丧偶或分居子女为户主	子女为户主且丧偶，与其（岳）父母或公婆组成的家庭，父辈年龄≥60 岁
	离婚子女为户主	子女为户主但离婚，与其父母组成的家庭，父亲或母亲年龄≥60 岁
	孙子女为户主的隔代家庭	孙子女为户主，与祖父母组成的家庭，祖父或祖母年龄≥60 岁
		孙子女为户主但离婚、丧偶或分居，与祖父母组成的家庭，祖父或祖母年龄≥60 岁
	孙子女为户主的家庭	孙子女为户主，与祖父母及（岳）父母或公婆组成的家庭，祖父或祖母年龄≥60 岁
		孙子女为户主但离婚、丧偶或分居，与祖父母及父母组成的家庭，祖父或祖母年龄≥60 岁

从数据来看，在我国老年人的六大类居住安排中，有子女的单老家庭所占比例最高，为 21.26%，独居老年人比例最低，为 11.56%。分城镇乡的老年人居住安排存在较大差异，在城市和乡，有子女的单老家庭所占比例最高，分别为 22.21% 和 28.06%，而镇中则是与其他人居住的独老家庭占比最大，为 27.86%；城市、镇中比例最小的居住安排均为独居老年人（城市 10.05%、镇 7.92%），乡则是与其他人居住的独老家庭比例最小（3.71%）。具体如图 5-5、表 5-7 所示。

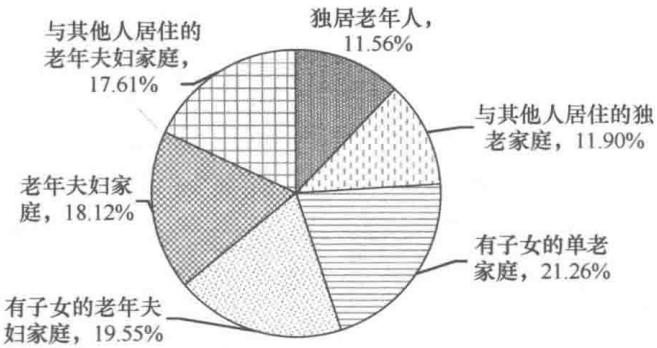


图 5-5　2010 年全国 60 岁及以上老年人的居住安排

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

表 5-7　2010 年全国分城镇乡的 60 岁及以上老年人居住安排

老年人居住模式	全国	城市	镇	乡
独居老年人	11.56%	10.05%	7.92%	12.41%
有子女的单老家庭	21.26%	22.21%	25.57%	28.06%
与其他人居住的独老家庭	11.90%	10.42%	27.86%	3.71%
老年夫妇家庭	18.12%	18.93%	12.77%	17.74%
有子女的老年夫妇家庭	19.55%	19.61%	13.25%	21.13%
与其他人居住的老年夫妇家庭	17.61%	18.79%	12.63%	16.95%

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

80 岁及以上高龄老年人的居住安排与平均情况表现出相当大的差异。首先，由于 80 岁已经超过了当前中国人的平均预期寿命，所以在这一群体中丧偶的现象较多，因此老年夫妇仍住在一起的家庭仅占到 11.71%，大部分家庭中的老年人已经不与配偶一同居住。其次，与 60 岁及以上老年人口形成鲜明对比的是，独居老年人所占的比例超过一半，高达 53.86%。有子女的单老家庭成为第二大居住模式，占到 30.21%。高龄老年人居住安排中的城镇乡差异也十分显著。城市中的独居老年人现象尤为明显，该群体占到全部高龄家庭的 68.07%，而有子女的单老家庭

在城市中仅占到 17.64%，大大低于全国平均水平。具体如图 5-6、表 5-8 所示。

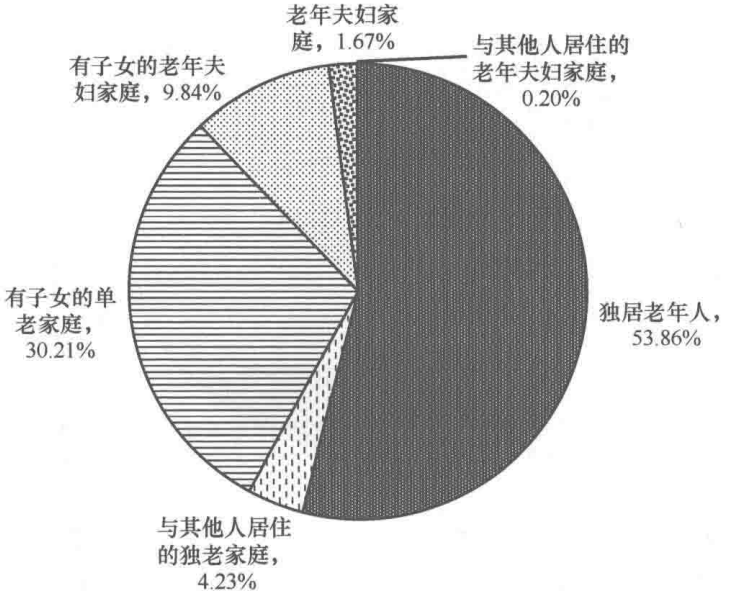


图 5-6　2010 年全国 80 岁及以上老年人居住安排

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

图中数据进行过修约，合计不等于 100%

表 5-8　2010 年全国分城镇乡的 80 岁及以上老年人居住安排

老年人居住模式	全国	城市	镇	乡
独居老年人	53.86%	68.07%	44.63%	55.61%
有子女的单老家庭	30.21%	17.64%	38.28%	28.90%
与其他人居住的独老家庭	4.23%	3.51%	4.67%	4.23%
老年夫妇家庭	1.67%	1.76%	1.68%	1.50%
有子女的老年夫妇家庭	9.84%	8.89%	10.69%	9.01%
与其他人居住的老年夫妇家庭	0.20%	0.13%	0.04%	0.75%

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

若按三大类来看，2010 年我国 60 岁及以上老年人或老年夫妇独立居住的家庭的比例为 29.68%，老年父母与子女共同居住的家庭的比例为 40.81%，老年人与其他家庭成员同住的家庭占到 29.51%，如图 5-7 所示。与此相对应，在 80 岁及以上的高龄群体中，老年父母与子女共同居住的家庭占到 40.05%，老年人或老年夫妇独立居住的家庭则显著增加到 55.53%，老年人与其他家庭成员同住的家庭仅占到 4.42%，如图 5-8 所示。

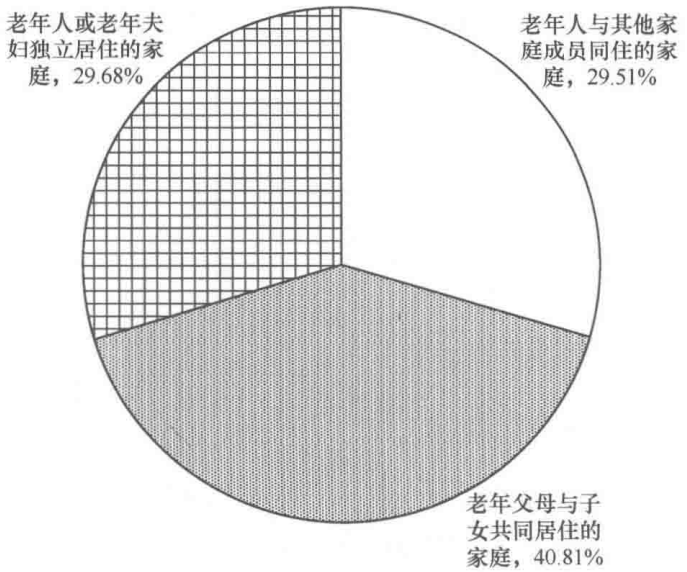


图 5-7　2010 年全国 60 岁及以上老年人的居住安排（三类分法）

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

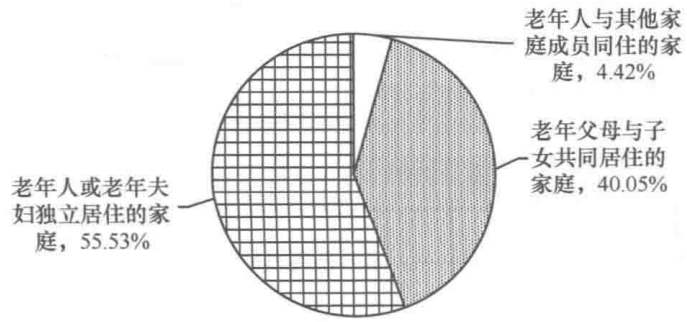


图 5-8　2010 年全国 80 岁及以上老年人的居住安排（三类分法）

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

分地区来看，全国各大区老年人居住模式的分布情况大致相同。独居老年人在各大区所占比例均为最低，全国平均仅 11.56%，这说明传统的家庭供养仍是中国老年人的主要生活来源，老年人与其他家庭成员同住比例较高。在华北、东北和华东地区，老年夫妇家庭所占比例最高，分别为 20.94%、22.59%和 20.07%；在中南、西南地区，有子女的单老家庭占比最高，分别为 25.25%和 23.92%；西北地区有子女的老年夫妇家庭占比最高，为 25.90%，如表 5-9 所示。这种从东到西的分布变化或多或少能反映出一些地区的社会文化差异。另外，全国各地区在 80 岁及以上高龄人口中，西北地区的独居老年人的比例最小，仅为 47.31%，不足一半，而该地区有子女的单老家庭、有子女的老年夫妇家庭合计达到 49.38%，为全国各地区最高，这反映了西北地区对于传统家庭养老的重视。而华北、东北、华东等东部地区则普遍表现出相反的趋势，这些地区独居老年人所占比例分别达

到 56.47%、58.64%、55.07%，均超过全国平均水平，如表 5-10 所示。

表 5-9　2010 年全国及各地区 60 岁及以上老年人居住安排

老年人居住模式	全国	华北	东北	华东	中南	西南	西北
独居老年人	11.56%	10.93%	10.06%	12.27%	11.24%	12.75%	9.25%
有子女的单老家庭	21.26%	18.09%	16.85%	18.49%	25.25%	23.92%	25.13%
与其他人居住的独老家庭	11.90%	11.28%	10.33%	12.58%	11.64%	13.14%	9.54%
老年夫妇家庭	18.12%	20.94%	22.59%	20.07%	14.64%	16.10%	15.43%
有子女的老年夫妇家庭	19.55%	18.19%	17.89%	16.99%	23.06%	18.82%	25.90%
与其他人居住的老年夫妇家庭	17.61%	20.58%	22.28%	19.61%	14.17%	15.27%	14.76%

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

表 5-10　2010 年全国各地区 80 岁及以上老年人居住安排

老年人居住模式	全国	华北	东北	华东	中南	西南	西北
独居老年人	53.86%	56.47%	58.64%	55.07%	52.67%	51.82%	47.31%
有子女的单老家庭	30.21%	27.79%	26.06%	27.78%	32.23%	32.37%	34.63%
与其他人居住的独老家庭	4.23%	4.43%	3.84%	5.64%	3.59%	3.46%	2.13%
老年夫妇家庭	1.67%	1.85%	2.09%	2.32%	1.26%	1.22%	0.71%
有子女的老年夫妇家庭	9.84%	9.12%	9.12%	8.74%	9.77%	10.67%	14.75%
与其他人居住的老年夫妇家庭	0.20%	0.34%	0.24%	0.46%	0.48%	0.47%	0.47%

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

总的来说，目前中国家庭内部的代际支持仍是老年保障和照料的主要来源，大部分老年人也都与他们的子女同住（包括孙子女）。1990 年与子女同住的低龄老年人（65～79 岁）和高龄老年人（80 岁及以上）的比例与 1982 年比较几乎没有变化或变化非常小，但是 2000 年男性低龄老年人和女性低龄老年人与子女同住的比例比 1990 年分别下降了 12.7%和 8.8%。2010 年，80 岁及以上高龄老年人与子女同住的比例为 63.8%，65 岁及以上老年人与子女同住的比例为 57.1%。这一结果表明，老年父母与成年子女同住的传统家庭结构比例自 20 世纪 90 年代以来持续下降。这一方面可能是由于较年轻和健康的老年人倾向于自己单独居住，另一方面可能是由于更多的子女因为工作而迁移到外地。

2. 老年人与子女同住的家庭户

第六次全国人口普查资料显示，在有子女的单老家庭中，子女为户主的家庭占 71.75%，老年人为户主的家庭占 28.25%。这一现象在乡一级别尤为明显，老年人为户主的家庭所占比例仅为 7.35%，大大低于镇的 47.39%和城市的 36.24%，如图 5-9 所示。而在有子女的老年夫妇家庭中，子女为户主的家庭占 23.35%，老年人为户主的家庭占 76.65%，如图 5-10 所示。尽管户主的选定常常出于偶然或是一些现实考虑，但这仍能从一个侧面说明老年人在家庭中的地位正在逐渐弱化，对于独身老年人更是如此。

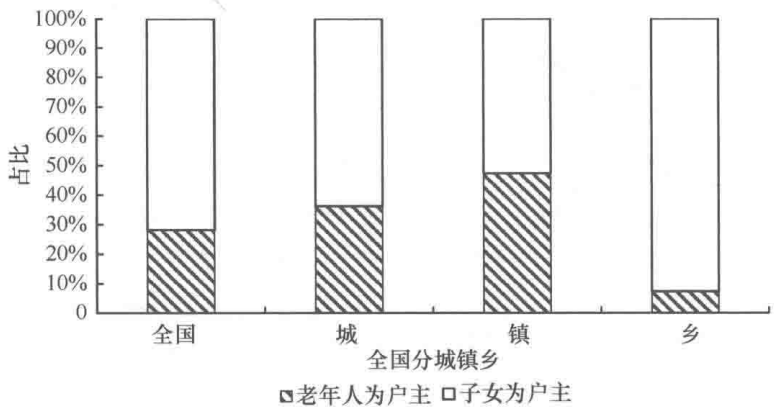


图 5-9　有子女的单老家庭的户主模式

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

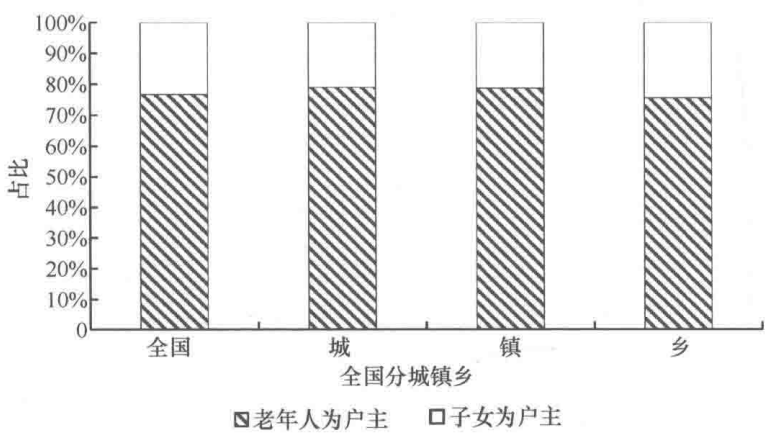


图 5-10　有子女的老年夫妇家庭的户主模式

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

在子女为户主的这一部分家庭中，有子女的单老家庭绝大部分的子女户主为已婚，其比例达到 86.92%，未婚子女、分居子女、离婚子女和孙子女为户主的比例分别为 5.73%、2.69%、2.28%和 2.38%；有子女的老年夫妇家庭情况类似，89.69%的

子女户主为已婚，5.85%的子女户主未婚。但农村地区未婚子女作为有子女的老年夫妇家庭的户主情况较多，占到子女为户主的 17.47%，大大超过全国及城镇平均水平。

3. 老年人与配偶同住的家庭户

第六次全国人口普查资料显示，2010 年我国 60 岁及以上与配偶共同居住的老年人家庭大约有 3166.6 万户。80 岁及以上与配偶共同居住的老年人家庭，约有 165.4 万户，其中乡约 26.3 万户。同时，不同年龄段的此类老年人家庭在城乡分布上表现出较大的差异，农村低龄老年人（60～79 岁）中与配偶共同居住的比例最高，为 54.03%，而高龄老年人中与配偶共同居住的老年人家庭所在地主要为城镇，农村的该类家庭仅占 15.90%，如图 5-11 所示。

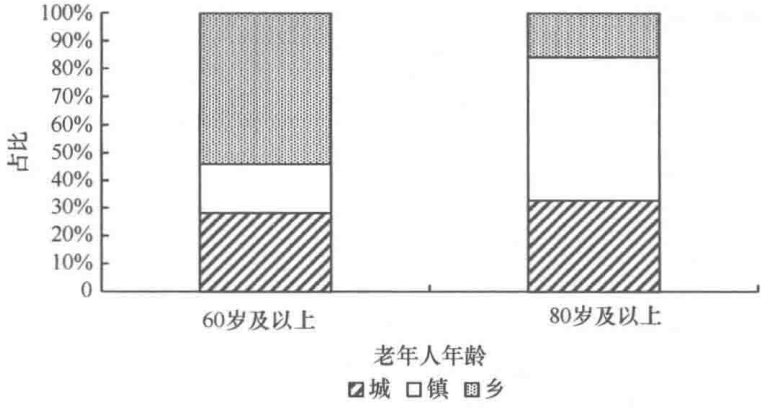


图 5-11　与配偶共同居住的老年人家庭的城镇乡分布

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

从地区分布上来看，华东地区 60 岁及以上与配偶共同居住的老年人家庭高达 1133.7 万户，80 岁及以上与配偶共同居住的老年人家庭也有 71.3 万户，其比例在六大区中最高，西北地区则最低（图 5-12）。

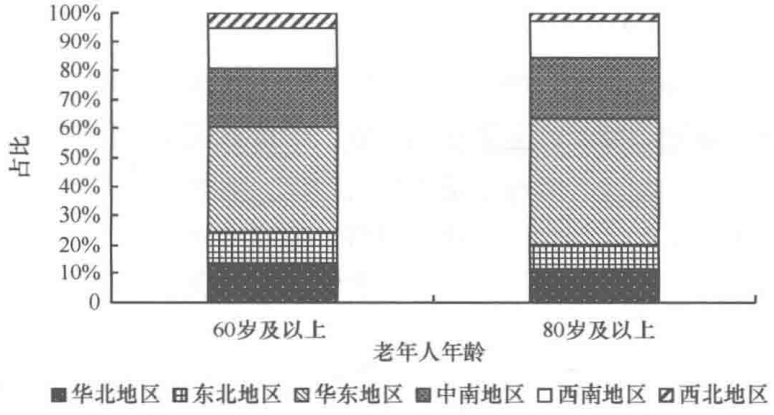


图 5-12　与配偶共同居住的老年人家庭的区域分布

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

4. 独居老年人家庭户

第六次全国人口普查资料显示，2010 年我国 60 岁及以上的独居老年人约有 1900.1 万人，65 岁及以上的独居老年人约有 1529.1 万人，80 岁及以上的独居老年人约有 418.4 万人（表 5-11）。不同年龄段独居老年人在城镇乡的分布类似，总的来说，镇的独居老年人比例最高，为 58%，城市的独居老年人大约占到 24%，而农村的独居老年人仅占 18%，如表 5-10 所示。从地区分布上来看，华东地区 60 岁及以上独居老年人约有 658.1 万人，80 岁及以上独居老年人约有 173.7 万人，在六大区中比例最高，西北地区则最低，如图 5-13 所示。

表 5-11　2010 年全国分城镇乡的独居老年人状况（单位：万人）

年龄	全国	城市	镇	乡
60 岁及以上	1900.1	463.1	1099.6	337.4
65 岁及以上	1529.1	374.3	883.9	270.9
80 岁及以上	418.4	108.0	237.6	72.8

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

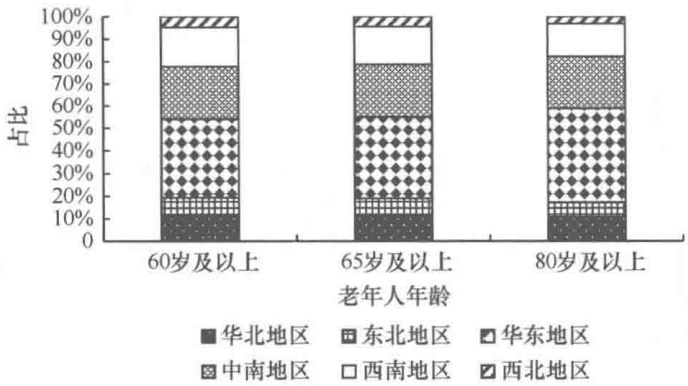


图 5-13　独居老年人的区域分布

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

必须指出，随着中国人口老龄化的加剧，空巢老年人、独居老年人等老年人群体开始受到人们的关注。而与空巢老年人相比，独居老年人不仅自己的子女不在身边，而且失去了配偶的相互扶持、照料，很容易成为“无人问津”的群体，他们是老年人中最需要社会关注的对象。老年人独居现象的不断增长，一方面原因是住房条件改善，从物质条件上使独居更为可能；另一方面原因是计划生育导致少子化严重，减少了家庭人口；同时，工作流动的加快，子女外出求学、务工现象也越来越多，这些因素也都加剧了独居现象。独居老年人问题已不仅是个人问题、家庭问题，而将成为一个亟待解决的社会政策命题。

5. 高龄丧偶老年人家庭户

丧偶老年人是一个相对弱势的老年人群体。与有配偶者相比，丧偶者晚年往往会感到更加孤独寂寞，而且其在生活自理方面也存在更多问题。不仅如此，目前我国仍有相当一部分老年人（农村、非政府或企事业单位退休员工、女性老年人等）较依赖配偶的收入生活，在社会保障仍不健全的情况下，丧偶老年人群体在经济上也更为脆弱。因而此处特别选取高龄丧偶老年人家庭予以考察。

第六次全国人口普查资料显示，2010 年我国 80 岁及以上的丧偶老年人约有 1386.6 万人。其中约七成与子女共同居住，其余的丧偶老年人大多选择独居，极少数与其他人共同居住。城市丧偶老年人独居的比例最高，占全部城市丧偶老年人的 32.60%，与子女共同居住的比例则最低，为 66.16%，如表 5-12 所示。

表 5-12　2010 年全国分城镇乡的高龄丧偶老年人居住模式

老年人居住模式	全国	城市	镇	乡
独居	27.32%	32.60%	25.01%	29.10%
与子女共同居住	72.07%	66.16%	74.63%	70.15%
与其他人共同居住	0.61%	1.24%	0.36%	0.74%

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

从地区分布来看，西北地区的高龄丧偶老年人选择与子女共同居住的比例最高，达到 78.27%，华东地区的高龄丧偶老年人独居比例最高，为 33.36%，如表 5-13 所示。可见，在经济较发达的城市和东部沿海地区，选择独居的高龄丧偶老年人较多，而农村和西部内陆地区的高龄丧偶老年人则更加传统，更倾向于与子女共同居住。

表 5-13　2010 年全国分大区的高龄丧偶老年人居住模式

老年人居住模式	全国	华北地区	东北地区	华东地区	中南地区	西南地区	西北地区
独居	27.32%	28.48%	25.91%	33.36%	22.26%	24.23%	21.22%
与子女共同居住	72.07%	70.55%	73.69%	66.02%	77.13%	75.26%	78.27%
与其他人共同居住	0.61%	0.97%	0.40%	0.62%	0.61%	0.50%	0.51%

资料来源：2010 年全国人口普查抽样数据

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

此外，女性比男性老年人更倾向于与子女同住，而且这种性别差异从 2000

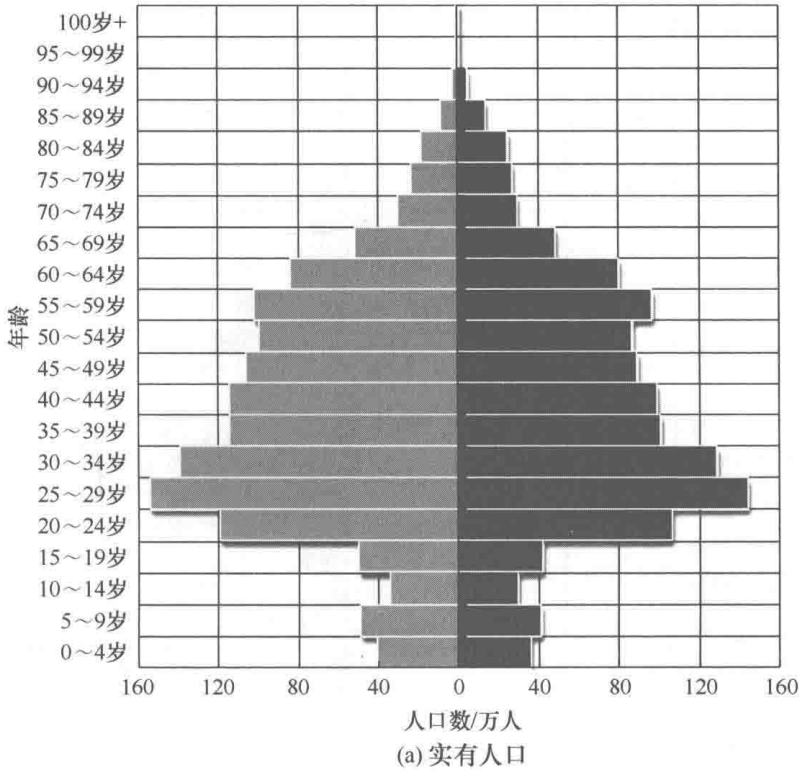
年开始明显增大。这是因为女性老年人在经济上有更大的依赖性以及更可能处在丧偶状态，她们也可能是应子女请求而与子女同住以便于照料孙子女。中国目前大量老年夫妇单独居住的原因，一方面是他们倾向于独立生活，另一方面可能是由于其子女的迁移流动。这导致了老年人与子女同住的比例大幅度下降，特别是低龄老年人。需要指出的是，尽管我国老年人仅与配偶同住的比例自 20 世纪 90 年代以来大幅增长，但仍远低于西方发达国家的水平。

5.1.4　关于流动老年家庭的一些情况[①]

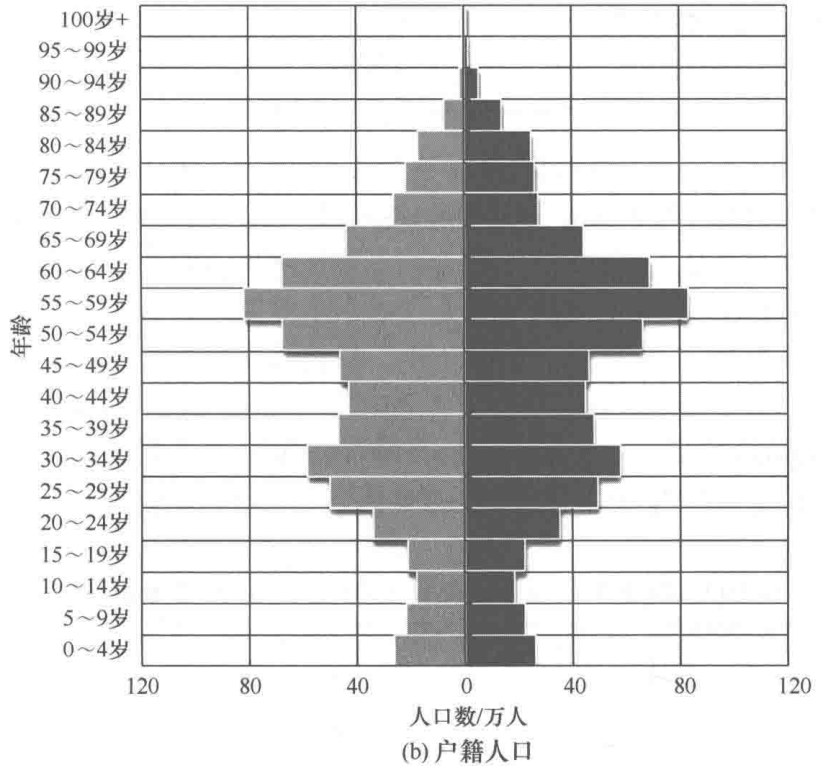
第六次全国人口普查资料显示，2010 年我国迁移流动人口已达到 2.6 亿人的规模，其人口年龄结构覆盖了全年龄段。在人口老龄化加剧和迁移家庭化凸显等趋势下，已有相关学者和政策研究者开始关注其中流动老年人口所处的家庭形态及其居住模式，但却一直没有相对较全面的数据资料披露。针对这一问题，本节以上海为例，利用 2015 年上海市流动人口的流入人口监测数据对来沪老年人的基本状况进行分析，以期从一个侧面描述其迁移逻辑和群体特征。

上海市历来是中国各省市中人口转变的先行者。1975 年全国总和生育率仍徘徊在每对夫妇平均生育 3.5 个孩子左右时，上海市的总和生育率已低至 1.37，远低于 2.1 的更替水平。2000 年，上海市户籍人口总和生育率仅为 0.92，并进一步下滑至 2010 年的 0.89。2000～2010 年，上海市户籍人口由 1322 万人缓慢增长至 1412 万人，年均自然增长仅为 0.7%，这完全源于人口年龄结构形成的人口增长惯性。如果随着人口的进一步老龄化，这一增长惯性将消耗殆尽，上海势必将开启长期的人口负增长模式。然而，如果从常住或实有人口的口径来看，上海却又展现出截然不同的另一番景象。2000～2010 年，上海市常住人口增长率位居全国第二，仅次于北京。10 年间上海常住人口由 1609 万人增长至 2303 万人，增加 694 万人，年均增长率达 3.65%，而 87%的常住人口增长均归因于外来人口的增加。2014 年，上海境内来沪人口总量为 1100.09 万人，已占上海实有人口总量的 42.8%。流动人口的涌入不仅改变了上海的人口规模，更为重要的是，直接影响上海市的人口年龄结构。如图 5-14 所示，上海市户籍人口金字塔已呈现底部萎缩、顶部扩张的形态。其中，55～59 岁队列人数众多，他们即将迈入老年，这将大幅度加深上海的老龄化程度。然而境内来沪人口的年龄金字塔则呈现两头窄中间宽的“核形”，即劳动力资源充沛，而被抚养人口稀少。

① 本节的部分研究得到原上海市卫生和计划生育委员会的数据支持，感谢沈可和许弯弯在数据处理中提供的帮助。


100岁+
95～99岁
90～94岁
85～89岁
80～84岁
75～79岁
70～74岁
65～69岁
60～64岁
55～59岁
50～54岁
45～49岁
40～44岁
35～39岁
30～34岁
25～29岁
20～24岁
15～19岁
10～14岁
5～9岁
0～4岁
年龄
160
120
80
40
0
40
80
120
160
人口数/万人

(a) 实有人口


100岁+
95～99岁
90～94岁
85～89岁
80～84岁
75～79岁
70～74岁
65～69岁
60～64岁
55～59岁
50～54岁
45～49岁
40～44岁
35～39岁
30～34岁
25～29岁
20～24岁
15～19岁
10～14岁
5～9岁
0～4岁
年龄
120
80
40
0
40
80
120
人口数/万人

(b) 户籍人口

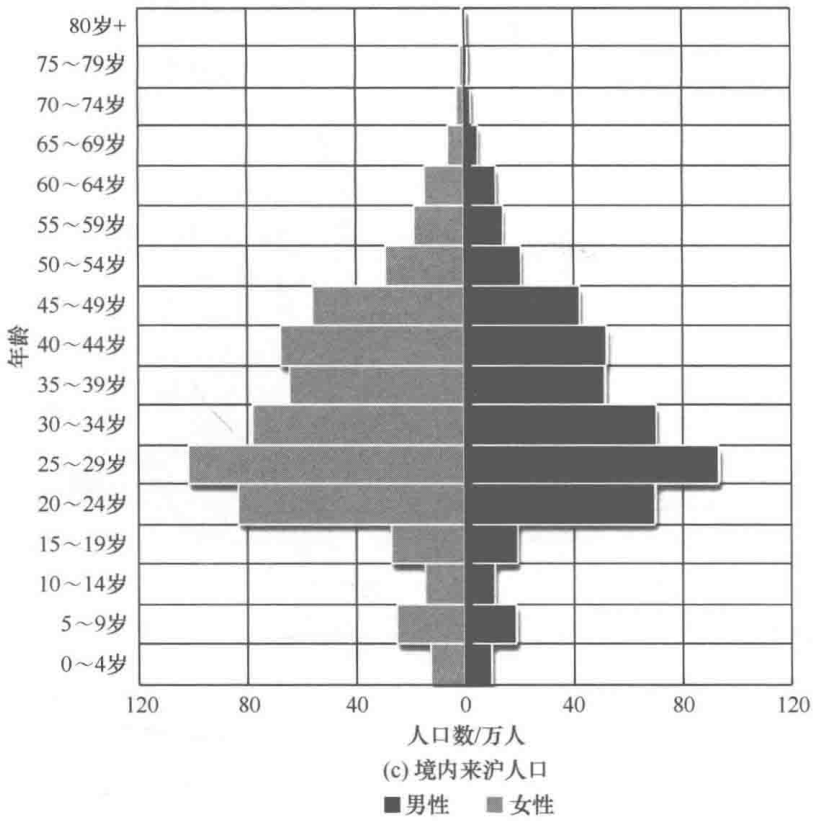


图 5-14　2014 年实有人口、户籍人口、境内来沪人口金字塔

资料来源：2015 年上海市流入人口监测数据

作为来沪人口中的特殊群体，来沪老年人口的生存状况及趋势不仅关乎民生，而且将可能直接关乎公共医疗卫生资源的配置。本节由此对 2015 年 60 岁及以上上海市流动人口的流入人口监测数据进行整理、分析，筛选得到 752 个来沪老年人样本，其中男性 378 人，女性 374 人；60～69 岁老年人 580 人，70 岁及以上老年人 172 人（80 岁及以上老年人 24 人）。他们的基本状况总结见表 5-14。尽管样本量不大，由于监测调查采取分层、多阶段、与规模成正比的按容量比例概率抽样法（proportionate to population size，PPS），同时调查问卷以居住关系为标准获取了每一位受访者“同住”老年人的相关信息，因此样本具有相对较好的代表性。

表 5-14　2014 年上海市 60 岁及以上来沪老年人的基本状况总结

特征变量	分布描述
年龄分布	49%集中于 60～64 岁，77%为 60～69 岁，仅有 3%为 80 岁及以上的高龄老年人
受教育程度	接受过高等教育（大学本科或专科及以上学历）的比例高达 15%，远超全国 3.3%的水平
子女受教育程度	接受过高等教育的比例超过 51%

续表

特征变量	分布描述
来沪原因	半数以上（男性 46%，女性 58%）为“照顾子女或孙子女”，这在 60～69 岁年龄段的低龄老年人中比例更高。21%的男性和 9%的女性为“务工经商”，以“养老”为需求者为 22%～23%（主要集中在 70 岁及以上年龄段）
主要经济来源	离退休金/养老金（男性 60%，女性 55%），劳动收入（男性 16%，女性 7%），储蓄及理财（男性 2%，女性 3%），依赖其他家庭成员（男性 18%，女性 25%）
健康自评	97%认为自己“很健康”或“基本健康”，性别差异很小
医疗保险	90%左右参与了各类医疗保险项目，且在户籍所在地参保
过去一年住院率	住院诊断率低于 5%，其中 85%的男性和 65%的女性选择最终住院 未住院者中，67%的男性和 57%的女性为“本人或家人觉得没必要”

资料来源：2015 年上海市流入人口监测数据

不难看出，绝大部分来沪流动老年人为相对低龄老年人，他们的受教育程度显著高于全国平均水平，其子女的整体受教育水平也较高；他们的主要经济来源以离退休金和养老金为主，有一部分通过务工经商还在持续获得劳动收入，依赖其他家庭成员获得生活资源的比例显著低于全国平均水平；健康状况普遍良好，参加各类医疗保险项目的比例很高，高血压和糖尿病的患病率相对较低。这些老年人七成以上都与已经来沪的子女同住，印证了前文所分析的“迁移家庭化”现象，他们来上海的最主要目的是“照顾子女或孙子女”，也因此，过去一年这一群体的住院诊断率尽管低于 5%，但实际住院率更低，仅有 3%～4%，因为“本人或家人觉得没有必要”。

具体而言，男性流动老年人来沪的主要原因依次为照顾子女和照顾孙辈（46%，其中照顾子女 18%、照顾孙辈 28%）、养老（23%）、务工经商（21%）和其他（10%）；女性流动老年人来沪的主要原因依次为照顾子女和照顾孙辈（58%，其中照顾子女 24%、照顾孙辈 34%）、养老（22%）、其他（11%）和务工经商（9%）。超过半数的来沪老年人是为了照顾子女或照顾孙辈，其中男性在照顾孙辈和照顾子女上的比例要低于女性，但依然处于一个非常高的水平。这些老年人中约 1/5 的人是出于养老需求才流入上海，而治病动因较低，如图 5-15 所示。

对不同年龄段的老年人口进行观察，也会发现高、低龄老年人的来沪动因都集中分布在照顾孙辈和照顾子女上，治病动因都不甚明显，即便是对于 70 岁及以上的老年人群体而言，其照顾子女和照顾孙辈的比例也达到了 43%，如图 5-16 所示。当然，必须指出，70 岁及以上老年人因养老需求流入上海而与其子女共同居住的占比远高于 60～69 岁老年人，达到 40%。

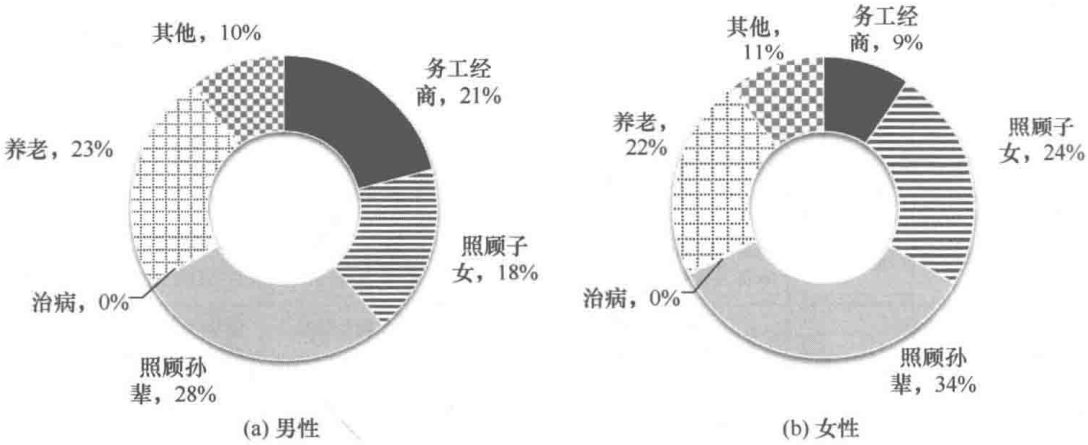


图 5-15　流动老年人来沪主要原因（分性别）

资料来源：2015 年上海市流入人口监测数据

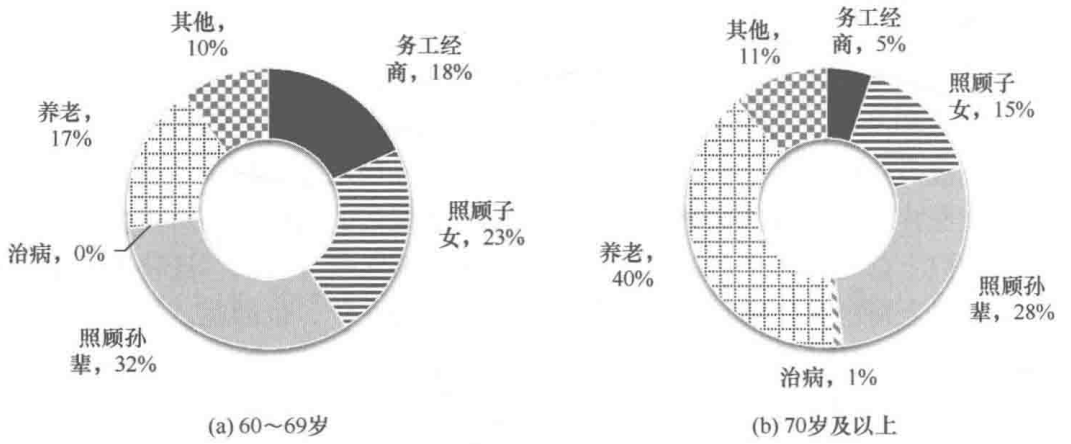


图 5-16　流动老年人来沪主要原因（分年龄）

资料来源：2015 年上海市流入人口监测数据

这些老年人的平均收入水平相对较好、经济来源较稳定，六成的老年人以离退休金为主要经济来源，这一比例远远高于 2010 年全国人口普查资料揭示的全国平均水平，14%的 70 岁以下老年人甚至以“劳动收入”为主要经济来源，各类医疗保险项目对该群体的覆盖率也达到了九成左右。97%的老年人认为自己“健康”或“基本健康”，即便对于 70 岁及以上的老年人群体，其自评健康或基本健康的比例也达到了 91%，来沪老年人的整体健康状况良好，如图 5-17 所示。在过去一年是否诊断需住院的问题上，各有 5%的男性老年人和女性老年人患有经医生诊断需住院的病/伤，而在这些经诊断需住院的流动老年人中，85%的男性和 65%的女性会最终选择住院。对于经诊断需住院而未住院的原因，男性流动老年人的主要原因有两个，即 67%的是本人/家人觉得没必要，33%的是因为无人照料。女性流动老年人中 57%的是本人或家人觉得没必要，29%的是因为没有床位，如图 5-18

所示。这一方面与老年人所参与医保的性质有一定关联，但另一方面是这些老年人认为自己是带着“任务”的，他们来沪是为了家人、为了下一代，一些老年人甚至认为“小病小灾没有必要闹那么大动静”“不能来了没帮上忙，还给孩子添乱”。

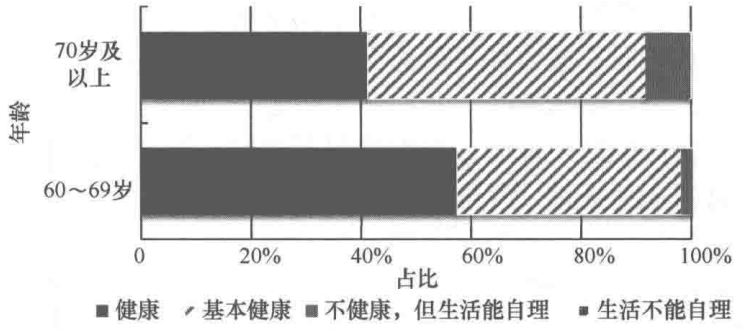


图 5-17　流动老年人健康状况自评（分年龄）

资料来源：2015 年上海市流入人口监测数据

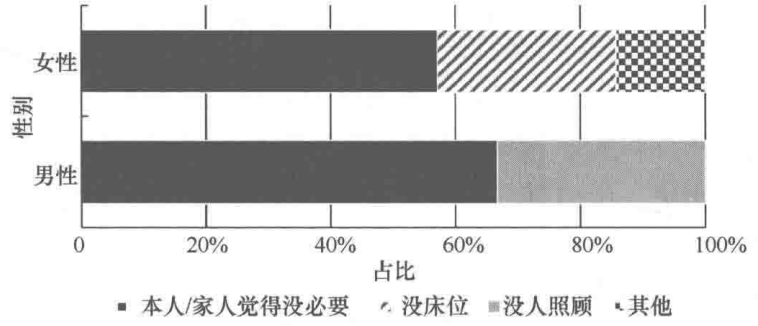


图 5-18　流动老年人没住院的原因（分性别）

资料来源：2015 年上海市流入人口监测数据

通过对 752 名 60 岁及以上来沪老年人的人口家庭特征、经济能力、健康状况及医疗服务利用率的综合分析，我们对来沪老年人形成一个较全面的认知：低龄化、受过较好教育、经济相对独立、健康状况良好并享受户籍地基本医疗保险。他们来沪大多与已在沪的子女同住，却并非以养老、治病为主要目的，而主要是为了服务下一代，是子女与孙子女的照料者乃至于“带薪”照料者。这一现象与复旦大学长三角地区社会变迁调查（Fudan Yangtze River Delta Social Transformation Survey，FYRST）的研究发现互为印证，FYRST 以上海市“80 后”群体为调查对象，调查发现相当多的“80 后”年轻父母在孩子学龄之前都主要由（外）祖父母照料孩子。来沪老年人对子女家庭的协助，可以极大地解放中青年劳动力，特别是中青年女性劳动力的家务负担，促使他们将更多的时间投入于市场化劳动、提高劳动生产率、增加劳动产出。事实上早就有研究指出，“正是因为中国有老年人承担家庭义务，才能将劳动力相对充分地从家庭中释放出来，以实现社会的飞速发展”（彭希哲和胡湛，2015；沈奕斐，2013），而这一效应往往

在评估老年人经济价值时被忽视。

因此，我们亟待扭转对来沪老年人的刻板印象：他们并非传统意义上的被抚养者，他们很大程度上在家庭中扮演了“守门人”和“照料者”的角色；他们也并非社会公共资源的攫取者，由于其良好的教育经历与经济独立性，他们的消费能力不可小觑，这也对上海市经济增长与财政收入增加有所裨益。然而从公共政策与福利的层面，目前来沪老年人仍无法享受本市户籍老年人的同等福利。例如，他们参加户籍所在地的医疗保险，多数情况下他们在上海的就医治疗无法报销或者需要回到户籍所在地报销。又例如，他们不能享受“70 岁以上老年人免费乘车卡”，不能领取针对特定户籍老年人群体的“养老服务补贴”，也不能领取“老年综合津贴”。这一系列的制度隔阂或福利短缺将不仅成为优质老年人力资源来沪的阻碍，而且对已来沪老年人价值的挖掘与释放具有较大的负面影响，未来的公共福利及服务应逐步考虑向来沪流动老年人适度开放。

5.2 对当代家庭变迁及政策实践的反思

不难看出，在少子老龄化的背景下，未来中国家庭的抚养压力正在不断增大。在传统文化的作用下，中国家庭的很多养老资源乃是通过生育资源所转化，这并不全是政府的责任，尤其是对于中国的老年人来说，“花儿女的钱”和“花国家的钱”有着截然不同的含义，而通过家庭获得情感和心理上的满足更是任何专业的社会服务都无法取代的。缺少家庭责任的养老政策是残缺的政策，既不能使老年人获得完整的福利，还会造成社会和政府财政的负担过重。尽管在制度相对缺位的情况下，中国家庭仍以这样或那样的方式竭力为家庭成员提供保障并帮助其抵御风险、适应变迁，但却不足以应对人口、家庭、社会等多重变迁所带来的结构性冲击，改革乃至重构当代老龄社会中的家庭政策已迫在眉睫。

2015 年以来，随着习近平明确提出“不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设”[①]，传统中常处于学术研究边缘地带的家庭和家庭政策研究也越来越受到重视，大量卓有成效的研究成果涌现，但同时一些似是而非的观点或论断也泥沙俱下，并伴随媒体与网络传播而影响和干扰了公众及政府的判断，这无疑给家庭建设和家庭政策发展制造了障碍，当审视和辨析之。

① 《习近平：不论时代发生多大变化都要重视家庭建设》，http://politics.people.com.cn/n/2015/0217/c70731-26580958.html[2015-02-17]。

5.2.1　“家庭核心化”和“家庭功能弱化论”再认识

作为人类社会中一种渗透着情感和传统的基本制度，相当多的理论都认为家庭不可能迅速发生巨变。但是，也有不少研究试图解释现代社会中的哪些因素如何以及在多大程度上可能给家庭模式带来变化，这主要涉及经济发展、文化传播及国家干预。具体而言：①经济发展。论及经济发展对家庭模式的影响，最著名的尝试莫过于 Goode（1963）出版的 *World Revolution and Family Patterns*（《世界革命与家庭模式》）。Goode（1963）认为，一个社会中家庭模式的形成，首先取决于其经济发展水平，而不是特定的财产关系甚至政治社会制度。当然，他也在书中承认，经济发展绝不是促进现代社会家庭变迁的唯一要素。②文化传播。不少西方研究者认为西方发达社会的文化传播可能会引起家庭生活的变化。西方社会以夫妻关系为基础的小家庭，已经逐渐被视为现代生活的标志之一，诸如此类的西方家庭理想与家庭文化的传播和扩散成为促进第三世界国家家庭变迁的重要动力（Whyte，2005）。③国家干预。国家对家庭变迁的操作有直接和间接两种形式。直接的干预主要包括相关法律法规的推行，如婚姻法、生育政策、性别平权运动等；间接的干预则来自国家对制度环境的改变，如新中国成立后发动的社会主义改造，由此发展出对家庭生活和家族财产的干预、对传统婚姻模式（如包办婚姻和买卖婚姻）的批判，此外也有一些西方学者认为新中国成立初期对社会的改造破坏了旧的儒家家庭传统等。

当我们将这些西方学者提炼出的要素用以解释中国家庭模式的变化时，却无奈地发现，尽管中国情境也展现了这些动因的重要性和必要性，它们却不能全面描绘出当代中国家庭变迁的图景，甚至在细节处更有与理论预期相悖的情况出现。例如，就工业化和城市化水平而言，中国台湾的进程相对高于中国大陆诸地区，1949 年后西方文化在中国台湾的传播也远远超过中国大陆，因而对于经济发展和西方家庭文化传播所引起的中国台湾家庭变迁应较之中国大陆更为显著，但 Whyte（2005）通过对保定和台湾若干城市的长期调查研究后却做出了相反的判定。一方面，中国的巨大体量本就决定了其缤纷的内部异质性；另一方面，中国传承数千年的家庭伦理和家庭文化是中华文明得以延续的重要基础，两千多年前的儒家在将社会理论化的过程中甚至将中国家庭的凝聚力作为社会发展的主要动力（比尔基埃等，1998），在漫长岁月的演进中，中国的家庭制度尽管历经时代洗礼，但仍长期保持着某种稳定性，其边界与内涵常异于西方家庭。尤其是近现代以来深刻剧烈的社会经济变迁更使得中国家庭模式和功能的转变与西方社会和风细雨式的家庭变迁过程截然不同，中国家庭模式和功能的转变更为复杂与剧烈，并在很短的时期内酝酿出巨变。

事实上，定义“家庭”尤其是“中国家庭”是一件非常困难的事情。不同社

会或文化中“家”的内涵与外延不尽相同，费孝通先生很早就曾指出英语中的“family”与中国人的“家”在本质上截然不同，他还提出用“extended family”（扩大家庭或多代同堂式家庭）作为中文“家”的译法（Fei，1939）。不仅如此，虽然家庭植根于姻亲血缘关系，但在时空上和结构形态上却可能是“流动”乃至“割裂”的，这种概念边界的模糊性造成了家庭量化资料的匮乏，因而在研究中人们常常出于实用主义而用家庭户（family household）指标来近似地表征家庭（胡湛和彭希哲，2014）。家庭户是一个具有人口学倾向的术语，它聚焦于居住模式（包括居住关系与居住形态）。以此为出发点，不难看出中国家庭户近年来不断呈现出规模小型化和结构简化的趋势，尤其是核心家庭户在家庭户总数中所占比例已过半，生活在核心家庭户中的人口也超过了家庭户总人口的一半。同时，由于以核心家庭与现代化之间相互适应为核心观点的家庭现代化理论在家庭研究中长期占据主导地位，学界也据此逐渐形成了对中国当代家庭变迁模式的基本判定，并在一定程度上倾向于将其简单归结为“家庭核心化”（彭希哲和胡湛，2015）。

然而从本质上讲，这些现象充其量只是“家庭户的核心化”，仍非“家庭核心化”。“核心家庭”（nuclear family）不仅表现为居住形态，其内涵更指向与其形态相匹配的一系列物质条件、生活方式和价值体系（Barker and MacFarlane，1979）。“核心家庭”占主导地位的确曾被认为是西方现代社会的显著特征之一，其制度基础是相对完善的社会保障及福利系统，这些制度及政策安排相对充分地保障了个体可以在不依赖于亲属或家族网络的情况下独立乃至体面生活，即“家庭功能核心化”（唐灿，2010）。不仅如此，由于新文化运动和其后的五四运动创造性地通过批判传统家庭伦理而撼动了封建道德的统治地位，在其后的很长一段时间以推崇西方核心家庭模式为核心之一的家庭革命都与“强国梦”紧密相连（沈奕斐，2013），这尤其受到知识分子的追捧。从新中国成立到改革开放之前，这一情结依然存在，并使中国的“国家—家庭—个体”关系呈现出一种特殊的张力。新中国对传统家庭的改造，是以让个体为整个国家的社会理念奋斗为前提所做出的制度路径选择，但这并非轻而易举。一方面，中国传统家庭虽然有压制个体自由的一面，但同时也具有中和或抵御公共权力挤压的一面。另一方面，国家对家庭的改造不得不受到其实际福利支付能力的限制，尤其是赡老抚幼、就业失业等责任义务的扩大使国家无力为全体国民提供相对全面的福利保障系统（陈映芳，2010）。虽然当时的政府在批判传统，但同时也不无矛盾地强化个体的家庭义务以及家庭成员间的连带感，并赞美传统家庭伦理。人们对家庭的忠诚及义务仍然延续着，甚至受到国家政策的强化，家庭及其亲属网络在中国人的生活中依然占有无可替代的特殊地位（Davis and Harrell，1993）。

改革开放之后，在“减轻国家负担、增加家庭和个人责任”的方针下，面向家庭的基本公共服务和福利制度仍聚焦于困难家庭与问题家庭，这缺乏普适性，

占主流的核心家庭户在多重社会压力面前已难以独立完成传统的基本家庭功能，而不得不在家庭政策及公共服务缺位的情况下假手于亲属网络（尤其是亲子网络）的扶持，其家庭功能的完成呈现网络化特征（王跃生，2010）。FYRST 自 2012 年开始追踪改革开放后第一代独生子女群体“80 后”的家庭变迁，2012 年基线调查资料即显示出多数“80 后”夫妇需要父母帮助照料下一代，甚至“父母能否帮助带孩子”已经成为影响年轻夫妇生育意愿的一个因素，2016 年的追踪资料则进一步表明，超过 85%的已婚“80 后”夫妇都是“双职工”，他们与父母分开居住以形成核心家庭的比重日趋提升，而目前绝大多数就业单位并不具备涉及托幼及上班哺乳等的设施和资质，这样的工作和居住安排模式使众多年轻核心家庭在子女照顾上存在相当压力，高达 91.48%的已育上海“80 后”家庭需要自己的父母（即孩子的祖父母或外祖父母）帮忙照看学龄前孩子（6 岁及以下），同时有 65.77%的父母几乎每天都会参与到照看孙子女的活动中去（胡湛，2018）。而对于“新上海人”和一些非本地户籍人口而言，除了邀请孩子的（外）祖父母来沪同住外，从老家花钱请其他亲戚来帮忙带孩子的情况也越来越多。以亲子网络为核心的当代亲属网络不仅在实现家庭抚育功能的过程中发挥了不可或缺的作用，且家庭网络在家务互助和经济往来方面也存在频繁互动，显现出典型的“互助互惠”特征（唐灿和陈午晴，2012）。这说明尽管核心家庭户已成为主流，但他们并未自我孤立，仍与其亲属网络（尤其是亲子网络）源源不断地相互汲取养分。这远非西方传统核心家庭模式中家庭形态与功能的一体式核心化，而不啻为一种“家庭形态核心化”与“家庭功能网络化”的创造式结合，反映出当代中国家庭在形式与功能上正呈现出结构性的脱嵌及重构现象。

不难看出，随着家庭小型化进程的持续，以及人口迁移流动所导致家庭成员之间的地域分割，家庭在生命周期不同阶段的可利用资源确实正在减少，但却没有迹象表明当代家庭功能的必然弱化乃至丧失。不少人出于对家庭小型化或家庭户核心化现象加剧的担忧而误信“家庭功能弱化论”乃至“家庭崩溃论”，断言我国家庭功能及其凝聚力已普遍磨损而致使传统家庭功能难以为继，却对家庭网络在新历史时期的新表现形式视而不见。随着单位制的解体，个体早已由过去的“组织的人”变成现在“家庭的人”，家庭成员间（主要是亲子之间）的传统互助模式是应对外部风险的前提，家庭网络化现象的涌现反而在一定程度上增强了家庭的凝聚力（彭希哲和胡湛，2015）。但同时必须指出，中国当代家庭和家庭网络虽然正以这样或那样的方式竭力为家庭成员提供保障并帮助其抵御风险、适应变迁，但在少子老龄化等结构性冲击下正逐渐显现其脆弱性。随着中国社会经济的进一步发展，人口态势与社会形态的变化、家庭模式与人们生存状态的改变必将对社会的稳定以及维系社会正常运作的各项社会政策带来更大挑战，家庭政策的完善乃至重构已成为关系中国经济社会可持续发展的一件大事。

5.2.2　对当代家庭政策研究实践的若干理解偏差

出于家庭概念的多义性和各国治理模式的多元化，对家庭政策的定义一直存有争议，任何一种定义都可能是带有意识形态色彩的抽象概念。但通常来讲，家庭政策主要是指政府用于支持和帮助家庭承担特定功能而针对家庭推行的社会政策，甚至从某种意义上说“社会政策就是家庭政策”（Kamerman and Kahn，1978），任何在家庭以外建立起来的社会制度都不能取代家庭的功能，而只是政府以不同程度和方式对家庭责任的分担，政府乃至社会对家庭及其功能的认识与重视程度则决定了家庭政策的走向。在改革开放之后的较长时间里，中国的家庭政策在影响人口发展、提供家庭保障和促进性别平等等方面有所建树，但仍较多囿于一种“含蓄的援助”（胡湛和彭希哲，2012），难以有效稳定家庭和承担家庭功能。目前随着家庭建设和家庭研究的兴起，中国的家庭政策正呈现欣欣向荣的前景，但也存在若干结构性和系统性的理解偏差乃至发展症结，若不正视将可能埋下隐患。

1. 不少人误认为中国人口政策已经蕴含了家庭政策，而事实上现有的人口政策与家庭政策更多体现为一种互补关系，而不是相互包含关系

生育政策的本质乃是通过对家庭进行生育调节以达到有效控制人口规模增长的目的，这使不少人误认为中国人口政策已经包含了家庭政策（孙常敏，2010）。我国政府自 20 世纪 70 年代开始推行的人口计划生育政策及项目，其理论出发点在于当时政府认为人口过快增长会给社会经济发展带来巨大压力并形成与资源环境的紧张关系，这一政策的实施为当时的社会经济发展创造了相对较好的人口条件，但同时也催生出一系列问题。正是因为原有政策继续实施对人口和家庭结构等方面的负面影响不断集聚，中国政府在 2013 年、2015 年和 2021 年相继调整生育政策，即实行“单独二孩”“全面二孩”“三孩”政策。除了使人口老龄化提前出现，计划生育还催生了大量独生子女家庭，这加速且加剧了中国家庭的小型化和结构简化及异化（如“4-2-1”乃至“8-4-2-2”家庭），并涌现出较多的非常规家庭（如丁克家庭、纯老家庭），这一进程更由于中国经济社会的快速发展（特别是人口流动和房地产市场的发展）而进一步提速。虽然政府一直有针对孕产保健、育儿等方面的政策与项目，但仍不能完全解决这些家庭的负担与风险问题。换句话说，现有的家庭政策仍在很大程度上体现为对人口政策的补充，即专注于弥补因生育政策而“吃亏”的社会群体及问题家庭或缺乏家庭依托的边缘群体，尚缺乏适度普惠性，因而也有学者认为中国尚未建成现代意义上的家庭政策体系。

2. 现有制度安排较多关注“多生”却忽略“善养”，不仅存在政策错配的风险，而且忽视了家庭政策本身就有优化生育养育环境以优化人口发展态势的潜在目的

随着“单独二孩”和“全面二孩”政策的实施，我国育龄人群所累积的二孩生育意愿正在逐渐兑现，但毕竟对提高生育率效果的表现有限，尤其是随着育龄人群开始缩减，出生人口数在 2016 年达到高峰以后 2017 年又有所下降。尽管生育水平在中短期内大幅锐减的可能性并不存在，更不会出现家庭生育“塌陷式下滑”乃至“人口雪崩”等危言耸听的景象，但毕竟未来中国人口态势在整体上趋于下降，人们也由此普遍性地担忧中国人口发展受挫。在这样的背景下，现有制度安排较多关注如何通过调整生育政策及优化生育配套而鼓励年轻育龄夫妇多生，但对如何提高已出生少年儿童健康素质和人力资本的关注则相对较少，尤其是现有的几千万留守儿童、残疾儿童的生存与发展问题。良好的家庭功能是优化人口结构和提升人口素质的首要条件，人力资本在当前新的社会经济形势下的新内涵（如社会能力、精神品质等因素）更与家庭有着千丝万缕的联系（彭希哲和胡湛，2011），实现从“多生”到“善养”的转型已势在必行。

此外，还有不少地方相继推出各类“鼓励生育”配套措施（如产假、住院分娩补贴、增加托幼机构供给、女性劳动权益保障等），有效优化了家庭生育养育环境，但一些观点及建议却对此进行了过度解读，尤其是不恰当地将“鼓励生育”定位为生育政策乃至国策的政策目标，甚至有专家建议通过强制征收“生育基金”乃至对“单身”和“丁克家庭”征税等“负激励”（即惩罚或变相惩罚）方式来刺激人们生育（刘志彪和张晔，2018）。这无疑是从一个极端走向另一个极端，将生育政策仍陷于行政干预的泥沼，将“政策目标”和“政策功能”错配，已干扰了社会的认知。事实上，以“鼓励生育”为表现形式的一系列用于减轻生育养育负担的配套措施大多落脚于家庭政策及其相关社会政策的完善，即以家庭为基础完善生育政策的整体性配套政策措施及福利输送。设计更加完善的家庭政策来调节家庭规模与家庭结构，向家庭支付某种形式的津贴以鼓励生育，也是西方发达国家政府在本国生育率出现明显下降趋势时采取的常规行政手段，而不应将其贸然裹挟于生育政策之中。

3. “家庭自立自强论”和“政府全能全责论”各行其道，缺乏对具体政策问题的具体分析，也反映出“去家庭化”和“再家庭化”的矛盾博弈

反观西方发达国家的家庭政策，他们在第二次世界大战之后重新认识到家庭作为社会稳定基石的重要性，家庭被视为风险应对的核心单元，家庭福利在 20 世纪 40 年代到 20 世纪 60 年代经历了一个迅速扩大的时期，原本以聚焦特殊家庭为主的补缺型家庭政策逐步发展为国家通过持续的财政投入面向全体公民的普惠

型政策。但这一时期国家对家庭生活的过度干预也造成了家庭功能的失衡，相当一部分福利资源存在低效运作。20 世纪 70 年代末期和 20 世纪 80 年代之后，在经济衰退、老龄化加剧和传统家庭模式进一步萎缩的背景下，西方国家的福利制度在经济和政治上陷入困境，对家庭福利进行改革的研究大量涌现。20 世纪 90 年代以来，家庭政策改革开始在强调家庭责任的同时，从战略的角度给予家庭以发展型福利支持，而不是不加选择地将福利“覆盖所有个人和家庭所不能解决的困难与问题”，“找回家庭”成为一种重要的政策思路（Briar-Lawson et al., 2001）。从总体上看，近现代西方家庭政策大致呈现出从“去家庭化”到“再家庭化”的演化路径，并且这二者趋于相互融合，以期在国家与家庭的均衡关系中支持公民权益的实现。

中国家庭政策的发展路径则大不相同，呈现相对显著的工具理性色彩。计划经济时期国家对传统家庭制度进行了广泛的改造，但在削弱家庭对个体控制的同时保留和利用了家庭对其成员的约束或保障等功能，表现出既削弱又强化的矛盾。改革开放之后，特别是在国有企业改革和社会主义市场经济体系建立的过程中政府成为公共服务的直接提供者，在中国这样的一个大国开始建立前所未有的覆盖全体人民的社会保障和福利体系时，这必然面临巨大的体制和资源的挑战。此后，在政府试图逐渐改变其对福利和保障的无限责任的大背景下，中国的社会政策开始重视家庭在个人发展和保障方面的功能，强调“减轻国家负担、增加家庭和个人责任”的原则，尝试通过家庭消化社会转型的成本，并由此产生了一种期望“家庭自立自强”以“为国分忧”的倾向。各级政府也习惯性地将相当一部分社会福利打包给家庭，这在各种有关城市住房政策、普及教育、公共服务均等化等制度安排中均有所体现。有限的家庭福利主要表现为“补缺模式”，这体现的是一种选择主义的“病理学”干预思路。

另外，在“再家庭化”的同时，我们的“去家庭化”也在同步进行。与发达国家家庭政策在“黄金时期”因福利干预过度而使家庭功能失衡的“去家庭化”不同，中国的“去家庭化”的主要因素之一是国家在政策层面或有意或无意的实用操作而导致了家庭功能的普遍磨损。例如，改革开放后计划经济向市场经济的转变，迫使个体以不同方式从家庭和单位中脱嵌出来投入经济社会建设。在这样的背景下，大量的制度安排保证了女性得以走出家庭并广泛参与社会经济活动，尽管参与的质量仍有待提高，但参与的程度则始终排在世界前列。甚至有学者认为，中国之所以发展如此迅速，同女性工作、老年人承担家庭义务有密切关联，“正是有这两项条件，我们在家庭没有崩溃的情况下，既实现了家庭的完整，又实现了社会的飞速发展”（沈奕斐，2013）。而随着家庭模式的进一步变化以及人口社会多重变迁的深化，目前这一模式已越来越难以持续，并由此酝酿出“政府全能全责”式的论调。即既然政府出于自身治理需要而磨损了原有家庭功能，那

么政府就理应承担全部家庭保护责任，尤其是当家庭出现问题时更应由政府为主进行干预，计划生育政策得到大量伦理诟病乃至苛责便是一证。

这些现象无疑使中国当代的家庭政策呈现出“去家庭化”与“再家庭化”的矛盾博弈。这除了由缺乏明确的家庭理论并在制度层面使家庭工具化所致，现有家庭政策的过度分散和碎片化也加剧了这一现象。在现有行政管理体制下，与家庭相关的社会政策往往出自不同的政府部门，而这些部门又大多专注于自身的功能和职能定位，相关部门之间职责交叉但界限不明确的情况时有出现，家庭在发展序列中的排序以及家庭政策优先对象的确定都要取决于相关部门对家庭事务的理解，不同部门的政策乃至同一部门的不同政策交替出现“再家庭化”和“去家庭化”取向并不鲜见，政策之间相互制约乃至冲突的现象时有发生。以养老为例，家庭养老在相当长的时间内仍是中国多支柱养老模式中的一种重要形式，政府也正在采取相应措施帮助家庭提高其参与养老服务的能力和积极性，甚至将子女探视家中老年人纳入法律条例，但近年来不少其他政策却有意或无意地加速削弱了本已弱化的家庭养老功能。政府在调节住房市场时诸多对住房面积和贷款优惠等的规定都鼓励以核心家庭为主的居住模式，这在事实上推动了中国家庭小型化，使家庭养老功能进一步削弱。尽管这些政策在个别领域对于解决特定的问题是有效的，但从家庭发展的视角来看有其明显的负面影响。必须承认，家庭继续小型化可能是中国家庭变迁过程中不可阻挡的趋势之一，但问题的关键在于我们的政策安排是否要选择在现阶段主动地进一步加速这一进程，住房政策完全可以通过与家庭政策的互动而将相当一部分家庭的养老需求考虑进来。

5.3　老年友好型社会的家庭政策重构要点

阿马蒂亚·森曾引用中国古典文论《诗品》中“以古为新”的整合性原则作为对中国经济社会发展的建议（森，2002），即在继承传统的基础上形成适应时代变化的创新。任何不考虑传统持续性的“现代”，很可能是貌似现代其实是守旧，貌似进步其实是落后。尽管在当代社会变迁的过程中，中国家庭的传统形貌看似面目全非，但其传统内核却仍顽强地存在，并在新历史时期再生出新的表现形式，这是中华文明得以延续的重要基础之一，即正如费正清（1999）所说“制度与文化的历史惯性”（徐勇，2013）。家庭政策，正是要保障这种惯性在新的历史环境下发挥新的作用，而绝非产生“不动的惰性”。然而就整体而言，我国政府在家庭问题上的治理原则仍未脱离传统意义上的“家国同构”理念及模式。这一模式的最大问题，就是“家”往往被“国”所同构，“家”的利益只能被“国”所代表，它实际上包含了“国”和“家”的等级逻辑与排斥关系（吴小英，2012）。这使得国家对家庭的操作逻辑常常自相矛盾、家庭在国家制度法规中频频缺位、

政策实践中的家国关系界限模糊。

事实上，在实现我国政府所提出的“保障改善民生”和“四个全面建设”等执政理念与发展目标的过程中，支持现代家庭建设都是应有之义，家庭政策可发挥巨大作用。当前中国所经历的是人口与家庭的双重变迁，其进程多是在“少子化”或“独子化”现象相对普遍以及“老龄化”成为常态的情境下进行的，更内嵌于社会转型之中，因而无疑需立足于当前人口与家庭发展的实际态势而选择完善乃至重构家庭政策的有效切入点。

1. 明确以家庭整体作为政策对象，推进家庭政策适度普惠性的同时强化对承担养老责任家庭的援助

“所有的社会政策都是家庭政策”，任何在家庭以外建立起来的社会制度都不能取代家庭的功能，而只是政府以不同程度和方式对家庭责任的分担。将家庭视为一个整体，充分考虑家庭的真实需求，通过对家庭而非向个人提供资源支持，可以使资源更有效地在家庭得到流转，并避免政策“瞄偏”。事实上，对家庭进行制度性支持可以产生典型的“辐射”效应，家庭功能具有“领域不敏感性”，通过支持家庭功能完善可以同时实现对不同福利领域的“一揽子”支持（如养老、抚幼、未就业成员保障等）。我国现有社会政策仍较多以“个人”为基本的政策对象或福利单位，不仅未将不同类型家庭的福利需求考虑在内，也无法为未就业或非正规就业的家庭成员提供有效保障。缺乏与家庭的实质性配合，家庭政策鲜有成功的先例。近期，政府开始在一些非常具体的政策领域尝试并部分实现了以家庭为单位的政策评估与实施。例如，在针对经济困难家庭的最低生活保障、廉租房/经济适用房的评估审核过程中，都往往会将家庭视作一个整体来估计家庭总体资产状况、收入流水等；家庭医生制度也有效整合了家庭和社区资源，实现了居民就诊的便利和家庭健康的全过程维护等。在这样的背景下，家庭政策及相关社会政策应当尽快实现以家庭整体作为政策对象，尤其是要考虑到承担养老责任家庭的需求及成本。

另外，家庭需求具有极强的多样性，为不同类型的家庭提供直接经济援助是家庭政策的重要组成部分。政府应当逐渐摒弃“病理学式”的家庭政策取向，突破传统的应急干预和查漏补缺，以满足现代家庭的发展需求为出发点，制定不仅能被动应急且具有预防发展作用的家庭政策，并逐步走向适度普惠。不仅如此，还要尝试消除现行福利体制固有的内在不平等（如高收入和低收入家庭在收入再分配方面的不平等），提升对最有需求家庭的资助力度（如残疾人家庭、空巢家庭、单亲家庭、独生子女家庭等），并减少妨碍有抚幼或养老责任的夫妇就业的不利因素。在此基础上，为应对老龄化常态化的挑战和回应老年友好型社会的建设诉求，应着重考虑那些正承担着养老责任的家庭（尤其是中低收入家庭）的负

担与压力，为其提供直接援助。这样做有以下优点：①有养老需求的中低收入家庭面临较大脆弱性，且总量较大。如果这一群体均能得到一定资助，则需要救助的家庭数量可能会大幅下降。②避免制度的内在不平等导致中低收入家庭无法从再分配系统中公平获利，这也是社会贫困现象的根源之一。③第一代独生子女已经到了兼具养老和育儿需求的阶段，政府理应为这一群体提供支持，同时这还可消除更多的伦理诟病。④操作简单，避免“家计审查”的困扰及政策“瞄偏”等情况。

2. 将支持家庭作为中国养老制度安排的政策重点及特点，灵活使用和积极创新各类政策工具

人口老龄化已成为中国社会的常态，养老是其应对研究中的核心命题之一。笔者认为，结合西方国家的教训和中国自己的经验与传统，重视并支持家庭应当成为中国养老制度安排的一个重点和特点。一方面，由谁来承担老龄化所带来的财政压力和保障风险是人们最为关注的政策焦点之一。尽管社会福利不可避免地承担起越来越大的养老责任，但任何社会养老政策都无法完全取代家庭在养老中的责任与功能。缺少家庭责任的养老制度注定是残缺的，既不能使老年人获得完整的福利，还会造成社会财政的过重负担。尤其是对于中国的老年人而言，“花家里的钱”和“花国家的钱”有着完全不同的情感与心理含义。另一方面，为了应对人口年龄结构老化的长期不可逆性和二三十年后到来的老龄化高峰，保证经济社会的可持续发展，投资人力资本、提高劳动生产率应已成为当前最重要的制度安排之一。尽管涉及教育、卫生及就业等政策的方方面面，但良好的家庭功能是形成和发展人力资本的首要环境。可见无论是应对老龄社会的现实养老问题，还是保证老龄社会的可持续发展与代际和谐，家庭都具有独特且重要的功能。

在这一过程中，应积极探索各类政策工具的创新，目前可考虑如下切入点：①运用公共消费品杠杆等工具降低家庭成本，促进居家养老。公用消费品具有公益和市场的双重特性，充分利用这种特性即能取得良好的社会效应，目前许多地方在居民公共消费品方面所采用的阶梯用水用电方案是促进资源节约和环境保护的重要手段。然而，这些举措主要针对的对象是“一户一表”的家庭，对于承担养老或抚幼家庭责任的“多人口家庭”的需求并未给予充分考虑。可尝试将家庭规模及结构作为公共消费品（如水、电、燃气等）价格的制定依据之一，对于有 60 岁及以上老年人同住的家庭户以及实质上的“一户多代、多人口家庭”，可根据老年人和儿童数量增加阶梯水、电消费量的基数，并适当放宽“一户多人口家庭”的认定条件（即按常住而非户籍）。②尝试在社会保险及医疗保险政策中考虑家庭需求。研究论证各类社会保险尤其是医疗保险在家庭中的转移机制及可能性，允许部分保险在家庭成员（主要考虑配偶或家庭成员中的老年人）之间适当

转移，并向老年家庭（如考虑亲子转移）倾斜。目前在浙江、重庆、厦门、深圳等地，配偶和某些直系亲属可以在一定条件下共享其他家庭成员的个人医保账户余额等，应加快其研究实践。还可以论证将家庭成员所承担的某些长期家庭服务（如失能老年人的长期照护等）纳入社会保险范畴的可行性等。③探索以家庭为单位的税收制度创新。将所得收入以家庭而不是个人作为计税缴税的度量范围，可以对家中有老年人、病人的家庭给予税收优惠或减免，从家庭收入这个源头给家庭以保护和支持，也可以更加稳定“家庭”这个立户形式在现代社会的可持续性。

3. 将生育政策调整与家庭政策完善协调起来，实现从“多生”到“善养”的过渡，保障老龄社会的人口可持续发展

老龄社会的可持续发展依赖于全生命周期人口的发展格局，如果生育率一直过低、人口结构长期失衡，那么大量制度安排从长期来看终将缺乏其可持续性。家庭政策本就具有调节家庭规模与家庭结构的潜在目的，政府应该尽快以家庭为基础完善生育政策的整体性配套措施，让育龄人群不仅“能生”，而且“敢生”和“想生”，从而有效挖掘生育潜力。尽管国家已实行三孩政策，但现阶段其象征意义更大，进一步的调整和过渡必须有时间表，并设计家庭福利与之匹配，以规避社会风险。原有生育政策所催生的大量独生子女家庭面临较大脆弱性。虽然一直有一些针对孕产保健、育儿等方面的政策与项目，却仍未从更高的层次上去考虑各类独生子女家庭的负担与风险，其中尤以其养老风险最为突出，亟须制定新的政策项目对此进行补充。特别是对于失独老年家庭，应尽快推出相应的税收减免或现金补助计划。

不仅如此，老龄社会可持续发展的战略目标还包括提高人口素质和增加人力资本储备，良好的家庭功能是形成和发展优质人力资本的首要环境，增进对家庭（主要是中低收入家庭）的教育及社会投资、提高家庭的人力资本含量无疑是发展家庭能力的必由之路。政府通过家庭政策及其相关的社会政策将社会资源用于改善家庭环境、满足儿童的成长需要，实现从“多生”到“善养”的过渡，从而为社会成员提供形成和发展人力资本、优化人口素质结构的良好环境，这实际上是对经济发展的积极支持与持续投资，也是老龄社会可持续发展的重要基础，并将有效推动“全龄友好”社会建设。

4. 扶持家庭服务业，并将其与社区建设、社会组织培育紧密结合

在城市中，核心家庭的“功能网络化”现象已十分普遍。这不仅凸显家庭服务缺位，还极大制约了老年人力资本的有效开发，甚至在一定程度上导致了推行“推迟退休年龄”政策的困难。政府应着力扶持和规范家庭服务业，并论证政府购

买服务的方式及可操作性。改革开放之后国家从家庭福利中退出时，对相关社会组织缺乏支持和培育，致使很多社会服务只能通过市场的收费服务将成本转嫁于家庭，政府应尽快引导社会组织将帮助不同类型家庭行使责任作为其重要功能。在此基础上，政府应以社区为依托，引导社会组织进入社区，把增强家庭功能的家庭服务作为目前社区建设的最重要切入点。

在关注“民生”的总体政策导向中实施家庭政策，提高家庭政策的行政效率，最终形成一个政府、市场、社区和社会组织都有责任、动力和行动来帮助家庭承担应有责任的制度框架。家庭政策不仅要提升家庭延续传统功能的能力，还应能使中国家庭在生态文明、社会建设和文化传承等长期发展战略中成为主体。而家庭政策也将成为全面建成小康社会的重要抓手之一，以及中国社会稳定和持续发展的基础之一。

总的来说，家庭是最具“中国特性”的本源型基础制度，重视和支持家庭应当成为中国建设老年友好型社会乃至完善老龄社会治理的一个重点和特点，更是探索中国现代社会发展道路的应有之义。政府不仅需要通过家庭政策对社会成员进行福利输送，也需要通过家庭政策来适应新的社会变化，以使中国社会顺利完成传统与现代的历史转换。英国前首相布莱尔曾认为：“家庭是培育人们社会责任感的最重要场所，它与狭隘的自私观水火不容。”（刘骥，2008），当时，欧洲福利国家正经历着老龄化所带来的福利危机，“找回家庭”是一种重要的改革思路，不少学者更由此对东亚国家（尤其是中国）的传统家庭制度表达过不同程度的艳羡。尽管有不少人也由此庆幸，与西方国家相比，中国的家庭从未远离，似乎不需要去“找回来”，但我们必须同时清醒地认识到，今天的中国家庭完全不同于所谓的传统家庭。纯粹的传统家庭养老和照料模式已经找不回来了，完全依赖社会和政府的福利模式在中国也没有发展的可能。我们必须尊重传统并超越传统，在已剧变的社会经济环境中创造出新的家庭与家庭政策，以使我们的社会在老龄化的背景下依然健康持续地运行。

第 6 章　老年友好型社会的基层卫生政策创新

黄蛟灵　胡　湛

人口老龄化已经成为中国社会的常态。养老是其核心议题，是关乎家庭负担的社会问题，也是牵涉到国计民生的重要政策议题。而养老这个核心议题中的难点就是老年人群的医疗问题，医疗与养老有着紧密的关联，这也是“医养结合”的出处。“医养结合”涉及老年人就医的便利性与可及性、医疗服务的连续性与综合性，以及医疗产品的经济适宜性、医疗费用的可负担性等一系列的问题。这就对公共政策的顶层设计与医疗卫生资源的配置提出了较高的要求，如何有效地进行医疗资源的配置从而缓解老龄化带来的巨大医疗需求，同时又抑制医疗费用的快速上升成为全球发达国家以及包括中国在内的发展中国家共同面临的难题。

加强以初级卫生保健为核心的基层卫生系统正是对这一难题的回应。初级卫生保健被世界卫生组织称为最经济适宜的医疗卫生服务模式，其倡导医疗服务的可及性、可负担性及经济适宜性，并且倡导医疗卫生服务就发生在人群所居住的社区内。因此这样一种经济适宜的模式在各国越来越受到重视，成为全球各国共同倡导与努力建设的卫生体系。中国自 2009 年新医改就提出了“保基本、强基层、建机制”的顶层设计，这赋予了基层卫生的重要战略地位。初级卫生保健在经历了十年的探索实践后，面临着重重挑战的同时取得了重要的成绩，逐步形成了具有中国特色的本土化发展经验。本章从中国基层卫生政策的本土化实践开始，从中国特色的家庭医生模式的发展、困境与创新探索展开，并且从供给侧与需求侧两个方面对当前取得的基层卫生服务的基本状况与成效展开论述。

6.1　基层卫生政策的本土化实践

基层卫生在十年发展历程中衍生出了不同的实践探索，但是近年较为典型的是家庭医生制度的建立与发展完善。家庭医生制度目前在全国范围内尤其是上海、北京、浙江等区域已经基本建成并且卓有成效。家庭医生签约服务的重点人群是老年人群尤其是老年慢性病患者人群，由包括家庭医生、护士、公共卫生医师等在内的团队为老年人提供连续、综合的全方位健康管理服务，签约后可享受慢性病长处方、延伸处方、慢性病管理等服务，这在很大程度上满足了老年人群的基本健康需求，助力老年友好型社会的建设。

6.1.1　家庭医生制度的四大要素

家庭医生制度提供的全科医疗被世界卫生组织称为“最经济”“最适宜”的医疗卫生保健服务模式（葛运运等，2013），世界卫生组织提出 80%以上的健康问题可以在基层通过全科医学得到解决。我国自 20 世纪 80 年代引入全科医学的概念，其在一系列政府文件中被反复提及，家庭医生制度在我国医疗卫生体系中的功能定位越来越清晰，即通过家庭医生与居民建立契约关系从而构建社区首诊的有序医疗体系。然而，我国家庭医生制度在本土化发展过程中面临着重重挑战，如何在这些挑战下寻找适合我国国情的家庭医生制度的推进策略是亟须回答的问题。

以全科医疗著称的英国以较低的医疗卫生投入，解决了民众大部分医疗需求，各项健康指标与其他欧美发达国家相似甚至更高（张一飞和冯学山，2013）。英国卫生部部长曾经在以“深化医改，加强慢病防控，可持续健康发展”为主题的中国卫生论坛上指出：“我们比美国的医疗投入少 50%，但是我们却能够为所有英国公民提供医疗服务，这是非常重大的举措，同时也是非常大的成就。”[①]那么以全科医疗为核心的全科医生系统是如何实现这一巨大成就的呢？我们认为有四大要素在其中发挥着重要作用。

第一，强大的人才队伍与严格的培养系统。英国全科医生数量约占医生总数的 50%（徐江荣等，2011），在数量上十分充足。同时英国全科医生的培养以严格出名，英国的全科医学教育采用“5+2+3”模式，即 5 年的临床医学本科教育，2 年的临床基础训练，此外还有 3 年的全科临床培训。5 年的临床医学本科教育与 2 年的临床基础训练适用于所有的医学生，在这 2 年的临床基础训练期间医学生将会在不同的科室进行轮转。3 年全科临床专业培训项目则是针对全科医学生的专业培训，包括 18 个月的综合培训与 18 个月的全科专业培训。也就是说，一名全科医生从医学本科学习到最后从事该职业，需要长达 10 年的医学训练。

第二，有效的激励手段与控费方式。英国每年约有 50%的医学本科毕业生选择全科医学培训项目，在社区从事医疗保健服务，这与职业本身带来的有效激励密切相关，有研究表明英国全科医生的收入约是社会平均薪酬的 4.2 倍（姬军生等，2014）。英国全科医生中 25%直接受雇于国家卫生服务系统（National Health Service，NHS），领取相对固定的薪酬。而剩下 75%的全科医生与 NHS 签订服务协议、自由执业，其收入来源有两部分：一部分是签约人头费（约占 2/3），每签 1 名居民将获得约 80 磅/年的签约服务费。我们按照 2000 名签约对象计算，1 名全科医生签约人头费的年收入约 160 000 磅/年。另一部分由健康质量框架决

① 《英国医保追求完全免费与平等 全科医生是主力》，https://health.sohu.com/20120817/n350893642.shtml [2021-10-10]。

定，主要依据是服务提供的数量与质量。按人头付费的方式与考核依据引导着全科医生通过开展源头健康管理从而控制医疗费用，鼓励医生开展体检等健康监测实现源头健康干预，降低签约者发生疾病的概率。

第三，畅通的转诊机制与有序医疗。英国执行严格的社区首诊制度，只有通过全科医生转诊后才可进入大医院诊疗，否则医院不直接收治，医保也不买单（张雪和杨柠溪，2015）。当然居民也可以直接前往大医院就诊或者使用私人医疗服务，这将产生昂贵的医疗费用，绝大部分居民会选择在全科医生诊所首诊，根据全科医生的判断进行转诊等候。虽然一定程度上受到低效率的批评，但该项制度的严格执行创造了良好的医疗秩序。这对于医生行为的引导也是十分有效的，由于转诊费需要从医生获得的居民人头费中扣除，所以除非有必要，全科医生不会将病人推向大医院，这也是实现控费用的有效手段。此外，转诊机制的内在支撑是发达的信息化，居民具有从出生到死亡的电子病历，可以在各家医院之间传递共享，动态图像也可以实现实时传输（陈荃等，2012）。信息的共通与共享为上下转诊提供了便利，为健康监测跟踪提供了可能性。

第四，居民需求与满意度的服务导向。在英国，居民具有自主选择全科诊所与医生的权利，这种模式引发了不同诊所及全科医生之间的竞争机制，使得全科服务围绕着居民的需求和满意度不断发展与完善，形成良性的互动机制。这背后的运行逻辑是自由职业的全科医生通过与 NHS 签约，开设全科诊所自由执业、自主运营、自负盈亏。从第二个要素我们了解到，全科医生的收入取决于居民的签约数量、服务的数量与质量，这使得诊所会尽力维持居民的签约数量，而维持签约数量的办法是提高服务的质量让居民对诊所提供的签约服务满意。在这样一个内在的逻辑下，诊所围绕“居民的满意度”提供签约服务，开展自由化市场竞争。

6.1.2　家庭医生制度的发展困境

全科医学于 20 世纪 80 年代进入我国，在本土化发展过程中得到了快速成长，同时也遇到了种种障碍。就英国模式的四要素来看我国全科医学还比较薄弱。

第一，巨大的数量缺口与较低的专业素养。按照《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》的要求，每万名居民有 2～3 名合格的全科医生。这意味着要在 2020 年前培养 30 万名全科医生（线福华等，2012），而根据《中国卫生和计划生育统计年鉴 2014》的统计口径，2013 年我国全科医生人数为 145 511 名，也就是仍然存在 15 万多名的缺口。此外，目前我国全科医学人才主要通过转岗培训而来，不少研究认为目前家庭医生队伍普遍存在学历低、职称低、知识结构老化、经验欠缺等问题（刘吉成，2004；李红艳，2006）。

第二，缺乏有效激励措施与控费机制。家庭医生的收入仍然是传统的薪酬制，

尚未建立与服务数量、质量挂钩的绩效考核和激励机制。有研究表明全科医生月平均收入仅为 2000～3000 元，远远低于专科医生的收入（张凯和刘继同，2010）。这是造成家庭医生数量缺口的重要原因之一，较低的收入难以形成较高的职业吸引力，进而导致人才“下不去、留不住”的问题。不少研究提出建立与家庭医生制度配套的医保支付方式（贺小林和梁鸿，2012），但目前该种支付方式尚未形成。家庭医生缺乏激励的同时，也缺乏开展健康管理、实现防治结合从而节省医疗费用的内在动力。

第三，转诊资源与转诊机制的缺位。建立社区卫生服务中心与二、三级医院的上下联动协同机制、构建以家庭医生为主体的有序医疗服务成为越来越清晰的政策目标。然而我国目前二、三级医院与社区卫生服务中心双向转诊、技术指导、业务培训等上下联动、资源整合的平台比较薄弱（张玮，2011）。有学者概括现有的转诊模式有院办院管模式、协议合作模式、医院“托管模式”，而最为常见的是医院和社区卫生服务机构以利益为导向的松散式模式（赵阳等，2010）。可见，目前转诊机制尚未形成长效的制度安排。现实状况是我国家庭医生手中并不掌握转诊资源，而实际调查研究又表明居民具有较高的转诊服务需求（袁立等，2014），服务与需求没有有效匹配。

第四，行政命令工作导向下较低的居民认知与信任。在现行卫生事业单位体制下，家庭医生收入、考核仍然是传统的薪酬制，工作模式也仍然是行政命令导向的。又由于绩效考核激励机制的不足，家庭医生服务仍然停留在以门诊为主的疾病治疗模式中。在这样一种工作模式与服务模式下，居民对于家庭医生的认知十分模糊，信任程度也不高。当然，低信任程度也与家庭医生目前普遍较低的专业素养有关。认知调查显示，17.0%的居民明确表示了解家庭医生制度，30.4%的居民表示只是听说过，52.6%的居民表示不知道该制度（胡霞和黄文龙，2014），而居民就医的第一选择仍然是三级医院而不是社区卫生服务中心（鲍勇等，2012）。

进一步分析可以发现上述四大要素之间相互关联、相互影响。比如，有效激励方式不足导致人才队伍的缺失，人才队伍数量与质量的不足遏制了居民的信任与需求，而低居民信任与需求不足又延缓了转诊机制的建立和绩效激励方式的改革，转诊机制的缺位又反过来导致居民需求的难以满足，绩效方式改革的滞后又引发人才的持续缺失。所以，我国家庭医生制度的推进陷入了混乱的恶性循环中，尚未形成破局之势（孟庆跃，2014）。

6.1.3　家庭医生服务模式本土化探索

上海市虹口区自 2000 年以来进入全科团队建设阶段，各社区卫生服务中心逐

步实现功能转换，打破原地段医院专科服务形式，探索以全科团队服务形式提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育于一体的社区卫生服务，但是其在人才队伍、激励机制、转诊服务、居民认知与满意度等方面仍然存在着重重挑战。自 2012 年起，该区试点探索家庭医生制度。试点改革从全科团队入手，着眼于组织形态的重组，通过组织形态的创新实现服务形态的转变与体制机制的变革，在试点过程中逐步形成 112531 模式。

1. 模式构成

112531 模式由几个子模式组成，它们分别是单元模式、组织模式、服务模式、协同模式与管理模式。为了剖析 112531 模式的内在运行动力与运行逻辑（图 6-1），我们先对这几个子模式加以说明。

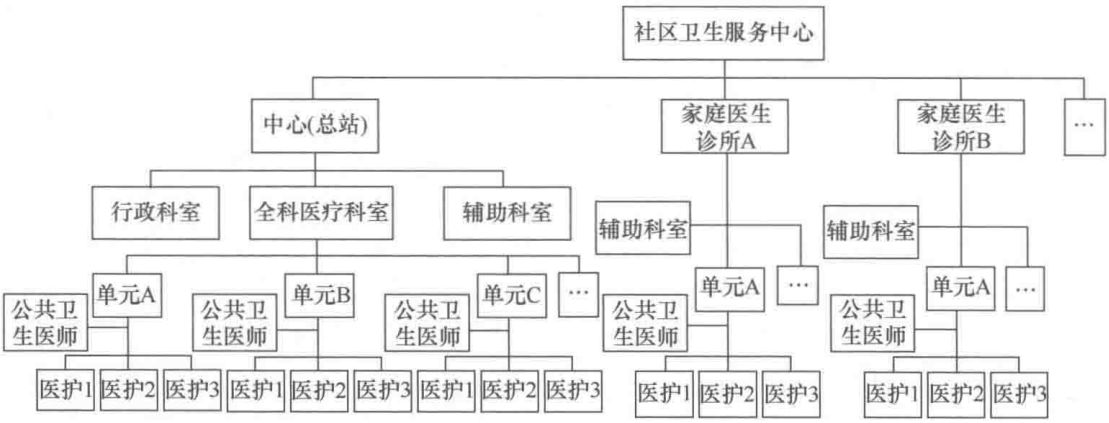


图 6-1　虹口区 112531 模式组织结构图

单元模式：构建以家庭医生为核心的单元。所谓 112531，即 1 名家庭医生与 1 名全科护士（医护组合）负责约 2500 名居民，3 组医护组合与 1 名公共卫生医师构成 1 个家庭医生单元。所以完整的一个家庭医生单元既包含了“医护组合”，也包含了“医卫组合”。为了让单元落地，该区通过改造与重建等手段为每个家庭医生单元提供配套的标准化诊所，按照一定的标准进行硬件设施的配置，为单元模式提供了空间载体。相较于全科团队，该种单元模式下：①每一个医护组合签约 2500 名居民，明确服务对象与责任，“片段式”服务转变为“连续性”服务；② 3 组医护组合之间实现互帮互助，在现有信息化平台下，弥补了家庭医生数量的缺口与能力的不足；③标准化诊所建设类似于英国全科医生诊所，为家庭医生打造了良好的职业化发展平台，为探索自主经营的新做法提供了空间。

组织模式：围绕单元进行机构功能调整。112531 模式打破了原全科团队模式的层级架构，撤除全科团队阶段大量的团队长，每个家庭医生单元设一名“门办主任”与“首席医师”，分别负责行政工作与业务质控工作，压缩了组织的中间

层级。同时，科室的设置也进行了相应调整，社区卫生服务中心围绕家庭医生单元设置行政科室与辅助科室。家庭医生诊所根据辖区人口设置，一般一个诊所内设置一个家庭医生单元，并配有辅助科室的检验、影像、药剂师等辅助人员。在这种组织模式下，围绕家庭医生单元，中心科室的设置发生了转变，形成了以单元为核心的机构形态。

服务模式：单元协商分工共同提供签约服务，实现防治结合。112531 模式打破了传统全科团队分工，家庭医生服务单元内所有医生、护士和防保医生作为一个整体，共同对所负责的社区居民提供疾病管理和健康管理服务。比如，护士也会参与随访、体检、门诊预约、健康教育等工作，而不再是从前板块式的分工。112531 模式给予了医护人员更为灵活的自主性，在签约服务的分工上可以进行团队内部的协商。签约服务的内容主要包括个性化健康管理、预约门诊服务、绿色转诊服务、健康咨询服务、慢性病配药优惠、家庭病床、健康体检。该种服务模式的突破体现在：112531 模式构建了以家庭医生为核心，护士、行政助手、公共卫生医师为辅助的团队，而不再是各自负责与专业分工。辅助人员协助家庭医生共同提供基本医疗与公共卫生服务，真正做到了防治结合。

协同模式：整合政府部门协作支撑，从专科科室入手医疗协同。虹口区卫生和计划生育委员会（现名为虹口区卫生和健康委员会）围绕行政协同进行了制度安排，整合街道办事处/居民委员会、区医疗保险办公室、区人力资源和社会保障局、区财政局、区发展和改革委员会等单位的支撑力量，就各协同方的角色定位在实施方案中进行了规定。此外，在上海市目前正在开展的新一轮基层卫生服务改革的大背景下，虹口区以“社区卫生服务中心—专科科室”为抓手与区域内外医疗机构开展了协同服务。该种协同模式尝试整合政府部门多方协同的力量，同时探索建立医疗协同的制度性安排，而从大医院较热门的科室入手建立协同机制具有可行性。

管理模式：转变绩效激励考核机制。由于服务模式发生了转变，机构就绩效激励与考核进行了探索。尝试构建“捆绑式”定向补助与考核机制。定向补助遵循“按劳分配为基准、效率优先、兼顾公平”的原则，由区卫生和计划生育委员会（现改为区卫生和健康委员会）设置专项补助经费。绩效考核以家庭医生单元整体为对象，从医疗、护理、公共卫生三个维度对家庭医生单元进行服务数量、质量与最终结果的综合考核，凸显“预防为主、防治结合”的服务理念与居民满意度的机制引导。管理模式进行了如下突破：绩效激励方式从原先的“挣工分”转变为与服务数量和质量挂钩，直接引导家庭医生向着居民的需求靠拢，这同时提高了家庭医生及团队成员的收入。

2. 运行机制与模式特征

我们将 112531 模式特征概括为以组织形态创新为突破口的良性循环系统。即以组织形态的创新推动服务形态的转变进而引发体制机制的变革，后者又反过来推动服务形态与组织形态的转变。它的特征显得十分抽象，我们将 112531 模式内在运行机制表象化（图 6-2），从中就能找到这种特征的线索。

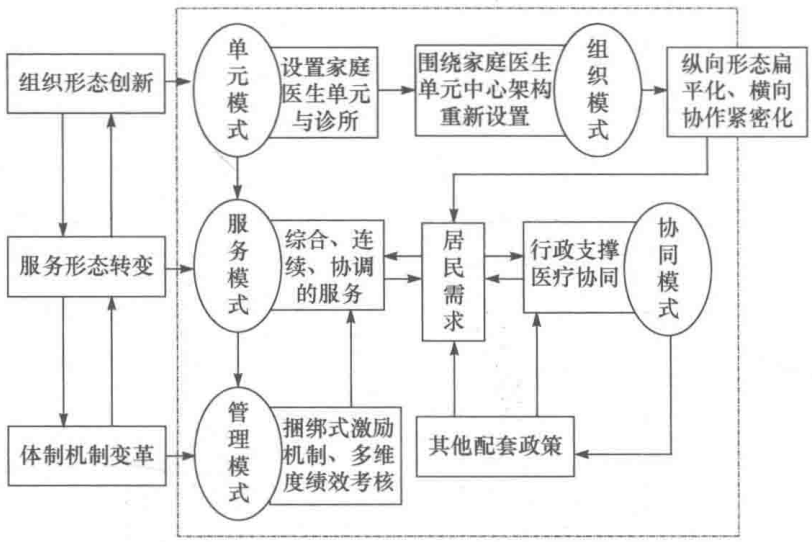


图 6-2　112531 模式内在运行机制

组织形态创新。该区最初与其他地区一样面临着人才队伍的短缺，要实现每万名居民有 2～3 名合格的家庭医生仍然具有挑战。而要激活家庭医生服务的能动性，提供防治结合的健康管理也显得后劲不足。家庭医生单元与家庭医生诊所的建设尝试打破这种人才缺失导致的服务后劲不足。家庭医生单元内融入家庭医生、护士、公共卫生医师三种角色，拥有共同的工作场所，三组医护组合借助信息化系统实现互帮互助，实现每组医护负责 2500 名目标人群的覆盖。而这种单元模式引发了组织模式的变化，即围绕家庭医生单元社区卫生服务中心进行了机构的科室功能的重新设置，这种机构功能的转变压缩了中间层级，赋予了家庭医生单元更强的自主性与协同性。我们将这种单元模式重构以及其引发的组织模式的调整概括为组织形态的创新，组织形态创新体现为“纵向形态扁平化、横向协作紧密化”。

服务形态转变。“纵向形态扁平化，横向协作紧密化”使家庭医生单元内部具有更强的协同性，家庭医生、护士与公共卫生医师开始共同发挥作用，他们在家庭医生诊所的工作平台中更为频繁地互动、更为紧密地协同，逐渐产生职业的自我认同与素养，家庭医生单元能力提升；同时，层级的削弱使得单元具有更强的自主性，行政命令导向在逐渐减弱，单元被赋予更大的自主权，在诊所的平台

上共同完成对于居民疾病的干预、治疗与管理，家庭医生单元的工作导向由最初的行政命令向着居民需求导向转变。单元的协同性与自主性两者共同发生作用，使得服务的内容由过去片段式、防治分离的服务模式逐渐向“综合、连续、协调”的防治结合的服务模式转变。而在此过程中，居民需求导向及单元本身的特征衍生了协同模式，尤其是医疗协同的构建。

体制机制变革。服务的形态与内容发生转变后，绩效考核的方式与激励措施也相应发生转变。比如，考核的对象不再是个人，而是单元，因为服务的结果是单元共同体的工作成效。单元内部再根据绩效激励自主产生分配。再如，考核的内容不再是记工分式的，而是与服务模式相匹配的，112531 模式下，考核内容包含医疗、护理、公共卫生三个维度，考核指标包含签约服务的数量、质量及居民满意度这三个部分。这样的绩效考核与激励方式是与服务模式匹配的结果。除了绩效考核与支付的政策外，其他配套政策（如慢性病长处方）将逐渐生成以保证居民需求的满意及制度更好开展。

内在循环机制。绩效激励与考核方式发生转变后，将赋予单元组织形态更高的活力，使得单元具有更强的服务意识与动力，根据签约居民个体开展个性化服务，越发以居民的需求与满意度为导向，服务方式与内容根据居民的需求不断修正，绩效考核与激励会根据服务模式的转变调整完善，而组织形态也会进一步发生转变，以适应这种服务需求的满足与服务模式的变迁。在这个运行机制中，居民需求成为关键所在，五大模式围绕居民需求发生着变迁。我们注意到，家庭医生在与居民的互动中，围绕着“居民需求”个人技能与职业素养在不断自我完善。目前以单元为核心的诊所模式与英国全科医生诊所类似，我们推测在不久的将来，可能会有更新的组织形态的突破，社区卫生服务中心只发挥平台功能的作用，而诊所将具有更高的自我治理权。

6.2　基层卫生机构人力资源状况分析

6.2.1　基层卫生组织架构

本节以上海市家庭医生改革与示范区长宁区为例，展示上海市家庭医生签约服务组织架构形态（图 6-3）。长宁区社区卫生管理中心于 2006 年 5 月成立，是社区卫生服务综合改革过程中产生的一个新生事物。长宁区社区卫生管理中心受长宁区卫生局（现名为长宁区卫生健康委员会）委托对长宁区内各社区卫生服务中心的业务工作和机制运行的具体事务实施监督管理，在行政上接受长宁区卫生和计划生育委员会（现名为长宁区卫生健康委员会）直接领导、管理、监督和考核。长宁区社区卫生管理中心包括综合办公室、业务质控科、财务监管科等主要

部门，各部门之间虽然分工上存在侧重，但是协作紧密。长宁区疾病预防控制中心、妇幼保健所与长宁区疾病预防控制中心精神卫生分中心等专业机构主要负责社区公共卫生服务的培训、指导，是社区卫生服务中心在公共卫生工作方面的技术支撑。专业机构不能直接布置社区卫生服务中心工作，必须使新任务、新工作通过卫生和计划生育委员会认可，由卫生和计划生育委员会通知社区卫生管理中心纳入社区公共卫生基本服务包范围，新任务和新工作才能得以在社区卫生服务中心顺利开展。

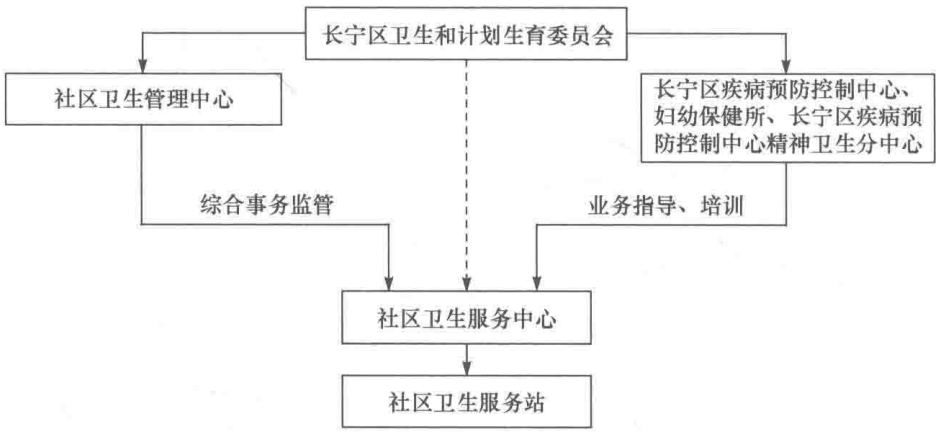


图 6-3　长宁区社区卫生机构组织架构图

社区卫生服务中心的全科医生运作的五大系统分别是中心管理系统、支持系统、医技系统、病房系统和全科团队系统（图 6-4）。其中，全科团队系统由各

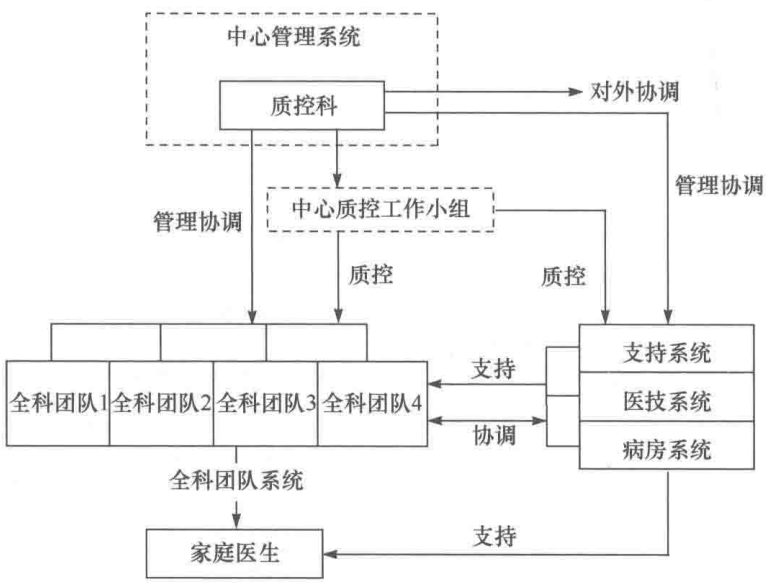


图 6-4　以全科团队为核心的社区卫生服务中心组织框架

个全科服务团队组成，支持系统由临床诊疗门诊、预防保健门诊、中西药房等门诊辅助部门组成，医技系统由医学检验科、医学影像科、功能检查科等科室组成，中心管理系统主要包括行政管理科室、质量控制科室和信息管理科室等部门，病房系统主要是中心病区、医护工作站和病房小药房等部门。五大系统以全科团队系统为核心，通过全科医生、公共卫生医师和护士的有机组合，取长补短，实现服务能力和服务水平的全面提升，在支持、医技、病房、中心管理等系统对全科团队系统的协同配合下，为居民提供医疗、康复、预防、保健、健康教育及计划生育六位一体的服务。每个全科团队负责 3～5 个居委会。

社区卫生服务中心下设社区卫生服务站，中心或站点下设全科团队。目前长宁区家庭医生团队服务形态正在发生转变，分布于中心或者站点的全科团队开始组建家庭医生工作室。而随着这一团队形态的转变，社区卫生服务内部的组织架构也随之转变。中心管理系统整合了人力资源管理、信息中心、资产/财务与经济运行管理、资源管理与对外联系、业务管理几个部分。全科团队系统则转变为服务支持平台，整合了医疗服务支持与公共卫生服务支持。医疗服务支持部分功能：①发展妇科、儿科、口腔科、五官科、中医科、康复科等门诊支持功能；②加强病房和护理系统建设；③完善药房、检验、检查等临床辅助科室或部门的配置。公共卫生服务支持部分功能：加强承担公共卫生服务的职能，开展公共卫生应急处置、场所性及群体性公共卫生服务或项目的管理与实施，公共卫生业务指导与培训。

从原有的组织架构到试行组织架构，存在如下几个规律：①弱化了管理职能，强化了支持功能。试行组织架构打破了自上而下的原有管理体系，突出了社区卫生服务平台功能。②突出了家庭医生的主体地位。家庭医生工作室是家庭医生的执业平台，家庭医生被明确为“社区基本卫生服务于健康管理的责任主体”，通过家庭医生工作室及支持系统“赋予权力，激发活力”。③强调了信息系统的建设。围绕家庭医生工作室进一步做实卫生信息化技术支撑，实现家庭医生工作室—中心—区（管理机构/专业机构）三级信息化管理。④围绕家庭医生工作室整合了部门资源，避免了不同科室的交叉。将原来的支持系统、医技系统、病房系统整合为医疗支持，并单独设立了公共卫生支持系统，围绕家庭医生工作室的主要工作内容提供支持。原来的管理系统主要包括行政管理科室、质量控制科室和信息管理科室等部门，管理系统内部围绕家庭医生工作室进行了细化与职责的再切割，避免了职能分工的重叠，向着更精准、更清晰、更高效的行政管理系统演变。

6.2.2　基层医务人员权益诉求分析

1. 基层医务人员权益诉求状况分析

数据分析结果显示，基层医务人员“提升薪酬”的诉求最高，均值为 4.783（±0.598）。其次为“带薪休假”与“补充公积金”，均值分别为 4.578（±0.851）、4.553（±0.963）。此外，基层医务人员在“外来职工进编”（3.255±1.671）、“学历晋升”（3.797±1.382）、“培训进修”（3.809±1.314）上的诉求最低（表 6-1）。

表 6-1　基层医务人员权益诉求状况

权益需求	打分/个					均值	标准差	排序
	1	2	3	4	5			
提升薪酬	2（0.36%）	4（0.72%）	28（5.05%）	44（7.94%）	476（85.92%）	4.783	0.598	1
日常报销	43（8.29%）	51（9.83%）	96（18.50%）	63（12.14%）	266（51.25%）	3.882	1.351	9
住房补贴	22（4.11%）	14（2.62%）	55（10.28%）	45（8.41%）	399（74.58%）	4.467	1.052	4
外来职工进编	139（28.54%）	23（4.72%）	92（18.89%）	41（8.42%）	192（39.43%）	3.255	1.671	12
子女教育	57（10.90%）	14（2.68%）	81（15.49%）	47（8.99%）	324（61.95%）	4.084	1.363	6
补充公积金	15（2.78%）	15（2.78%）	48（8.91%）	40（7.42%）	421（78.11%）	4.553	0.963	3
培训进修	43（8.11%）	51（9.62%）	106（20.00%）	94（17.74%）	236（44.53%）	3.809	1.314	10
学历晋升	56（10.83%）	41（7.93%）	97（18.76%）	81（15.67%）	242（46.81%）	3.797	1.382	11
职称聘任	25（4.77%）	37（7.06%）	74（14.12%）	79（15.08%）	309（58.97%）	4.164	1.191	5
带薪休假	7（1.31%）	13（2.43%）	47（8.79%）	65（12.15%）	403（75.33%）	4.578	0.851	2
文娱活动	39（7.40%）	23（4.36%）	100（18.98%）	91（17.27%）	274（51.99%）	4.021	1.246	8
意见反馈机制	27（5.54%）	31（6.37%）	95（19.51%）	83（17.04%）	251（51.54%）	4.027	1.211	7

2. 不同职业医务人员的权益诉求结果分析

不同职业医务人员的权益诉求结果显示，家庭医生对“提升薪酬”“补充公

积金”诉求最高，分别为 4.760（±0.665）、4.521（±1.096）；“外来职工进编”诉求较低，均值为 3.139（±1.697）。护士对“提升薪酬”“住房补贴”诉求最高，分别为 4.967（±2.75）、4.686（±0.749）；对“外来职工进编”诉求较低，得分为 3.326（±1.624）。公共卫生医师对“提升薪酬”诉求最高，为 4.841（±0.532），对“外来职工进编”诉求较低，得分为 3.017（±1.727）；技师对“提升薪酬”诉求最高，为 4.773（±0.562），对“外来职工进编”诉求较低，得分为 3.313（±1.688）；可见不同职业的医务工作者对“提升薪酬”诉求最高、对“外来职工进编”的诉求最低。此外，不同职业类别在相关诉求上存在差异。护士在“日常报销”上的诉求高于其他医务人员，技师的“培训进修”诉求更高，而公共卫生医师的“文娱活动”诉求更高（表 6-2）。

表 6-2　不同职业医务人员的权益诉求结果

内容	家庭医生		护士		公共卫生医师		技师		其他		*F* 检验
	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	均值	标准差	
提升薪酬	4.760[1]	0.665	4.967[1]	2.75	4.841[1]	0.532	4.773[1]	0.562	4.776[1]	0.531	3.298（p=0.509）
日常报销	3.500[11]	1.495	4.125[6]	1.182	3.896[8]	1.361	3.928[11]	1.332	3.685[11]	1.477	20.518（p=0.000）
住房补贴	4.217[4]	1.271	4.686[2]	0.749	4.239[4]	1.338	4.500[3]	1.006	4.418[4]	1.031	3.023（p=0.554）
外来职工进编	3.139[12]	1.697	3.326[12]	1.624	3.017[12]	1.727	3.313[12]	1.688	3.358[12]	1.722	40.519（p=0.000）
子女教育	3.948[6]	1.419	4.287[5]	1.179	3.937[7]	1.554	4.011[10]	1.443	3.889[10]	1.475	11.244（p=0.024）
补充公积金	4.521[2]	1.096	4.657[3]	0.756	4.424[3]	1.177	4.477[4]	0.991	4.491[3]	1.037	6.414（p=0.170）
培训进修	3.706[10]	1.349	3.628[11]	1.333	3.765[9]	1.306	4.167[7]	1.191	4.179[7]	1.223	53.389（p=0.000）
学历晋升	3.719[9]	1.386	3.707[10]	1.387	3.646[11]	1.473	4.108[9]	1.269	3.964[8]	1.375	38.098（p=0.000）
职称聘任	4.169[5]	1.127	4.125[7]	1.223	4.000[6]	1.277	4.282[5]	1.181	4.219[5]	1.257	26.961（p=0.000）
带薪休假	4.446[3]	1.000	4.641[4]	0.737	4.591[2]	0.944	4.535[2]	0.954	4.589[2]	0.826	8.378（p=0.079）
文娱活动	3.835[8]	1.363	4.089[9]	1.153	4.030[5]	1.381	4.140[8]	1.139	3.946[9]	1.313	18.928（p=0.001）
意见反馈机制	3.889[7]	1.263	4.101[8]	1.148	3.617[10]	1.354	4.188[6]	1.181	4.218[6]	1.100	29.767（p=0.000）

注：上标为不同职业类别基层医务人员在各个诉求类别上的排序

3. 启示与建议

1）基层医务人员权益诉求上的现状分析

在权益诉求内容上，基层医务人员对“提升薪酬”“带薪休假”“补充公积金”和“住房补贴”有较大的需求。可见，目前基层医务人员工作激励与绩效考核机制有待进一步发挥。

基层医务人员对“外来职工进编”“学历晋升”“培训进修”以及“意见反馈机制”的诉求较低。其主要原因是上海市对基层医疗工作者进行规范化培养，并提供市级医院临床教学基地和社区教学基地实践培训机会很多（卢杉，2016）。还可能是因为基层医疗卫生服务的工作量多、工作强度大、上班时间不规律等特点，导致医务工作者缺少时间和精力关注于自身的发展。其中，对于“外来职工进编”的诉求最弱，这可能是由于本市职工的占比较高（89.5%）。

此外，不同职业类别医务人员的诉求存在显著差异，护士在“日常报销”上的诉求高于其他医务人员，技师的“培训进修”诉求更高，而公共卫生医师的“文娱活动”诉求更高。

不同职业类别医务人员在“培训进修”“日常报销”“文娱活动”等项目上存在显著性差异（p=0.05）。这可能在于不同职业的工作人员工作性质的不同。比如，技师和其他岗位人员由于入职时对学历、职称的要求相对较低，更需要及时有效地进行系统化培训和更新知识系统，对“培训进修”、“学历晋升”和“职称聘任”有一定需求。而家庭医生、公共卫生医师、护士的学历、职称相对较高，参加院内外培训概率较高，故“学历晋升”“培训进修”的需求相对较低。

2）建立合理的薪酬体系，提升医务人员积极性

马斯洛需求层次理论指出：只要解决最基本的生存需求，才能追求更高层次的发展，而工资待遇是基础需求（马斯洛，2008）。家庭医生制度本身就具有社会公益性，在这个过程中，患者不用挂号费，药品零加成，就诊费较低，但是患者的就诊量却较大，而且家庭医生的收入较低，卫生部门的补助较少（张学标等，2010）。这就导致家庭医生干的活多，却得到的报酬少（Friemoth，2014）。世界卫生组织建议，居民中 80%的健康问题可在基层解决（WHO，2009）。但是我国 2014 年、2015 年和 2016 年在基层医疗卫生机构的资金投入占比仅为 9.78%、10.79%、10.84%，投入不足，这也制约了基层医疗工作者的积极性。另外，现有家庭医生的薪酬激励也不到位。以英国为例，2013 年英国的全科医生工资均高于医生整体平均水平，全科医生为医生整体平均工资的 1.8 倍。2017 年，签署基本医疗服务合同的全科医生每名患者的补偿由 80.59 英镑增加至 85.35 英镑，在此标准下，全科医生的薪资将进一步提高（徐静等，2013）。来自社区实践经验指出，家庭医生签约服务应由政府支付、基本医疗保险支付、社会支付、个人支付

四方付费，而我国在非完全服务模式下，家庭医生待遇偏低，付出与收入不成正比（莫海韵，2017）。北京市的经济发展水平接近发达国家，但是全科医生的年期望薪酬中间值为 20.37 万元，护士为 11.44 万元，远高于其当前的实际平均薪酬，这也说明当前我国卫生从业人员的薪酬不能体现其劳动价值。这一问题在一定程度上造成了目前医疗服务体系里过度医疗的存在（桂小海等，2018）。本节也很好地验证了基层医务人员对于“提升薪酬”的诉求最大。

3）提升基层医务人员满意度的对策

完善薪酬体系，科学合理地确定医务人员岗位工资标准，使其劳动报酬与所承担的风险及压力成正比，充分体现医生的劳动价值。建议完善绩效考核标准或建立多样化的绩效分配模式，如分开设立临床医生与辅助科室绩效考核指标，让临床能力强的医务人员能够全身心地扑在临床工作上，在提高医院的医疗业务水平的同时，达到提升患者就诊满意度的目的。平衡医院各项指标，在实现医疗、公卫和管理同步发展的基础上，达到资源优化配置，最终实现社会效益、医院效益和职工个人效益的共赢。建立科学的绩效考核制度，将能力、绩效与工资分配和职位相结合，使考核结果透明、全面、真实。

提升基层卫生人才的满意度，尤其是薪酬待遇，能够增强基层医疗机构对卫生人才的吸引力，提高基层医务人员的稳定性，提升基层医疗机构的服务能力和在患者中的信任度，为分级诊疗制度的推进提供保障。

6.2.3　基层医务人员健康状况分析

在健康中国背景下全民健康被倡导，而基层医务人员自身的健康状况常常被忽略。本节研究发放问卷 591 份，收回 570 份，回复率较高，为 96.6%，其中有效问卷 562 份。其中，家庭医生、护士、公共卫生医师分别为 126 人（22.42%）、215 人（38.26%）、72 人（12.81%）。26.51%的其他类别包括技师、药剂师、心理咨询师、营养师、康复治疗师等，不同的社区卫生服务中心的情况有所不同。如表 6-3 所示，该样本的平均年龄为 37.57 岁（±8.59 岁），而外地户籍医生的平均年龄大于其他人员。79.36%的基层医务人员为女性，99.53%的护士为女性。基层医务人员的婚姻状况各不相同，已婚的占 83.10%，单身的占 14.77%，离婚或丧偶的只占 2%左右。大部分基层医务人员的户口登记在上海，只有 10.50%来自其他省份。基层医务人员的受教育程度较高，90.57%的人具有本科学历，17.46%的家庭医生具有硕士学位；基层医务人员的平均年收入为 8.45 万元，家庭医生年收入为 9.19 万元，高于其他群体（表 6-3）。

表 6-3　基本人口特征

变量		家庭医生		护士		公共卫生医师		其他		合计	
		数量或均值	占比或标准差	数量或均值	占比或标准差	数量或均值	占比或标准差	数量或均值	占比或标准差	数量或均值	占比或标准差
性别	男性	49 人	38.89%	1 人	0.47%	12 人	16.67%	54 人	36.24%	116 人	20.64%
	女性	77 人	61.11%	214 人	99.53%	60 人	83.33%	95 人	63.76%	446 人	79.36%
婚姻状况	单身	18 人	14.29%	18 人	8.37%	7 人	9.72%	40 人	26.85%	83 人	14.77%
	已婚	104 人	82.54%	195 人	90.70%	63 人	87.50%	105 人	70.47%	467 人	83.10%
	离婚	3 人	2.38%	1 人	0.47%	2 人	2.78%	3 人	2.01%	9 人	1.60%
	丧偶	1 人	0.79%	1 人	0.47%	0 人	0.00%	1 人	0.67%	3 人	0.53%
户口	本市本街道	30 人	23.81%	46 人	21.40%	14 人	19.44%	11 人	7.38%	101 人	17.97%
	本市其他街道	81 人	64.29%	154 人	71.63%	54 人	75.00%	113 人	75.84%	402 人	71.53%
	其他省份	15 人	11.90%	15 人	6.98%	4 人	5.56%	25 人	16.78%	59 人	10.50%
教育水平	高中或更低	4 人	3.17%	16 人	7.44%	4 人	5.56%	3 人	2.01%	27 人	4.80%
	本科	100 人	79.37%	199 人	92.56%	67 人	93.06%	143 人	95.97%	509 人	90.57%
	硕士或更高	22 人	17.46%	0 人	0.00%	1 人	1.39%	3 人	2.01%	26 人	4.63%
年龄/岁		40.03	±8.49	36.37	±7.42	39.87	±8.11	36.10	±9.75	37.57	±8.59
年收入/万元		9.19（1.31）	±2.65（±0.38）	7.98（1.14）	±1.77（±0.25）	8.14（1.16）	±1.82（±0.26）	8.64（1.23）	±2.78（±0.39）	8.45（1.20）	±2.33（±0.33）
合计/人		126		215		72		149		562	

注：其他指的是其他基层医务人员，包括技师、心理咨询师、营养师、康复治疗师等

基层医务人员健康状况。描述性分析显示，基层医务人员在自评健康方面存在显著差异。例如，18.25%的家庭医生认为自己的健康状况良好或优秀，而 20.00%的护士、26.39%的公共卫生医师和 29.06%的其他基层医务人员报告为健康状况良好或优秀。然而，家庭医生对自己的健康评估最差（一般、差或非常差），这表明他们的自评健康存在明显两极分化。较为一致的发现是，大多数不同职业类别的基层医务人员将自己的健康评价为一般。总的来说，护士和其他基层医务人员似乎健康状况更好（表 6-4）。

表 6-4　基层医务人员健康状况

自评健康	家庭医生	护士	公共卫生医师	其他
非常差	0.79%	0.93%	6.94%	0.68%
差	15.08%	7.91%	13.89%	10.14%
一般	65.87%	71.16%	52.78%	60.14%
良好	15.87%	18.14%	20.83%	25.68%
优秀	2.38%	1.86%	5.56%	3.38%
合计/人	126	215	72	149
卡方检验	29.3467（$p = 0.000$）			

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

在控制了社会经济特征和工作场所环境后，我们进一步进行了模型测试，以区分不同基层医务人员的健康差异。我们观察到工作环境与自评健康状况之间存在明显的正向关系。具体来说，对工作场所的信息技术（information technology，IT）系统评价为“好”者的自评健康是评价为“非常差”的人的 2.95 倍。对其文化环境评价“非常好”者的自评健康是报告其文化环境“非常差”的人的约 4.74 倍。对其绩效激励评价较好的基层医务人员似乎有更好的健康状况，尽管这种关系似乎没有显示出梯度。然后，我们关注了职业类别对自评健康的影响，这与我们的描述性发现相当一致。相比于家庭医生，其他类别的初级保健医生健康状况更好。例如，以家庭医生作为参照组，其他类别的基层医务人员的比值比（odds ratio，OR）为 2.034，护士的 OR 为 1.980。此外，我们发现男性的健康状况比女性更佳（OR=2.428，95% CI 为 1.480～3.983），而来自其他省份的基层医务人员的自评健康是本地基层医务人员的 2.370 倍（表 6-5）。

表 6-5　基层医务人员的自评健康 logistic 回归分析

变量			模型 1			模型 2			模型 3		
			OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI
基本人口特征	年龄		0.969**	0.007	0.947～0.991	0.98	0.112	0.957～1.005	0.985	0.231	0.960～1.009
	性别		1.886**	0.004	1.222～2.909	2.047**	2.047	1.268～3.302	2.428***	0.000	1.480～3.983
	户口（参照组：本市本街道）	本市其他街道	1.429	0.129	0.901～2.263	1.319	0.246	0.826～2.105	1.313	0.294	0.789～2.184
		其他省份	2.602**	0.006	1.318～5.139	2.612**	0.006	1.312～5.200	2.370*	0.022	1.133～4.958
	教育水平（参照组：高中或更低）	本科				2.029	0.111	0.850～4.843	1.866	0.176	0.755～4.611
		硕士及以上				3.089	0.076	0.888～10.741	3.407	0.065	0.928～12.495
	年收入/万元					0.977**	0.003	0.962～0.992	0.983*	0.032	0.967～0.998
	职业类别（参照组：家庭医生）	护士				1.950*	0.013	1.154～3.293	1.980*	0.016	1.136～3.452
		公共卫生医师				1.641	0.140	0.849～3.170	1.593	0.192	0.791～3.210
		其他				1.674	0.054	0.992～2.825	2.034*	0.013	1.163～3.560
工作环境	信息技术系统（参照组：非常差）	差							0.591	0.340	0.199～1.743
		一般							2.219	0.136	0.777～6.336
		好							2.950*	0.049	1.002～8.675
		非常好							2.059	0.194	0.692～6.120
	文化环境（参照组：非常差）	差							3.519	0.080	0.861～14.378
		一般							1.711	0.408	0.479～6.106
		好							3.324	0.066	0.925～11.944
		非常好							4.738*	0.016	1.329～16.884

续表

变量			模型 1			模型 2			模型 3		
			OR	p	95% CI	OR	p	95% CI	OR	p	95% CI
工作环境	绩效激励（参照组：非常差）	差							2.223	0.061	0.964～5.119
		一般							2.602*	0.012	1.236～5.476
		好							2.360*	0.044	1.022～5.447
		非常好							1.491	0.551	0.401～5.534
频数统计			561			561			558		
最大似然估计值			−552.7			−544.6			−508		
BIC			1175			1196.7			1250.1		
伪 R^2			0.0269			0.0411			0.1015		

注：不显著变量包括婚姻状况、办公室环境、设施设备，表格中只展示了显著变量确保表格的整洁和简短。BIC 表示 Bayesian information criterion（贝叶斯信息准则），CI 表示 confidence interval（置信区间）

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

不同基层医务人员健康相关因素分析。我们将模型分为四个子模型，重点关注四类职业，其中所有社会人口学、社会经济和工作场所环境变量都得到控制。我们得到了一些有趣的发现：工作场所环境是基层医务人员健康的重要预测因素，尽管这一点因职业类别而异。对于家庭医生来说，工作场所环境中的设施和设备是唯一显著的变量，即“好”评价的 OR 是“非常差”评价的 235.733 倍。令人惊讶的是，家庭医生实践中的所有项目对家庭医生的自评健康都没有显著影响。办公室环境对护士有负相关影响，而信息技术系统和绩效激励则对其有正面影响。在护士中，观察到一个显著的影响，具体而言，由于签约服务而强烈感到工作量增加的护士的健康状况较差。也就是说，感受到“比较强”的压力的护士 OR 比“无”压力的护士 OR 高 12.0%。同样，感受到较强工作压力的工作者的自评健康也较差，即与“无”压力相比，“一般”、“比较强”和“非常强”的工作压力评价者的自评健康 OR 分别为 0.002、0.001 和 0.000。公共卫生医师对工作环境的评价没有那么显著，但是对社会支持变量十分敏感。具体来说，考虑到单位增加团队/部门支持，OR 是增加前的 10.700 倍。然而，政策支持对公共卫生医师的自评健康有负相关影响。对于其他基层医务人员而言，家庭医生实践对他们的健康状况影响不大，但工作场所的环境，尤其是文化环境、设施设备，对他们的健康状况影响很大。具体来说，与那些对设施和设备评价为“非常差”的人相比，评价为“差”的人的 OR 是 138.335 倍。同样，对文化环境评价为“好”的人是评价为“非常差”的 25.980 倍。此外，本节研究还发现信息技术系统与健康状况之间存在负相关关系（表 6-6）。

6.2.4　基层医务人员满意度分析

在 2000 年，《关于城镇医药卫生体制改革指导的意见》中，明确提出要形成规范的社区卫生服务组织和综合医院、专科医院双向转诊制度；社区卫生服务组织主要从事预防、保健、健康教育、计划生育，以及常见病、多发病、诊断明确的慢性病的治疗和康复（张双德和郝海，2005）。因此与其他医务工作者相比，基层医务人员面临的工作往往更加烦琐和复杂，他们承担着更大的责任和风险。国内现有的研究多是从患者的角度出发，力图通过提高患者的满意度来提高社区卫生服务的成效。但基层医务人员的工作满意度直接关系到服务的质量，只有少数学者对基层医务人员的心理健康（薛慧英等，2003；李驰等，2014）和职业倦怠（马良和丁璐，2017；张建等，2018；蔡景泉和李文秀，2018）进行了研究，对不同职业的医务人员的工作满意度的关注较少。本节研究分析了不同职业类别的基层医务人员的工作满意度，从而为提高基层医务人员的工作满意度提出相应的对策建议。

表 6-6 不同职业类别基层医务人员自评健康的 logistic 回归分析

变量			模型 4（家庭医生）			模型 5（护士）			模型 6（公共卫生医生）			模型 7（其他）		
			OR	*p*	CI	OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI
基本人口与社会经济地位特征	年龄		0.942	0.173	0.865～1.026	1.018	0.587	0.954～1.086	0.895	0.103	0.783～1.023	1.016	0.577	0.962～1.073
	性别		3.048	0.061	0.951～9.770	83.929	0.060	0.824～8 545.770	0.113	0.087	0.009～1.376	5.646**	0.001	1.994～15.990
	教育水平（参照组：高中或更低）	本科	1.918	0.677	0.090～40.963	14.098**	0.004	2.362～84.143	0.334	0.562	0.008～13.591	0.464	0.628	0.021～10.306
		硕士及以上	4.388	0.366	0.178～108.383	—	—	—	4.10×10^{5}	1	—	0.197	0.485	0.002～18.857
	年收入/万元		0.972	0.200	0.931～1.015	0.983	0.378	0.946～1.021	0.858**	0.003	0.776～0.948	1.006	0.764	0.970～1.043
工作环境	办公室环境（参照组：非常差）	差	0.218	0.460	0.004～12.405	0.001*	0.003	0.000～0.096	0.207	0.714	0.000～943.872	1.672	0.734	0.087～32.314
		一般	0.165	0.331	0.004～6.233	0.012	0.053	0.000～1.062	0.333	0.812	0.000～2 927.996	0.915	0.938	0.096～8.728
		好	0.050	0.100	0.001～1.769	0.018	0.093	0.000～1.954	0.033	0.401	0.000～95.050	1.077	0.951	0.102～11.394
		非常好	0.121	0.288	0.002～5.933	0.014	0.069	0.000～1.398	0.357	0.759	0.000～261.548	1.448	0.778	0.111～18.952
	设施设备（参照组：非常差）	差	86.194	0.067	0.729～10 192.560	19.489	0.228	0.156～2 439.597	9.80×10^{8}	0.998	—	138.335*	0.03	1.601～11 956.5
		一般	98.905	0.074	0.637～15 346.800	11.415	0.346	0.072～1 804.725	2.30×10^{10}	0.998	—	4.919	0.395	0.125～193.59
		好	235.733*	0.044	1.158～47 999.460	8.316	0.422	0.047～1 458.228	3.40×10^{11}	0.997	—	12.233	0.173	0.333～449.672
		非常好	89.389	0.101	0.415～19 245.420	7.419	0.424	0.054～1 013.823	3.30×10^{9}	0.998	—	11.600	0.170	0.350～384.606
	信息技术系统（参照组：非常差）	差	1.191	0.908	0.061～23.227	21.061*	0.036	1.214～365.342	6.497	0.388	0.093～455.615	0.006***	0.001	0.000～0.119
		一般	2.273	0.581	0.123～42.074	37.716**	0.008	2.550～557.840	9.427	0.256	0.196～453.069	0.047*	0.028	0.003～0.724
		好	8.584	0.191	0.343～214.654	20.968*	0.027	1.408～312.282	0.544	0.779	0.008～37.761	0.091	0.074	0.007～1.257
		非常好	5.573	0.322	0.186～66.734	10.132	0.081	0.752～136.434	13.795	0.188	0.278～683.983	0.051*	0.042	0.003～0.897

续表

变量			模型4（家庭医生）			模型5（护士）			模型6（公共卫生医生）			模型7（其他）		
			OR	*p*	CI	OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI
工作环境	文化环境（参照组：非常差）	差	0.004	0.218	0.000～26.694	6.079	0.351	0.137～269.703	23.026	0.194	0.202～2 623.828	7.911	0.251	0.232～269.645
		一般	0.007	0.26	0.000～39.301	0.600	0.799	0.012～30.763	28.227	0.102	0.517～1 541.532	1.414	0.810	0.085～23.629
		好	0.003	0.226	0.000～33.659	1.618	0.816	0.028～92.432	2.525	0.458	0.218～29.220	25.980*	0.029	1.391～485.186
		非常好	0.010	0.334	0.000～114.362	4.080	0.513	0.061～275.038	—	—	—	13.162	0.098	0.624～277.621
	绩效激励（参照组：非常差）	差	1.933	0.583	0.184～20.310	10.106*	0.026	1.327～76.956	0.148	0.452	0.001～21.335	1.302	0.817	0.139～12.220
		一般	1.365	0.786	0.144～12.940	10.752*	0.017	1.524～75.866	0.686	0.860	0.011～44.618	1.013	0.989	0.163～6.311
		好	0.911	0.942	0.075～11.052	19.065**	0.007	2.252～161.370	3.923	0.549	0.045～343.590	0.633	0.655	0.085～4.722
		非常好	—			0.257	0.356	0.014～4.595	0.048	0.305	0.000～15.836	1.771	0.673	0.124～25.207
家庭医生实践	家庭医生签约服务带来的工作压力（参照组：无）	非常小	—			0.181	0.115	0.022～1.514	0.069	0.257	0.001～7.005	1.264	0.748	0.302～5.295
		一般	42.355	0.234	0.089～20 182.05	0.169	0.052	0.028～1.016	0.303	0.556	0.006～16.075	0.848	0.825	0.197～3.657
		比较强	13.309	0.437	0.020～9 066.505	0.120*	0.030	0.018～0.815	0.151	0.358	0.003～8.497	0.595	0.523	0.120～2.936
		非常强	67.059	0.215	0.087～51 873.88	0.111	0.051	0.012～1.012	0.010	0.086	0.000～1.931	0.179	0.106	0.022～1.441
	工作压力（参照组：无）	比较小	（base）			0.096	0.190	0.003～3.193	0.534	0.799	0.004～67.792	0.596	0.752	0.024～14.782
		一般	0.409	0.481	0.034～4.902	0.002***	0.000	0.000～0.055	0.611	0.764	0.025～15.160	0.355	0.51	0.016～7.745
		比较强	0.157	0.203	0.009～2.725	0.001***	0.000	0.000～0.033	6.049	0.308	0.190～192.356	0.239	0.393	0.009～6.402
		非常强	0.225	0.438	0.005～9.769	0.000***	0.000	0.000～0.006	—	—	—	0.061	0.155	0.001～2.885
	团队/部门支持		0.778	0.644	0.269～2.255	0.451	0.109	0.170～1.194	10.700*	0.012	1.700～67.352	0.856	0.741	0.340～2.153
	政策支持		1.515	0.259	0.736～3.118	0.832	0.718	0.307～2.253	0.155**	0.008	0.039～0.614	1.070	0.883	0.438～2.614

续表

变量	模型 4（家庭医生）			模型 5（护士）			模型 6（公共卫生医生）			模型 7（其他）		
	OR	*p*	CI	R	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI	OR	*p*	95% CI
频数统计	124			214			72			148		
最大似然估计值	−88.8			−122.6			−54.4			−102.9		
BIC	413.9			513.6			309.7			460.6		
伪 R^2	0.266 8			0.343 2			0.412 1			0.328 4		

注：不显著变量包括婚姻状况、户口、工作时长、工作强度、社区卫生服务中心支持，此表只展示显著变量以确保表格的简洁

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

1. 基层医务人员工作满意度

基层医务人员对基层工作的满意度整体较高，得分均在 3 分以上。基层医务人员最满意的首先是办公环境，平均得分为 3.968 分；其次主要包括中心支持协同（3.950 分）、医疗设备（3.932 分）、部门或团队支持协同（3.929 分）、团队建设（3.911 分）。基层医务人员普遍最不满意的是收入与绩效，平均得分 3.032 分；其次主要是加班机制（3.569 分）、休假制度（3.628 分）、信息系统（3.633 分）、进修培训（3.661 分）（表 6-7）。从调查数据可以看出，基层医务人员对外部工作环境的满意度较高，对于有关自身发展的项目满意度较低。

表 6-7　基层医务人员满意度

项目	非常不满意/人	不满意/人	一般/人	满意/人	非常满意/人	均值/分	标准差	排序
办公环境	29（5.16%）	41（7.30%）	110（19.57%）	121（21.53%）	261（46.44%）	3.968	1.191	1
医疗设备	13（2.32%）	39（6.96%）	137（24.46%）	155（27.68%）	216（38.57%）	3.932	1.056	3
信息系统	25（4.46%）	59（10.52%）	180（32.09%）	130（23.17%）	167（29.77%）	3.633	1.144	13
收入与绩效	71（12.63%）	96（17.08%）	217（38.61%）	100（17.79%）	78（13.88%）	3.032	1.188	16
组织管理	10（1.78%）	42（7.47%）	144（25.62%）	168（29.89%）	198（35.23%）	3.893	1.029	6
团队建设	8（1.42%）	46（8.19%）	137（24.38%）	168（29.89%）	203（36.12%）	3.911	1.027	5
分工协同	10（1.78%）	48（8.54%）	157（27.94%）	163（29.00%）	184（32.74%）	3.824	1.039	7
职称晋升	18（3.21%）	43（7.66%）	175（31.19%）	159（28.34%）	166（29.59%）	3.734	1.065	10
进修培训	22（3.92%）	56（9.98%）	179（31.91%）	137（24.42%）	167（29.77%）	3.661	1.121	12
精神文化活动	17（3.02%）	40（7.12%）	165（29.36%）	149（26.51%）	191（33.99%）	3.813	1.076	9
加班机制	29（5.16%）	59（10.50%）	190（33.81%）	131（23.31%）	153（27.22%）	3.569	1.145	15
休假制度	23（4.09%）	65（11.57%）	172（30.60%）	140（24.91%）	162（28.83%）	3.628	1.135	14
中心支持协同	8（1.42%）	42（7.47%）	144（25.62%）	144（25.62%）	224（39.86%）	3.950	1.040	2

续表

项目	非常不满意/人	不满意/人	一般/人	满意/人	非常满意/人	均值/分	标准差	排序
反馈投诉机制	16（2.85%）	42（7.47%）	170（30.25%）	133（23.67%）	201（35.77%）	3.820	1.089	8
部门或团队支持协同	9（1.60%）	40（7.12%）	154（27.40%）	138（24.56%）	221（39.32%）	3.929	1.045	4
政策支持	23（4.10%）	57（10.16%）	162（28.88%）	131（23.35%）	188（33.51%）	3.720	1.15	11

2. 不同职业的基层医务人员的工作满意度

从表 6-8 的统计数据来看，不同职业的基层医务人员的工作满意度在不同指标上存在差异。从基层医务人员不同职业类型来看，家庭医生对“办公环境”的满意度最高，平均得分为 4.119 分；护士对“中心支持协同”的满意度最高，平均得分为 3.981 分；公共卫生医师对“组织管理”最满意，平均得分为 4.097 分；技师对“团队建设”最满意，平均得分为 3.989 分；其他基层医务人员对“医疗设备”最满意，平均得分为 4.100 分；但这五类不同职业的基层医务人员普遍对“收入与绩效”最不满意，它们的平均得分分别为 2.833 分、3.140 分、3.083 分、2.865 分、3.217 分，其中家庭医生给出的工作满意度平均得分最低。除了关注“收入与绩效”外，家庭医生和公共卫生医师对“加班机制”和“休假机制”的满意度也较低，家庭医生在“加班机制”和“休假机制”上给出的工作满意度平均得分分别为 3.452 分、3.484 分；公共卫生医师的平均得分分别为 3.278 分、3.319 分；公共卫生医师对这二者的满意度要低于家庭医生。护士对“信息系统”和“加班机制”的满意度较低，平均得分为 3.659 分、3.673 分。技师对“进修培训”和“政策支持”较不满意，它们的平均得分依次为 3.393 分、3.629 分。其他基层医务人员对“进修培训”和“加班机制”的满意度较低，平均得分分别为 3.450 分、3.633 分。

表 6-8　不同职业的基层医务人员工作满意度

内容	家庭医生		护士		公共卫生医师		技师		其他		*F* 检验
	均值/分	标准差	均值/分	标准差	均值/分	标准差	均值/分	标准差	均值/分	标准差	
办公环境	4.119	1.150	3.977	1.119	3.917	1.319	3.831	1.208	3.867	1.334	5.105（p=0.277）
医疗设备	3.904	1.035	3.883	1.082	4.056	0.977	3.865	1.047	4.100	1.115	1.536（p=0.820）
信息系统	3.640	1.180	3.659	1.084	3.403	1.206	3.652	1.099	3.750	1.257	3.260（p=0.515）

续表

内容	家庭医生		护士		公共卫生医师		技师		其他		F 检验
	均值/分	标准差	均值/分	标准差	均值/分	标准差	均值/分	标准差	均值/分	标准差	
收入与绩效	2.833	1.151	3.140	1.096	3.083	1.219	2.865	1.217	3.217	1.415	7.092（p=0.131）
组织管理	3.778	0.954	3.864	1.028	4.097	1.023	3.921	1.003	3.933	1.205	4.754（p=0.314）
团队建设	3.849	0.947	3.850	1.037	4.083	1.097	3.989	0.971	3.917	1.139	4.125（p=0.389）
分工协同	3.706	1.028	3.813	1.027	3.931	1.105	3.921	0.944	3.817	1.157	3.6115（p=0.461）
职称晋升	3.664	0.967	3.748	1.101	3.931	1.025	3.674	1.020	3.667	1.230	5.881（p= 0.208）
进修培训	3.704	1.008	3.790	1.078	3.694	1.083	3.393	1.114	3.450	1.443	12.277（p=0.015）
精神文化活动	3.754	1.009	3.869	1.049	3.847	1.122	3.787	1.005	3.717	1.342	8.921（p= 0.063）
加班机制	3.452	1.157	3.673	1.103	3.278	1.153	3.663	1.076	3.633	1.301	3.344（p= 0.502）
休假制度	3.484	1.231	3.710	1.088	3.319	1.059	3.775	1.063	3.767	1.212	4.3351（p=0.363）
中心支持协同	3.913	0.996	3.981	1.061	3.944	1.019	3.876	1.020	4.017	1.127	1.5441（p=0.819）
反馈投诉机制	3.778	1.057	3.888	1.099	3.750	1.058	3.876	1.076	3.883	1.180	1.1864（p=0.880）
部门或团队支持协同	3.921	1.001	3.939	1.053	3.861	1.179	3.921	0.956	3.983	1.097	4.2708（p=0.371）
政策支持	3.544	1.154	3.832	1.142	3.694	1.218	3.629	1.091	3.833	1.152	0.967（p=0.915）

从不同工作内容维度来看，家庭医生、护士、公共卫生医师、技师和其他基层医务人员在“进修培训”上存在着显著性差异（p=0.015），技师对“进修培训”的满意度最低，平均得分为 3.393 分，其次是其他类型的医务工作者。不同职业类型基层医务人员在其他 15 个内容维度上的满意度没有明显差异（表 6-8）。

3. 启示与建议

1）基层医务人员整体满意度情况

本节研究结果显示基层医务人员的工作满意度在 16 个工作维度上的各自平均得分都在 2～5 分，满意度较高的 5 个维度依次为医疗设备、中心支持协同、办公环境、团队建设、部门或团队支持协同。这表明基层医务人员对工作环境和管理的满意度较高（邱德星等，2007），一方面，近年来政府不断加大对基层公共卫生的投入，为基层医务人员提供了较好的硬件设施和工作环境；另一方面，在医疗卫生事业改革过程中，社区卫生服务中心管理模式的变革提高了团队和部门的支持与协同能力。

收入与绩效、加班机制、进修培训、休假制度、信息系统等还存在着一些问

题，导致基层医务人员的满意度较低。基层医务工作者普遍对收入与绩效的打分最低，收入与绩效直接关系到基层医务人员的切身利益，不合理的收入与绩效会降低基层医务人员的工作满意度，这与其他学者的研究结论也相一致（胡静超等，2007；周湘涛等，2009；张恩宇和陈娟，2011）。目前，我国社区基层医务人员的工作量大、工作强度大、工作时间长，缺乏休假和加班奖励机制，现有的工资水平与基层医务人员的实际付出和期望不符；已有的进修培训机制、绩效工资比例和考核机制不完善，不能对社区基层医务人员产生较好的激励作用，这可能造成基层医务人员疲于工作，以及社区卫生服务中心缺乏学科带头人和学术骨干人才（王丽敏，2005）。

2）不同职业的基层医务人员的满意度情况

不同职业基层医务人员的工作满意度存在差异。家庭医生对办公环境、部门或团队支持协同、中心支持协同的满意度较高；对收入与绩效、加班机制、休假制度的满意度较低。护士对中心支持协同、办公环境、部门或团队支持协同的满意度较高；对收入与绩效、信息系统、加班机制的满意度较低。公共卫生医师对组织管理、团队建设、医疗设备很满意；对收入与绩效、加班机制、休假制度较不满意。技师对团队建设、组织管理、分工协同较为满意；对收入与绩效、进修培训、政策支持、信息系统较不满意。其他基层医务人员对医疗设备、中心支持协同、部门或团队支持协同很满意，对收入与绩效、进修培训、加班机制很不满意。

家庭医生和公共卫生医师对加班机制和休假制度的满意度较低。家庭医生和公共卫生医师除了要承担基本的诊疗服务外，还要从事有关疾病预防、医疗保健及计划生育等方面的工作（齐晓琳等，2006），他们的工作量较大、工作时间较长、工作强度大，经常需要加班，导致个人时间经常被占用，因此，这两类职业的基层医务人员对加班和休假制度的调整有较大的需求。而在此次调查中，公共卫生医师的占比明显低于家庭医生，这也表明相比于家庭医生，公共卫生医师的人数较少，可能存在人手不足，加班更多的情况，因此公共卫生医师的满意度得分要低于家庭医生。

护士和技师对信息系统的满意度较低。护士和技师需要协助医生开展医疗工作，因此护士和技师的加班时间与医生的加班时间往往存在一致性，经常性加班降低了护士和技师对加班机制的满意度。而在双向转诊制度的推广和实施过程中，护士和技师除了需要协助开展咨询、辅导、接诊、治疗和医疗保健工作，还要负责医疗文件及患者资料等信息的整理，因此信息系统的好坏也直接关系到护士和技师的工作满意度。而技师作为技术导向型的职业类别，则更需要定期加强对相关技术的学习，因此对进修培训机制的要求更高。

进修培训机制在不同职业类别的基层医务人员中存在显著性差异。本节研究

的结果显示，不同职业的基层医务人员在进修培训上满意度得分的差异具有统计学意义，这在以往的研究中并没有提及。刘姗姗等（2016）在对浦东新区基层医务人员的研究中发现基层医务人员对培训的满意度较高，但其主要是从基层医务人员对患者进行培训的效果进行评估，并没有对基层医务人员自身接受进修培训的满意度情况进行测量。在基层医务人员队伍中，相比于其他职业类别，技师的技术工作具有严格的操作规程，需要不断学习新技术和新疗法，更新业务训练和学习内容，但由于社区卫生服务中心的学习资源有限，技师的专业技术发展也受到一定的阻碍。因此，技师对于能够获得学习和提升机会的进修培训机制的期望更高。

3）提升基层医务人员工作满意度的政策建议

提升基层医务人员的工资待遇，完善绩效考核机制。在 2017 年，卫生部再次强调要深化基层绩效考核，提高奖励性绩效工资比例。但目前，社区基层医务人员工作收入与工作人员的付出不相匹配，这严重影响了基层医务人员的工作积极性，造成人才流失（何毅平，2007）。完善基层医务人员的绩效工资首先应该在注重公平性的基础上，提高基层医务人员的薪酬，建立与基层医务人员的劳动价值相匹配的收入增长机制；可以在提高薪酬的基础上，增加多种形式的福利机制，如带薪休假和外出培训等，帮助基层医务人员寻找工作和生活的平衡点，发挥收入与绩效的激励作用，调动基层医务人员的积极性（李永斌等，2013）。同时，要进一步完善基层医务人员的职称评审工作，健全基层卫生人才考评和激励机制，为各类职业的基层医务人员提供公平的发展空间。

完善基层医务人员的进修培训机制。从本节的研究结果中可以看出，上海市某区社区卫生服务中心的 35 岁以下的基层医务人员和技术人员较少，学历为本科及以上约占 95%，工作资历较深。要培养社区卫生服务的专业性人才，首先，应该继续贯彻落实《关于加强城市社区卫生人才队伍建设的指导意见》，加强与高校合作，注重全科医学人才的培养，建立全科医生的实践培养机制，通过开设相关课程，培养专门的基层社区卫生服务人才；其次，基层医务工作人员往往具有强烈的学习愿望，通过链接各高校和医院的优质培训资源，为基层医务人员（特别是技师）提供更多的学习和培训机会，有利于帮助基层医务人员获得提升自我和实现自我价值的途径（由晓柳等，2007）；最后，也要在中心建立具有连续性的专科支持体系，为医务工作者定期开展有针对性的学习和培训，提高服务的适应性，培养社区卫生服务的专业性人才（梁鸿等，2010）。

优化社区卫生服务中心的信息管理系统。信息化管理是社区卫生服务的发展方向，但目前我国社区患者的信息还不能很好地实现与社区卫生服务中心的对接，这不仅没有提高基层卫生服务的效率，反而加重了基层医务人员的工作量。借鉴各地已初见成效的社区卫生信息管理系统，首先，通过可操作化的具体政策措施，

优化社区的卫生信息管理系统，实现社区患者档案与社区卫生服务的对接，通过资源共享、实时更新和反馈，减少基层医务人员多余的工作量；其次，通过对护士及技师等工作人员的信息化培训，提高社区卫生管理和服务效率。

6.3　家庭医生的健康与费用管理成效分析

6.3.1　家庭医生签约服务慢性病管理

伴随着老龄社会的到来，人群疾病谱经历了传统的传染性疾病主导向慢性非传染性主导的转变，高血压、糖尿病等慢性疾病不可遏制地呈现出“井喷”状态，严重威胁我国居民的健康生活与经济生产（傅华等，2012）。国内外研究较为一致地认为社区应当是承担健康管理的主要平台，家庭医生则应当是健康管理的主要责任主体（梁万年，2007；Rothman et al.，2003）。而目前家庭医生缺乏有效的激励措施成为其提供签约服务发挥健康守门人作用的重要瓶颈(贺小林和梁鸿，2012）。2013 年上海市区域内开展家庭医生签约服务协同改革试点，以医保支付方式协同改革为抓手助推家庭医生签约服务。其基本逻辑是通过提升家庭医生签约收入激活其工作动力、主导开展签约服务进行签约管理、提升签约服务质量。那么，以签约服务费为核心的协同改革是否有效激励了家庭医生开展签约服务并发挥了健康守门人的作用，这是本节重点要探讨的问题。

1. 签约与未签约居民的行为差异

从健康行为看，签约与未签约高血压患者在 2013～2016 年测量频率都有所提升，但是签约患者始终高于未签约患者。2013 年，签约居民每周至少测量一次的频率（60.30%）高于未签约居民（47.11%），经卡方检验该差异具有统计显著性。2016 年，签约居民该比例（65.60%）依然显著高于未签约居民（56.62%），卡方检验结果显示该差异具有统计显著性（表 6-9）。这表明在家庭医生的引导下，签约居民提升健康理念、更加关注自身健康，通过更高频率的血压/血糖测量开展健康监测，进行有效的健康管理。

糖尿病患者的调查结果显示签约居民血糖测量频率并不显著高于未签约居民，但是签约居民行为的改善程度优于未签约居民。2013 年未签约居民每周至少测量一次的频率为 21.16%，签约居民该比例为 18.80%，略低于未签约居民，但是经检验差异并不具有统计显著性；2016 年，未签约居民每周测量一次的频率由 2013 年的 21.16%上升至 2016 年的 36.94%，而签约居民该比例则由 2013 年的 18.80%上升至 2016 年的 42.28%，签约居民测量血糖频率超过未签约居民。从两期调查结果来看，签约居民测量行为的改善程度优于未签约居民（表 6-10）。

表 6-9　签约与未签约居民测量血压频率

组别	2013 年						2016 年						卡方值	*p*
	每天多次	每天 1 次	每周 1 次	每月 1 次	每月不到 1 次	不固定	每天多次	每天 1 次	每周 1 次	每月 1 次	每月不到 1 次	不固定		
未签约	11 人（2.26%）	65 人（13.37%）	153 人（31.48%）	125 人（25.72%）	15 人（3.09%）	117 人（24.07%）	12 人（3.31%）	76 人（20.99%）	117 人（32.32%）	47 人（12.98%）	7 人（1.93%）	103 人（28.45%）	27.326	0.000
签约	10 人（2.99%）	51 人（15.22%）	141 人（42.09%）	80 人（23.88%）	5 人（1.49%）	48 人（14.33%）	24 人（7.00%）	66 人（19.24%）	135 人（39.36%）	51 人（14.87%）	3 人（0.87%）	64 人（18.66%）	16.932	0.005
例数	821 人						705 人							
卡方值	18.824						16.361							
p	0.002						0.006							

表 6-10　签约与未签约居民测量血糖频率

组别	2013 年						2016 年						卡方值	*p*
	每天多次	每天 1 次	每周 1 次	每月 1 次	每月不到 1 次	不固定	每天多次	每天 1 次	每周 1 次	每月 1 次	每月不到 1 次	不固定		
未签约	2 人（1.06%）	8 人（4.23%）	30 人（15.87%）	38 人（20.11%）	21 人（11.11%）	90 人（47.62%）	0 人（0.00%）	11 人（9.91%）	30 人（27.03%）	18 人（16.22%）	7 人（6.31%）	45 人（40.54%）	12.158	0.033
签约	1 人（0.75%）	3 人（2.26%）	21 人（15.79%）	29 人（21.80%）	20 人（15.04%）	59 人（44.36%）	1 人（0.81%）	9 人（7.32%）	42 人（34.15%）	29 人（23.58%）	10 人（8.13%）	32 人（26.02%）	20.986	0.001
例数	322 人						234 人							
卡方值	2.205						7.904							
p	0.82						0.162							

2. 签约与未签约居民的健康成效差异

本节通过健康自评与并发症干预两个维度考察家庭医生对高血糖与糖尿病患者的健康干预成效影响。自评健康是二期调查（2016 年）新加入的变量，组间差异比较显示高血压与糖尿病签约居民自评健康均优于未签约居民。其中，高血压签约居民自评健康好（非常好、很好、好）的比例为 29.73%，略高于未签约居民（28.17%）；糖尿病患者签约居民自评健康好（非常好、很好、好）的比例为 29.27%，而未签约居民该比例仅为 15.31%，经统计两者具有显著的差异（表 6-11）。

表 6-11　高血压与糖尿病患者自评健康（2016 年）

自评健康	高血压		糖尿病	
	未签约（比例）	签约（比例）	未签约（比例）	签约（比例）
非常好	7 人（1.93%）	3 人（0.87%）	2 人（1.80%）	2 人（1.63%）
很好	42 人（11.60%）	33 人（9.62%）	2 人（1.80%）	13 人（10.57%）
好	53 人（14.64%）	66 人（19.24%）	13 人（11.71%）	21 人（17.07%）
一般	206 人（56.91%）	190 人（55.39%）	68 人（61.26%）	56 人（45.53%）
较差	54 人（14.92%）	48 人（13.99%）	26 人（23.42%）	30 人（24.39%）
不清楚	0 人（0.00%）	3 人（0.87%）	0 人（0.00%）	1 人（0.81%）
合计/人	362	343	111	123
卡方值	7.593		11.812	
p	0.180		0.037	

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

签约居民的并发症干预成效始终优于未签约居民，但是在 2013～2016 年有效干预比例略有下降。2013 年，未签约居民中并发症干预有效的比例（非常有作用、比较有作用）为 39.58%，而同期调查中签约居民该比例高达 72.78%，该差异具有统计显著性；2016 年签约与未签约居民并发症干预有效的比例均出现下滑，其中未签约居民并发症干预有效（非常有作用、比较有作用）的比例下降至 38.28%，签约居民干预有效比例则下降至 63.34%。尽管如此，签约居民干预有效的比例仍然显著高于未签约居民，且差异具有统计显著性（表 6-12）。

表 6-12　签约与未签约居民慢性病患者并发症干预成效评价

组别	2013 年					2016 年					卡方值	*p*
	非常有作用（比例）	比较有作用（比例）	一般（比例）	基本没作用（比例）	不清楚（比例）	非常有作用（比例）	比较有作用（比例）	一般（比例）	基本没作用（比例）	不清楚（比例）		
未签约	30 人（5.30%）	194 人（34.28%）	148 人（26.15%）	23 人（4.06%）	171 人（30.21%）	25 人（6.74%）	117 人（31.54%）	121 人（32.61%）	59 人（15.9%）	49 人（13.21%）	68.054	0.000
签约	73 人（19.68%）	197 人（53.1%）	67 人（18.06%）	3 人（0.81%）	31 人（8.36%）	47 人（13.06%）	181 人（50.28%）	89 人（24.72%）	25 人（6.94%）	18 人（5.00%）	29.989	0.000
合计	937 人					731 人						
卡方值	125.771					53.295						
p	0.000					0.000						

3. 启示与建议

本节通过在协同改革之初的基线调查与跟踪调查对糖尿病、高血压患者重点慢性病人群的健康干预成效进行分析，得到如下结论。

第一，签约居民的健康行为较未签约居民更优。主要表现为签约居民进行血压测量行为较未签约居民频率更高。在糖尿病患者中表现为时间维度上签约居民血糖测量健康行为的改善状况更优。以糖尿病患者为例，2013 年签约居民每周至少测量一次血糖占比仅 18.80%，未签约居民该比例为 21.16%，略高于签约居民，而到了 2016 年，签约居民该比例上升至 42.28%，已显著高于未签约居民（36.94%）。第二，签约居民的健康管理效果较未签约居民更优。这主要表现为签约居民中高血压、糖尿病患者的自评健康、并发症干预效果显著高于未签约居民。比如，2016 年糖尿病患者签约居民自评健康好（非常好、很好、好）的比例为 29.27%，显著高于未签约居民（15.31%）。

目前家庭医生开展健康管理的研究均较为一致地表明家庭医生在健康管理中发挥了积极作用（吴海燕等，2015；尉敏琦等，2015；肖筱等，2015）。但是目前相关研究主要是对干预组进行前后干预成效比较，少有同时进行不同组别与组间前后比较的。比如，有研究对某社区卫生服务中心辖区内高血压患者进行全科医生团队干预效果研究。研究结果发现干预后高血压患者对疾病认知、全科医生满意度、健康行为、依从性与控制率都得到了显著提高（沈序英等，2010）。其他慢性病患者前后干预研究通过家庭医生团队的健康档案管理、健康知识宣讲、健康行为养成、定期随访、自我管理等干预方式，得出了相似的结论（王苏中等，2000；曹静等，2010；张学标等，2011）。但是由于数据获取的困难，少有研究同时进行签约组与未签约组的前后对照研究。来自长宁的实证研究进行了不同组别的前后干预比较。结果显示，糖尿病干预组与对照组在干预前无显著人口特征与生化指标差异，但是在家庭医生干预后，干预组对糖尿病防治知识知晓度和行为的改变明显高于对照组，并且干预组的空腹血糖、餐后血糖、总胆固醇、三酰甘油、高密度脂蛋白等生化指标较对照组有明显下降（张蓓燕等，2013）。

尽管如此，依然能够从本节的研究结论初步推断在家庭医生签约服务协同改革中，签约家庭医生对居民的健康管理产生了积极的效果，这在高血压、糖尿病患者两类常见的慢性病患者的健康行为与成效中均得到了体现。但并发症的干预效果在几年内出现了下滑，这暗示在进行慢性疾病本身干预的同时，应当进一步加强对并发症的关注、预防与控制。

6.3.2　家庭医生签约服务的费用管理成效

医疗费用的快速上涨是全球共同的发展趋势，美国、英国、加拿大等发达国

家在 2000 年以后卫生支出年均增长率均超过 5%，而我国卫生支出年均增长率则高达 18%。家庭医生在新一轮医疗改革中被赋予了重要地位，它是提供基本公共卫生服务的平台与实现全民健康的重要抓手，同时有不少观点认为它应当是医保支付方式改革的突破（梁鸿和贺小林，2012）。上海市早在 2013 年就进行了家庭医生签约与医保支付方式的联动改革，通过签约服务费激发家庭医生服务动力，开展健康管理进而控制医疗费用。本节问卷调查采集试点区长宁的样本数据，从居民感受最为直观的个人现金支出入手，分析家庭医生费用守门人成效，进而探讨缓解居民医疗负担的成效及影响机制，为家庭医生制度的进一步推进提供政策建议。

1. 签约与未签约居民的医疗费用描述性分析

签约居民年医疗费用高于未签约居民，但是这种差异随着时间的推移逐渐缩小。2013 年未签约居民年医疗费用为 1658.35 元，签约居民年医疗费用为 3060.39 元，高出未签约居民近一倍。经检验，该差异具有统计显著性。而 2016 年，签约居民年医疗费用下降为 2673.51 元（下降了 12.64%），未签约居民则达到 2434.88 元（上升了 46.83%）。经检验，两者差异缩小且不具有统计显著性（表 6-13）。

表 6-13　签约居民与未签约居民年医疗费用差异

项目	2013 年		2016 年	
	未签约	签约	未签约	签约
均值/元	1 658.35	3 060.39	2 434.88	2 673.51
标准差	4 722.65	8 603.89	10 809.23	6 434.62
例数/人	2020	569	1094	594
t 检验	−5.091 8（p=0.000）		−0.492 7（p=0.622）	

本节认为签约居民医疗费用高可能与签约居民的年龄结构与疾病特征有关系，即签约居民中往往为老年人且慢性病患者比例高。在纳入人口年龄结构后发现签约与未签约居民两组人群的费用差异消失。2013 年签约居民在各个年龄段医疗费用均高于未签约居民，仅 18～44 岁、45～59 岁年龄段存在显著差异。而到了 2016 年，签约居民与未签约居民在各个年龄段的费用无显著差异，并且 75 岁及以上人口中签约居民的医疗费用为 2409.21 元，显著低于未签约人口（3812.89 元），见表 6-14。

表 6-14　签约与未签约居民分年龄段年均医疗费用交叉分析

年龄段	2013 年			2016 年		
	未签约/元	签约/元	*t* 检验	未签约/元	签约/元	*t* 检验
18～44 岁	671.88	1931.63	−3.7679（*p*=0.000）	852.51	991.66	−0.3743（*p*=0.708）
45～59 岁	1799.19	3131.15	−2.2425（*p*=0.025）	1724.29	2212.79	−0.9627（*p*=0.336）
60～74 岁	2099.53	3143.66	−1.7581（*p*=0.079）	3025.84	3060.20	−0.0366（*p*=0.970）
75 岁及以上	2971.17	3227.77	−0.4712（*p*=0.637）	3812.89	2409.21	1.6755（*p*=0.047）
例数	2159 人	591 人		1346 人	649 人	

进一步进行慢性病变量交叉分析，签约与未签约居民组间差异消失。当观察对象限定为慢性病人群时，2013 年签约与未签约慢性病患者个人医疗支出不存在显著差异，而到了 2016 年签约居民年均医疗费用仅为 2730.38 元，低于未签约居民（3697.96 元），尽管两者差异并不显著（表 6-15）。也就是说，在慢性病患者中，签约居民与未签约居民不存在医疗费用的显著差异，而时间维度检验结果表明签约慢性病患者的医疗费用下降，已经低于未签约居民。

表 6-15　签约与未签约居民慢性病患者年均医疗费用交叉分析

医疗费用	2013 年		2016 年	
	未签约	签约	未签约	签约
均值/元	3 174.36	3 624.47	3 697.96	2 730.38
标准差	7 053.37	9 792.82	15 222.81	4 457.72
合计	694 人	420 人	517 人	452 人
t 检验	−0.888 6（*p*=0.374）		1.3033（*p*=0.096）	

2. 签约家庭医生对医疗费用影响的模型检验

模型 1 与模型 2 分别为 2013 年与 2016 年医疗费用影响因素分析。模型纳入了包括年龄在内的基本人口学变量以及是否患有慢性病变量。模型 1 显示年龄平均每增长一岁，每年花费的医疗费用平均增长 20.03 元。此外，慢性病患者比非慢性病患者年医疗费用高出 2018.67 元。这两个变量均具有统计显著性。模型 2 检验结果与模型 1 基本一致，这验证了上述描述分析部分的初步结论，即年龄、

疾病结构导致签约居民医疗费用高的假象。在两个模型中，本节最为关心的签约变量具有较大的差异。在控制了众多变量后，2013 年签约居民较未签约居民年医疗费用高出 394.76 元，但是到了 2016 年该系数值变为负数，签约居民年医疗费用较未签约居民低 593.6 元（表 6-16）。尽管签约变量并不显著，但是该系数值在方向上的转变表明签约家庭医生对医疗费用控制开始产生成效。

模型 3 至模型 5 进一步探讨签约家庭费用成效的影响因素，三个模型在模型 2 的基础上进一步纳入了居民的认知变量、行为变量及慢性病服务变量。在逐渐纳入这些变量后，签约居民较未签约居民的费用优势（系数绝对值）被逐步缩小，可初步推断认知、行为与服务是签约家庭医生对费用产生作用的影响因素。具体来看，模型 3 显示清楚知晓社区卫生服务中心位置的居民医疗费用较其他不知道居民高 3190.72 元，而对社区卫生服务功能认知功能差异认知变量则不显著影响费用；模型 4 显示患病时的就诊行为显著影响医疗费用，前往三级医院就诊居民较选择在一级医院就诊居民年医疗费用平均高出 3235.30 元，而转诊变量在模型中影响并不显著；模型 5 显示社区卫生服务功能认知变量在模型中影响不显著（表 6-16）。

表 6-16　签约家庭医生对年医疗费用的影响因素分析

变量		模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
签约		394.76	−593.60	−342.46	−162.93	−12.70
性别		215.31	−271.87	−370.53	−359.92	−1 715.06
年龄		20.03*	33.62	34.45	29.54	25.61
教育水平	初中	78.52	2 051.64*	2 295.16**	2 606.64*	3 201.92
	高中	29.32	526.61	824.27	557.44	968.16
	本科及以上	326.59	1 107.89	1 342.73	907.20	2 033.72
婚姻状况（对照=未婚）	已婚	−16.23	308.18	631.64	1 146.35	311.16
	其他	−17.14	600.37	930.49	1 384.48	698.17
职业		−34.94	709.54	740.00	1 173.54	−1 571.46
户籍		23.50	71.88	479.91	483.45	2 604.89
慢性病		2 018.67***	1 419.38**	1 470.69**	1 484.32*	—
社区卫生服务地点知晓（对照=知道）	有点印象			−306.33	−338.12	546.80
	不知道			3 190.72**	5 013.75**	12 737.53***
社区卫生服务功能认知（对照=有区别）	没有区别			−593.37	−788.02	−271.20
	不清楚			1 169.41	1 744.42	3 044.47

续表

变量		模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
就诊行为（对照=一级医院）	二级医院				853.25	970.47
	三级医院				3 235.30***	4 119.99**
转诊行为					–490.03	–472.48
慢性病服务（对照=提供）	不提供					458.19
	不清楚					1 828.77
截距		–324.61	–1 612.43	–2 924.26	–4 384.54	–4 963.74
N		2573	1649	1641	1202	576
R^2		4.16%	1.67%	2.51%	4.36%	6.84%

* $p<0.05$; ** $p<0.01$; *** $p<0.001$

3. 启示与建议

从本节的数据分析结果发现以下几点。

第一，签约居民医疗费用中的个人现金支出高于未签约居民，这是由年龄结构、疾病结构导致的结果。比如，2013 年签约居民年医疗费用高出了未签约居民近一倍，在控制了年龄结构后，费用差异只在中青年人群中显著存在；而在控制了疾病状况（患有慢性疾病）后，签约居民与未签约居民的费用差异骤然消失。这表明签约是具有选择性的，即越患有慢性病的居民越倾向于签约，这一点在现有研究中得到证实（张跃红等，2013）。

第二，随着时间推移签约家庭医生对于个人现金支出的控制成效逐渐加强，签约对缓解个人医疗负担开始发挥作用。在控制了年龄、性别等基本人口学变量及慢性病患病状况后，2016 年的模型检验结果显示签约居民医疗费用已经低于未签约居民，而在 2013 年签约变量的系数值为正（高于未签约居民）。可见随着时间的推移，家庭医生通过签约开始发挥作用从而对居民医疗费用产生了积极成效。关于家庭医生与医疗费用的研究并不多，但是现有研究均较为一致地表明家庭医生对医疗费用具有一定的控制作用（李娟等，2008；刘虹丽等，2012）。

第三，在认知、行为与服务三大因素中，目前对费用产生作用的是认知与就诊行为。本节重点检验了居民认知、行为与服务三个维度的因素对个人现金支出医疗费用的影响，结果显示居民对社区卫生服务地点的知晓是显著影响费用的重要变量，而对于社区卫生服务功能认知并未产生作用，这表明居民对后者的认知可能仍然不足或者不清晰，使其并未发挥作用。就诊行为的选择是显著的费用影响变量，而转诊并未发挥作用，这与目前转诊机制尚未建设或有待完善直接有关（黄蛟灵等，2016）。而慢性病服务的提供作为健康管理的重要变量对于医疗费用

并未产生作用，这表明目前家庭医生并未充分发挥健康守门人的角色。

签约家庭医生的居民个人现金支出更高并不是签约带来的现象，相反签约家庭医生对医疗费用的抑制已初显成效。而依托家庭医生构建按人头付费的医保支付方式变革带来医疗费用的合理有效控制有赖于家庭医生健康管理的充分开展。目前居民对家庭医生认知不清、转诊机制尚未建立、签约服务有待做实，以家庭医生为抓手实现全民健康、有序诊疗与医疗费用的管理还有漫长的道路要走。

第 7 章　老年友好型社会的老年社会参与

宋靓珺　王雪辉

21 世纪的老年人具有知识广博、思维敏捷、参与意识强、健康长寿、生活丰富等特征，这些特征使之成为推动社会经济可持续发展的重要人力资本之一。挖掘老年人口的“生产力”是应对人口老龄化的积极举措，鼓励和支持老年人参与就业、志愿服务和家庭照料，是对“和谐美满”晚年生活的重新认识与定义。摒弃传统的仅以休闲娱乐为主的老年生活，尊重老年群体的自主性和自我发展需求，从而可以更充分地挖掘和发挥老年人群体的人力资本与社会资本价值。

从个体发展的微观视角来看，鼓励老年人积极参与社会活动，可以提高老年人的身心健康水平，提升其自养能力和精神文化水平，同时老年人社会参与可以缓解沉重的养老、医疗负担，促进代际和谐与社会融合。世界卫生组织对于健康的定义为“健康不仅仅是没有疾病或虚弱，而是身体、心理和社会适应的完好状态”[①]，也就是健康是在身体上、心理上、社会适应上完全处于良好的状态。从社会发展的宏观视角来看，老年人的社会参与行为通过个人以各种角色的扮演和介入，实现和保持个体与社会的互动，进而实现社会资源的共建共享。在此互动过程中，老年人通过社会参与不仅创造了经济价值，也产生了积极的社会意义。第二次老龄问题世界大会明确提出“使老年人能够通过赚取收入工作和自愿工作，充分和有效地参与其社会的社会、经济和政治生活”[②]。在一个“不分年龄人人共享的社会”中，老年人应该和其他年龄群体一样，享有学习的权利、工作的权利、娱乐休闲的权利等。低龄老年人力资源开发利用是老有所为的体现，也是老年群体对社会发展的全面参与和发展成果的共享。

近年来，随着社会经济的快速发展和人们生活质量的提升，我国低龄活力老年人继续参与社会的各项活动，如老年志愿者队伍日渐庞大，各类老年兴趣爱好团体快速增加，老年大学招生供不应求，等等。种种迹象表明，我国低龄老年人保有继续参与社会、发挥自身价值的诉求，然而我国现阶段针对老年人社会参与的机会和渠道仍以休闲娱乐、公益慈善领域为主，老年参与的领域和范围较窄，

---

① “World report on ageing and health 2015”, https://apps.who.int/iris/handle/10665/186463?search-result=true&query=World+report+on+ageing+and+health+2015&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc[2021- 05-28]。

②《2002 年老龄问题国际行动战略》, https://www.un.org/chinese/events/ageing/ecn5-01pcl9.pdf[2020-12-12]。

难以满足老年人自身的需求和社会经济可持续发展的需要。基于此，本章试图探讨以下几个关键问题：我国老年群体社会参与的现状如何？制约我国低龄老年人力资源开发利用的困境有哪些？从实证模型的角度来看，影响我国老年人社会参与的影响因素有哪些？面对人口老龄化的迅速发展，如何有效开发老年人口红利，以及在理念、政策和制度层面应当做出怎样的调适与回应？

7.1 老年社会参与的定义与理论

7.1.1 老年社会参与的定义

社会参与是一个内涵丰富且较为抽象的概念，目前学术界对此还没有形成统一清晰的定义。学者从不同的角度对老年人社会参与进行界定，主要的界定标准有两种（王莉莉，2011a）：一是根据参与的内容。邬沧萍（1999）认为将老年人的社会参与概括为政治、经济、社会和文化等几个方面，每个方面可根据社会发展的需要具体细分，如再就业、参政议政、参与街道社区活动等；段世江和张辉（2008）把社会参与分为“为他人服务的社会参与”和“包含个人目的的社会参与”。二是根据老年人自身的特征和参与社会的能力。例如，有学者从个人资源角度将社会参与分为三种类型——集体性参与、生产性参与和政治性参与（Bukov et al.，2002；陈功和高羽，2014）；还有的学者认为社会参与是参加除家庭外的人际交往活动，如社会、休闲活动和工作（Goll et al.，2015），但也有学者对此持相反观点，认为应该将家务劳动作为老年人社会参与的一部分（杨宗传，2000；刘颂，2007）；此外，某些学者出于可操作性的角度考虑，将社会参与具体分为三种类型——制度性参与、同质性参与和社会活动参与，其中制度性参与体现在国家保障权利上，如各类养老保险的参与，同质性参与是指各种社会组织的参与，社会活动参与包含各种社区活动（赵玉峰和扈新强，2019）。

综上所述，可以发现学者对于社会参与定义争论的焦点主要集中于以下两点，其一是老年人社会参与是否应该有报酬；其二是家务劳动是否应该属于老年人社会参与。生产性参与理论认为老年人参与劳动就业、志愿活动和家庭照料等具有经济价值的活动或服务都应被认为是社会参与，而且无论是有偿还是无偿。该理论对上述定义的争议进行了明确的回应，同时这一理论也满足了社会参与社会性和互动性的属性特征。

7.1.2 老年社会参与的理论

老年社会学、老年心理学等学科为老年期社会参与的动机与行为提供了理论

体系的构建。比较有代表的经典理论如下：角色理论（role theory）是由美国社会学家乔治·米德提出的（郑杭生，2017），他认为老年人由于退出生产岗位后，身份由劳动者变成了消费者从而引发了角色冲突，进而直接引起了老年人身心健康水平的下降。所以通过鼓励老年人重新参与社会，转变角色从而降低这种由角色改变引起的不良影响；活动理论（activity theory）是由美国学者罗伯特·哈维格斯特（Havighurst，1961）提出的，他认为通过参与活动尽可能地使老年人继续承担和保持原有的社会角色与关系，用新的角色替代因丧偶或退休等失去的角色，把自身与社会的距离缩小到最小限度。

Morrow-Howell（2014）等学者通过对上述角色理论、活动理论的回顾，在世界卫生组织提出的积极老龄化框架的基础上，提出了老年人社会参与模式的新研究框架。在该研究框架中，影响老年人参与模式的因素划分为四大要素：个人因素（性别、年龄、种族、健康状况、受教育程度）、经济因素（家庭收入、家庭财产）、社会因素（婚姻状况、家庭支持、社会支持）和环境因素（城乡类型和服务设施）（谢立黎和汪斌，2019）。

7.2　老年社会参与的现状与困境

7.2.1　老年社会参与的现状

1. 低龄老年人的在业比例

老年人口在业率是反映老年人力资源利用和供给状况的重要指标。老年在业人口是指从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的老年人口。基于中国老年社会追踪调查（2014 年）的数据分析（表 7-1），展示我国低龄老年群体的在业状况。由该调查数据可知，2014 年全国有约 20%的老年人仍从事有报酬的工作或劳动。其中，60～64 岁和 65～69 岁老年人在业比例分别约 1/3 和 1/4，表明低龄老年群体保持着较高的劳动参与。分性别比较可知，低龄老年男性在业比例高于女性，其中 60～64 岁的男性高于女性 13.45 个百分点，65～69 岁的男性高于女性 7.67 个百分点；分城乡来看，农村低龄老年人在业比例远高于城市，其中 60～64 岁的农村低龄老年人在业比例接近一半，城市低龄老年人的在业比例约为 20%，65～69 岁的农村低龄老年在业比例超过 1/3，城市则仅为 10.38%。总体上看，目前我国老年在业群体以农村低龄老年人为主，一方面，这是由我国养老保障制度城乡差异所导致的，农村老年人养老金水平普遍较低，需要通过从事一定的工作或劳动获取经济收入。另一方面，农村老年人以农业体力劳动为主，活到老干到老是很多农村老年人的观念。在身体状况允许的情况下，他们一般不会放

弃干农活或其他相关体力劳动。

表 7-1　我国分年龄、城乡的低龄老年人口在业比例（2014 年）

年龄组	合计	性别		城乡	
		男性	女性	城市	农村
60～64 岁	31.83%	38.62%	25.17%	18.83%	46.11%
65～69 岁	22.68%	26.48%	18.81%	10.38%	34.67%
70 岁+	19.25%	23.33%	15.32%	10.00%	29.67%

资料来源：中国老年社会追踪调查，中国人民大学中国调查与数据中心，2014 年

2. 低龄老年人在业的行业构成

现阶段，我国低龄老年人从事工作以第一产业为主。2015 年全国 1%人口抽样调查数据的结果显示（表 7-2），在业的老年群体中，有 80.57%的人在农林牧渔业工作，只有不到两成的老年在业人口从事除农林牧渔业外的其他行业的工作。相比之下，他们相对集中于制造业、批发零售业和建筑业，分别占 4.76%、3.88%和 3.32%。低龄老年人作为老年在业人口的主体，其行业构成与老年在业总人口的特征保持一致。可以得知，我国低龄老年在业人口绝大多数都在从事农林牧渔业第一产业，农业仍然是我国低龄老年人就业的主要行业。

表 7-2　2015 年我国老年在业人口的行业构成

行业	小计	男性	女性
农林牧渔业	80.57%	76.32%	87.46%
制造业	4.76%	5.48%	3.61%
批发零售业	3.88%	4.20%	3.36%
建筑业	3.32%	5.12%	0.46%
其他行业	7.47%	8.88%	5.11%

资料来源：根据 2015 年全国 1%人口抽样调查数据测算

3. 老年群体社会参与类型

以公益活动参与为例，公益活动指老年人以个人身份或者通过志愿者团体、社区、街道及其他社会组织团体等形式自觉自愿参与的、无偿的服务、劳动或其他援助性活动。2014 年中国老年社会追踪调查数据显示，随着年龄增长，老年人中参加公益活动的比例整体呈下降趋势。60～64 岁和 65～69 岁老年人口中分别

有 22.6%和 23.2%表示仍在参加公益活动。与中高龄老年人相比，低龄老年群体身体状况和体能素质较好，公益活动参与率较高且类型更加多元化。约一半的低龄老年人参与过陪同聊天类公益活动，其他参与度较高的公益活动包括环境卫生保护、照看其他人家的小孩、调解纠纷等。具体如图 7-1 所示。

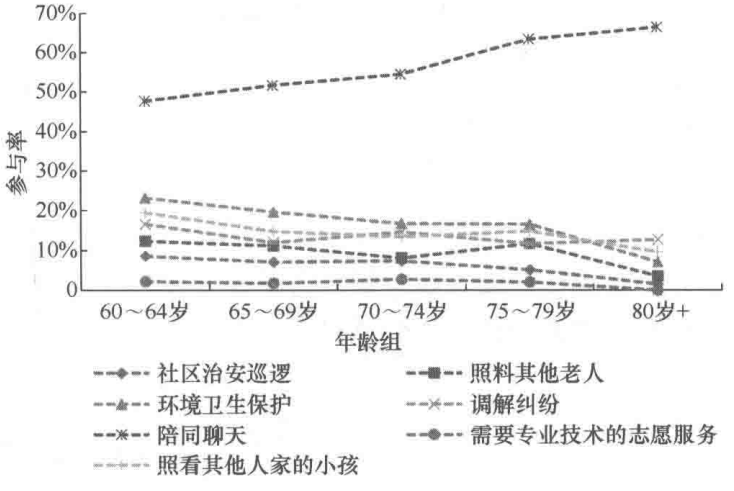


图 7-1　参与公益活动的老年人口年龄分布

资料来源：中国老年社会追踪调查，中国人民大学中国调查与数据中心，2014 年

7.2.2　老年社会参与的困境

1. 传统观念与思维定式制约老年社会参与的多元化

传统文化视老年人为经验和智慧的化身，俗话说，家有一老如有一宝，但在现代社会中老年人的人生经验很难得到后辈的认可。社会大众普遍不相信老年人可以继续发展完善，更加难以对老年人作为人力资源储备中不可或缺的力量达成共识。老年群体被认为与社会主流群体（如青壮年群体）具有根本的差别，被静态地视为需要帮助的、不具有生产力的社会负担人口。

2. 相关政策法律发展滞后

从企业角度看，员工达到退休年龄不再受到《工伤保险条例》的保护，一旦在工作中出现任何意外，企业需要承担较大的风险。对参与再就业的老年人而言，《中华人民共和国劳动合同法》不能保障其合法权利，他们处于相对弱势的地位，不但面临随时被解约的风险，薪酬福利也将被大幅削减。

3. 互联网时代带来新挑战

随着 5G 时代的到来，万物互联格局逐步形成，这将打破人与人之间的空间

距离和交往方式，对传统的就业模式也形成冲击。部分老年群体难以适应这种新的生产生活方式，形成“数字鸿沟”。但与此同时，新的科学技术的开发利用，延伸了中老年人口群体的体力和智力的生理极限，为老年人群继续参与社会经济活动创造了崭新的机遇。虽然这一过程已经开始产生了可能的机遇与发展，但人们还没有充分认识。未来可以肯定的是，随着科技与工作场景的进一步深度融合，人机互动将更趋频繁，这将对老年群体的劳动参与提出更高要求。

4. 老年教育存在认知偏差

老有所为尚未成为老年事业的关注重点，各种为老服务主要聚焦于老年人文体和健康生活的丰富与满足，忽视了老年人的职业进取性和社会参与性。以老年大学为代表的老年教育机构课程设置主要教授传统文化和生活技能，缺乏适应现代科学技术发展的相关课程设计，难以满足老年人对生产性再就业发展的需求。

7.3　老年社会参与影响因素的实证分析

7.3.1　社会参与影响因素的文献回顾

影响老年人社会参与的因素来自不同的层面。学者通常从性别、年龄及健康水平等微观个体层面和社区设施、老年福利政策及社会保障程度等宏观区域层面分别展开研究。

1. 个体因素

男性和女性在心理和行为方面存在差异，性别差异会对老年人社会参与产生不同的影响。国外学者的研究表明，老年女性的社会参与意愿比老年男性强，和老年男性相比，老年女性的社会参与水平更高（Harry，1970；Edwards et al.，1984）。国内关于性别差异对老年人社会参与影响的研究很多，但还未能得到一致的结论。有些研究表明，我国传统观念认为男性从事的器械性工作更多，而女性参与表达性的工作更多，沟通能力更强，在老年期到来时，由于器械性工作减少，老年女性的社会参与水平更高（李宗华等，2011）。有的研究则表明，由于国内老年女性受教育水平普遍较低和经济收入不高，老年男性的社会参与水平更高（韩青松，2007；陈茗和林志婉，2004）。

年龄显著影响老年人社会参与的水平。国外有关文献表明，在控制了其他个人和经济变量的情况下，老年人年龄的不断增加会引起社会参与度的降低，这和年龄增大引起的社会参与能力与意愿降低有着显著的关联（Zborowski，1962；

Bukov et al.，2002；Desrosiers et al.，2004；Gallardo-Peralta et al.，2016）。国内学者结合我国国情开展的研究表明，我国老年人社会参与具有低龄化的特点，即随着老年人年龄的增加，社会参与水平降低，主要原因是年龄大的老年人行动不便并且反应也会变慢，智力水平普遍降低。通过梳理文献可以看出关于年龄对老年人社会参与影响问题的研究，国内外学者普遍认为二者之间存在负相关关系，即年龄越大，老年人社会参与水平越低（李宗华等，2011）。

老年人的健康状况和社会参与水平关系密切。国内外学者关于健康对老年人社会参与的影响有着基本一致的看法。大多数文献认为，健康状况对老年人社会参与有着促进作用，即健康状况良好的老年人，更加积极参与社会活动，社会参与水平更高，身心健康情况是制约老年人是否愿意参加社会活动的最主要原因（刘颂，2007；张文娟，2010；陆杰华等，2017）。

老年人的受教育水平也是影响其社会参与的重要因素。国内外学者普遍认为，受教育水平高的老年人文化水平和综合素质相对较高，他们掌握更加专业、更高价值的专业技能，当这些人步入老年期时具有更强的自信，他们认为自己还能继续为社会创造价值，也更乐意参加社会活动，而受教育水平低的老年人缺乏自信，往往觉得自己什么都做不了，不愿意参加社会活动。因此，受教育水平高的老年人社会参与水平更高（Goll et al.，2015）。

2. 区域因素

除了个体因素，区域因素也对老年人社会参与具有重要的影响。区域因素主要包括老年人在社区中的人际关系、社区基础设施情况、社区组织因素和社会保障政策。关于老年人在社区中的人际关系对社会参与影响的研究还不多，而且大多数只存在于理论层面上。一些研究关注老年人和朋友之间的关系对其社会参与度的影响，结果表明，在社区中拥有更密集的人际网络，有更多朋友的老年人更愿意参加社区活动（李宗华等，2011）。同样，社区基础设施也会显著影响老年人的社会参与水平。大部分研究认为，基础设施完善的社区使老年人更容易参加社会活动，生活在这种社区的老年人社会参与水平较高（王莉莉，2011b）。社区组织因素对于老年人社会参与的影响不容忽视。相关研究表明，社区组织的成熟与否显著影响老年人的社会参与度，住在组织制度完善社区的老年人的社会参与水平较高（李梦嘉，2009）。也有研究表明，社会保障政策的完善与否会对老年人社会参与产生影响，社会保障政策如社会保险的提高会显著降低老年人参加社会工作的可能性，老年人养老保险和医疗保险与工作就业之间存在替代性（朱浩和易龙飞，2015）。除此之外，也有学者关注社区的老年教育对社会参与的影响，发现老年教育能够显著地提高老年人的社会参与水平（王英和谭琳，2009）。

7.3.2　老年社会参与影响因素分析的实证策略

1. 数据来源

本节使用的数据为 2014 年中国老年社会追踪调查全国范围的第一次基线调查。调查采用多层分阶段的概率抽样方法，调查对象为 60 岁及以上的老年人群（个人问卷）和社区（村居）工作人员（社区问卷）。调查范围为除香港、台湾、澳门、海南、新疆和西藏之外的全国 28 个省（自治区、直辖市），462 个村/居委会，共获得 11 511 个老年人调查样本和 462 份社区调查样本。研究剔除相关变量缺失值后，工作模型的个人有效样本为 8446 人、家庭照顾模型的个人有效样本为 7660 人，志愿活动模型的个人有效样本为 7598 人。

其中，缺失值的处理方法如下：将第一层变量中（个体特征因素）的缺失值标注为“缺失”，按照“个案剔除法”进行剔除处理（基本缺失项为“收入”和“疾病”项）；第二层变量中（社会环境因素）的缺失值因缺失率较低，按照固定值替换法，通过增加一个变量“0”值进行处理。

2. 模型选择

由于本节研究所使用的数据具有明确的层次关系与嵌套结构，老年人生产性参与是个体、社会等多层次因素共同作用的结果。在传统的普通最小二乘法（ordinary least squares，OLS）线性模型的基本假设中随机误差项是同方差且和解释变量不相关的，而这两个假设在本节研究中不成立。由于本节研究中采用分层抽样的方法，不同社区间通过回归得到的随机误差项是不太可能满足同方差假设的，且同一社区内部的误差项可能存在相关性，因此，分层线性模型（hierarchical linear model）[①]因其能很好地处理具有嵌套结构的非独立数据而成为较为合适的分析方法。此外，多水平模型还能有效连接微观个体数据和宏观社会环境数据，并明确区分残差的组内效应和组间效应。

3. 变量选取

美国著名老年学家 Morrow-Howell 等（2001）对老年人生产性参与的狭义定义为“老年人参与所有的有报酬或无报酬的商品生产及服务供给活动”均为“老年人生产性参与”，这些活动包括工作、家庭照顾和志愿活动。这三项活动是从不同维度测量老年人生产性参与的程度。因此，本节分别考察三个因变量在三个

① 分层线性模型是一种跨层次的统计模型。当数据存在于不同层级时，先以第一层级的变量建立回归模型，然后把该方程中的截距和斜率作为因变量，使用第二层数据中的变量作为自变量，再建立两个新的方程。通过这种处理，可以探索不同层级变量对因变量的影响（薛艳，2016）。

模型中的结果，分别以虚拟变量（0，1）表示。①在老年人工作模型中，老年人只要回答“目前正在从事有收入的工作/活动”，则用 1 表示“参与工作”；否则，用 0 表示。②在老年人家庭照顾模型中，老年人只要回答参与过活动——“老年人在过去十二个月中帮助过子女做家务、照顾孙子女、在过去一个月里照顾自己或配偶的父母”中的任意一项，则被视为有家庭照顾行为，用 1 表示；以上三项活动均没有参与，用 0 表示。③在老年人志愿活动模型中，老年人只要回答参与过活动——“过去三个月内参与过社区治安巡逻、照料其他老年人、环境卫生保护等公益活动，参与过本地居民委员会/村民委员会的投票选举”中的任意一项则被视为有志愿活动，用 1 表示；以上活动均没有参与，用 0 表示。影响老年人生产性参与的因素主要来自个体和环境，因此自变量涉及两个层次：微观个体特征因素与宏观社会环境因素。

首先，在层-1 微观个体特征变量中：性别、年龄、城乡、社会保障、慢性病、婚姻状况、居住模式、社会隔离状况[①]、老年优待状况等采用 0-1 变量；受教育程度、个人收入、工具性日常生活活动（instrumental activities of daily living，IADL）状况采用虚拟变量；认知能力采用连续变量（0～16 分）。

其次，在层-2 宏观社会环境变量中：社区中是否有社区医院/卫生室等、社区中是否有老年活动室、社区中是否有养老院、社区中是否有农业协会（互助组织）和社区中是否有居（村）民文化组织等采用 0-1 变量。上述变量的选择依据为相关理论、经验发现及多轮试算，变量的选择、定义及具体分布等描述性统计结果如表 7-3 所示。

表 7-3　变量的选择、定义及具体分布的描述性统计结果

变量名称	变量定义	样本数量/个	变量分布	因变量 1：参与工作的比例	因变量 2：参与家庭照顾的比例	因变量 3：参与志愿活动的比例
性别	0=女	5 977	52.0%	14.0%	55.1%	54.9%
	1=男	5 526	48.0%	24.4%	56.0%	59.9%
年龄	0=中低龄老年人（60～79 岁）	9 648	83.9%	21.9%	61.3%	59.2%
	1=高龄老年人（80 岁及以上）	1 854	16.1%	3.7%	25.7%	47.4%

① 本节采用张文娟等学者使用的精简版社会网络量表来评估老年人社会隔离程度，社会网络总体得分在 12 分以下的老年人处于社会隔离状态。中国老年社会追踪调查数据的社会网络量表信度系数良好，达到统计分析的要求（张文娟和刘瑞平，2016）。

续表

变量名称	变量定义	样本数量/个	变量分布	因变量 1：参与工作的比例	因变量 2：参与家庭照顾的比例	因变量 3：参与志愿活动的比例
城乡	0=农村	4 601	40.0%	31.2%	54.3%	61.7%
	1=城市	6 902	60.0%	10.9%	56.4%	54.4%
受教育程度	0=没上过学	3 614	31.4%	19.8%	48.7%	48.6%
	1=受过小学教育	3 875	33.7%	23.1%	56.9%	61.3%
	2=受过小学以上教育	4 007	34.9%	14.3%	60.5%	61.3%
个人收入	1=低收入（0～25%）	2 628	25.6%	13.9%	51.4%	51.6%
	2=中低收入（25%～50%）	2 720	26.5%	34.5%	55.6%	60.5%
	3=中高收入（50%～75%）	2 742	26.7%	15.6%	58.7%	55.6%
	4=高收入（75%～100%）	2 188	21.3%	11.0%	55.9%	66.5%
社会保障	0=没有社会保障	860	7.5%	32.8%	59.5%	51.2%
	1=有社会保障	10 623	92.5%	17.9%	55.2%	57.8%
IADL 状况	0=完好	6 480	56.3%	22.7%	63.6%	61.8%
	1=1～5 项失能	3 969	34.5%	17.5%	50.6%	54.7%
	2=6～10 项失能	1 054	9.2%	1.8%	24.7%	39.4%
慢性病（高血压）	0=未患病	4 817	55.7%	20.4%	53.8%	55.8%
	1=患病	3 826	44.3%	14.0%	53.1%	59.1%
慢性病（关节炎）	0=未患病	6 591	76.3%	16.0%	53.2%	56.8%
	1=患病	2 052	23.7%	22.6%	54.4%	58.8%
慢性病（颈椎腰椎病）	0=未患病	6 714	77.7%	15.9%	53.1%	57.1%
	1=患病	1 929	22.3%	23.2%	54.6%	57.7%
慢性病（冠心病）	0=未患病	6 723	77.8%	19.1%	54.9%	57.3%
	1=患病	1 920	22.2%	12.1%	48.8%	57.0%
认知能力	连续变量（0～16 分）	11 374	10.36	10.73	11.15	11.03
婚姻状况	0=没有配偶	4 046	35.2%	10.6%	45.8%	51.9%
	1=有配偶	7 444	64.8%	23.5%	60.8%	60.3%

续表

变量名称	变量定义	样本数量/个	变量分布	因变量 1：参与工作的比例	因变量 2：参与家庭照顾的比例	因变量 3：参与志愿活动的比例
居住模式	0=非空巢	6 310	54.9%	18.6%	72.0%	57.4%
	1=空巢（独居或仅与伴侣居住）	5 193	45.1%	19.4%	35.5%	57.2%
社会隔离状况	0=不存在社会隔离	7 331	63.8%	19.3%	60.0%	61.2%
	1=存在社会隔离	4 155	36.2%	18.6%	47.8%	50.6%
老年优待状况	0=未享受过老年优待	8 102	70.6%	23.3%	58.5%	56.0%
	1=享受过老年优待	3 370	29.4%	8.7%	48.5%	60.5%
社区中是否有社区医院/卫生室等	0=没有	1 543	13.5%	13.8%	57.9%	66.8%
	1=有	9 901	86.5%	19.9%	55.2%	55.9%
社区中是否有老年活动室	0=没有	3 976	35.0%	25.9%	54.6%	56.4%
	1=有	7 378	65.0%	15.1%	56.2%	57.8%
社区中是否有养老院	0=没有	9 336	82.7%	20.1%	56.1%	57.6%
	1=有	1 949	17.3%	14.7%	53.4%	56.8%
社区中是否有农业协会（互助组织）	0=没有	8 595	77.3%	17.2%	56.0%	57.2%
	1=有	2 524	22.7%	26.8%	54.0%	57.4%
社区中是否有居（村）民文化组织	0=没有	3 699	32.5%	28.8%	55.5%	56.2%
	1=有	7 696	67.5%	14.5%	55.5%	57.8%

注：表中数据进行过修约，可能存在合计不等于 100%的情况

7.3.3　老年社会参与影响因素的模型结果

1. 老年人工作模型

1）零模型：影响老年人工作的因素是否存在分层效应？

零模型（the null model，也称为无条件模型）在分层线性模型的分析中是第一步，它的作用在于提供对组内相关系数的估计，从而考察因变量是否存在显著的层间差异，进而论证是否有使用分层线性模型分析的必要。老年人工作的零模型设定如下：

$$\text{Prob}(\text{Work}=1|\beta)=\varphi$$

$$\lg\left[\frac{\varphi}{1-\varphi}\right]=\eta$$

$$\eta_{ij}=\beta_{0j}+r$$

$$\beta_{0j}=\gamma_{00}+\mu_{0j}$$

模型估计得到的组内方差为 0.862 97，组间差异为 1.015 11（$p<0.01$）。这表明老年人工作的影响因素中源于个体差异的部分和源于环境差异的部分同时存在。而工作模型的组内相关系数 $\mathrm{ICC}=\dfrac{1.015\,11}{1.015\,11+0.862\,97}\approx 0.541$，进一步表明约有 54%的影响老年人工作的因素被宏观区域环境因素所解释。根据温福星（2009）等学者的建议，当组内相关系数大于 0.059 时，则表明组间的差异不可忽略，需要在统计建模处理中考虑如何处理组间效应。因此，对老年人工作的模型进行分层分析是适用的。

2）随机效应模型（层-1 变量单因素分析）

随机系数模型用于对层-1 微观变量进行单因素检验和初步筛选。所有自变量和因变量与老年人工作都存在显著的相关关系，因此，这些变量均需放入完全模型进行进一步检验。

3）最终效应模型（最终混合模型）

完全分层线性模型就是层-1 和层-2 的模型均包含解释变量，以截距和斜率为结果。该模型的目的在于考察有统计控制的情况下，层-1 和层-2 变量对因变量综合影响的显著程度。完全分层线性模型的设定如下。

层-1：

$$\mathrm{Prob}(\mathrm{Work}=1\,|\,\beta)=\varphi$$

$$\lg\left[\frac{\varphi}{1-\varphi}\right]=\eta$$

$$\begin{aligned}\eta_{ij}=\beta_{0j}&+\beta_1\times\text{年龄}+\beta_2\times\text{性别}+\beta_3\times\text{社会保障}+\beta_4\times\text{高血压}\\&+\beta_5\times\text{关节炎}+\beta_6\times\text{颈椎腰椎病}+\beta_7\times\text{冠心病}\\&+\beta_8\times\text{认知能力}+\beta_9\times\text{婚姻状况}+\beta_{10}\times\text{空巢老年人}\\&+\beta_{11}\times\text{社会隔离}+\beta_{12}\times\text{享受老年优待政策}+\beta_{13}\times\text{小学学历}\\&+\beta_{14}\times\text{小学以上学历}+\beta_{15}\times\text{轻度失能}+\beta_{16}\times\text{重度失能}\end{aligned}$$

$$\beta_{0j}=\gamma_{00}+\mu_{0j}$$

层-2：

$$\mathrm{Prob}(\mathrm{Work}=1\,|\,\beta)=\varphi$$

$$\lg\left[\frac{\varphi}{1-\varphi}\right]=\eta$$

$$\begin{aligned}\eta_{ij}=&\beta_{0j}+\beta_1\times\text{年龄}+\beta_2\times\text{性别}+\beta_3\times\text{社会保障}+\beta_4\times\text{高血压}\\&+\beta_5\times\text{关节炎}+\beta_6\times\text{颈椎腰椎病}+\beta_7\times\text{冠心病}\\&+\beta_8\times\text{认知能力}+\beta_9\times\text{婚姻状况}+\beta_{10}\times\text{空巢老年人}\\&+\beta_{11}\times\text{社会隔离}+\beta_{12}\times\text{享受老年优待政策}+\beta_{13}\times\text{小学学历}\\&+\beta_{14}\times\text{小学以上学历}+\beta_{15j}\times\text{轻度失能}+\beta_{16j}\times\text{重度失能}\\\beta_{0j}=&\gamma_{00}+\gamma_{01}\times\text{社区是否属于城市}+\gamma_{02}\times\text{社区是否有医院}\\&+\gamma_{03}\times\text{社区是否有老年活动室}+\gamma_{04}\times\text{社区是否有敬老院}\\&+\gamma_{05}\times\text{社区是否有互助组织}+\gamma_{06}\times\text{社区是否有文化组织}\\&+\mu_{0j}\\\beta_{15j}=&\gamma_{150}+\gamma_{151}\times\text{社区是否属于城市}+\mu_{15j}\\\beta_{16j}=&\gamma_{160}+\gamma_{161}\times\text{社区是否属于城市}+\mu_{16j}\end{aligned}$$

对这一完全模型，作如下两点说明。

（1）模型纳入交互项，是因为本节的研究关注老年人健康状况对生产性参与的影响在城乡间是否存在差异，因为城乡差异是中国社会经济发展不平衡的主要特征之一。而在此处，选取 IADL 而非日常生活活动（activities of daily living，ADL），则是参考了陆杰华等（2017）的做法，选取 IADL 来衡量老年人的健康状况用以反映其对社会参与等有更高体能需求的能力。本节也认为，因为老年人要参与各类生产性活动，基本的生活自理能力是必备条件。因而，在研究社会参与问题时，评估和测量老年人与社会交互和适应的 IADL 是比 ADL 更为合适的指标。

（2）模型建立之初，层-1 的解释变量中还包括老年人收入水平、退休前在单位的层次、抑郁水平和居住社区类型等四个变量，但在最终完全模型中并未将它们纳入。主要原因是老年人的收入水平、退休前在单位的层次与因变量工作变量具有较高的相关性、抑郁水平变量与自变量认知能力有相关性、居住社区类型与自变量老年活动设施相关性较高。为了避免变量之间的多重共线性，在最终效应模型中未纳入上述四个变量。

表 7-4 给出了老年人工作模型的回归结果，包含零模型、随机效应模型和最终效应模型。此处的随机效应模型是指仅在层-1 加入自变量——个体变量。通过随机效应模型和最终效应模型的对比分析，可以看出加入宏观环境变量后，方程截距、个体变量斜率及显著程度的变化。

表 7-4　老年人工作模型的完全模型结果

层-1 变量	层-2 变量	零模型系数	随机效应模型系数	最终效应模型系数
截距	截距，γ_{00}	−1.448 ***	−0.929***	−0.441 **
	社区是否属于城市，γ_{01}			−1.150 ***
	社区是否有医院，γ_{02}			0.258 **
	社区是否有老年活动室，γ_{03}			−0.080
	社区是否有敬老院，γ_{04}			−0.045
	社区是否有互助组织，γ_{05}			0.336 ***
	社区是否有文化组织，γ_{06}			−0.395 ***
年龄	截距，β_1		−1.283 ***	−1.089 ***
性别	截距，β_2		0.524***	0.456 ***
社会保障	截距，β_3		−0.633 ***	−0.636 ***
高血压	截距，β_4		−0.282 ***	−0.252 ***
关节炎	截距，β_5		0.197 ***	0.166 ***
颈椎腰椎病	截距，β_6		0.192 ***	0.184 ***
冠心病	截距，β_7		−0.394 ***	−0.406 ***
认知能力	截距，β_8		0.006	0.013 **
婚姻状况	截距，β_9		0.610 ***	0.586 ***
空巢老年人	截距，β_{10}		0.014	−0.005
社会隔离	截距，β_{11}		0.015	0.010
享受老年优待政策	截距，β_{12}		−0.619 ***	−0.368 ***
小学学历	截距，β_{13}		−0.171 **	−0.146 **
小学以上学历	截距，β_{14}		−0.568 ***	−0.343 ***
轻度失能	截距，β_{150}		−0.442 ***	−0.578 ***
	社区是否属于城市，β_{151}			0.293 **
重度失能	截距，β_{160}		−2.374 ***	−2.254 ***
	社区是否属于城市，β_{161}			1.129 ***

*** $p<0.01$，** $p<0.05$

层-1 模型中：在最终效应模型中，性别的系数比较显著，也就是说老年人参与经济生产活动有较为明显的性别差异。性别的系数为正（女性为参照组），说明男性老年人从事经济生产活动的概率高于女性老年人，且在随机效应模型和最

终模型中，性别的影响都显著，说明在业率性别差异的显著性在目前中国的社会经济背景下具有一定的普遍性。

年龄对于老年人工作的影响依然存在，中低龄老年人的在业率明显高于高龄老年人，说明年龄可能通过健康等因素直接或间接地限制高龄老年人的经济活动参与情况。目前中国的老年人的经济活动参与率主要集中在中低龄老年人中。

老年人享有的社会保障水平和老年优待政策等社会福利由于对老年人晚年经济生活的保障作用从而削弱了老年人参与经济劳动以增加劳动收入的动机；另外，具有良好社会保障水平的老年人一般是城镇居民、企事业单位退休人员，一般他们退休后由于有固定的退休金收入等良好的社会保障水平，因此，继续工作的比例较低。

在模型中本节统计了得病率较高的前四种慢性疾病，得出不同病种对于老年人工作的影响机制并不一致。高血压、冠心病等致残障疾病严重降低了老年人继续工作的可能性，因为这一类疾病对老年人的基本日常生活构成了一定的影响，更不用提需要一定体力和脑力的工作活动；但是，关节炎和颈椎腰椎病一般不会引起老年人太大的重视，不会直接影响老年人参与经济活动，反过来说，这是较为常见的由长期伏案工作或从事繁重体力劳动引起的职业病，长期工作的老年人更有可能罹患此类疾病。

婚姻状况对老年人的工作有正向保护作用。但我们推测，这可能是婚姻通过健康状况等其他中介变量对老年人的工作参与率发生作用。统计描述数据进一步表明：婚姻状况为已婚的有 28%的老年人是轻度失能；只有约 6%的老年人是重度失能；而未婚的老年人中有 47%是轻度失能，15%是重度失能，各项失能程度均高于已婚老年人群。这与以往的研究结论是一致的，即“婚姻的保护作用在老年期仍然存在”。婚姻状况越是和谐的老年人，身心各方面的健康状况越是良好，这从客观条件上保障了劳动经济活动参与的可能性。

受教育程度越高的老年人继续参与工作的可能性越低，这与前述的“老年人社会保障水平越高，工作的可能性越低”是一致的。因为，受教育程度高的老年人一般拥有较为体面、稳定的工作，退休后享有的社会保障水平也较高。因此，在中国目前的社会观念下他们工作的积极性不高。由此，我们有理由推断目前中国老年人参与经济活动的动机主要为增加家庭收入等最基本的生活保障需求，而从通过工作实现个人价值等更高心理层面的追求动机还较低。这也客观上反映了我国仍然处于“社会主义初级阶段”的现实国情。

在引入层-2 的变量之后，层-1 变量的显著性并未发生明显的变化。然而在引入城乡作为层-2 变量时，失能老年人的工作参与反映出显著的城乡差异。轻度失能和重度失能均为虚拟变量（对照组为没有失能）。这两个变量的截距均为负值且显著，表明相较于没有失能的老年人，轻度失能和重度失能均会对工作的参与

率带来显著的负向影响，且重度失能的影响更大。而和这两个变量交互的层-2 变量城市的系数为正且显著，表明相比于农村，失能对于城市老年人工作参与率的影响更小，老年人生活在城市减弱了由失能导致的工作参与率降低。我们认为这是由于城市具有良好的医疗卫生条件和便利的就医环境，因此身体功能的限制对于居住在城市的老年人参加工作的影响更小；从另一个角度而言，城市无障碍的设施降低了老年人参与经济活动需要依靠自身体力的限制。中国城乡之间在医疗服务、老年友好型设施构建等方面的差距依然客观存在，一个依托智能科技、便捷和无障碍的社会环境，可以提高老年人发挥残存的应对社会风险、发挥潜在效能的身体功能与心理效用，这也是世界卫生组织广泛倡导的提高老年人“复原力”（resilience）从而达到积极老龄化的最优目标的原因。

层-2 模型中，城乡差异在影响老年人工作的因素中依然显著存在，农村老年人的在业率高于城镇老年人。这与我国农村地区无明确的退休年龄机制有关，很多年事已高的老年人依然在田间从事耕作劳动，为家庭创造经济财富。因此，需要提高农村地区老年人的收入水平和社会保障水平，通过对农村地区的资源投入倾斜改善我国城乡之间发展不平衡的现状。所在社区有医院等较好的医疗水平和互助组织，都会提高老年人工作的概率。良好的基础设施建设和组织机构（通常这种社区互助组织都是经济互助合作组织）会增加老年人之间的信息分享和沟通，并通过组织机构的力量帮助老年人重返工作岗位。而这些软硬件条件也是老年友好型社区的重要组成部分，通过改善老年人所处的环境提高经济活动参与率，从而实现“积极老龄化”和“成功老龄化”的战略目标。

2. 老年人家庭照顾模型

家庭照顾模型与构建老年人工作模型类似，通过了 ICC 值检验。表 7-5 各列分别显示了老年人家庭照顾模型的零模型、随机效应模型及最终模型的统计结果。此处的随机效应模型是指仅在层-1 变量中加入自变量——个体特征变量。通过随机效应模型和最终效应模型的对比分析，可以看出加入宏观社会环境变量后，方程截距、个体变量斜率及显著程度的变化。

表 7-5　老年人家庭照顾模型的完全模型结果

层-1 变量	层-2 变量	零模型系数	随机效应模型系数	最终效应模型系数
截距	截距，γ_{00}	0.222***	0.701***	0.772***
	社区是否属于城市，γ_{01}			0.244**
	社区是否有医院，γ_{02}			–0.180**
	社区是否有老年活动室，γ_{03}			0.074

续表

层-1 变量	层-2 变量	零模型系数	随机效应模型系数	最终效应模型系数
截距	社区是否有敬老院，γ_{04}			−0.080
	社区是否有互助组织，γ_{05}			−0.013
	社区是否有文化组织，γ_{06}			−0.112
年龄	截距，β_1		−0.949***	−0.947***
性别	截距，β_2		−0.216***	−0.203***
社会保障	截距，β_3		−0.128	−0.128
高血压	截距，β_4		−0.029	−0.034
关节炎	截距，β_5		0.003	0.003
颈椎腰椎病	截距，β_6		−0.009	−0.007
冠心病	截距，β_7		−0.181***	−0.172***
认知能力	截距，β_8		0.021***	0.021***
婚姻状况	截距，β_9		0.226***	0.228***
社会隔离	截距，β_{10}		−0.352***	−0.356***
享受老年优待政策	截距，β_{11}		−0.456***	−0.478***
小学学历	截距，β_{12}		−0.015	−0.001
小学以上学历	截距，β_{13}		0.005	−0.021
轻度失能	截距，γ_{140}		−0.264***	−0.114
	社区是否属于城市，γ_{141}			−0.280**
重度失能	截距，γ_{150}		−1.040***	−1.046***
	社区是否属于城市，γ_{151}			0.024
年收入在 2 500～12 000 元	截距，β_{16}		−0.091	−0.084
年收入在 12 000～30 000 元	截距，β_{17}		0.089	0.052
年收入在 30 000 元以上	截距，β_{18}		−0.010	−0.079

*** $p<0.01$，** $p<0.05$

老年人家庭照顾模型的回归结果分析如下。从表 7-5 中可以得出，在随机效应模型和最终效应模型中，年龄和家庭照顾活动之间存在显著的负相关关系，这说明随着年龄的增加，老年人参与家庭照顾活动水平下降。这是因为家庭照顾活动对老年人的体力等方面有所要求，随着年龄的增加，老年人自身健康水平不断下降，照顾家人自然成了“心有余而力不足”的事情；另外，随着家庭成员中孙

子女逐渐长大成人、高龄父母相继离世，客观上需要老年人承担“抚幼孝老”的家庭照顾活动的比例也在下降，上述这两方面的因素都会引起老年人家庭照顾活动随着增龄而逐渐减少。

在老年人家庭照顾模型中，性别对老年人家庭照顾的影响十分强烈，即对于老年人来说，男性和女性参与家庭照顾活动的差异较大。在随机效应模型和最终效应模型中，性别的系数为负（女性为参照组）且在1%的显著性水平下显著（非常显著），说明和女性老年人相比，男性老年人参与家庭照顾活动的比例较低。这符合中国“男主外，女主内”的文化传统，女性从年轻时就承担了主要的家庭照顾活动并且延续至老年时期。这提醒我们需要关注老年女性的“累计劣势”，关注老年女性在漫长生命周期中持续积累的各方面劣势，充分考虑老年女性晚年时期在劳动就业、学习培训和志愿活动参与方面的平等参与的机会，充分满足这部分人群各个方面自我发展的诉求，创造一个“不分年龄、不分性别、人人共享”的和谐社会形态。

本节将目前老年人在问卷调查中统计的发病率最高的四种慢性疾病作为控制变量引入模型，得到了不尽相同的结果。在随机效应模型和最终效应模型中，高血压、关节炎和颈椎腰椎病对老年人家庭照顾的影响不显著，而冠心病对老年人家庭照顾具有负向影响，即冠心病显著降低了老年人参与家庭照顾活动的可能性。其中可能的原因是，高血压、关节炎和颈椎腰椎病作为老年人群中非致命性慢性病症，对家庭照顾活动不构成直接影响；而冠心病对老年人具有致命的威胁，稍有不慎就会出现生命危险，故而患有冠心病的老年人不能长期参与对体力有一定要求的家庭照顾活动。以上结果分析提示我们关注一个现象：中国的老年人只有在身体健康严重影响的情况下才会放弃家庭照顾活动，即便身患其他一般慢性疾病（无直接生命危险）依然在坚持照顾家人。老年家庭照顾者的身体健康状况亟待纳入长期照护体系中，与被照顾者一起成为政策关注与支持的对象。

认知能力强的老年人参与家庭照顾活动的可能性更大，这说明家庭照顾活动不仅对老年人的身体健康状况有要求，同时也要求老年人具备良好的认知能力。认知能力包括观察力、记忆力、想象力和注意力，上述能力出现障碍的老年人是无法照顾家庭其他成员的。这说明，家庭照顾活动其实是一项繁复性和综合性的活动，我们需要更正对这项活动的原有认识，也必须前瞻性地预见到对家庭照顾者进行培训的必要性。

婚姻状况对老年人的家庭照顾参与依然有正向影响作用，即有配偶的老年人参与家庭照顾活动的比例也更大。这和前面论述的原因一致，可能是婚姻通过健康状况对老年人的家庭照顾活动发生作用，即“婚姻的保护作用”，婚姻状况越和谐的老年人，其健康状况和心理状态越好，从事家庭照顾的主观意识和客观条件都大大提高。社会不仅需要关注老年人的身体健康状况，也需要从鼓励老年人

再婚、对老年群体设立婚姻咨询等社区服务方面提高老年群体的整体婚姻状况，从而提高老年人的心理健康水平。

社会隔离状况反映了老年人在对抗外部风险时可以动用的个人资本和社会资本。随机效应模型和最终效应模型的回归结果同样表明社会隔离会对老年人家庭照顾参与产生显著的负向影响，社会隔离越严重的老年人参与家庭照顾活动的比例越低。可能的原因是社会隔离严重的老年人长期处在孤立状态，会使自己在心理、情绪和行为等方面产生障碍，不愿意和外界沟通交流，越加地封闭自我，不愿意参与家庭照顾活动；也有可能是因为中国老年人的社会网络更多的是基于血亲关系，因此社会隔离越严重意味着老年人的社会网络越狭窄（如独居或空巢老年人），对家庭成员的照顾的机会越少（表 7-5）。无论是随机效应模型还是最终模型，老年人的受教育水平和收入水平对其家庭照顾参与的影响都不显著。可能的原因是老年人家庭照顾活动在中国目前的社会经济背景和文化传统下，具有一般性和普遍性，即无论是哪个社会阶层的老年人只要健康状况允许都会义不容辞地承担起照顾家庭成员的责任。家庭照顾行为虽然在中国普遍存在且绵延千载，但对于这项生产性参与活动的价值认同仍然需要借助更完善的理论体系加以解读和诠释。

在引入城乡作为层-2 变量时，轻度失能老年人的家庭照顾活动参与体现出显著的城乡差异。对于轻度失能老年人，在随机效应模型中，系数为负并且显著，这说明轻度失能会显著降低老年人参与家庭照顾活动的概率。而在最终模型中，轻度失能对老年人家庭照顾参与的独立影响消失，取而代之的是轻度失能和社区是否处在城市对老年人家庭照顾参与的交互影响，系数为负数并且显著，这表明相比于农村，轻度失能对于城市老年人家庭照顾参与率的影响更大，老年人生活在城市加剧了由轻度失能导致家庭照顾参与率降低的趋势。我们分析其中可能的原因是居住在城市地区的老年人群由于受教育水平较高等对自身健康问题的关注较多，出现了轻度健康状况受损即放弃了家庭照顾活动，但其影响作用仍然弱于重度失能（在随机效应模型中，重度失能系数的绝对值更大）。而在最终模型中，虽然重度失能对老年人家庭照顾参与具有显著的负向影响，但是重度失能和所在社区是否处于城市之间不存在对老年人家庭照顾参与的交互影响，这说明重度失能老年人的家庭照顾活动参与不存在显著的城乡差异，健康状况对于家庭照顾活动的影响具有普遍性，与居住地没有明显的关系。

3. 老年人志愿活动模型

表 7-6 各列分别显示了老年人志愿活动模型的零模型、随机效应模型及最终模型的统计结果。此处的随机效应模型是指仅在层-1 中加入自变量——个体特征变量。通过随机效应模型和最终模型的对比分析，可以看出加入宏观社会环境变

量后，方程截距、个体变量斜率及显著程度的变化。

表 7-6　老年人志愿活动模型的完全模型结果

层-1 变量	层-2 变量	零模型系数	随机效应模型系数	最终模型系数
截距	截距，γ_{00}	0.295***	−0.187	0.593***
	社区是否属于城市，γ_{01}			−0.974***
	社区是否有医院，γ_{02}			−0.527***
	社区是否有老年活动室，γ_{03}			0.226**
	社区是否有敬老院，γ_{04}			0.198
	社区是否有互助组织，γ_{05}			−0.082
	社区是否有文化组织，γ_{06}			0.145
年龄	截距，β_1		−0.275***	−0.282***
性别	截距，β_2		0.000	−0.021
社会保障	截距，β_3		0.113	0.116
高血压	截距，β_4		0.041	0.045
关节炎	截距，β_5		0.016	0.012
颈椎腰椎病	截距，β_6		−0.042	−0.040
冠心病	截距，β_7		0.068	0.062
认知能力	截距，β_8		0.025***	0.026***
婚姻状况	截距，β_9		0.128**	0.126**
空巢老年人	截距，β_{10}		0.060	0.055
社会隔离	截距，β_{11}		−0.401***	−0.412***
享受老年优待政策	截距，β_{12}		0.141**	0.173***
小学学历	截距，β_{13}		0.159**	0.160**
小学以上学历	截距，β_{14}		0.121	0.152*
轻度失能	截距，γ_{150}		−0.076	−0.260***
	社区是否属于城市，γ_{151}			0.298***
重度失能	截距，γ_{160}		−0.406***	−0.591***
	社区是否属于城市，γ_{161}			0.288*
年收入在 2 500～12 000 元	截距，β_{17}		0.272***	0.256***
年收入在 12 000～30 000 元	截距，β_{18}		0.130	0.167**
年收入在 30 000 元以上	截距，β_{19}		0.185*	0.237**

*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1

老年人志愿活动模型的回归结果分析如下。从表 7-6 中可以看出，在随机效应模型和最终模型中，年龄和老年人志愿活动之间存在显著的负相关关系，这说明中低龄老年人参与志愿活动的概率比高龄老年人高。因为随着年龄的增加，老年人身体每况愈下，身体条件不允许其参与志愿活动。三个模型的结果说明，年龄是影响中国老年人生产性参与的重要因素，与生产性参与的类型无关。

从表 7-6 中还可以进一步得到，不论是随机效应模型还是最终模型，认知能力对老年人志愿活动参与具有显著的正向影响，即认知能力越强的老年人参与志愿活动的可能性越大。这可能是因为认知能力包括观察力、记忆力、想象力和注意力，这些能力越强会使老年人越愿意参与志愿活动。这提示我们的公共政策需要对老年人的认知能力给予更多的重视，这是影响老年人生产性参与的重要因素之一。

婚姻状况也同样是影响老年人志愿活动参与的重要因素，婚姻状况良好的老年人参与志愿活动的概率更高。婚姻的作用机制对各个类型的生产性参与活动的影响作用一致。

和家庭照顾模型一致，在随机效应模型和最终模型中，社会隔离会对老年人志愿活动参与具有显著的负向影响，即社会隔离越严重的老年人越不愿意参与志愿活动。其可能的原因是社会隔离严重的老年人长期处在孤立状态，会使自己在心理、情绪和行为等方面产生障碍，更加地封闭自我，畏惧和他人进行沟通交流，从而不愿意参与志愿活动。这说明中国老年人的社会关系网络虽然以亲缘关系为主，但随着家庭规模萎缩和城镇化的加速，正逐步向地缘关系过渡（刘燕和纪晓岚，2014）。中国老年人社会网络体系正在呈现新的变化态势（张文娟和刘瑞平，2016），这种新社会环境下产生的新态势值得引起政策制定者的关注。

在最终模型中，由表 7-6 可知，城市老年人要比农村地区老年人的志愿活动参与率低，即农村老年人的志愿活动参与率更高，这与一些已有研究结论一致（胡宏伟等，2018；柴一凡和郭森，2020），说明我国老年人的志愿活动具有明显的城乡差异。其可能原因是我国城乡老年人志愿活动参与模式具有较大差异，农村老年人主要参加以邻里互帮互助形式存在的志愿活动，城镇老年人更倾向于参加社区组织的公益活动，而后者对相关组织形式和资源具有较高的要求，具有一定的参与门槛，而农村老年人参加志愿活动则往往建立在熟人社会的基础之上，邻里间的熟悉程度较高，故而参加志愿活动的可及性和便利性更高。

引入城乡作为层-2 变量后，轻度失能老年人的志愿活动参与体现出显著的城乡差异。对于轻度失能老年人，在随机效应模型中，系数不显著。但在最终模型中，轻度失能对老年人志愿活动参与产生显著的负向影响，即和没有失能的老年人相比，轻度失能的老年人志愿活动参与水平更低。并且同时出现轻度失能和社区是否处在城市对老年人志愿活动参与的交互影响，系数为正并且显著，这表明

相比于农村，轻度失能对于城市老年人家庭照顾参与率的影响更小，老年人生活在城市降低了轻度失能对志愿活动的负面影响。

同样，重度失能会显著影响老年人志愿活动参与。在随机效应模型中，重度失能会显著降低老年人参与志愿活动的可能性，其原因是当老年人出现重度失能症状时，身体状况的恶化会显著降低老年人参与志愿活动的可能性。最终模型中，重度失能仍然对老年人志愿活动参与具有显著的负向影响，同时重度失能和社区是否处在城市之间存在较显著的对老年人志愿活动参与的交互作用（10%的显著性水平以下）。

7.4　促进老年社会参与的对策与建议

现阶段，我国低龄老年人力资源开发仍处于初级阶段，低龄老年群体的社会经济参与主要是自发行为，政府的顶层设计基本空白，尚未形成相对完整的政策安排和制度体系。在新一轮科技和产业革命方兴未艾、世界经济长期处于长周期相对衰退期、我国人口结构发生重大变化等宏观背景下，我国亟须辩证地认识老年人力资源，引导形成理性的老年群体社会经济参与观念，科学设置低龄老年群体社会经济参与的制度体系，从而提高我国低龄老年人社会经济参与水平。

1. 厘清关键理念与任务重点：低龄老年人力资源开发需要全盘考虑

1）在观念转变上处理好老有所乐和老有所为的关系

在世界范围内，延迟退休的政府决策都面临重重阻力；在我国当前大部分人的观念里，含饴弄孙、颐养天年是晚年生活的主要安排，因此在推进低龄老年人参与社会经济工作时应首先形成新的社会风尚、改变老年人的参与理念，需要强调参与社会活动是部分先进老年人主动的选择，而非绝对的义务与责任。

2）在开发机制上处理好政府引导和市场主导的关系

社会氛围的引导、保障制度的整体设计、人力资源的再培训等都需要政府发挥主要作用，但低龄老年人参与社会经济活动主要通过市场机制来实现，以合理的价格兑现服务价值，调动其参与的积极性。

3）在政策衔接上处理好短期就业压力和长期劳动力紧张的关系

在全球新冠肺炎疫情的长期不确定背景下，我国面临严峻的就业压力，守住就业底线已经成为政府工作的重中之重；但从长期的人口发展来看，我国必然面对人力资源紧张的困境，为此需要在就业压力巨大的当下未雨绸缪地谋划事关未来发展的低龄老年人力资源开发。

4）在实施路径上处理好循序渐进和重点突破的关系

当前低龄老年人力资源开发的推进仍然面临许多深层次的问题，需要政府在制度设计时突出整体性、综合性和协调性，为重点领域的关键突破提供保障；同时，应在上海、北京等有条件的大城市积极试点，循序渐进推进积极老龄社会建设。

2. 从传统走向现代：更新对低龄老年群体的认知

1）在全社会形成鼓励低龄老年人社会参与的普遍认识与广泛意识

从世界范围的趋势来看，各个国家均在不遗余力地推迟甚至取消强制性的退休年龄制度。日本政府提出“取消退休年龄制度，创造终生活跃社会”的未来社会模式畅想。老年人力资源参与社会经济活动不仅有利于社会保障制度的长期持续平衡，也有利于老年人口的身心健康，更是老年人口的一项基本权利，是破除年龄歧视的具体体现。政府部门和社会组织应加强宣传教育，通过各种传播媒介在社会上形成不分年龄都能为中华民族伟大复兴和社会经济发展做出贡献的社会共识，构建老年（年龄）友好型的社会氛围。

2）推进终生学习理念，提升低龄老年群体适应互联网时代的能力和素质

全社会应逐步确立“活到老，学到老”的终生学习理念，老年大学等老年教育培训机构应更加重视技能型课程的设置，使低龄老年人具备现代社会工作岗位所要求的能力和素养，促进其继续发挥余热。此外，应将老年人数字经济意识的培养作为老年教育的重要组成部分，着重培养老年群体的人人合作、人机合作能力。政府应发挥主导作用，推动终身学习型社会建设。教育体系应当做适应性的改革，同时鼓励企业和社会组织广泛参与到终生教育特别是老年职业教育中，给予税费减免或补贴优惠，形成校企联合的发展模式。

3）重新评估家庭照顾活动在老年人经济参与中的社会价值

家务劳动对中国老年人而言具有双重意义，一方面，低龄老年人特别是女性承担着繁重的家务劳动，他们产生了巨大的经济和社会价值，但在目前的国民经济统计中尚未得到反映。另一方面，我国有相当数量的低龄老年人帮助子女教育和照顾下一代，为子女专心工作解除了后顾之忧，子女的劳动成果实际上也包含着他们所创造的价值。未来可考虑以家庭为整体的福利单位，将家庭照顾行为作为制定家庭税收豁免或优惠的主要依据，承认低龄老年人对家庭和社会的贡献。

3. 制度改革与创新：突破现有体制桎梏与障碍

1）逐步推行灵活的弹性退休制度

延迟退休是应对深度老龄社会劳动力短缺的必然举措，在人工智能、智能制造等新产业革命全面突破和应用的前景尚不明确的条件下，应逐步探索推进弹性

退休制度。即在保证退休年龄下限基本不变的前提下，适当提高部分劳动人口退休年龄的上限值，并尊重个人和企事业单位对于退休时间的选择，逐步实现退休年龄弹性化，使低龄老年群体由生产性人口向纯消费性人口转化的时间不断推后。国家应尽早出台退休制度改革的路线图，以形成合理预期和稳步推进。在保证现有养老金可持续运行的基础上，建议将退休年龄与领取养老金的年龄脱钩，逐渐淡化由国家规定退休年龄的制度安排，转变为主要规范不同退休年龄领取养老金的结构比例。弹性退休制可以先从老龄化程度较高的地区、高学历高技能人群开始进行试点。

2）开展低龄老年人力资源开发顶层设计并制定相应法律法规

制度保障是探索低龄老年群体深度参与社会经济活动的前提。国家应出台低龄老年人力资源开发利用政策，同时建立低龄老年人才数据库和低龄老年人就业指导中心，各级政府联合当地企业、社会组织、社区等社会资源建立合作网络，定期发布符合低龄老年群体需求的工作信息。同时，政府有关部门应强化顶层设计，从全局层面考虑老龄化问题，将积极老龄化上升为国家战略；在法律法规层面，相关政府部门应尽快出台促进低龄老年人再就业的法规及条例等；在退休制度方面，逐步改革当前企事业单位的退休制度，为退休返聘人员提供便利。可以借鉴日本制定的《高年龄者雇佣安全法》等法律法规，鼓励各单位提供适合老年人再就业的岗位，针对老年岗位的工作时间实行多人轮班制度、实施弹性管理。也可借鉴韩国开发的“老年人工作岗位事业”，把推动低龄老年人再就业视为一项政府民生工程。

3）调整老年教育的内容导向，增加工作技能培训

教育培训是转变老年群体认识观念、提高社会经济参与能力的重要方式。一方面，政府部门和社会组织在加强宣传教育的同时，应在老年教育机构和课程内容上进行改革，从以休闲娱乐型为主向适当增加职业技能型内容转变，在全国范围内发展一定规模的老年职业教育，为部分老年群体参与社会经济活动提供机会。另一方面，针对老年群体这类“数字难民”，应将老年人数字经济意识的培养作为老年教育的重要组成部分，着重培养老年群体的人人合作、人机合作能力。在老年教育供给方面，政府在这一过程中应发挥主导作用，同时鼓励企业和社会组织广泛参与到老年职业教育中，对其实施税收减免或补贴政策，形成校企联合的发展模式。

4）推进公务员退休群体人力资源开发先行先试

公务员退休群体（也被称为“老干部”）是我国特有的干部人事制度下产生的特殊老年群体（胡文琦和裴晓梅，2014）。与其他老年人相比，这部分人群在经济上基本无后顾之忧、社会保障完善、总体受教育水平较高，被视为“老年精英”群体。我们认为，开发利用这部分老年精英群体需要新的思路。规模巨大的

退休公务员群体是低龄老年人中文化程度最高、社会资本和管理能力最强的人口群体，目前这一群体不能参与有偿的社会经济活动，这有利于贯彻落实党和国家反腐败的战略决策，但在一定程度上也限制了这一群体人力资源的开发利用。建议开展专项研究和制度设计，在保证持续稳定地推进反腐倡廉的同时，鼓励这一群体积极参与社会经济活动。2020～2023 年是我国老年人口增长较慢的时间窗口，也是构建老年人口人力资源开发利用的制度政策体系的有利时机。广大政府部门、事业单位的退休公务员群体是社会宝贵的资源和财富，他们具备的智力资本和社会资本可以创造与发挥更大的社会价值。在部分个体自发参与社会经济活动的基础上，通过制度设计进一步调动该人群的更多个体参与意愿，破除其参与的制度壁垒，这将会为社会带来更多的活力和财富。

老年人力资源是未来中国社会发展不可忽视的重要人力资本。目前中国的老年人力资源开发和利用尚处于起步阶段，这受制于理念观念和体制机制的桎梏。未来的老龄政策既需要精准聚焦解决老年人特别是活动能力受限的老年人的生活顾虑，也应满足目前数量庞大且健康的中低龄老年人日益增长的社会参与的诉求。这对于正在迈向小康社会和建设社会主义现代化强国的中国是机遇。相关讨论则应跳出传统的框架约束，形成新时代的老年人力资源开发新理念，为老年人社会参与提供更多元和灵活的途径与渠道。在共同富裕的发展道路上，各个年龄阶段的人群都可以共享社会经济发展的成果。

第 8 章　老年友好型社会的智慧养老发展

彭　聪

信息通信技术对各行各业的渗透是必然的且呈现不可逆转的趋势，包括养老领域。智慧养老的发展是社会现代化的重要标志。在思考人口老龄化带来的问题方面，应转变思维，加入信息技术辅助的思维意识，认识与分析信息通信技术在老龄化进程中发挥的作用和运作机理，目前信息通信技术对中国智慧养老产业的渗透和影响还不够深入，一些技术创新尚未具有典型性，养老服务产品的研发和商业模式的探索仍处于初级阶段，老年群体对智慧养老产品的接纳度和对智能社会发展的适应度仍需要时间与过程。因此还需不断加强智慧养老方面的信息通信技术在“智慧城市”基础设施建设中的创新渗透，促进养老服务供给体系与信息通信技术的互动融合发展。

8.1　人口老龄化下智慧养老发展背景

伴随着经济全球化发展，人口老龄化已呈现不可逆的发展趋势，中国也面临老年人口占总人口比例不断提高的态势。2018 年 1 月国家统计局发布老年人口统计的数据，中国当时有 24 090 万 60 岁及以上的老年人口，在总人口数中占比 17.3%，并且 65 岁及以上的人口为 15 831 万，在总人口数中占比 11.4%。据国家统计局发布的第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月，中国目前有 2.64 亿 60 岁及以上的老年人口，在总人口数中占比 18.7%；65 岁及以上的人口为 1.9 亿人，在总人口数中占比 13.5%。据预测，到 2050 年中国的老年人口数量将达到 4.3 亿，处于峰值，并占总人口的 30%以上（彭希哲和胡湛，2011）。人口年龄结构的变化必将带来社会结构的变迁。保障中国老龄事业和产业的持续发展将为满足老年人日益增长的美好生活需要提供重要保证，并逐渐弥补老龄事业和产业发展不平衡、不充分的现状。

部分国内学者对智慧养老的概念进行了界定，左美云（2018）认为智慧养老是指利用信息技术等现代科学技术（如互联网、社交网、物联网、移动计算等技术），围绕老年人的生活起居、安全保障、保健康复、医疗卫生、娱乐休闲、学习分享等各方面支持老年人的生活服务和管理，对涉老信息自动检测、预警甚至

主动处置，使这些技术实现与老年人的友好、自主化、个性化智能交互，一方面提升老年人的生活质量，另一方面利用好老年人的经验智慧，使智慧科技和智慧老年人相得益彰，目的是使老年人过得更幸福，过得更有尊严，过得更有价值。杜鹏提出，智慧养老是面向居家老年人、社区及养老机构的传感网系统与信息平台，并在此基础上提供实时、快捷、高效、低成本的，物联化、互联化、智能化的养老服务[①]。王志良（2017）认为智慧养老是指以信息技术为主要支撑的养老服务，为老年人提供实时、快捷、高效、低成本的，物联化、互联化、智能化的养老服务。智慧养老的主要内容包括老年生理健康、心理慰藉、生活照料。中国通信工业协会于 2018 年 7 月 1 日发布《智慧养老云平台应用系统 总体技术要求》（T/CA005—2018），将智慧养老定义为基于网络信息化技术，通过互联网、云平台、大数据、移动互联网与养老行业相结合，优化政府管理服务，为用户提供实时、快捷、高效、低成本的，物联化、互联化、智能化的养老服务。

腾讯研究院发布的《2018 中国“互联网+”指数报告》显示，中国的数字经济正在高速增长，据估计，2016 年全国经济体量为 22.77 万亿元，2017 年则为 26.70 万亿元。数字经济占 GDP 的比例从 30.61%上升至 32.28%[②]。信息通信技术是信息技术与通信技术相融合，并实现人和组织在数字世界中交互的新技术领域。中国的人口老龄化进程与信息技术的飞速发展相同步，这些技术产业发展能够有效保持社会“老而不衰”，在降低老年人自理的生理门槛的同时，促进老年人生产方式和社会角色的转变。认识到信息通信技术可以使具有特殊需要的群体受益，中国政府在国家和地方层面为应对老年人口不断增长的态势，均积极采取措施鼓励基于信息通信技术的创新，以增强老年人独立生活的能力。

目前针对老年群体的辅助技术研发存在两种主流趋势：一是针对老年人自身，尽可能维持和增强老年人的独立性；二是针对老年照料护理人员，即研发对老年人家庭照护和康复护理方面的技术支持。这两种趋势均面临重大的创新技术发展问题。

8.1.1　当代技术跃迁与老龄化进程高度重叠

基于信息技术、数字技术、大数据技术和人工智能数据的新一轮科技产业革命正在重建社会的技术架构，并随着技术的发展深化逐步改变人类生产生活方式和产业形态，重塑工业社会产生的基本社会结构和政治形态。中国的老龄化进程

① 《杜鹏：智慧养老可以让老年人更有尊严和独立自主的生活》，http://tv.cctv.com/2018/06/10/VIDE5S9EbEZMocmeF1A3mF7U180610.shtml[2020-10-11]。

② 《重磅发布 | 2018 中国“互联网+”指数报告：中国数字经济版图初现（附完整版下载）》，https://www.tisi.org/5025[2020-12-31]。

伴随着信息通信技术的飞速发展，因此，充分利用信息通信技术发展的契机对解决老龄社会问题至关重要。

老龄社会面临的挑战之一是老年人的身体机能较弱，这是信息通信技术可在时间和空间上克服的问题。

（1）技术进步正在改变老年人的生活方式。相比较于传统养老方式，技术进步在一定程度上弥补了老年人生理功能不断退化的现实状况，并将部分照护人力资源解放出来。例如，网购、在线支付解决了老年人搬运能力及计算货价能力减弱的问题；为老、助老设备（特别是智能养老设施）大量涌现则进一步提升了老年人的自理水平。

（2）技术进步正在改变老年人的生产方式。智能辅助设备可大大提升老年群体的自理能力，在一定程度上可延长劳动者的职业年限，为社会创造更大的价值。

（3）技术进步正在改变老年人的知识结构和社会定位。信息通信技术的目标之一是利用老年人的知识，在应对技术新时代的挑战的同时，拓宽技术新时代的视野。

8.1.2　智慧养老服务标准化的现状

智慧养老服务标准体系建设与规范发展主要表现如下：一是制定设备产品标准，实现不同设备之间数据信息的开放共享；二是制定健康指标检测设备和数据服务标准；三是完善服务流程规范和评估评价指标体系（朱勇，2018）。

在政府标准制定方面，2013 年 11 月，民政部发布《养老服务业标准化建设规划（2013—2017 年）》，将养老服务信息数据标准规范（养老机构部分）、养老服务信息数据集分类与编码规则、养老服务信息化平台建设规范、养老机构信息化服务指南、养老服务信息数据元标准化规则（系列）、养老服务信息数据模式描述指南、养老服务信息数据集元数据规范、养老服务信息化基础设施建设规范等，列为重点修订项目。这说明国家已开始关注智慧养老发展的基础信息数据搭建方面的标准化建设，为后续的产品标准、智慧养老设备标准、信息化服务的流程规范和评价体系的发展做铺垫。2014 年 10 月，中国首个智能养老技术标准《全国智能化养老实验基地规划建设基本要求》发布，旨在促进“全国智能化养老实验基地”的建设，发挥智能化养老实验基地的示范作用。2015 年 1 月 22 日中国老龄产业协会、华龄涉老智能科技产业发展中心发布《全国智能化养老实验基地智能化系统技术导则》，规范智能养老服务标准。

在团体标准发展方面，中关村乐家智慧居住区产业技术联盟于 2016 年 11 月 1 日发布《国家智能化养老基地建设标准》（T/ZSPH 0001—2016），规定了智能化养老基地建设的规划、设计、建设、运营与服务领域的系统集成、产品研发要

求等；深圳市智慧城市研究会于 2017 年发布《智慧城市智慧养老规划导则》（T/SCSS 035—2017），内容涵盖了智慧养老建设目标、智慧养老建设原则、智慧养老应用分类、智慧养老技术分类、智慧养老服务信息平台规划、智慧养老应用系统设计规范等；中国通信工业协会于 2018 年 7 月 1 日发布《智慧养老云平台应用系统 总体技术要求》（T/CA005—2018），该标准适用于养老云平台应用系统设计、研发过程。智慧养老服务标准的制定重点逐渐从硬件建设转为软件建设。

智慧养老服务的标准化可大大提升行业效率，促进技术创新与融合。目前智慧养老服务标准化建设仍处于探索试行阶段。

8.1.3　老年人信息技术可及性的政策支持

“可及性”指营造社会成员可以方便、顺畅、平等地参与社会生活的无障碍环境。“无障碍”体现在信息社会中的最重要的特征则为电子信息交流无障碍及电子信息的可及性、易用性。

2008 年 7 月，工业和信息化部发布《信息无障碍 身体机能差异人群 网站设计无障碍技术要求》和《信息无障碍 身体机能差异人群 网站设计无障碍评级测试方法》，旨在对无障碍上网的网页设计、内容可感知、接口组件可操作等方面提出要求，以便使身体机能差异群体（指由于身体机能丧失或弱化导致常态下无法正常获取和使用信息的群体，包括残障群体、老年群体、身体机能未发展成熟的幼年群体等）均能从信息技术中获益。2020 年 11 月，国务院办公厅制定《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，进一步推动解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难。2021 年 4 月，工信部发布《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》，旨在加快推进互联网应用适老化及无障碍改造专项行动，助力老年人、残疾人等重点受益群体平等便捷地获取、使用互联网应用信息。

8.2　信息通信技术在老年人生活保障中的作用

据目前技术发展程度，可用于养老领域的智能应用产品主要有以下几种：一是设备类，包括可穿戴（便携式）健康监测设备、自助健康检测设备、智能监护设备、家庭服务机器人等；二是管理与服务系统，包括智能健康管理系统、智能养老应用系统、数据分析应用系统等；三是信息共享平台，统一规范、互联互通的健康养老信息共享平台已成为发展趋势，实现了健康养老信息共享利用和大数据深度挖掘应用（朱勇，2018）。

一般来说发达国家满足与保障老年人生活质量方面的需求包括五类：健康、安全、独立、参与和活动。以下从这五个方面阐述信息通信技术在保障老年人生活质量方面发挥的作用。

8.2.1　改善老年群体机体健康状况

健康作为人类最根本的需求，其在很大程度上与人的安全、独立、参与和活动方面的需求直接相关。这些需求的实现通常受到老年人自身机体健康状况恶化的挑战。

远程医疗（tele-medicine）是以互联网、远程通信技术、计算机多媒体技术为支撑的医疗服务，可不受限于地理空间的差异，对异地患者进行远距离的视频咨询、诊断和治疗。远程医疗可服务于任何群体，其中老年群体可作为其服务的主要对象之一。中国医疗资源分配存在不均的现象，这体现在不同层级的医疗机构和地区间。地区间经济发展不平衡导致年轻劳动力人口由中西部向东南沿海省份流动，内陆省份由于年轻劳动人口的迁出和老年流动人口的反迁，导致老龄化进一步加剧。同理，中国农村老龄化的态势也较城市更为严峻（彭希哲，2018）。医疗资源的分配则呈现城市优于农村的现状，导致居住在农村或偏远地区的老年患者需进城才能获得更好的治疗。

目前中国大多数养老院医疗资源比较缺乏，无法真正实现医养结合，这与入住养老院的老年人身体机能较差的特点不相匹配，较难实现医疗、康复服务的充足供给。且老年医学相关专业人数较少，远程医疗的发展则可成为连接医院与养老院的纽带。

面向老年群体的远程医疗领域主要体现在：一是老年人家庭、社区康复护理的远程看护；二是老年人疾病管理，尤其是慢性疾病的管理，高龄老年人往往存在一体多病，需多重用药等问题，远程医疗可实现较广泛、高频的病情评估与管理，并实现不同医院间多科室或多部门的共同参与及诊断。目前 5G 网络的发展给远程医疗的实现与发展提供了有力的保障，部分国内医院开始创建 5G 智慧医疗中心，这进一步促进了医疗生态系统的变革。

8.2.2　保障老年群体人身安全

中国现阶段处于人口老龄化初期，老年人口的年龄特征呈现“低龄化”特点。随着时间的推移，中国家庭结构的核心化、空巢化导致中国空巢老年人的数量不断增加，其安全问题日益凸显。具体表现如下：一是缺乏关注的老年孤独死数量呈增长趋势。二是老年人交通安全事故率高发。根据公安部统计数据，2012 年全

年，老年人交通事故占机动车肇事总数的比例超过 40%（程志凯，2014）。由于老年人身体机能衰退，感官器官退化，反应迟钝，动作相对缓慢，导致老年人在交通事故中受伤或致死率较高。

目前中国企业正在开展防走失的移动定位装置研究，如部分企业研发可实现 24 小时安全监护的智能机器人保姆，其在节省人力的基础上，可在老年人跌倒、出现意外时即时报警。部分企业利用物联网技术积极收集老年人在家中的日常生活信息（如出入房间、开关电器、使用设施等），以此来推断老年人的生活是否存在“规律异常”，并以此发出报警求助。

无人驾驶技术的出现，使行动不便的老年人出行成为可能并更加便利。据麦肯锡未来出行研究中心 2018 年 4 月发布的报告，未来无人驾驶将从一些较简单的场景应用，逐渐发展到较复杂的场景应用。且中国资本与企业正进入自动驾驶领域。无人驾驶在创造经济价值的同时，也会实现较大的社会增值，在养老服务领域则将体现在助老出行方面。

8.2.3　提升老年群体独立生活能力

中国 2015 年 1%人口抽样调查数据显示，中国 65 岁以上人口的家庭户数占总户数的比例为 25%，其中 65 岁以上的一人户占 65 岁以上人口的家庭户的比例为 16%，并且这一比例还在持续上升。独居和空巢老年人极易遭遇各种各样的突发状况和由身体机能不断退化而导致的不同程度的失能境况，因此应为这部分老年人尽可能地提供舒适和能够增强其独立生活能力的家庭环境。随着信息通信技术的发展，老龄化社区、独居老年人和空巢老年人的独立生活可依靠各种各样的技术与应用程序的支持。

中国三大通信运营商——移动、电信、联通均推出智能养老方面的信息通信服务。2014 年中国联合网络通信有限公司西安软件研究院以智慧城市建设为切入点，与政府共同构建新型的社区管理形态，旨在探索智慧城市实施的新模式。2017 年，中国电信“互联网养老”平台包括移动云呼叫平台和大数据管理软件，集居家养老业务管理、居家养老数据采集管理、居家养老服务监督、居家养老服务结算管理、居家养老服务对象紧急救助及 GPS 等多种功能于一体，通过“老人宝”手机应用程序与老年人建立联系纽带，解决了居家养老信息化、平台化、便捷化的管理问题。2018 年中国移动通信研究院自主研发“老人室内监护助手”，使用主体为“三无”独居老年人，主要是通过室内传感器来对老年人日常生活的异常突发状况进行监测与预警。

近年来中国部分地区开展基于社区的区级、市级智慧养老信息服务平台的试点建设与探索，积极性较高。其中，2017 年 3 月贵州省贵阳市观山湖碧海社

区开始搭建“数治小区”智慧管理平台，其涵盖智慧养老服务供给；2017 年 5 月，黑龙江省哈尔滨市社区服务中心搭建服务半径最大、服务人口最多的智慧养老平台——12349 民政助老公益服务平台；北京市丰台区推出针对空巢、独居老年人智能养老服务的“连心通”平台；江苏省连云港建设市级智慧养老服务平台；浙江省杭州市成立“智慧养老服务平台”，为高龄独居老年人打造应急救助网；山东济南市历城区启动“互联网+”智慧养老新模式；等等。

8.2.4　促使老年群体深度参与社会活动

除了提供解决健康和安全问题的服务之外，老年人有参与社会活动的诉求，希望成为社会中积极的一员，并希望获得社会切实的认可。这主要体现在以下三个方面。

（1）社会参与。《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》显示：老年人社会参与不断拓展。一是老年人参与公益活动活跃：2015 年，45.6%的老年人经常参加各种公益活动，参与人数总规模突破 1 亿人，有助老意愿的老年人占比较高，72.9%的老年人愿意为社区有困难的老年人伸出援助之手。二是老年人热心社区公共事务：2015 年，21.4%的老年人曾向社区建言献策。三是老年人对基层老年协会举办的活动较欢迎：76.5%参加过老年协会的老年人表示对举办活动较满意。2021 年 8 月 21 日，中国人民大学人口与发展研究中心与抖音联合发布《中老年人短视频使用情况调查报告》，指出短视频产品降低了老年人保持社会连接的门槛，老年人通过抖音了解社会动态、和子女加强沟通、发挥余热特长，可以被视为当代老年人社会参与的新形式。

（2）劳动参与。《老龄蓝皮书：中国城乡老年人生活状况调查报告（2018）》显示：9000 多万 60 岁以上的老年人仍在业。老年人力资源储量充足，1990 年至今，中国老年在业人口数呈上升趋势，2015 年 60 岁及以上老年在业人口比 1990 年增加 3188.5 万人，其中，65 岁及以上老年在业人口增加 1395.4 万人，增长率为 115%。老年在业人口中低龄健康老年人占比较高，60～64 岁老年人数占比 42.8%。目前中国大部分信息通信技术发展仅停留在为老服务层面，缺乏对老年人作为劳动力的思量。发展信息通信技术不应仅仅针对行动力不足的老年人，还应为有“发挥余热，为社会再做贡献”意愿的低龄或行动自由的老年人做充分考虑。通过信息通信技术潜在地提升生命的质量，如为老年人提供就业与劳动参与的渠道。

（3）社交需求。微信成为老年群体社交、娱乐的主要网络平台和应用软件。截至 2017 年 9 月，微信月活跃老年用户（55～70 岁）达 5000 万人[①]。据国家统

① 《重磅！2017 微信数据报告！（完整版）》，https://www.sohu.com/a/203437993_667510[2020-12-31]。

计局公布的数据，截至 2017 年末，中国 60 岁及以上人口 24 090 万人，据 2016 年 1‰人口抽样调查结果，55～59 岁人口为 59 638 人，据估算，中国 55 岁及以上的人口中使用微信的占 16.64%。相比于其他的适老产品和应用软件，微信的老年用户活跃度相对较高，可持续性较强。此外，部分高校、机构研发了可供老年人交流分享的社交网络平台。例如，中国人民大学信息学院智慧养老研究团队创建了中国首个专门面向老年人的公益型社交网络平台——老友帮，为老年人之间的沟通与交流提供新天地（左美云和薄夷帆，2014）。

8.2.5　扩大老年群体活动范围

老年助行辅具的生产与使用。智能助行产品为行动不便的老年人提供了出行的可能性，如智能轮椅、助行机器人等。

外骨骼机器人可帮助无法站立或失去行走能力的患者提供直立行走康复训练的新方式，可辅助患者高频率、长时间保持仿人行走的运动训练，其在康复临床应用中的效果优于传统设备。可在机器人与老年人皮肤接触面安装传感器，以便对老年人进行身体数据监测，如测量血压和体温等。

随着机器人技术的发展，我国已成为全球第一大工业机器人应用市场，我国工业机器人应用市场份额占全球市场份额的 1/3。同时，我国人口老龄化趋势加快激发了服务机器人需求的增长，我国服务机器人存在巨大的市场潜力和发展空间。工业和信息化部发布的《2017 中国机器人产业发展报告》指出，2017 年全球机器人市场规模将达到 232 亿美元，2012～2017 年其平均增长率接近 17%。同时，中国机器人市场规模将达到 62.8 亿美元，占全球机器人市场规模的 27%，2012～2017 年的平均增长率达到 28%，也高于全球机器人产业规模年增长率。

8.3　技术赋能进程中的养老服务供给模式动态演进

信息通信技术的发展为养老服务的有效供给提供了新的契机，随着智慧养老相关的政策密集出台，养老服务供给模式也呈现动态演进过程。基于 2010 年、2016 年、2018 年中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies，CFPS）互联网及手机使用情况的数据分析得出：随时间推移，不同世代对互联网的使用频率已发生较大转变，其接受度也有很大提升。因此，以信息通信技术为基础的人工智能、大数据、物联网等介入养老服务供给具有一定的可行性。

中国老年人的家庭照料资源较短缺，80%以上完全自理老年人的照料者首选

是自己，不完全能自理的老年人仅有一半以上由其他家庭成员照料，更严峻的是，近 20%的完全失能的老年人缺乏照料（国家卫生计生委家庭司，2016）。同时，市场经济条件下子女支持父母的观念也发生转变，家庭照料功能不断弱化，致使老年人家庭照料风险日益提升。在当前中国社会，家庭照料功能弱化与因照料劳动力紧缺导致的社会照料功能不足的问题并存；同时，技术创新带来新的契机，智能辅助技术的创新与发展将有效弥补这一缺口，为养老服务供给实现技术赋能，促进养老服务供给模式的转变升级。技术赋能背景下养老服务供给模式的发展主要体现为借助信息通信技术的发展来提升养老服务供给的效能。2019 年 4 月 16 日国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）指出要“促进人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智能硬件等产品在养老服务领域深度应用”。2019 年 9 月 20 日，民政部印发《民政部关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》，指出要加快互联网与养老服务的深度融合，打造多层次智慧养老服务体系，创造养老服务的新业态、新模式。从政策层面看，现有的政策环境十分有利于智慧养老的发展。养老服务供给涉及老年群体最关心、最现实的切身利益，养老服务保质保量的供给是满足当前老年群体日益增长的美好生活需要的实现路径。在当前社会经济发展和技术发展双向作用下，养老服务智能辅助技术将得到进一步推广、发展和应用，其在养老服务中的地位也将从“可选”变为“首选”，最后成为“必选”。

2012 年中国开始推行“智慧城市”建设，不断促进城市智能网络技术的发展与完善，并逐步实现城市各项服务功能的技术化与信息化，5G、物联网技术的发展助力智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术以及室内外高精度定位技术的研发与应用（中投产业研究院，2018）。随着数字时代的到来，一方面，老年群体内部自身的迭代与变化，促使其对互联网的接纳度和使用度在上升；另一方面，基于智能辅助技术的研发与应用，可促进养老服务供给内容的调整、数量与质量的提升，人们将有能力充分收集、储存、传递以及处理数据和信息，基于大数据对老年群体进行精准画像，可提供更具个性化及人性化的养老服务，进一步提升养老服务供给的精准化。在内因与外因共同作用下，致使养老服务供给模式呈现动态演进态势。

8.3.1　中国不同代际间群体互联网使用习惯及程度分析

当前及未来养老照料需求不断增长，中国将面临养老服务人才供给与需求失衡等一系列问题，因此以人工智能、物联网等为代表的智能辅助技术介入养老服务的必要性在不断增强。2019 年 5 月 29 日宽带发展联盟发布的第 10 期《中国宽

带普及状况报告》显示，截至2018年第三季度，全国固定宽带家庭普及率为85.4%，其中，东部、中部、西部地区固定宽带普及率分别为98.5%、75.6%、78.2%；全国移动宽带用户普及率为93.1%，其中东部、中部、西部地区移动宽带普及率分别为107.9%、77%、89.7%[①]。同时，随着时间的推移，我国的手机网民数量也呈现持续上升的态势，2018年已达到8.17亿人（表8-1），未来仍将持续增长，宽带的普及度与网民的数量是显示信息化创新驱动潜力的指标，为智慧养老的实现与发展奠定了基础。

表 8-1　2009～2018 年中国网民数量等情况统计

年份	网民数量/亿人	宽带网民数量/亿人	手机网民数量/亿人	网站数量/万个	域名数量/万个
2009	—	3.46	—	323	1682.0
2010	4.57	4.50	—	191	866.0
2011	5.13	—	—	230	775.0
2012	5.64	—	4.20	268	1341.0
2013	6.18	—	5.00	320	1844.0
2014	6.49	—	5.57	335	2060.0
2015	6.88	—	6.20	423	3102.0
2016	7.31	—	6.95	482	4228.0
2017	7.72	—	7.53	533	3848.0
2018	8.29	—	8.17	523	3792.8

资料来源：《中国互联网发展状况统计报告》（2009～2018 年）

为探究不同世代群体对互联网的接受与使用程度，本节还使用了2010年、2016年、2018年中国家庭追踪调查[②]成人问卷和少儿问卷的数据，对中国居民互联网的使用习惯、用途及程度进行刻画，将不同世代人群按照出生年份每隔10年分别划分为“10后”“20后”“30后”“40后”“50后”“60后”“70后”“80后”“90后”“00后”，其中“70后”“80后”“90后”在未来的几十年

① 移动宽带用户普及率=（3G移动电话用户数+4G移动电话用户数）/本地区人口总数；移动宽带用户普及率超过100%的主要原因：一是存在一个移动用户使用多个3G或4G手机号码的情况；二是部分地区外来流动人口较多，如办理本地手机号码，则统计属于本地移动电话用户，但外来流动人口并未包含在本地常住人口统计中。

② 中国家庭追踪调查旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据，反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁，为学术研究和公共政策分析提供数据基础。需要说明的是，在总量分析上，本节仅使用了成人问卷数据库的数据，而在世代分析中，本节将部分成人问卷和少儿问卷进行合并，以避免“90后”和“00后”的数据样本数量太少。

内也将逐步跨入老年群体，“00 后”“10 后”“20 后”“30 后”老年人数量为处于两端的群体，“40 后”“50 后”“60 后”为当前的主要老年群体。本节重点分析现有老年群体（“40 后”“50 后”“60 后”）以及“70 后”“80 后”“90 后”人群，以此来分析随着世代更迭、互联网接纳度的不断提升，以信息通信技术为载体的养老服务供给接纳度的变动趋势，数据分析主要结果如下。

第一，手机作为互联网使用与发展便携式载体的重要性日益凸显，2010～2018 年现有老年群体与“70 后”“80 后”“90 后”的手机和网络使用率均有提升，群体间存在差异。一方面，总样本数据显示手机使用率和上网率迅速增长。2010 年到 2018 年，手机使用比例从 32.1%上升至 89.0%，电脑上网比例从 18.7%上升为 22.1%；与此同时，居民上网方式有所转变，移动上网变得越来越普遍，2018 年使用比例高达 52.1%[①]。另一方面，各世代手机使用率和上网比例均有增长，手机和网络主要使用人群在代际发生转移。2010 年到 2018 年，现有老年群体“40 后”“50 后”“60 后”使用手机的比例分别从 38.1%、56.9%、75.9%上升至 72.1%、85.7%、95.4%，比例分别上升了 34.0 个百分点、28.8 个百分点、19.5 个百分点；“70 后”“80 后”“90 后”使用手机的比例分别从 86.8%、92.3%、55.0%上升至 97.8%、99.2%、99.2%，比例分别上升了 11.0 个百分点、6.9 个百分点、44.2 个百分点。从上网比例来看，2018 年各出生队列中移动上网的比例均高于电脑上网的比例。2010 年的问卷只询问了上网情况，从 2010 年（上网）到 2018 年（移动上网），“40 后”“50 后”“60 后”上网比例分别从 1.7%、4.7%、9.0%上升至 8.4%、15.2%、35.7%，比例分别上升了 6.7 个百分点、10.5 个百分点和 26.7 个百分点；“70 后”“80 后”“90 后”上网比例分别从 21.7%、52.3%、42.8%上升至 60.8%、85.3%、91.3%，比例分别上升了 39.1 个百分点、33.0 个百分点和 48.5 个百分点。

第二，互联网逐渐成为人们了解信息的主要渠道之一，特别是在“80 后”和“90 后”群体中，互联网作为信息获取渠道的重要性逐步上升。从信息获取的 8 个渠道（电视、互联网、报纸、期刊、广播、手机短信、别人转告及其他）来看，三个调查年份，互联网作为主要渠道 2010 年排名为第四位，2016 年升至第三位，2018 年进一步升至第二位，重要性越发凸显；分出生队列来看，截至 2018 年，现有老年群体信息获取的主要渠道仍以传统媒体电视、别人转告为主，而“70 后”、“80 后”和“90 后”群体中，互联网在获取信息渠道中排名第一。

与目前已经处于老年阶段的人口队列相比，即将相继步入老年的人口队列对互联网的接纳与使用程度均不断提升（翟振武，2019），作为数字化原生代的“80 后”“90 后”互联网使用比例在 85%以上。互联网使用度是衡量老年人运用现代

① 需说明的是，2010 年的问卷中只有上网这一个问题，而 2018 年将上网分为了移动上网和手机上网，因此本节分别对这两个问题进行统计。

信息技术手段的重要指标，对老年人或即将进入老年期的群体来说，是否具备互联网使用能力会在很大程度上影响老年人的养老方式和生活质量。因此，以人工智能、大数据、物联网为基础的智慧养老技术的运用：首先，其对象不应仅涉及现阶段老年人，还应充分考虑“50 后”“60 后”初老族及更年轻一代；其次，应充分考虑不同代际使用互联网与电子设备和产品的习惯，并基于技术的发展进行有针对性的研发与推广。

8.3.2　智慧养老技术发展与养老服务供给模式的互动融合

根据 2019 年 7 月 28 日国家统计局公布的数据，2018 年全国“三新”经济增加值为 145.4 万亿元，占 GDP 的比重为 16.1%，呈持续增长态势。新技术的发展将进一步催生养老服务新产品，塑造养老服务供给新结构。智能技术的运用，可在一定程度上弥补养老服务人才的缺口，提升服务质量，并加大养老服务个性化定制的可能性，促进传统养老服务供给模式的演变与创新。

1. 技术赋能背景下养老服务供给方式的变化

传统的养老服务基本依靠的是人力供给，采取的是“人盯人”的方式，需要配备的服务护理人员必须与服务的老年群体数量相近或略少，若护理人员人数供给不足，则极易出现护理人员超负荷工作，导致其工作效率下降或服务质量下降。当下人工智能、物联网、机器人、可穿戴设备等新技术与养老产业结合越来越紧密，以数字化为特征的智慧养老将快速普及，未来的养老服务供给不应仅局限于人力资源，而应通过借助现代互联网技术与云科技，向更加智能化和广泛化发展，以构建养老服务供需平衡生态模式。同时，将大数据、云计算、人工智能等运用到养老服务平台上，不仅可以实现养老人才资源的优化配置，还可以迅速提高养老服务供给的效率。因此，智能养老技术的发展，可发挥对护理人员的辅助功能，帮助护理人员减轻负担或提高效率，养老服务供给的方式也从仅靠人力逐步转变为人机结合。

2. 技术赋能背景下养老服务供给内容的变化

前文分析得出，随着时间向后推移，现有群体对互联网的接纳度不断提升；同时，出生年份越靠后的世代，其对互联网的接纳度也呈现逐渐上升的趋势。这将促使以信息通信技术为载体的养老服务供给的接纳度不断提升，老年群体对于新技术的使用逐渐从不熟悉到必不可少。另外，技术的发展将导致一些原本属于养老服务内容范畴的事项被逐渐替代，养老服务供给的内容发生改变。当下自动化技术的发展，可逐渐弥补老年人在某些活动方面的障碍。比如，通过智能技术，上街购物可通过线上购物替代；外出活动可通过佩戴智能可穿戴设备确保老年人

定位精准防走失；家务维持可尽量使用基于物联网的一体化智能家居，如洗衣服可使用联网的智能化洗衣机；使用电话的能力可以通过智能语音实现自动控制电话拨打、语音通话等；智能设备可自动识别老年人的用药品类和用药量，避免老年人因视力模糊或意识不清导致的用药失误等。

3. 技术赋能背景下养老服务供给精准度的变化

传统养老服务供给由于人员紧缺，往往优先考虑标准化、统一化的服务以提升服务效率，致使个性化的养老服务难以实现。当下，基于智能养老服务平台的设计、运用与发展，可以对老年人服务需求进行精准记录与反馈，并为其定制个性化养老服务供给，减少沟通方面的人力物力成本。同时，信息通信技术的应用促进养老服务供给的内容也将由原来的统一化、标准化向多元化、定制化方向发展。2020 年 12 月国家卫生健康委员会办公厅发布《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》，指出要规范有序开展“互联网+护理服务”试点工作，将“互联网+护理服务”与家庭医生签约、家庭病床、延续性护理等服务有机结合，为群众提供个性化、差异化的护理服务。

8.4 中国智慧养老发展中存在的问题及对策建议

智慧养老属于老年健康信息学的范畴，老年健康信息学是一门新兴的交叉科学技术领域，目前对老年人的技术需求还缺乏较深的认识，特别是缺乏将信息学和技术与老龄化过程的不同阶段联系起来的跨学科研究。习近平在中共中央政治局第九次集体学习（2018 年 10 月）指出，人工智能具有多学科综合、高度复杂的特征[①]。当前养老辅助技术使用的研究非常广泛，但还处于起步阶段，主要由小规模研究和很少的纵向研究组成（Yusif et al.，2016）。

中国智慧养老产业作为新兴业态，其培育和发展仍面临诸多挑战。目前这些技术创新不仅没有发展成为能被广泛运用的典型，且其中很少有创新能够取得商业成功，大部分的产品仍处于研发和推广阶段。智慧养老产业的发展仍处于市场开拓初期阶段，大多数项目正在探索更清晰的商业模式和盈利模式，其产品和服务往往存在不可持续或不可复制的局限性，推广难度较大。目前进入智慧养老行业需制定长期的发展战略，发展智慧养老产业对企业的规模和资本都有一定的要求，以便能够承担智慧养老的产品研发和市场风险，并需具备较强的市场开拓和

① 《习近平：推动我国新一代人工智能健康发展》，http://www.xinhuanet.com//2018-10/31/c_1123643321.htm[2018-03-07]。

资源整合能力。这意味着小微企业与小资本进入智慧养老市场将步履维艰，在一定程度上减弱市场的灵活度和产品服务的多样化。

同时，智慧养老发展的难点往往伴随着社会变革的进程，社会中普遍存在对智慧养老的肯定但不确定的态度，由于市场刚刚兴起且引导不足，社会大众对智慧养老概念模糊。老年人自身对智慧养老的接纳度也成为行业发展中至关重要的一环，许多老年人存在技术接纳的障碍，老年人采用智能技术是一个复杂的问题，将技术运用到达实质性的扩展阶段不仅仅是技术问题，更多的是一个社会发展过程。

目前中国智慧养老发展仍处于探寻老年人真正需求的层面。需深入实际不断了解和试探老年人的智慧养老消费习惯与需求，以精准供给智慧养老服务和智慧养老产品。我们应审时度势，在中国情境下走出具有中国特色的智慧居家养老服务的道路。中国的人口基数大，未来老年人口数量将达到 4 亿多人，老年人作为人口结构中的主流群体之一，应充分被看到和尊重。

8.4.1　智慧养老在当前养老服务体系中的定位问题

人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智能硬件等产品的使用在未来养老中的定位主要体现为两个层面：一是完全替代劳动力；二是作为辅助技术，进一步提升劳动效率，减轻劳动力负担。根据目前人工智能对工种的替代率统计的研究看，养老护理员（从事养老看护的职业种类）被人工智能替代的概率较低。这也可理解为与人类感情交互越多的职业工种，被替代的可能性越低。综合牛津大学、麦肯锡公司、普华永道会计师事务所、创新工场等研究报告对从 2018 年起未来 10～15 年 365 类工作被取代的概率进行预测，与养老服务相关的职业种类被替代的可能性均在 5%以下（表 8-2）（李开复，2018）。

表 8-2　与养老服务相关的职业种类替代率统计

职业种类	10～15 年被替代的可能性
社会服务工作者	2.3%
福利专业人员	2.4%
老年人看护	4.0%
健康辅助专业人员	4.0%

目前关于智能技术在老年护理中发挥作用的部分文献集中在人员替换和成本效率方面可能带来的优势，但智能技术的引入将减少需要护理的人与其他人接触

的时间。那么，智能技术为孤独的老年人提供陪伴甚至友谊的观点将被质疑，当前智能设备发展更像是一种辅助设备，无法实现与人的充分互动（Sparrow R and Sparrow L，2006）。Shinkle 和 Tassin（2011）研究表明，缺乏社会融合对老年人的发病率和死亡率有负面影响。Farber 等（2011）认为任何旨在提高老年人和年轻人（或病人）福祉与生活质量的智能技术的目标，或许都不是培养唯我主义的独立性，而是促进和维持人际交往与联系的能力。

技术的目的是促进人与人之间的联系，而不仅仅是取代它。从这个角度来看，必须仔细审查任何智能辅助技术系统的效力。当下新技术的研发和使用成本是相当高的，应充分评估单靠社会支持是否可能取得同样甚至更好的结果。当前智能环境辅助生活系统不太可能被用作单独解决方案的技术，因此核心点在于要在社会环境中考虑动态充分交互的技术发展，并在此基础上调整社会结构，且需要对老年人的需求以及老年人是否愿意在智能技术环境的辅助下保持联系或建立新的联系进行研究。许多智能技术引发的伦理问题，值得进一步研究，这些信息对于护理人员、制造商及老年消费者来说是必不可少的。了解老年人可以接受多大程度的行为改变，以及其行为如何随着独立程度的改变而改变，是信息通信技术辅助延长独立和生活质量的关键（Daniel et al.，2009）。

8.4.2　智能技术发展对老年人不同生命周期阶段的适配问题

老年人与科技的互动不仅受到个体特征的影响，还受到相关社会关系和环境的影响，而社会对老龄化的定义和公众对老龄化的看法又反过来影响着老年人与科技的互动（Lee，2014）。

许多现有的系统尚未被欣然接受，原因在于技术与产品的设计和开发与老年人特征和需求不相符合。因此，应尽早让老年人参与到技术与产品的开发过程中以识别他们的需求并评估设计规范，提升技术的用户吸引力。

虽然老龄化是一种客观与可量化的现象，但确切的老年化的开始是一种主观体验，在不同的文化和历史中也各不相同。因此，老龄化被认为是一种社会角色意识的重新建构，它代表着一个时间段内的包括生理和心理的转变。当个人处于初老阶段时，需要提供智能辅助技术，让其更充分地参与社会活动或贡献自身价值和力量，强调较强的社会参与感。当个人处于高龄阶段（达到并超过 80 岁）时，他们对保健的需要，包括对慢性病的管理和日常生活活动的协助频率会显著增加。在老年慢性病的控制中，治疗并非核心手段，健康管理、康复护理、生活照料及精神慰藉反而十分重要。与此同时，随着年龄的增长，家庭照顾者往往要求照顾他们的老年家庭成员，然而，由于人力的有限性，照顾者在维持老年人有尊严地生活时会面临诸多挑战。为帮助减轻家庭护理人员的照料负担，建议探索辅助技

术设备的应用。

因此，要充分考量老年人不同迭代之间的信息习得能力与需求差别。中国科学院院士梅宏指出，我国的信息化从 20 世纪 80 年代单机运用的数字化阶段过渡到以联网运用为特征，现将进入数据深入挖掘和融合运用的智能化阶段。聚焦到养老领域，人口持续的迭代使不同代际的老年人对物质与精神需求不同，不断满足老年人日益增长的物质文化需求是智慧养老发展的应有之义。应充分考虑不同老年群体的特殊性，持续充实养老照料人才数量以及提升人才供给质量，并基于智慧养老的辅助，构建精准的养老服务供给模式。首先，技术的研发与养老服务的供给应具有时代性和场域性，需充分考虑产品使用对象的特点和使用偏好。对老年人的需求进行科学精准的评估，根据不同年代的老年人的技术使用习惯和使用标准去研发产品，将适老科技与养老服务供给放在特定的场域中。其次，企业与市场在产品研发过程中应增设老龄化产品设计模块，充分考虑不同年代老年人的生活需求和原来的生存背景，基于全生命周期视角进行产品开发；充分考虑老年人客户主体性的原则，采用新人新办法、中人中办法、老年人老办法的原则。

8.4.3　智能技术参与者之间的关系互动与博弈问题

从当前智慧养老市场发展的角度看，智能技术和相关服务的购买与维护成本通常很高。而老年人在做出接纳决定时，他们会根据潜在的收益来评估成本（Lee et al.，2013），所以充分与老年人进行分析和沟通是关键之一，需促使老年人将服务成本视为“明智的投资”而不是“负担”，进一步扩大智慧养老技术的适用范围。

基于公共政策支持的视角，在智慧养老发展中提供激励和补贴的政策举措也可能增加技术的采用度。例如，在美国，只有不到 5%的潜在市场采用了个人紧急报警系统，而在英国，这一比例为 15%，其部分原因是国家卫生服务部门提供了全额补贴。智能技术的发展涉及各方利益的协调，通过文献研究得出，老年人对智能家居技术的态度是积极的，通过适当的支持可克服老年用户中存在的一些普遍的技术障碍。研究发现，政府在智能技术的发展与推广中所起的作用不容低估，政府可通过市场监管、执行标准制定、隐私保护协议、补贴试点项目或初始投资成本支持等措施，提高智能技术的使用率。

8.4.4　养老服务人才与智慧养老技术发展的关系问题

从我国现状来看，养老服务人才紧缺，一是现有规模无法满足未来快速增长的照料需求；二是目前我国养老服务人才分工不明显。

据《中国健康养老产业发展报告（2016）》，截至2016年，我国养老机构护理人员低于30万人，其中仅有4万人持有职业资格证书。目前我国老龄服务人员需求缺口巨大，现有老龄服务人员的规模远远无法满足人口老龄化发展的需求。同时，《全国民政人才中长期发展规划（2010—2020年）》指出，到2020年养老护理员的数量应发展到600万人。按照国际公认的3位老年人需要1名护理人员的标准计算，我国养老人才的供需处于严重失衡状态，这将导致老龄服务缺乏基本的人力资源支持，并会致使一些老龄服务机构只能聘用没有受过正规培训的服务人员，老龄服务质量无法得到保证。养老服务领域劳动力供给结构与需求结构的不匹配是未来一段时期内劳动力市场的主要矛盾（彭希哲等，2019）。传统仅依靠人力供给的养老服务随着人口老龄化的加重难以满足老年群体的需求，养老服务供给会逐渐陷入困境，养老服务供需面临失衡境况，给有老年人的家庭带来较沉重的照料负担。养老服务领域劳动力供需失衡必然导致养老机构运营和家庭照料者压力日益增加，并且呈现不可逆的趋势。

同时，人口老龄化程度的深化除了进一步催生照料劳动力需求外，还会在中国创造一系列其他职业的巨大需求，包括医生、护士和卫生技术人员及居家照料护理助理与医疗康复护理助理等。但目前我国养老护理人才分工并不明确，养老护理方面的人才细化度和精度也不充分，分工不明确易导致养老护理人才待遇提升遇阻。同时，我国缺乏对技能需求较高的养老服务人才工种识别和鉴定的依据，导致整体养老人才的待遇不高，职业吸引力缺乏。《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（国发〔2017〕13号）指出，要加快培养老年医学、康复、护理、营养、心理和社会工作、经营管理、康复辅具配置等人才。一般来说，居家养老的护理人才需求涵盖生活照料人员、家政服务人员、健康保健人员和精神慰藉人员；机构养老的护理人才需求涵盖医护人员、康复人员、护理人员、营养人员、经营管理人员、养老志愿者等（李艳，2018）。

面对当前及未来养老服务人力资源缺乏及专业度难以提升的问题与困境，以信息通信技术为基础的智慧养老提供了新的契机和抓手，技术赋能的养老服务供给可逐渐改变老年服务中“人盯人，一对一”的传统模式，为养老服务人力提供辅助，并提高服务效率和质量。

技术的切入可以有效地改变养老护理人员等部分职业的流程和内容，但机器自动化与传统劳动力之间的关系并非完全的替代关系，两者之间的互补性和替代性并存。国家应注意调整劳动力培训内容和政策支持方向，实现更好的导向作用，在技术变革中占据主动权。

1. 政府应注重在科技助老领域培养高层次复合型人才

人口老龄化导致整个社会劳动力年龄结构的老化及劳动力人口数量下降，同

时，传统养老服务供给模式的弊端进一步导致养老护理人才发展陷入数量紧缺、增长困难的双重困境。借助自动化有助于抵消劳动人口比例下降的影响，智能辅助技术则有助于提升养老护理人员的劳动效率，减轻养老护理人员的劳动负担。但智慧养老涉及多学科协调发展，同时其也对养老护理人员的信息通信技能提升提出一定的要求。目前智慧养老发展面临的瓶颈之一在于掌握信息通信技术的人才不熟悉养老理论和实践，而懂养老理论和有实践经验的人员，却对智能技术不熟悉甚至不了解，智慧养老方面的综合性人才较少。因此，从长远来看，应注重在科技助老领域培养高层次复合型人才以促进智慧养老发展。

2020 年 1 月，教育部、国家发展和改革委员会、财政部发布《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》，强调要以产业行业人工智能应用为导向，拓展核心技术和创新方法，实现人工智能对相关学科的赋能改造，形成“人工智能+X”的复合发展新模式。顺应人工智能发展形成的学科不断交叉趋势，养老服务供给行业也应逐步对养老护理人才掌握的技能进行调整与培训，使养老照料护理人才逐渐专注于提升机器自动化无法替代的人类能力方面，进一步提升养老服务供给的效率。

2. 定期调整养老照料护理劳动力培训内容

人口老龄化程度加深，为老年人提供服务的专业化程度将逐渐提升，促使老年照护服务的职业工种不断细化。一方面，应日益细化老年照护的职业分工。精细化的职业分类有助于科技辅助的介入，机器自动化的出现是为了高效地完成工作而非进行替代，人与机器更多的是一种协同关系（Manyika et al.，2017）。另一方面，需要不断理清老年照料职业群体之间的定位，并对其给予有针对性的培训。科技介入将使与养老护理相关职业工种的流程发生调整，所以相应地需要对养老照料护理人员定期进行工作流程及内容的培训以提升其能力。

8.4.5　智能城市建设中老年友好型技术设施嵌入问题

智慧城市的概念是 20 世纪 90 年代由 IBM 首次提出的，中国智慧城市的发展从 2011 年开始，截至 2015 年全国智慧城市试点累计超 300 个，2016 年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》再次提出“建设智慧城市”。以互联网、大数据、高速计算机为基础，国家在促进城市发展中积极运用人工智能，为智慧养老的发展提供更有利的发展基础和条件。以此为契机将智慧养老发展嵌入其中，这将大大促进养老的智能化发展程度和服务供给效率的提高，并且基于信息技术发展的养老服务体系运行可减少老年人对养老护理人员的依赖，缓解当前养老护理人才供给不足的现状。

基于智慧城市的发展，老龄社会的信息通信技术创新应覆盖和改造以下部分。

（1）居住环境的改善。进行住房适老化改造，除为老年人提供旧宅适老化改造外，逐步推广电子适老化改造，并鼓励养老院进行信息技术改造；远程监测预警，使用基于物联网的预防跌倒和紧急援助等安全系统，保障老年人尤其是独居、空巢老年人的人身安全，防止意外事故的发生；促进服务机器人的发展，借力智能技术发展人工智能私人助理。

（2）适应智能医疗保健系统。促进远程医疗的开发与应用，提升医疗资料的可获得性；在为老年人开发低成本的护理机器人和智能护理辅具方面，以及在其销售、租赁方面给予一定的补贴。

（3）降低老龄化带来的负面效应，提升自理能力。发展与推广新型老年人友好交通系统和积极做好老龄化城市的智能城市规划；通过移动网络和 GPS 建立安全、高保障的远程监测，防止老年人走丢；提升养老金保障体系的信息技术含量，以用户友好的方式为老年人提供生活保障。

（4）提升老年群体的社会参与感。通过远程参与终身教育项目，鼓励老年人积极学习教授电子参与课程的知识与内容；在电子政务建设与升级过程中，充分考虑老年群体，增强老年人的体验感，使老年人在使用时感到简便和舒适；促进老年人就业，建立新的促进老年人就业的系统和平台，如专为老年人设立的远程工作模式或一周工作三天的弹性工作机制；依托电子信息技术进一步扩大老年人的社交网络，并构建社区志愿服务文化氛围，鼓励老年群体积极参与。

在此基础上制定相应的指标和评估方法对上述四个部分的信息与通信技术创新发展的进展进行评估。

习近平在中共中央政治局第九次集体学习时强调，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”“加强人工智能在教育、医疗卫生、体育、住房、交通、助残养老、家政服务等领域的深度应用，创新智能服务体系”①。中国的数字化发展程度已位于世界前列，中国是全球最大的数字技术投资国之一，也是全球三分之一“独角兽”企业的所在地。国内数字市场规模较大，对各种形式的数字化接纳度较高。政府对数字化创新和创业持积极与鼓励的态度，推进数字转型对本国经济已产生深远的影响，并也将可能对全球数字格局产生更大的影响。智慧养老发展任重而道远，应充分利用当前社会经济发展契机，紧密结合当下时代发展背景，利用智能技术发展切实解决养老服务出现的难题与痛点。

① 《习近平：推动我国新一代人工智能健康发展》，http://www.xinhuanet.com//2018-10/31/c_1123643321.htm[2018-03-07]。

第 9 章　中老年数字融入现状及数字能力提升

王雪辉　沈凯俊

新冠肺炎疫情暴发以来，我国高速发展的数字科技和老年群体落后的数字能力间的矛盾被逐渐放大，部分地区出现老年人因为没有智能手机导致出行、办事遇阻的事件。例如，2020 年 8 月，一位老年人因没有手机，不能出示“健康码”，遭到公交司机拒载和乘客轰撵；11 月，一位老年人独自冒雨交医保费却被告知不收现金。数字时代为社会提供了巨大的便利，但在很多老年人眼中遥不可及。数字鸿沟不仅拉开了老年群体和数字时代的距离，也将老年群体和年轻群体分隔成两个世界。在积极应对人口老龄化国家战略背景下，如何打破数字鸿沟已成为重要的发展议题。打破数字鸿沟不仅是老年人的期待，更是横在全社会面前的一道难题。

9.1　问题提出与研究现状

9.1.1　问题提出

中国的人口结构日趋老化，而中国的数字社会日新月异，数字化和老龄化同时成为时代的标签。科技进步驱使人们需要提高互联网技术运用等数字能力，以适应数字社会。目前数字社会对国民影响的主要表现形式是智能手机和互联网的使用。智能手机和互联网的发展变化带来的是人们生活方式的改变，小到出行、购物，大到看病、办理行政事务，都离不开互联网。因此，面对“数字化生活”洪流，老年人也很难置身事外，无法适应将使老年人在老龄社会和数字社会成为双重弱势群体。目前的老年群体主力军大多是“40 后”“50 后”，这一代人多数在工作期间无须接触互联网和智能手机，因此错过了科技进步带来的红利和缺乏使用科技产品的习惯，导致这类群体很难融入数字时代。这类老年群体跟不上数字时代的步伐，还因为他们对新技术、新知识的接受能力弱，而习得过程中又经常受到互联网上虚假信息的干扰，对新技术始终怀有一种畏惧感。另外，老年人对新技术的学习存在惰性，供给侧也未能够为老年人提供操作更简单的智能设备。

尤其在新冠肺炎疫情暴发后，人们生活中对互联网和智能手机的应用更加频繁，互联网实实在在地渗透到生活的每一个领域，但老年群体的生理素质和文化水平等众多因素限制其融入数字社会，形成了显著的数字鸿沟。

面对如此严峻的老年数字鸿沟形势，《国家积极应对人口老龄化中长期规划》指出，推动积极应对老龄化战略上升为国家战略，提倡多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给。在数字化和老龄化的后疫情时代，大部分智能软件仍将出于盈利考虑专注于中青年群体，而小部分针对老年用户的智能软件将迎来政策蓝海下的机遇。但从某一层面来说，“老”与日新月异的科技一样，都在代代更迭，故数字鸿沟虽长期存在，而智能手机和互联网引起的数字鸿沟将暂时存在。针对目前的数字鸿沟，政策制定对于不同情况的老年人需要区别对待，不必强求其接入数字社会，不要过分强调其面临的“数字困难”，重点是要有保障其权利的不同措施。故在科技产品设计之初，应更多关照老年群体的诉求，特别是对于那些没有身体限制和有实际学习需求的老年人，需要动员多方力量共同开展“数字反哺”行动，提升中老年群体的数字素养和能力。需要明确的是：①我国中老年群体数字使用现状和异质性；②我国中老年群体在互联网融入中的问题；③我国中老年群体数字能力提升的策略。

9.1.2 数字鸿沟的内涵及分类

数字鸿沟作为技术与社会发展过程中的映射，最初，该概念被理解为信息通信技术在不同人群中可获得性和使用性的差异，人们可以通过简单地提供信息通信技术接入实现对其的弥合（van Dijk，2006）。随着时间推移和互联网社会的快速发展，数字鸿沟概念的内涵和外延都有所扩展，人们的关注焦点逐渐转移到信息主体的能力和技能上。2002 年以后，为了解释信息主体能力差异，学者对数字鸿沟的研究加入了社会、心理和文化背景（Hsieh et al.，2008），由此形成了第一道数字鸿沟和第二道数字鸿沟的概念，前者指获取信息通信技术的差异，后者指信息通信技术使用方式的差异。随着研究的深入，有学者提出第三道数字鸿沟（Robles et al.，2011），是指由互联网使用的有益结果及其使用后引起的不平等现象（Wei et al.，2011）。

关于数字鸿沟的定义，国内外学者及相关国际组织等都提出了相应概念。其中，OECD（2001）提出数字鸿沟是指“不同社会经济层面的个人、家庭、企业和地理区域，在获取信息和通信技术以及在各种活动中利用互联网的机会及其使用方面的差距”。国际电信联盟认为，数字鸿沟能以不同的形式存在，如不同国家之间的数字鸿沟，还可以适用于不同人口特征的群体，如年龄、性别、收入、种族、地区等。Mariën 和 Prodnik（2014）的研究认为数字鸿沟不再以数字设备

或互联网接入为标志，而是以用户的数字技能为中心，把问题的核心与用户联系在一起。综上可知，随着互联网社会的快速发展，数字鸿沟的内容日益丰富，范围逐渐扩大。

数字鸿沟根据信息主体分类，通常包括国家间的数字鸿沟（全球数字鸿沟）以及国家内个人与群体之间的数字鸿沟（Zhao et al.，2014）。全球数字鸿沟侧重于各国的不平等，国家间数字鸿沟主要取决于教育水平、社会经济指标，以及与特定国家的互联网和宽带相关的基础设施（Cruz-Jesus et al.，2012）。初期，Mcconnaughey（1998）针对国家内部的数字鸿沟从社会经济和人口学视角下研究了个人电脑和互联网普及率，Mcconnaughey 等（1999）考虑了性别、年龄、种族、收入、教育和地理等一系列因素，发现数字的不平等主要是由收入和受教育水平的差异导致的。21 世纪以来，学者开始关注不同群体间数字鸿沟背后的深层次社会、文化和心理原因。例如，Newman 等（2017）利用布迪厄的批判理论探讨资源的不平等分配如何影响年轻人的数字包容过程。Brandtzæg 等（2011）对欧洲国家居民使用互联网的研究发现，在跨国层面，年龄和互联网接入是最显著的预测因素，并建议未来增加互联网用户类型之间的数字鸿沟划分。Yu 等（2016）针对中国农民工的互联网使用研究发现，由于缺乏动机、知识和社交途径，该群体仍保持最低限度的电子化，需要增强工业和公共资源来应对数字鸿沟的挑战，而社会经济差距仍是阻碍其互联网接入和使用的主要因素。

9.1.3　数字鸿沟的影响因素

数字鸿沟是一个复杂的现象，其受到多种因素的影响。在现有数字鸿沟的文献中，研究普遍认为互联网使用与信息获取和信息通信技术密切相关（Riggins and Dewan，2005）。其中，教育、收入、性别、年龄及基础设施等是形成数字鸿沟的重要影响因素（Quibria et al.，2003；Haight et al.，2014；Helsper，2010），地理因素也在数字鸿沟中发挥重要作用（Vicente and López，2011）。本节将重点从四个维度梳理数字鸿沟的影响因素。

1. 经济因素

经济因素是互联网使用的门槛因素。从已有研究文献看，较高的经济成本通常被认为是使用信息通信技术的重要限制因素（Riggins and Dewan，2005）。Hsieh 等（2008）的研究发现，受益于先进信息通信技术的人主要是经济优势主体，特别是在发展中国家，经济收入是能否使用信息通信技术的主要影响因素。发展中国家经济因素带来的技术排斥和制度排斥，在于发展中国家现阶段主要任务是追求经济效率而非追求经济公平，这使得智能技术暂未考虑老年群体的实用性以及

相应保障性制度滞后于经济发展。然而，随着数字时代的发展，经济收入因素对数字鸿沟的影响将逐渐减弱。Bohin 和 Rohman（2011）研究发现收入水平对移动宽带接入的影响小于地理区域的影响；Puspitasari 和 Ishii（2016）的研究表明，基于个人计算机的互联网的分歧正在转向智能手机的新鸿沟，而经济收入已不再是导致更高水平数字鸿沟的决定性因素。

2. 年龄和性别因素

年龄和性别是导致数字鸿沟的重要因素之一，但是非根本因素。老年群体的数字文盲现象是相关文献中的一个公认事实（Demoussis and Giannakopoulos，2006）。老年群体在生理和心理层面的限制，会影响其吸收新知识的兴趣和能力，从而导致数字鸿沟的出现（Czaja and Lee，2007）。在与年龄相关的数字鸿沟文献中，研究发现最重要的因素是那些出生和成长伴随信息通信技术发展与没有伴随信息通信技术发展人群之间的差异，这两个群体通常被称为“数字原住民”和“数字移民”（Prensky，2001）。尽管在西方国家，与性别相关的数字鸿沟已大大缩小（Mumporeze and Prieler，2017），但不少研究表明，女性使用计算机等智能设备的可能性明显低于男性（Wasserman and Richmond-Abbott，2005），尤其是在发展中国家（Antonio and Tuffley，2014）。总体上，不同队列和性别的老年群体对于维系社会关系纽带所借助的工具差异，导致老年群体的社交排斥和能力排斥，放大了个体因素的影响。

3. 教育因素

教育程度是导致数字鸿沟的根本因素，集中体现于年轻群体和老年群体的数字能力差异。相关文献表明，受教育水平是互联网技术使用能力和获取的最一致的预测因素（Chinn and Fairlie，2007）。Wilson 等（2003）的研究发现，与受教育程度较低的群体相比，受过高等教育的人接触互联网的机会更多，使用互联网的能力更强，实践经验更丰富。我国现阶段老年群体由于受教育程度较低，对于新技术的知识和学习能力相对不足。一方面是老年人自身学习能力不足客观导致的数字能力习得性差，另一方面是老年人科技恐惧感主观导致的心理排斥。

4. 地理因素

地理因素是导致数字鸿沟的重要因素，主要通过当地的经济因素和教育因素间接体现。不同国家和地区之间的技术与信息通信技术使用水平除了取决于当地社会、经济和政府因素，地理临近也可能对数字发展的速度和规模产生重要影响。相关文献详细分析了数字鸿沟中的地理因素，特别是地理位置的城乡因素（Pick

and Nishida，2015），认为城乡数字鸿沟是经济贫困和技术贫困等多维因素叠加的形态。

9.1.4　中国老年群体数字鸿沟的影响因素分析

老年群体在经济因素、年龄因素和教育因素中处于劣势地位，因而中国老年群体是数字鸿沟的重灾区。一般而言，导致老年群体数字鸿沟的直接因素包括两方面：接触机会和使用能力。与年轻群体相比，老年群体接触信息基础设施机会不足和数字能力较低，难以适应互联网社会的快速发展。然而，老年群体出现数字鸿沟的境况并非仅由其自身因素决定，而是个体、家庭、社会和科技等诸多因素共同作用的结果。

从个体方面来看，老年群体的生理、心理特征及社会经济因素导致老年群体在科技上处于弱势地位。研究发现，性别、年龄和受教育程度对老年人使用电脑、互联网、智能手机有显著影响，其中，受教育程度具有决定性作用（周裕琼，2018）。老年人视觉、听觉等身体机能的衰退直接影响其对智能化技术产品的使用。学习和记忆困难则让老年人产生无力感和心理抗拒，进而对智能产品产生恐惧感。而对技术有用性和易用性的感知缺失、对社交媒体的社会文化意义的理解不足及对新媒体的刻板印象，进一步影响老年人对新社交媒体的接纳。此外，面对市场导向的智能科技产品，收入也是老年人使用硬件设备、网络和拓展使用环境的重要基础。可支配收入越高的老年群体，其接触网络媒体的概率越大。

从家庭方面来看，信息科技方面的家庭反哺、亲友互助和社会支持不足，也会造成老年人难以融入信息社会。研究表明，代际文化反哺、亲友互助以及信息资源和文教投入对老年人的数字素养提升具有关键作用（徐越等，2020）。但是一方面子女往往缺少足够的耐心来教老年父母，另一方面空巢家庭比例上升，已经组建核心家庭的子女更容易忽视老年父母的需求，使得老年人与数字社会脱节。另外，对老年群体而言，互联网技术的社会普及相对滞后，这也是造成老年群体数字鸿沟的重要因素。尽管社区老年大学开设了电脑、网络和智能手机使用等方面的课程，但收费的老龄产业仍需等待有效需求队列进入老年期。

从社会方面来看，现代智能产品设计基于消费导向，在很大程度上影响老年人对数字产品的接受和使用。目前市场上的智能产品主要面向年轻群体，其产品设计对老年群体不太适用，老年数字友好程度较低。随着互联网社会的快速发展，信息不仅成为一种公共资源，而且变成一种生产要素、一种具有交换价值和交易价格的商品。市场开始介入信息的获取、传递和交流，信息交流从无偿走向收费，使得信息富有阶层与信息贫困阶层之间出现了信息差距，造成了数字鸿沟。从这个意义上说，数字鸿沟其实是经济鸿沟的产物。在现代科技飞速发展的背景

下，老年人利用信息通信技术来获取健康信息以及增加与远距离家人沟通交流的诉求越发强烈，但受市场主导和注重高精尖技术的现代信息科技并未将老年人设置为电信设备和信息内容的主要目标群体。这种由社会转型导致的结构张力使得老年人在与现代科技的互动过程中处于明显不利地位（杨一帆和潘君豪，2019）。

9.1.5　数字鸿沟研究趋势——数字包容

进入 21 世纪，随着数字鸿沟现象逐渐受到各国政府的重视，数字包容开始得到人们的关注。2001 年，美国、日本等八国领导人发表的《全球信息社会冲绳宪章》提出，世界各国在信息社会发展进程中，都面临消除数字排斥实现数字融合的问题，数字融合日益成为世界各国数字化进程中的重要政策与社会议题。2006 年，欧盟正式引入“数字包容”一词，其内涵是信息通信技术在各个层面（社会生活、就业、政治参与、健康、娱乐等）促进均衡和促进社会参与的程度，而数字鸿沟则指“那些有权大力参与信息和知识社会与经济的人与那些没有参与的人之间的差距”。Yu 等（2018）在其研究中指出数字包容和数字鸿沟是对比现象，代表了较为普遍的数字参与。他们认为，一个社会中的数字鸿沟越小，其就越接近数字包容性社会。当个人和群体被排除在数字社会的各种场景之外，这个社会将处于数字分裂社会。

数字包容意味着以全面的方式使用数字智能设备，促进就业，提高生活质量、社会参与和社会融合。数字包容的内涵涉及多个方面，包括数字社会包容、数字公民和数字社交融合（Lee et al.，2010）。根据 WebJunction 的分析，数字包容在数字社会对于经济和劳动力的发展、公民参与、教育、医疗、公共安全尤为重要[①]，但数字包容不仅需要通过基础设施和技术创新来提升数字能力与数字融入，更需要弥合由收入、教育、性别及年龄导致的数字能力差异。

2010 年，欧盟正式发布欧洲数字议程政策，旨在更好地利用信息和通信技术，以促进创新和经济增长，为所有人提供便捷的互联网接入，以及提高数字素养。从国际研究趋势看，Parsons 和 Hick（2008）的研究指出，关于互联网使用的研究已从描述数字鸿沟的静态特征转向分析数字包容的过程。未来，总之数字鸿沟的研究将更加聚焦数字包容，并以此为研究的出发点和落脚点。在数字时代，数字鸿沟的弥合程度越高，数字社会的数字包容程度越高，数字公民的社会融入程度也将越高。

① “What is digital inclusion?”, https://www.webjunction.org/explore-topics/digital-inclusion.html[2020-12-31]。

9.2　中老年群体的数字融入状况分析

近年来，相当数量的老年群体已经开始接触使用互联网，但是老年群体数字融入处于起步阶段。中国互联网信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2020 年 3 月我国 60 岁及以上老年网民占网民总数 6.7%，与此相比 2019 年末我国 60 岁及以上人口占比已经达到 18.1%。鉴于数字鸿沟对于不同年龄人群产生的意愿使用和实际使用机会、能力的不平等现象，国务院办公厅印发了《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，为打造老年数字友好型社会提供了基本的政策指导依据。本节通过使用 2017 年中国综合社会调查（Chinese General Social Survey，CGSS）数据，首先分析我国中老年群体数字使用状况，其次从接入鸿沟、使用鸿沟和认同鸿沟三个方面分析我国中老年群体从愿意使用到实际使用所面临的障碍，最后分析我国中老年群体数字使用对于人际关系和生活的影响。

9.2.1　中老年群体的数字使用状况

1. 互联网普及现状

智能设备连接互联网是数字使用的基础，设备是否上网可以较好描述老年群体的互联网使用现状。按照《中国互联网络发展状况统计报告》，2020 年老年人的互联网普及率仅为老年人口的 23.7%，远不及年轻网民 73.0%的普及率。为了进一步分析老年人口互联网普及率分布特征，选取 2017 年 CGSS 中 50～89 岁样本抽查数据。样本增加了 50～59 岁中年群体，并删减了 90 岁及以上高龄群体，整体上样本的智能设备上网普及率为 31.2%，基本契合《中国互联网络发展状况统计报告》统计的 60 岁及以上普及率指标，说明 CGSS 样本一定程度上可代表总体特征。

如图 9-1 所示，互联网普及在性别上呈现略微差异，在居住地和年龄上呈现显著差异。以性别分类可见，男性中老年人群略高于女性，占比分别为 33.3%和 29.2%。以居住地分类可见，农村相比于城镇，互联网普及率大幅落后。其中城镇中老年人群互联网的普及率达到了 44.2%，相对应农村中老年人群仅为 12.4%。以受教育程度分类可见，大学及以上学历中老年人群互联网普及率达到了 81.2%，相对应小学及以下学历中老年人群互联网普及率仅为 9.1%。以年龄分类可见，50～59 岁中年人群互联网普及率接近五成，相对应 70 岁及以上人群互联网普及率降至 13.1%。综合来看，随着年龄增加，农村和城镇老年群体互联网普及率占

比大幅下降。50～54 岁组的城镇老年群体互联网普及率达到了约七成，80～84 岁的城镇老年群体互联网普及率降到约两成。相对应地，55 岁及以上农村老年群体的互联网普及率低于两成，65 岁及以上农村老年群体已经低于一成，而 85～89 岁组的农村老年群体更是接近于“网盲”。

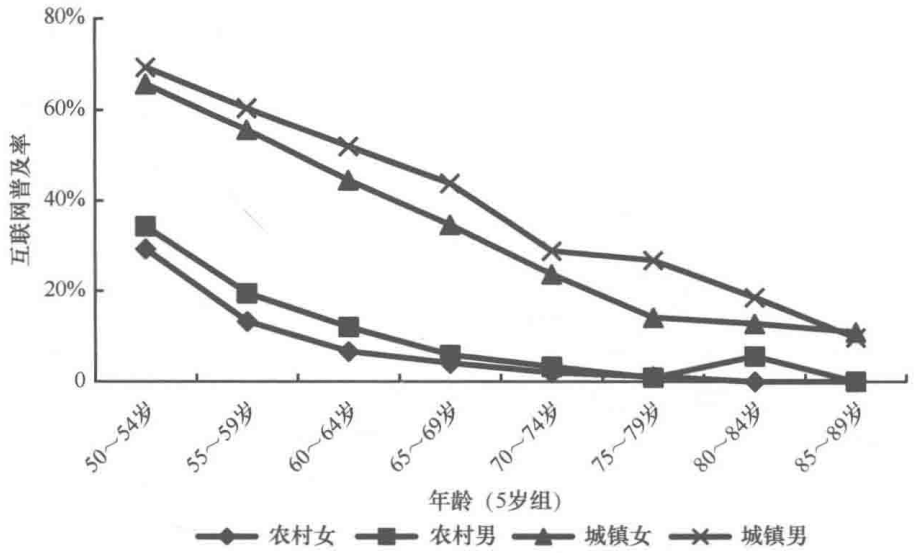


图 9-1　中国 50～89 岁中老年人城乡-性别互联网普及率

为了进一步研究互联网普及率，将互联网使用（包括手机端互联网使用）频率划分为从不使用、很少使用、有时使用、经常使用和非常频繁使用五类，分别将其赋值为 0～4 分。从不使用互联网的群体占样本总数的比重约为 67.8%，基本契合互联网普及率占比。而使用互联网的中老年群体，对于互联网的依赖程度较高。很少使用的群体在其中占比仅为 18.7%，有时群体使用的占比为 18.9%，经常使用和非常频繁使用的群体占比分别达到 31.8%和 30.6%。

如图 9-2 所示，将互联网使用频率根据城乡和性别分类，与互联网普及率类似，互联网使用频率也呈现出城镇男性、城镇女性、农村男性和农村女性的梯度分布。城镇中老年人群互联网使用频率显著高于农村，50～54 岁组的城镇男性是唯一均值超过了 2 分的组别，但也仅是有时会使用互联网。而 65 岁及以上的农村人群互联网使用频率均值接近于 0，相比于互联网普及率，呈现出更为严重的数字鸿沟。而随着年龄增长，城乡差异会逐渐减少，高龄样本均值普遍低于 1 分，意味着我国大部分城乡高龄老年人不会使用互联网。

2. 基础软件使用

随着社交网络和移动支付的盛行，以微信为代表的社交 App 以及以支付宝为代表的支付 App 在功能上高度整合，一方面，这确实为青年群体带来了实用性和

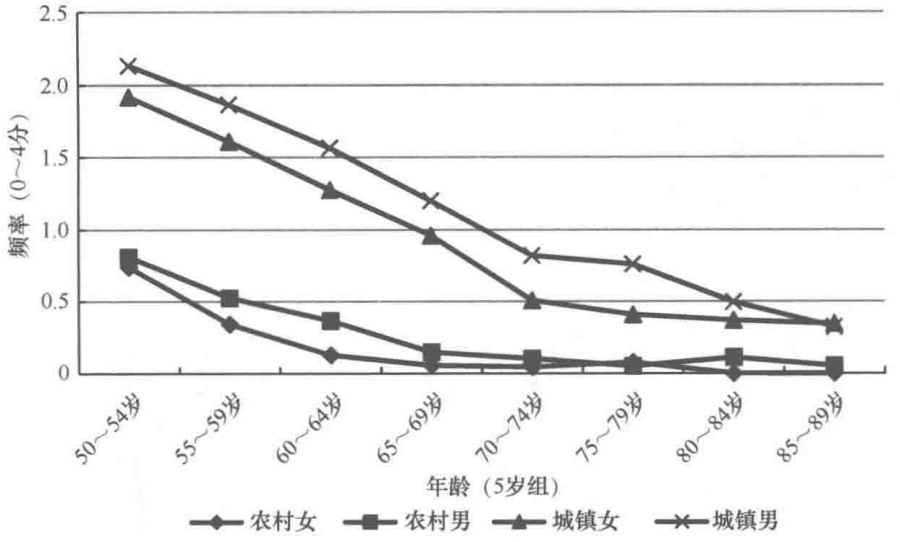


图 9-2　中国 50～89 岁中老年人城乡-性别互联网使用频率

便捷性；另一方面，这也增加了中老年群体的操作负担，提高了使用壁垒。《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》虽然强调简化健康码管理、预约挂号等操作，但仍无法脱离社交和支付平台。鉴于基础软件对于老年群体的非友好型界面设计，工业和信息化部推行的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”优先推动六大类 43 个 App 更新为适老版、关怀版和无障碍版本，在一定程度上方便了老年人的安全使用。

本节主要选择微信和支付宝两款基础软件，就支付和社交功能的普及率在中老年群体中进行对比。2019 年《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示，老年人群使用微信的比例为 26.2%，不到非老年用户的 1/3。而 2017 年 CGSS 抽样数据呈现出了更为严重的支付鸿沟和社交鸿沟。图 9-3 为我国 50～89 岁城乡支付软件普及率统计结果，可以得出以下三个结论：其一，微信支付在中老年人群中的普及率高于支付宝支付，这可能得益于微信背后的社交功能。虽然支付宝作为一款更为专业的支付类软件，推出了担保交易、快捷支付、被盗全赔、反向扫码、刷脸支付等系列功能，但是微信支付依托于社交功能，在以小额支付为主的中老年人群中更受欢迎。其二，支付功能在中老年群体的普及率不高，在 50～89 岁抽样人群中，微信支付的使用率为 12.2%，支付宝支付的使用率仅为 8.5%。50～54 岁城镇人群微信支付普及率最高，但也不到四成。其三，年龄、居住地对于支付软件普及率有着显著影响。从单项指标来看，农村中老年群体普及率较低，微信支付普及率仅为 3.4%，而支付宝支付普及率仅为 1.8%，相对应城镇中老年群体微信支付普及率为 18.3%，支付宝支付普及率为 13.1%。类似地，小学及以下教育程度的中老年群体微信支付普及率仅占 1.9%，支付宝支付普及率仅占 1.2%，而大学及以上教育程度的中老年群体微信支付普及率为 47.3%，支付宝支付普及

率为 37.9%。

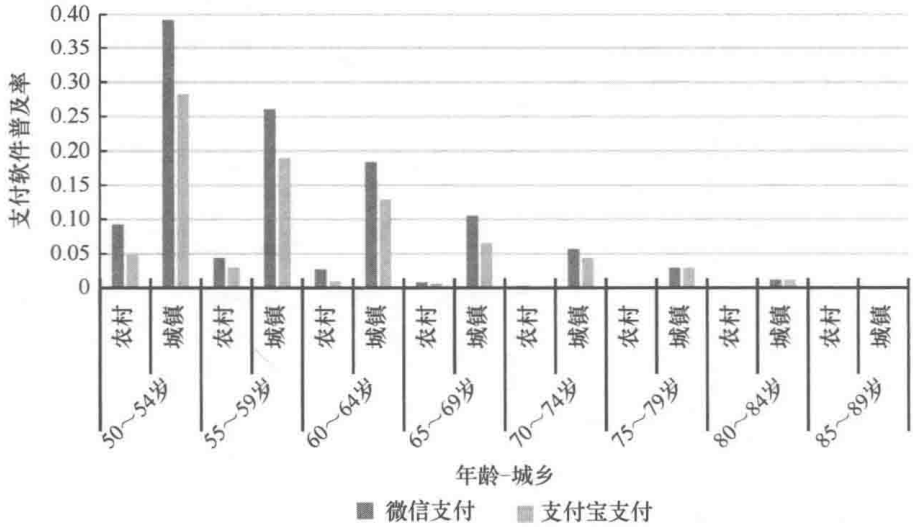


图 9-3　中国 50～89 岁中老年人城乡支付软件普及率

除了支付功能的普及率，社交功能的普及率在很大程度上可以衡量老年人对于基本软件的使用水平。如图 9-4 所示，我国 50～89 岁城乡社交软件普及率情况如下：其一，微信使用在中老年群体中普及率高于 QQ。其二，社交软件在中老年群体的整体普及率较低。对比微信社交功能与支付功能，城镇 50～59 岁中年群体的微信社交普及率低于支付普及率，而其他组别没有出现太大反差。其三，相比城镇中老年人群，农村社交软件普及率更低，普遍低于 5%。而对于 60 岁及以上农村人群，由于同龄人对于网上社交的依赖程度低，这类人群的社交软件普及率接近于零。

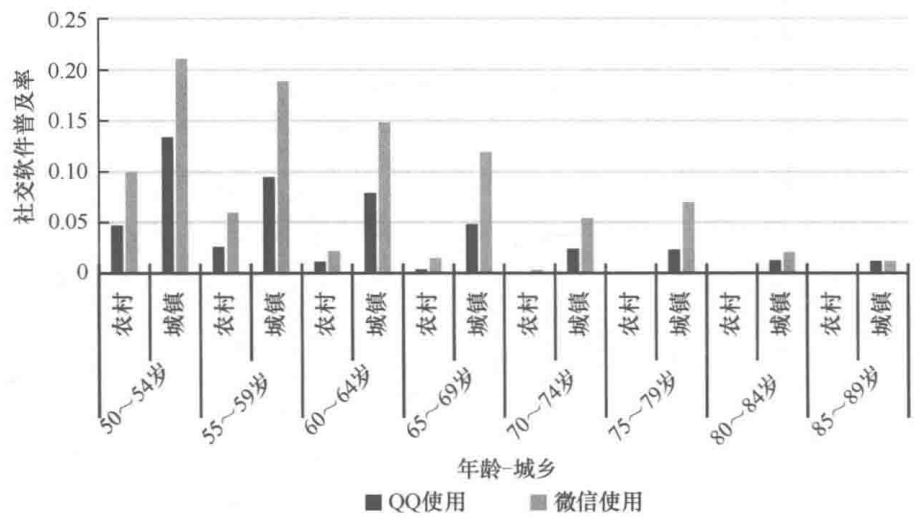


图 9-4　中国 50～89 岁中老年人城乡社交软件普及率

3. 互联网用途

进一步细分基础软件的功能使用，使用互联网的中老年人群对于互联网功能需求有较大差异。2017 年 CGSS 抽样统计了使用互联网的中老年群体对于上网内容的选择，总共分成了社交活动、自我展示、网络行动、休闲娱乐、获取信息和商务交易六大类。社交活动指的是通过 Email、QQ、微信、Skype 等与人交流。自我展示指的是将微信朋友圈、QQ 空间、微博等作为自我展示的平台，从而记录分享自己的心情。网络行动指的是通过网络维护自己的权益，或为他人伸张正义。休闲娱乐指的是通过互联网玩游戏、听音乐、看视频等手段进行休闲放松。获取信息指的是通过互联网搜索信息、浏览新闻等。商务交易指的是通过互联网进行网上转账、支付和网购等。进一步将这六种互联网用途按照频率划分为从不使用、很少使用、有时使用、经常使用和非常频繁使用五类，分别将其赋值为 0～4 分。在统计了六项上网内容得分后，得到两个主要结论：其一，中老年人群上网主要是为了社交活动、获取信息及休闲娱乐，不热衷于网络行动、商务交易和自我展示。其二，城镇中老年人群在各项互联网用途的上网频率较农村中老年人群更为频繁（图 9-5）。

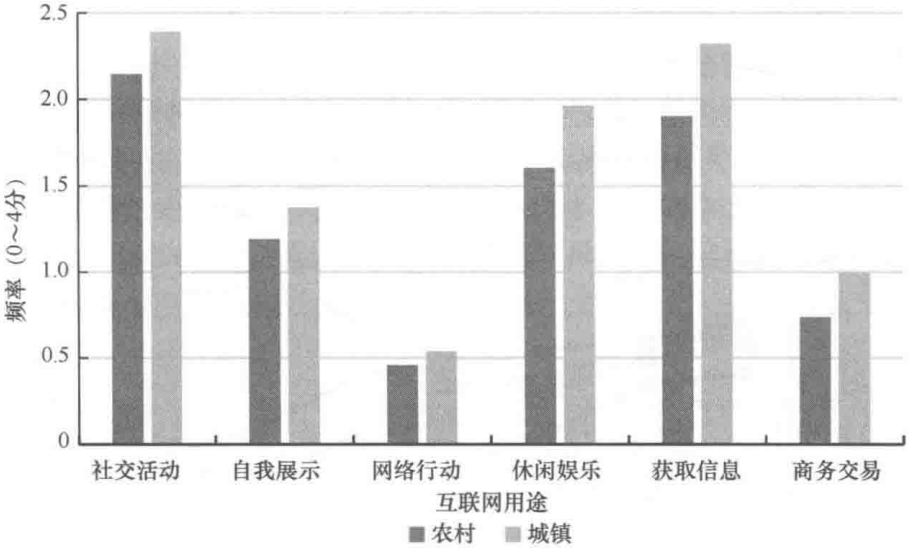


图 9-5　中国城乡互联网用途频率

9.2.2　中老年群体的数字鸿沟现状

CGSS 问卷在询问老年人为什么没有上网的统计中，得到的原因主要有以下三点：一是不知道什么是上网，这类人群占比达到 32.5%；二是不会或没人教，因而用起来很困难，这类人群占比达到 24.7%；三是年龄原因，对于老年人身份

的认同，这类人群占比达到了 34.3%。这些原因将数字鸿沟分解成接入鸿沟、使用鸿沟和认同鸿沟三类。

1. 接入鸿沟

接入鸿沟是第一道数字鸿沟，具体指老年人对于智能设备和互联网的可及性偏弱。老年人的可及性包括以下两种：一是主观的意愿可及性，是否由于兴趣和新技术的吸引力而愿意接触智能设备与互联网。二是客观的设备和互联网可及性，是否缺乏网络和设备条件而导致客观上存在数字鸿沟。主观意愿上排斥数字技术不是本节讨论的重点，本部分将重点描述客观的设备和互联网可及性。这类可及性主要体现了信息有产者和无产者在互联网可及性与性能上的差距。

跨越接入端的数字鸿沟意味着老年人需要习惯日常数字设备的使用，而目前的数字设备使用前提在于普及智能手机。根据 2017 年 CGSS 抽查数据，包括老人机在内的手机普及率已经达到八成。如图 9-6 所示，从居住地和性别分别进行细分，手机普及率呈现略微的差异。城镇中老年人群单独拥有手机占比达到了 85.4%，略高于农村的占比。男性中老年人群单独拥有手机占比达到了 85.7%，也略高于女性的占比。从教育程度和年龄分别细分，手机普及率呈现较大的差异。大学及以上学历中老年人群手机普及率达到了 95.7%，而小学及以下学历中老年人群手机普及率虽远低于前者，也达到了七成。类似地，50～59 岁中年人群包括老人机在内的移动手机普及率达到了九成以上，超过 70 岁老年人群仅有 65.5%，超过 80 岁的老年人手机普及率降至五成以下。综合年龄、性别和居住地，高龄段的农村女性是样本中单独拥有手机占比最低的人群，在 85～89 岁年龄组中仅占两成。相对应地，低龄段城镇男性单独拥有手机占比接近于 100%。

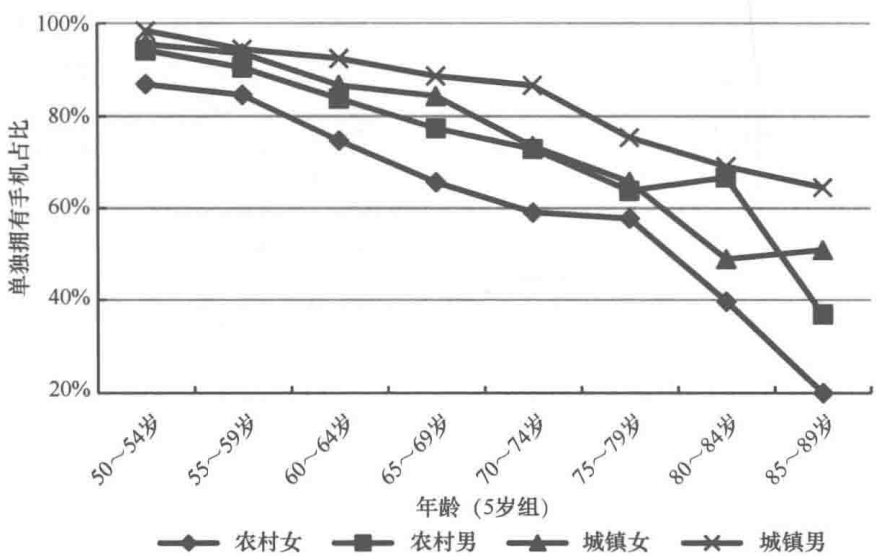


图 9-6　中国 50～89 岁中老年人城乡-性别手机普及率

手机普及率较高在一定程度上反映出中老年群体对于数字使用的意愿较高，但是数字使用的前提还是需要以智能设备为前提。但与手机普及率形成鲜明对比的是，在智能设备数量的统计中，没有智能设备的老年人占了九成。可见我国中老年人群数字使用意愿较高，而实际使用占比较低，表现为老年机普及率较高，而智能手机普及率较低。这种反差一方面是由于退休后工作需要的上网场景将大幅减少，客观上降低了设备上网普及率；另一方面是农村家庭上网率低也影响了老年群体智能设备的普及率，如 2017 年 CGSS 抽样结果表明，城镇家中能够上网占比为 68.2%，而农村家中能够上网占比仅为 37.5%。

2. 使用鸿沟

使用鸿沟是第二道数字鸿沟，具体指技术界面的友好性和使用者的数字技能方面的问题。使用鸿沟的缩小一方面依赖于网络和设备的适老化改造，另一方面依赖于使用者数字经验的提升。在使用鸿沟统计中，CGSS 分别统计了老年人打开网站、下载 App、查找信息和网上表达想法等四项数字能力。根据描述的符合情况划分为非常不符合、不符合、一般、符合和非常符合五类，将其分别赋值为 0～4 分。主要得到以下两个结论：其一，城乡、年龄会显著影响老年人数字能力，但整体上我国中老年群体的数字能力极低。即使是得分最高的 50～59 岁组的城镇人群，数字能力得分也低于 1 分，这意味着老年人基本上不具备独立使用互联网的能力。其二，打开网站和查找信息等基础操作相较于下载 App 和网上表达想法，中老年人群对于前者的适应性更好（图 9-7）。

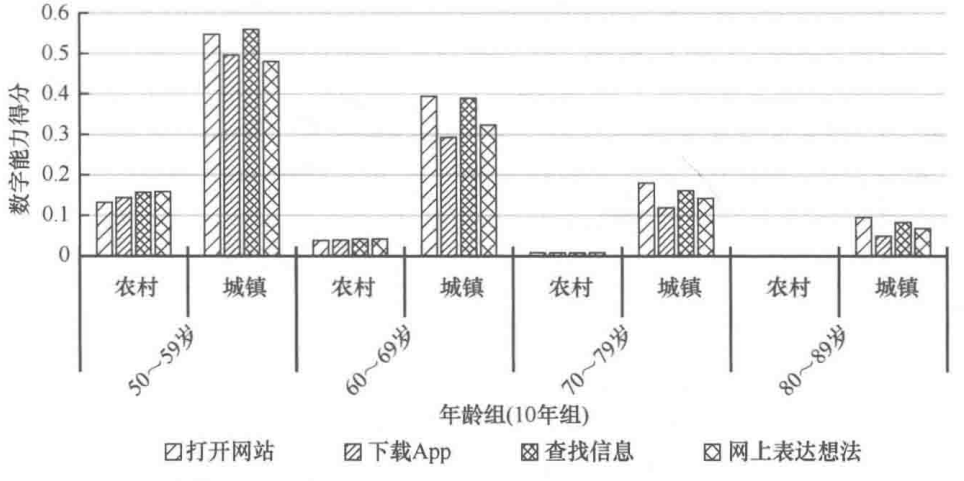


图 9-7　中国 50～89 岁中老年人城乡数字能力得分

人们在现实生活中运用数字技术能力的差距，反映了社会经济地位不同受众从中获取知识的差异，其中老年人的数字使用能力限于身体鸿沟和知识鸿沟的双重影响。在身体鸿沟方面，从问题视角审视老年人群时，个体步入老年期，不可

避免存在身心衰退。老年人的记忆力将逐渐衰退、视觉敏感度和触觉灵敏度降低，因此需要花更多时间去重复学习。而从优势视角审视老年期时，健康老年人能够凭借人生经验，独立自主选择适合自己生活方式的需求，不过延续的将是缺乏数字化技术支撑的中年期生活。随着互联网等技术的适老化进步，这类老年人群将有更多参与社会经济活动的机会，生活方式也有更多现代化、数字化的模式。前一种观点意味着老年群体的身体鸿沟更多源于年龄因素，而后一种观点意味着老年群体的身体鸿沟更多源于队列因素。

在知识鸿沟方面，老年人生理、心理特征及社会经济因素使其在数字使用中处于弱势地位。虽然性别、年龄、城乡居住都对互联网使用有着显著影响，而受教育程度在其中具有决定性作用。目前来看，手机使用和互联网的普及程度正如教育年限所反映的那样，呈现出城镇男性、城镇女性、农村男性、农村女性的梯度分布路径。如图 9-8 所示，城镇男性在各年龄段大部分有着最高的平均教育年限，从 50～54 岁组为 3.51 年，到 80～84 岁组为 1.51 年。城镇女性的教育年限整体略低于城镇男性，从 50～54 岁组的 3.41 年到 80～84 岁组的 1.21 年。农村女性在各年龄段大部分有着最低的平均教育年限，从 50～54 岁组的 1.76 年到 80～84 岁组的 0.05 年，而农村男性教育年限在部分年龄段仅略高于农村女性。总体上，样本中老年群体的教育年限表现出，城镇群体高于农村群体，男性群体略高于女性群体。

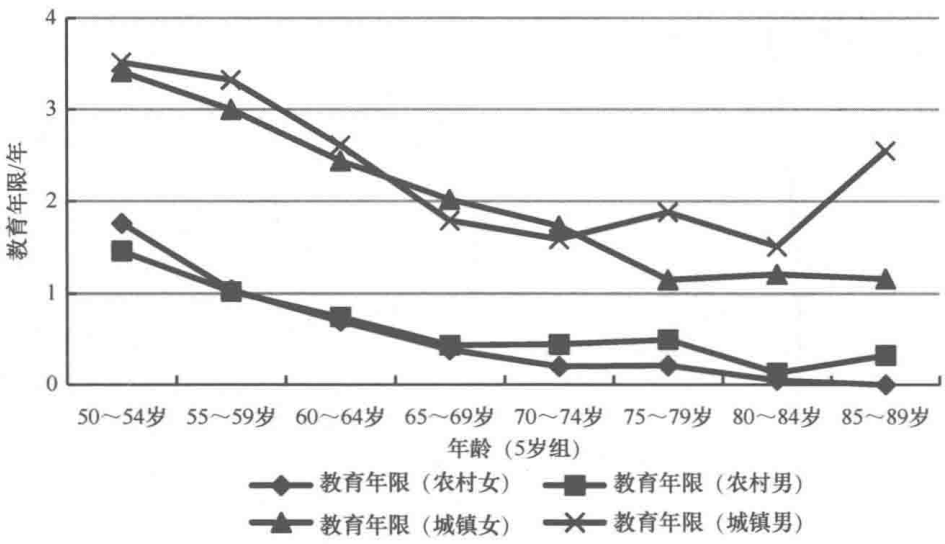


图 9-8　中国 50～89 岁中老年人城乡-性别教育年限

受教育程度较低是产生知识鸿沟的主要原因，集中体现于老年人的思维模式与认知能力的固化。教育年限与中老年群体的互联网使用存在一定的相关性，但是造成我国中老年群体数字鸿沟的还有更深层次的原因。按照中国互联网络信息

中心（China Internet Network Information Center，CNNIC）的第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》，在国内网民学历结构中，小学及以下网民占比为 19.2%，初中学历的网民占比为 40.5%。换言之，大量受教育程度较低的人群正在使用互联网，老年群体受教育程度低仅仅是产生数字鸿沟的重要原因之一。认同鸿沟是更深层次原因，即中老年群体对于智能手机与互联网等新鲜事物的畏惧心理。

3. 认同鸿沟

法国社会学家布迪厄在《单身者舞会》中有过这么一段描述："在舞台中央，十几对男女跟着流行音乐的节拍翩翩起舞。在舞场的边上，站立着一群年纪较大的农村男子，他们戴着贝雷帽，穿着深色的、款式过时的衣服。他们来到这些舞会上原本是为了跳舞，但他们却不跳舞。为了掩饰自己的尴尬，他们不时地说几句玩笑话，注视着那些可望而不可即的姑娘。"舞会是展示身体的场合，虽然农民身体是自在的，但是社会标识中的农民身体是粗野的、笨拙的。来自农村的单身男性虽然有意愿跳舞，但碍于对个人身体社会标识的认知，选择了默默旁观，避免了身体和心理的尴尬。

这一段描述极为契合老年人对于互联网使用的矛盾心理。智能手机是展示个性的事物，但同时也是时代标识，区别了老年人群体。一方面由于老年人学习新事物较为缓慢，另一方面由于老年人对信息技术的掌控能力匮乏，虚假信息识别存在困难，老年人被社会标识为互联网使用的困难户。并且老年人相对于年轻人，他们更清晰认识个人的社会定位。这种认同鸿沟使得社会大众普遍认为老年数字鸿沟是随着老年人年龄增长而来的必然产物，因而老年人没有学习和使用互联网的能力。老年人虽然有意愿尝试使用智能手机，但碍于对个人态度保守的社会标识的认知，他们保持了一直以来的生活方式，避免了身体和心理的尴尬。若这部分老年人认同了这种农村、高龄等社会标识，将会逐渐增加对于智能产品的恐惧，从而对数字社会产生畏惧和抵触心理，最终放弃参与数字社会。而从这个角度来看，有一定受教育程度的老年人并不是没有认同鸿沟，而是受教育程度较高的老年人有更多客观机会不得不尝试这些技术。一方面他们使用意愿会远高于低学历老年人，另一方面他们使用的客观场景会更多，这使得教育程度较高的老年人有更高比例使用智能手机。

老年人生理功能和心理功能的障碍，使得其对互联网产生了恐惧感。而对社交媒体的刻板理解进一步影响了老年人对社交媒体技术的接纳。认同鸿沟源于经济基础，所谓仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。经济收入是老年群体使用技术的重要基础，而城乡老年人之间的数字鸿沟在很大程度上受收入影响。因此，老年群体收入差距过大是引起认同鸿沟的关键。数字鸿沟本身很难通过改变文化来解决，只有让老年人群达到一定的客观物质条件，才有可能缩减认同鸿沟。并且

辅之以家庭知识反哺，通过父辈世界生活场景对数字知识的祛魅，让家庭成为习得数字能力的主要场域。

9.2.3　中老年群体的数字能力影响

互联网正在潜移默化地改变人们的生活、学习和工作方式。在传统的围炉而聚的时代，老年人在社会关系网络中会处于不同的位置，有些处于中心位置，而多数处于边缘位置，占据有利位置的老年人通常能够吸引网络中的其他角色与自己建立和保持联系。而数字社会打破了这种社会关系网络，数字能力将是衡量老年群体人际关系的重要维度，也将深度影响老年群体生活。本节主要分析使用互联网对于中老年群体的人际关系和生活的影响。

1. 对人际关系的影响

中老年群体使用互联网会提升其自身的人际关系。2017 年 CGSS 抽样统计了使用互联网的中老年群体社会关系亲密度的变化，包括有共同爱好的人、有相同政见的人、有共同宗教信仰的人、家人、朋友、同事六类人群。并且将亲密度划分为更疏远、疏远、没变化、亲密和更亲密，分别将其赋值为 0～4 分。在统计了六类人群得分后，得到两个主要结论：其一，中老年群体在使用互联网后与这六类人群亲密度均有所增加，整体均值超过 2 分。其二，互联网的使用显著提升了家人、朋友、同事、有共同爱好的人的亲密度，略微提升了有共同政见的人、有共同宗教信仰的人的亲密度（图 9-9）。

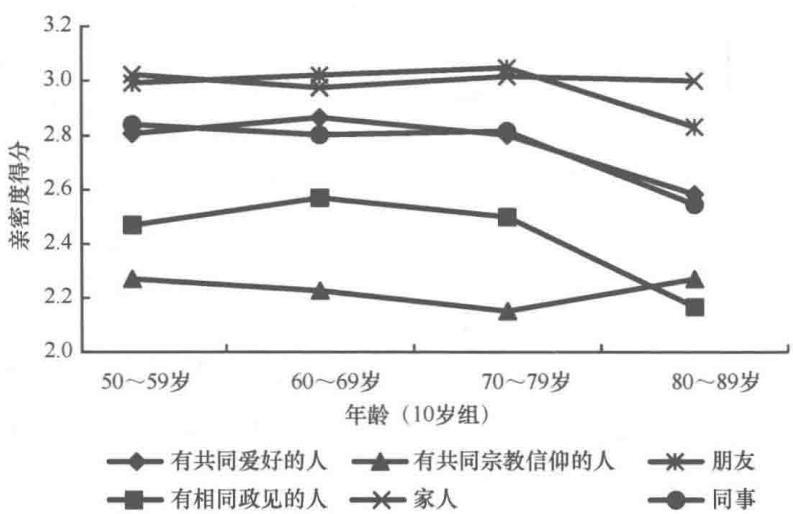


图 9-9　中国 50～89 岁中老年人互联网亲密度得分

2. 对生活的影响

2017 年 CGSS 抽样统计了使用互联网对中老年群体的生活影响，包括上网时间变长、上网时间超时、影响日常生活、影响工作、上网后与人疏远、不上网坐立不安、外出活动减少、视力变差、颈肩疼痛和家人抱怨共 10 项。并且将符合程度划分为非常不符合、比较不符合、一般、比较符合和非常符合，分别将其赋值为 0～4 分。在统计了 10 项指标后，得到了三个主要结论：其一，有 9 项指标得分均值低于 2 分，表明互联网对于生活的影响偏向正面。虽然中老年群体上网时间变长，但是互联网没有扰乱中老年人群的日常生活和工作。其二，中老年群体在控制上网时间方面比较出色，没有因为上网使得视力变差和颈肩疼痛。其三，中老年人群的互联网使用没有造成人际关系疏远和家人抱怨，表明这类人群的互联网使用一定程度得到了家人的理解和支持，并且通过使用互联网有效增进了与周围人的感情（图 9-10）。

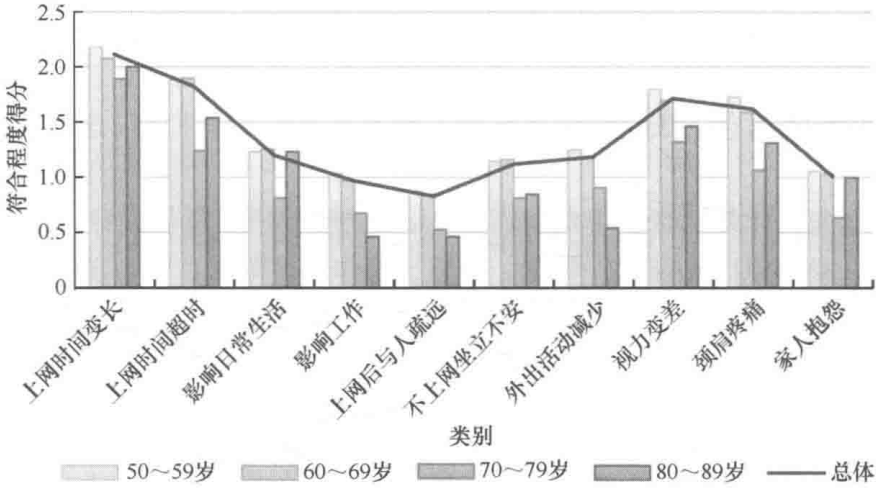


图 9-10　中国 50～89 岁互联网中老年人对生活影响符合程度

9.3　中老年群体数字融入面临的挑战

美国传播学者 Attewell（2001）根据接触程度，将数字鸿沟具体细化为接入阶段、使用阶段和能力阶段三个层面。第一层面的数字鸿沟主要指拥有电脑和接入互联网能力的差距，被称作“接入沟”。第二层面的数字鸿沟为电脑使用情况差异，被称作“使用沟”。根据 Attewell 的理论，由于不同的家庭收入、教育程度、性别、种族等因素的影响，即便社会中每个人都拥有信息接入设备，影响知识获取的因素将依然存在。第三层面的数字鸿沟为“知识沟”，主要体现在知识获取能力上的差距。综上可知，中老年群体的互联网融入面临的挑战可从接入端、

使用端和能力端展开分析。

9.3.1　数字融入接入端困难

数字融入在接入端受到老年群体的接入鸿沟和认同鸿沟的影响。在接入鸿沟中，硬件设备和网络的支持被认为是数字融入的首要门槛，智能手机、电脑或者平板电脑是互联网使用的基本要求。但对于老年人而言，无论是他们所使用手机的智能程度还是网络速度，都与年轻人差距悬殊，在物质条件上产生了新媒体的接入鸿沟。而在认同鸿沟中，新媒体被归结为年轻人的事物，老年群体自我学习意愿下降。

弥合接入鸿沟易，跨越认同鸿沟难。政策扶持可以有效解决老年群体的接入鸿沟，但是弥合认同鸿沟所需的社会认同需要长期的努力。目前老年群体得到的社会支持是基于弱势群体的社会认同，但是弥合认同鸿沟需要的是平等的社会认同。

9.3.2　数字融入使用端技术不友好

影响老年群体使用智能手机的因素主要是硬件构造、软件设计、操作复杂度、辅助工具、身体原因（视觉、听觉、触觉、操作速度等）、学习能力（辨别信息的能力、处理信息的能力、对事物的反应力）、学习信心及相应专业培训等。前四项属于老年群体使用端的技术不友好，后四项属于老年群体知识端的能力欠缺。对于“40 后”和“50 后”这些老年群体，学习互联网就好比学习一门新的语言，不仅要学习互联网术语、网络热词等，还要学习互联网使用技能。因而，“使用沟”不仅受个人因素影响，社会的发展变化带给不同代际人的烙印和生活方式也是产生“使用沟”的重要因素。

技术不友好或者技术排斥，源于老年群体需要花费较多精力去主动学习和适应新兴科技与设备。美国思科公司（Cisco）报告显示，电子设备的不必要的复杂界面让灵活度下降、学习和理解能力降低的老年人一筹莫展，“不会用”已经成为老年人拒绝使用智能产品的主要原因。目前主流软件很多时候倾向于满足有效需求群体，字体小、文字密度大等设计问题忽略了老年群体的信息需要，也降低了互联网对老年人的吸引力。虽然工业和信息化部已经针对 App 界面交互复杂、操作不友好等问题，鼓励更多企业推出界面简单、操作方便的界面模式，实现一键操作、文本输入提示等多种无障碍功能，但是由于技术简化收益与成本的不对等性，高新科技产品与老年群体生活难以有效衔接，智能产品老年化设计仍停留在政策阶段。

9.3.3　数字融入知识端能力欠缺

“知识沟”是指使用新媒体而导致的知识获取的差异。“知识沟”引发的社会问题中有两个比较突出，即社会权利的反转和媒介素养的差异。自改革开放以来，中国从封闭走向开放，各种新思潮、新事物，甚至是新观念、新的生活方式被引入中国，年轻人迅速吸收融入，这无疑加大了他们与父辈的代沟。伴随着中国新媒体的日新月异，年长一代向年轻一代进行广泛的文化吸收已经相当普遍。这与中国社会特有的家庭结构构成和社会主流文化密切相关。不少老年人在生活中需要使用新媒体时，直接让子女代劳，如网上购物、网上挂号、网约车等。数字化、新媒体时代趋势悄然而至，老年群体不得不接受当下的社会现实，然而，他们在适应当下社会时，往往会拒绝直接接触新兴事物，而是转向另一种更为简单的适应方法——求助子代。

求助子代反映的是老年人知识和学习能力不足，即能力排斥。数字融入知识端的能力欠缺一方面在于老年群体知识储备的不匹配性，另一方面在于自主学习能力不足，即思维模式与生活方式的固化。除此以外，由于社交网络信息良莠不齐，虚假信息进一步限制了老年群体数字能力的实践。

9.4　中老年群体数字能力提升路径与策略

同信息数字科技发展一样，人口老龄化也势不可挡。积极应对老龄化和发展数字经济、实现经济发展方式转变已经成为 21 世纪中国的国家发展战略。这就要求科技和长者相向而行，共享社会经济发展成果。在积极老龄化背景下，个人、政府、社会、市场应共同推动老年友好型数字社会建设，构筑老年友好信息基础设施和治理结构，实现以人为本的数字社会。

9.4.1　政府主导作用的有效发挥

首先，政府应将贯彻技术创新作为积极应对人口老龄化的第一动力和战略支撑思想，加强顶层设计和政策引领，将老年友好科技发展纳入老年事业与科技事业的发展规划中。一是进一步加大老年友好科技的研发投入。二是进一步优化老年友好科技创新环境。三是进一步改善老年友好科技应用政策环境，根据老年友好科技及其产品的最新进展及时修改调整相关政策规定。

其次，构建政府主导、多方参与的老年数字鸿沟社会支持体系，提升老年人数字素养，逐步缩小老年群体和年轻群体之间的数字鸿沟。一是增加投入，重点

加强薄弱地区数字信息基础设施建设，将数字信息服务纳入免费提供的基本公共服务中。二是将城乡网吧改造和家庭网络数字化改造作为城乡数字信息基础设施建设的重点，不断提升信息化和数字化服务能力，让各种数字化服务便捷地接入每个社区、每个家庭、每位老年人，形成智慧家居、智慧社区。

再次，大力倡导并建立终身教育体系，为老年人能够继续进行各类学习提供设施和机会，使他们能够及时跟上信息化社会的发展步伐。以落后地区为重点，依托老年学校和社会组织等，开设激发老年人学习兴趣、符合老年人学习特点的课程，为老年人提供互联网和数字信息科技教育，帮助其提高信息化应用能力。

最后，政府应优化公共服务，兼顾传统和新兴生活方式，为老年群体留出专门服务通道。在信息化快速发展的当下，应融合不同群体的需求，传统和新兴的生活方式应该在一段时期内并存。特别是公共服务部门，应该给老年人留出线下服务的窗口，线下客服、人工电话、纸质填表等老年人所熟悉的传统方式还应适时保留。此外，公共服务部门可以尝试将服务再细化。比如，针对不同场景录制相应的使用教程视频，教老年人学会办理对应的线上业务，缓解老年人不知从何做起的焦虑，也减轻线下窗口的办事压力。

此外，政府需切实采取措施保障老年人网络信息安全，增强对数字弱势老年群体的包容性。建议加强网络信息安全意识宣传，普及网络完全知识，提供基本防护策略，并完善网络信息安全法案，为保护老年群体的个人信息安全提供法律保障。同时，在医疗、金融等领域，要重视对数字信息弱势老年群体的数字包容，维护老年群体使用现金等传统支付方式的权利。

9.4.2　老年个体积极参加学习和培训

首先，老年群体应积极转变观念，发挥主观能动性，认真学习各种信息技术和知识，加快融入数字社会。不可否认，老年群体的知识技能基础和更新速度难以适应日新月异的互联网与智能技术。为此，老年人应克服守旧思想、更新观念，主动了解和学习互联网及相关智能产品的使用技能，克服对于互联网的焦虑情绪。

其次，建立终身学习的理念。尤其对于那些没有身体限制和有实际学习需求的老年人，更多还是应该靠家人进行教学指导，获得“数字反哺”。老年人应发扬不怕难的精神，不断学习紧跟数字社会发展的步伐。并且老年人应该树立一种观念，即网络信息甄别能力的提升恰恰需要依赖老年人自身数字能力的提升。

9.4.3　社会和家庭提供协助

帮助老年人更好融入数字化社会，家庭环节的努力必不可少。年轻人一方面

应多用“技术”反哺老年人，让老年人对学习使用智能手机更有信心；另一方面也要创造机会鼓励和陪伴老年人应用数字化产品，以更多耐心陪伴他们学习必要的数字生活技能。动员社会和家庭的力量，通过教育反哺和同辈学习等方式，提升老年人利用信息化工具的能力。在社区层面，社区作为连接老年个体和政府的中坚力量，应大力解决老年人不会用的问题。社区层面应积极组织多种形式的培训讲座、现场课堂等，为老年人学习新技术、新产品提供渠道。同时，社区层面应建立稳定的老年志愿服务体系，发挥老年协会等基层社会组织的公益力量，形成一支有质量的培训队伍。并且社区层面需要借助媒体力量，活用养老顾问和专用老年频道，多给老年群体做心理疏导，引导其主动转变观念，敢于接受新事物。

在家庭层面，家人特别是子女的教育反哺能够为老年父母提供最直接有效的支持，子女可以通过与老年父母面对面的沟通和互动来向他们传授新媒体的使用经验。此外，建议拓展青年志愿服务内容，将提升老年人学习和运用智能手机、互联网等现代信息科技知识与能力作为志愿服务的重要内容。

9.4.4　相关数字化企业优化产品

一是完善市场供给，引导企业充分考虑老年人需求，开发更多优质适老化数字产品。市场主体应下功夫开展老年人数字产品和服务需求的收集、分析与挖掘，深入研究老年群体的身体和心理变化规律，研发适老化数字产品，精准优化产品和服务质量。

二是加强老年友好型的数字产品的页面设计，新增老年版视图，使页面内容更加符合老年人的视力特征；创建“容错型”互联网交互机制，减缓老年人对于网络参与的焦虑和恐惧心理。

三是加强老年人专属智能重点产品的开发设计，满足老年人的个性化需求，如帮助出行的智能轮椅、生活层面的智能家居、精神层面的社交机器人等；为老年人设计专属使用说明书，便于老年人更好地理解操作。

第 10 章　老年友好型社会治理中的融合创新

檀榕基

2019 年 11 月，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》[①]，国家发展和改革委员会会同民政部、国家卫生健康委员会、教育部、人力资源和社会保障部等部门，形成了老年友好型社会治理齐抓共管、整体推进的工作格局。第七次全国人口普查主要数据显示，我国 60 岁及以上人口为 26402 万人，占 18.70%（其中，65 岁及以上人口为 19064 万人，占 13.50%），与 2010 年相比，60 岁及以上人口的比重上升 5.44 个百分点，人口老龄化程度进一步加深[②]。根据民政部的相关预测数据，我国在“十四五”期间（2021～2025 年）60 岁及以上老年人口的年均增长将为 1000 万人左右，到“十四五”末全国 60 岁及以上老年人口数量突破 3 亿人，占总人口的比例将超过 20%，这表明按照联合国的相关定义，到时我国将从“老龄化”社会（aging society）过渡到“老龄”社会（aged society），国内学者和媒体也称之为从“轻度”老龄化步入“中度”老龄化阶段。为此，党的十九届五中全会将“积极应对人口老龄化”上升为与科教兴国、乡村振兴等并列的最高层级公共政策目标，即国家战略。

“十四五”时期是我国积极应对人口老龄化的重要政策窗口期，这就需要在加快养老保险制度改革、实施渐进式延迟法定退休年龄、推进居家社区机构相协调、医养康养相结合、推广托育课后服务行动计划、增强生育政策包容性等围绕建设老年友好型社会的具体政策方面紧抓机遇和并行发力。老年友好型社会的建设关乎我们每个社会成员及家庭的切身利益，是积极应对人口老龄化的内在要求和现实路径，不仅需要与之相配套的制度安排和法律法规，还需要与之相适应的社会治理和政策工具。因此，有机结合传统与现代的理念来建设老年友好型社会，探索将其融合创新到具体的共建、共治、共享社会治理实践当中，营造开放包容的社会环境、建立全面长远的政策体系和结成良性互动的治理共同体，有利于满足人民日益增长的美好生活需要、有利于社会的安定有序和国家的长治久安。本章

---

① 《中共中央 国务院印发〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉》，http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/21/content_5454347.htm[2019-11-21]。

② 《第七次全国人口普查主要数据情况》，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html[2021-06-15]。

以老年友好型社会为场域，着重从老年友好型社会治理的理论支撑、治理共同体的基本内涵、政策工具的融合创新这三方面进行探讨和阐述。

10.1　老年友好型社会治理的理论支撑

10.1.1　社会整合与活跃理论

社会整合（社会团结）概念的提出，最早可追溯到（20 世纪一二十年代）社会学奠基人之一涂尔干（Émile Durkheim），他从社会分工的视角对社会统合（social cohesion）、社会团结（social solidarity）和社会整合（social integration）等概念进行了系统性区分与阐释。他认为，如果不能定期维护和重申那些可以形成社会统一人格的集体情感，社会将不复存在。由此可以看出，涂尔干不仅将“整合”看成改造和稳定社会的工具，而且将其视作一种保持社会可持续发展的内在状态。20 世纪三四十年代美国社会学家 T. 帕森斯（Talcott Parsons）拓展了社会整合理念，提出了结构-功能分析框架，它由四个子系统组成，即社会适应（adaptation）、目标达成（goal attainment）、社会整合（integration）和潜在模式维持（latency pattern maintenance），T. 帕森斯的结构-功能主义，上承欧洲古典宏大与抽象社会的传统范式，下开经验主义之先河，使学术思想脉络承上启下，对欧美社会学乃至全球社会科学领域的建构产生了重要影响（杨菊华，2016）。以 T. 帕森斯、洛克伍德、卢曼、哈贝马斯和吉登斯为代表的社会学家继承并发展了涂尔干的社会整合（社会团结）概念，逐渐形成了较为完整的社会整合理论体系。

社会整合理论在后来的演变中逐渐发展成为两类各具代表特征的研究分支：以“熔炉理论”为代表的美国学者更多强调移民从主观上融入，其研究侧重于个体的意愿和行动、融入的方式与路径等；而以“多元文化”为代表的欧洲学者则更多强调不同群体间的理解交流，其研究较多关注当地人口和输入地政府对外来人口的包容接纳与融合政策等。因此，具有不同侧重点和代表性的欧美学者都基于自身历史背景、文化传统和社会现状，对社会整合理论的研究秉持各家的研究范式和价值取向：美国作为移民国家，其社会整合的交融聚合不仅强调本土文化对外来人口的影响和重塑，还包括移民本身对通过努力实现阶层跃迁过程的渴望和认同；欧洲从共同体到联盟的发展过程中，为了尽可能实现经济社会的整合，各国不仅强调相关公共政策对移民的包容和保护，而且还重视欧盟成员国之间在政策法规、社会准则和舆论导向等方面的协同与合作。上述两类关于社会整合的理解和政策虽在研究范式与价值取向上有所差别，但目的都是促进不同社会成员

之间的融合，这不仅对我们理解社会融合理论的本源具有重要的启示作用，也成为研究老年友好型社会治理议题的支撑理论之一。当然，本章梳理的所有的理论都需要与中国具体实际结合起来进行辨析和考量，充分研究与选择哪些理论真正适合我国不同地区的需求，同时更需要原创和探索更契合中国本土的老年友好型社会治理的理论体系。

活跃理论（Activity Theory）基于人们的自我认知、源于社会角色扮演和社会参与程度的假设，认为思想决定自主行为、行动影响生活状态，随着年龄的增长，人们更容易延续之前的思维模式和生活状态（Costa and McCrae，1980）。同时，该理论还认为老年群体在退出原有的社会活动之后，会寻找替代性的社会角色。近年来，越来越多的实证研究也表明了老年人积极参与社会生产性或非生产性活动，有利于其身心健康和主观幸福感的提升（高鉴国等，2011）。从融合角度来看，活跃理论表达的是老年人积极融入社会的主观意识：一方面，老年人已经认识到长期的思维惯性难免导致行为固化，内心渴望跟得上时代步伐并尝试做出改变；另一方面，大部分老年人退出了正规劳动力市场，卸下了生产性社会参与的角色，更多地回归为家庭成员身份。这种角色与身份的切换，很难做到自然过渡，而是需要一定的时间和情绪去逐渐适应。在这当中有一部分老年人将负责更多的家庭事务，如承担起照护父辈或照看孙辈的家庭职能（第 5 章老年友好型社会的家庭政策发展重构中进行了系统分析），同时有一部分老年人会积极主动地寻求再就业或加入志愿者，继续在社会中发挥自身余热、发掘潜能、实现自我价值，可见活跃理论主要阐释的是老年人积极老龄化的态度。

10.1.2　社会排斥与脱离理论

法国社会学家 Lenoir（1975）较早提出了社会排斥（也称社会排他）的概念，他认为只要没有受到国家社会保障的保护，并且被认为存在社会问题的各类社会边缘人群都可归为社会排斥对象。这一概念受到学界和政界的高度关注，因此这类人群被社会排斥的境遇和如何重新融入社会引发了广泛的思考与讨论。在学术界，社会屏蔽和社会排斥的概念由于翻译与借鉴的原因，时常被混淆或通用。Parkin（1979）认为，社会屏蔽一般而言都是合法的，其实质就是某类社会群体采用所谓的合法手段挤占另一类群体的利益。笔者认为，社会屏蔽更多地呈现为一种现象或制度，而社会排斥更多地表现为一种行为或手段，社会屏蔽是社会分层理论的主要概念之一。Parkin 对社会屏蔽研究后发现，有两种屏蔽制度维护部分社会成员的利益：第一是产权制度，第二是认证制度。具体而言，产权制度主要功能是维护现有和未来权益，而认证制度主要作用是筛选潜在利益共同体。

脱离理论（disengagement theory），又称区隔理论或疏隔理论，其与现代化学说关系较为紧密，由卡明和亨利于 1961 年提出，其认为老年阶段是老年人与经济社会进行自然的和正常的脱离的时期，具体表现为生产性社会参与的减少、人际网络范围的缩小和众多社会角色的剥离等。老年阶段的到来，个人的体力和心力都会自顾不暇，随之将表现出“内化”的倾向，即更加关注自身的精神状态和内心世界，逐渐退出原来的社会参与领域。Rosow（1974）将当代社会中的老年人状态描述为“没有角色的角色”，即老年人在社会中处于一种没有明确目标或固定行为的状态。退休以后，老年人的工作网络收窄甚至消失，日常生活半径也会产生一定的变化，所处理的事务、接触的人群、感受的社会都将发生较明显的差异以至于不能及时调整和适应，导致与社会的脱节甚至脱离，但老年人与社会脱离并非必然，而是可以避免的。脱离现象的发生，一方面源于个体的主观因素，如思想沉浸在原有的舒适习惯区而不愿学习新的技能以适应社会的发展；另一方面可归因于变化着的人口年龄结构与现有社会经济架构、制度安排之间的不协调所产生的矛盾（Baltes et al.，1986；彭希哲和胡湛，2011，2018）。

一直以来，技术垄断也可以造成社会脱离或社会排斥，它既是一种文化形态，也是一种社会心态，总之是一切形式的文化生活都屈从于科学技术的统治（波斯曼，2007）。正如第 9 章对中老年群体数字融入现状及能力提升进行的实证分析所得出的结论，技术垄断、制度缺失和治理滞后等诸多因素共同导致了在不同的年龄、群体、城乡之间出现所谓的数字鸿沟或信息壁垒，这种无形的障碍尤其是在老年群体中越显突出，使得老年群体在信息技术背景下沦为弱势群体。在数字时代，对老年群体还存在着虚拟（数字）社区隔离的现实问题，这种隔离的发生不仅仅产生于技术的具体应用或设备的实际操作，也不完全归结于资源发布的偏年轻化或信息获取的低效率化，其更深层次的原因是这种数字化区隔与社会资本紧密相关，它可能会沿着社会经济地位、种族、信仰和居住地的方向使人们产生进一步的分化（林，2020）。人机交互（human-computer interaction，HCI）方式与形态的发展趋势已经从人机界面延伸到人机接口，随着人工智能和人机交互二者的关系从过去的此消彼长逐渐变成当下的相互促进，基于二者深度融合的典型应用也均在教育、医疗、养老等关键领域不断涌现（范向民等，2019），未来的人机互动必然会越来越频繁化、智能化和人性化。但从现实情况来看，一方面，技术的迭代、功能的升级、响应的提速和设备的更新等反而使部分老年人操作智能设备的难度增加；另一方面，信息的冗余和缺失、产生的碎片和失真等又使我们所有人辨识与获取所需信息的时间成本增加。因此，这种改变或革新并不完全都是积极的，它既表现为推陈出新的必然性，又往往伴随着独擅其美的局限性，这种由技术革新而引起的选择垄断或社会排斥，并不使其他选择不合法，也不会使之不道德或不受欢迎，而是使之无影无形，并因而失去社会变革的意义（波斯

曼，2007）。

10.1.3　社会支持与社会参与理论

社会支持这一个学术概念源于 20 世纪 70 年代，是指人们在感受到来自他人的关心和支持时有利于个人的身心健康（Raschke，1977）。另外，社会支持对于维系良好的社会网络关系（Stokes，1983）和维持一般情绪体验具有重要意义（Cohen and Wills，1985）。社会支持包含物质、行为支持以及精神、情感支持等方面。因此，学术界对该理论的研究较多聚焦于社会支持与个人（心理）情感、社会（关系）网络之间关系的研究，并且形成了较为成熟的分析模型，如主效应模型和缓冲器模型等，具体参见表 10-1。

表 10-1　社会支持理论的研究方向及代表学者（部分）

理论	研究方向	代表学者
社会支持	物质、情感、行为、网络、家庭、亲友、邻里、社区、企业和国家	索茨、马特、范德索尔、林南、郑杭生、张文宏、蔡禾
	主效应模型、缓冲器模型	李强、倪志丹
	关系强度、强弱关系	格兰诺威特、林南、边燕杰
	亲朋关系的强度、作用和差异，亲朋间的空间距离	Crohan、Antonucci、Wellman、Wortley、Campbell、Lee、Carrington、Hall
	社会支持关系相似性	Marsden、Wellman、Wortley
	社会支持网络规模、密度与中心度	Stokes、Riley、Eckenrode、Burt、Pescosolido、Sharon

资料来源：肖子华（2018）

2015 年 10 月，世界卫生组织发布的《关于老龄化与健康的全球报告》，将老年人的社会参与视作积极老龄化的基本条件之一，即“为提高老年人的生活质量，尽可能优化其健康、社会参与和保障机会的过程”。我们常讲的老有所为，就是通过老年人的社会参与来发挥其社会作用、体现其社会价值，“为”也可理解为社会参与。邬沧萍（1999）较为明确地提出了老年社会参与这一概念，指老年人自愿参与社会发展，为社会做力所能及的有益贡献。社会参与是生产性老龄化或产出性老龄化（productive aging）的重要内涵，是老年人无偿或有偿地为社会生产产品或提供服务。生产性老龄化提出了一个基本观念，即应当发掘和利用老年人对社会、对经济等继续做出贡献的能力。本书第 4 章对老年社工、照护机构等社会支持领域，尤其是对老年友好型社会中社区养老服务创新做了较为系统

的研究，第 7 章对老年友好型社会的老年社会参与进行了较为详尽的理论阐释和实证分析，故本章不再展开讨论。

10.1.4　人力资本与社会资本理论

随着生产工具的专业化、劳动分工的精细化、应用场景的智能化，人力资本在经济发展、社会治理中发挥越来越大的作用。亚当·斯密、李斯特、费雪和马歇尔等经济学家较早从资本的视角来考察“人”在社会生产活动中所产生的经济价值；Schultz（1961）开创性地将人力资本理论系统化，并且被当时经济学主流的研究框架所接受，其研究对象包括物质资本兼容人力资本、研究重点包括劳动力数量并蓄劳动力质量。他认为人力资本至少包含三个层面：年龄和身体状况层面、受教育程度和工作技能层面、受知识溢出效应影响的非正式教育传递层面。因此，Schultz 侧重于从个人综合能力的角度来阐释人力资本，即“体现在人身上的技能、知识、健康等因素”。Barker 和 MacFarlane（1979）在此基础上从微观经济学角度进一步分析和拓展了人力资本的研究边界，他们认为“人的知识、时间、技术、健康和寿命”等均属于人力资本范畴。他们不仅关注个体层面的寿命、教育和经验等传统领域，从生命周期视角构建了人力资本投资均衡模型，而且关注家庭层面在生育行为上的经济决策和成本——效用分析，提出了家庭的时间价值和配置等新概念。他将人力资本的应用场景从个人微观延伸到家庭中观，从更加现实的角度讨论和测量人力资本，对该理论的应用和发展做出了突出的贡献。基于上述诸多侧重点不同的研究，OECD[①]对人力资本做出如下定义：劳动者所拥有的能够创造个人、社会及经济福利的知识、技能、能力和素质。将人力资本的讨论范畴从家庭中观进一步拓展为社会宏观。

其中，人力资本中的平均预期寿命是体现生命质量的基本指标，它是直接衡量一个国家或地区人口生存水平的量表，也是间接反映该区域社会经济发展水平的指标。根据 2010 年第六次全国人口普查数据，2010 年我国人口平均预期寿命达到 74.83 岁，比 2000 年的 71.40 岁提高 3.43 岁；2010 年世界人口的平均预期寿命为 69.6 岁，其中高收入国家及地区为 79.8 岁，中等收入国家及地区为 69.1 岁。国家卫生健康委员会所发布的《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》[②]和《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》[③]显示，我国居民人均预期寿命由

① Understanding the digital divide，http://www.oecd.org/digital/ieconomy/1888451.pdf[2019-10-13]。

② 《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》，http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/201905/9b8d52727cf346049de8acce25ffcbd0.shtml[2019-06-01]。

③《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》，http://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/s10748/202006/ebfe31f24cc145b198dd730603ec4442.shtml[2021-03-04]。

2017 年的 76.7 岁、2018 年的 77.0 岁提高到 2019 年的 77.3 岁，从第七次全国人口普查数据可知，我国人口的预期寿命持续提高。因此，非常有必要在研究实践中对老年人和老龄社会的认知误区以及形成的主要机制进行厘清，本书第 2 章对此做了比较全面的论证和分析。所以，我们对老龄和老年的认识与定义，不能依旧停留在自然属性和传统观念上，也不必被过去的看法和理解所束缚与牵绊，而是应该立足于现实并着眼于未来，在社会变迁和科学预判的基础上，重新审视这两个概念，拓展对这两者的理解、延伸对这两者的界定，这不仅有助于评估老年人口的人力资本水平，而且有利于科学、积极地制定应对老龄社会的策略。

随着科技的进步、社会的变迁和年龄的增加，老年群体的健康状况、知识更新都会逐渐地落后于年轻群体，所以人力资本会存在一定的折旧率，在健康寿命和机会成本等多重条件的约束下，人力资本的最优投资窗口期会随着年龄的增长而下降，这给我们的启示是在青年时期要注重人力资本的投资和积累，在中老年时期要通过继续教育进行人力资本的开发和提升，在各年龄段中培养、树立和深化终身教育理念，激发与利用各年龄段的人力资本潜能。从传统的人口数量红利，到人口质量红利，再到人口长寿红利的转变，这既由我国人口数量与结构所决定，也是经济和社会发展的必然。

长期以来，我国城镇老年人口的人均预期寿命提高和劳动参与率较低并存，根据第六次全国人口普查数据我国 60～64 岁和 65～69 岁城镇老年人口的劳动参与率分别为 24.30%和 15.49%，而同年龄段条件下，美国分别为 55.80%和 31.56%，日本分别为 62.90%和 41.44%，OECD 国家分别为 49.12%和 25.03%，具体参见表 10-2。引起老年人口劳动参与率较低的因素较多，如退休年龄低、再就业难度大等，其中，老年人的受教育水平和职业技能难以满足产业的转型升级也是关键原因。因此，老年友好型社会的治理要重视人力资本的培育和积累、注重文化的传承与积淀，从小培养终身教育理念；激发全社会创新思维、弘扬工匠精神、树立正确人才观、建设高质量教育体系；完善户籍改革中的居住证积分制、加快统一城乡劳动力市场、盘活现有的城乡人力资源。

表 10-2　我国与其他地区城镇老年人口的劳动参与率比较（2010 年）

劳动参与率	中国	日本	美国	OECD 国家
60～64 岁	24.30%	62.90%	55.80%	49.12%
65～69 岁	15.49%	41.44%	31.56%	25.03%

资料来源：世界银行

而现阶段，我国对老年人力资本的运用和开发不充分，对老年群体的教育需

求情况掌握还不够，其原因不仅包含城乡老年人口间的人力资本和社会资本差别较大，还包括城乡劳动力市场分割，法定退休年龄无弹性，继续教育具有系统性、连续性和高门槛、长周期特征等现实情况。随着我国“十四五”期间“渐进式延迟法定退休年龄”的实施，用人单位与老年群体对人力资本提升的需求必然增加，因此《国家积极应对人口老龄化中长期规划》指出“构建老有所学的终身学习体系，提高我国人力资源整体素质”；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“积极开发老龄人力资源，发展银发经济”。笔者以为，激活与提升老年人口的人力资本至少包含三层含义：首先，作为年长者，提升老年人口人力资本，有利于其身心健康、提高生活质量、紧跟时代步伐、促进社会融合，而且还可以产生积极的代际传递和知识溢出效应，在全社会形成尊重知识、尊重人才的友好环境。其次，作为消费者，提升老年人口人力资本，能够在一定程度上激活内需、拉动消费，助力经济内循环。大量研究表明，受教育年限与消费观念、消费意愿、消费能力有较强的相关性。最后，作为生产者，提升老年人口人力资本，能够扩大全社会人力资源的规模，提升人力资源整体素质、提高劳动生产率，从而促进社会经济的良性循环及健康发展。所以，在提升老年人口人力资本的现实需求下，科教兴国与积极应对人口老龄化两大国家战略应有机结合、相互协同，共同为建设老年友好型社会发掘新的人口红利和人才红利，这不仅意味着要通过继续教育和技能培训有针对、成系统、分类别地延续与开发老年群体的人力资本，还需要进一步认识到推进普惠托幼服务、抓牢办好基础教育、高度重视职业教育、高质发展高等教育、资源整合继续教育、大力培养创新人才的紧迫性和重要性。

人力资本概念的提出具有突破传统资本研究框架的重大意义，它将“资本”的内涵与外延都进行极大的拓展，为社会资本等概念的提出奠定了词源基础（殷德生，2001）。社区改革倡导者莱达·贾德森·哈尼凡（Hanifan）于 1916 年在《乡村学校社区中心》一文中首次提出“社会资本”这一概念，用以代表有利于个体、家庭、社会团结等的资源综合，并借此来分析社区参与同社会纽带的重要性。法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄（Pierre Bourdieu）于 1980 年在《社会科学研究》上发表的《社会资本随笔》一文中最早从现代意义上对社会资本进行了系统阐释。随着研究的深入，他认为社会资本是“社会联系、社会荣誉和社会尊敬的资本”（Bourdieu，1985），是“社会或群体所具有的现实或潜在的资本集合，主要蕴含在群体成员所构成的社会网络之中”（Bourdieu，1986），他将“资本”的内涵从广义层面拓展为可以带来增值的所有资源总称；Bourdieu 认为社会资本至少具有三种属性——资源属性、网络属性和投资属性，概括而言，“社会中的特定行动者占有的社会资本的数量，依赖于行动者可以有效加以运用的关系网络规模，依赖于和他有关系的每位社会成员自身所拥有的社会资本体量”。20 世纪 90 年

代，詹姆斯·S·科尔曼（James S. Coleman）和罗伯特·D·帕特南（Robert D. Putnam）两位学者进一步充实和丰富了社会资本的概念及内涵。其中，詹姆斯·S·科尔曼认为社会资本看似无形实则有价，其主要蕴藏于社会网络之中，类似于人力资本等其他隐性资本，是可以通过投资而产生收益或回报的；罗伯特·D·帕特南也认为，我们与其他成员的联系越紧密，则越容易对其他社会成员产生社会信任，社会信任与公民参与之间又存在着强相关性。所以，社会资本指的是社会组织、社会网络、社会规范及社会信任等旨在促进协调与合作以便能实现相互利益的资源要素，具体参见表 10-3。

表 10-3　不同学科对社会资本的研究内容及代表学者

相关学科	研究内容	代表学者
政治学	社会规范、价值观念等	Robert D. Putnam、Francis Fukuyama
经济学	信任合作、契约精神等	Michael Woolcock、Alejandro Porytes
社会学	社会网络、组织关系等	Pierre Bourdieu、James S. Coleman、Nan Lin

资料来源：燕继荣（2015）、肖子华（2018）

社会资本首先是一个概念，它被定义为嵌入在社会关系网中的资源；同时，社会资本也是一种理论：对社会关系网的更多投入能带来更好的社会资源，从而产生更大的回报（林，2020）。中国的传统文化注重“乡土情结”“人情社会”，社会资本在我国更容易被大众理解和接受，并逐渐成为研究社会治理的理论基础。林南（Nan Lin）将个体能够运用和利用的资源划分为个人资源与社会资源两大类。其中，体能、知识、收入等主要依赖自身努力且容易被测量的资源，属于个人资源；而权力、财富、地位等需要依靠他人帮衬但难以测度的资源，属于社会资源。所以，社会资源主要指的是嵌入个体的社会网络内，可从中获取的潜在或现实资源。在社会资源理论基础上，林南将社会资本纳入经济学的资本理论体系之中，详细阐述了社会资本的要素、命题和理论发现，并对个体行为与社会结构之间的互动意义进行了理论说明，通过对社会资源理论与社会资本理论的彼此融合、相互补充，后来他将研究方向转向获取和动员的社会嵌入性资源的工具性效用上。前者（获取）指个体预期可能获取的潜在资源，后者（动员）指个体目前正在运用的现实资源。获取和动员存在于社会资本的不同阶段，共同反映着个体继承、构建、维护和利用社会资本的能力与效用。对于中青年来讲，社会网络不断拓展，事业正处于起步或上升期，社会资本所创造的获得感要大于危机感；而对于老年人来说，工作关系逐渐固定，亲朋关系也比较稳定，社会资本的边际效应变动不大。所以该理论对老年友好型社会的启示是，应当充分认识到社会资本这一非正式制度对全民身心健康的积极促进作用，并将其纳入推进“健康中国”战略的政

策工具箱中。实施差别化的社会资本拓展政策，向女性、老年人、低收入等群体倾斜，并培育和发展不同类型社会组织参与其中（孙博文等，2018）。

这里需要特别厘清的是，本节所指的社会资本是社会个体从社会关系、社会资源和社会网络等中所获得的有形与无形的“广义资本”总和，属于社会学层面的概念；区别于在经济领域，与国有资本相对应的社会资本或民间资本等概念，如近年来我国所鼓励的 PPP（public-private partnership）模式，即私营企业、民间（社会）资本参与到公共产品的供给当中的模式。

10.1.5　治理理论的起源、发展和演变

第 2 章已经对老年友好型社会观念及治理理念转型进行了较为系统的思考，本章将从治理理论的起源、发展和演变进行梳理，以期为老年友好型社会治理中的融合创新提供理论参照。治理理论兴起于 20 世纪 90 年代西方社会科学对原有管理范式失灵的反思和探索。1992 年，联合国全球治理委员会（Commission on Global Governance）在此背景下成立；1995 年，该委员会在《我们的全球伙伴关系报告》中将“治理”阐述为“各种公共或私人机构在管理其共同事务时所采用的诸多方式的总和，是调和各种社会冲突和利益矛盾时采取联合行动的持续性过程”（The Commission on Global Governance，1995）。Jan（1999）将社会治理定义为“公私部门均可作为行动体参与其中的各种互动安排的总和”。俞可平（2000）认为治理不同于统治，它指的是政府组织和（或）民间组织在一个既定范围内运用公共权威来管理社会政治事务、维护社会公共秩序、满足社会大众需要。唐钧（2018）根据联合国全球治理委员会对“治理”的定义，将社会治理界定为“在社会领域，从个人到公共或私人机构等各种多元主体，对与其利益攸关的社会事务，通过互动和协调而采取一致行动的过程，其过程是维护社会的正常运行和满足个人与社会的基本需要”，其特征是必须强调“过程、调和、多元与互动。”

治理理论的变迁伴随着政府角色从“官僚制政府”到“企业家政府”再到“协同型政府”的转变，在西方的治理理论中，“治理”更多强调的是一种“协调”。相比于西方政治制度下对“治理”的阐述，在我国国内的政策语境中，“治理”更重要的含义是“治国理政”。所以，这使得国内关于“治理”一词的使用，既有学术语境下西方治理范式的内容，也有政策语境下中国基本制度和社会文化的内涵。新中国成立以来，我国的治理理论经历了从“计划管理”到“社会管理”再到“社会治理”的三次重大理论演变（国务院发展研究中心公管所，2018）。相应地，在我国老年友好型社会治理中，作为负责老龄工作的相关政府部门既要有分工又需要协同，具体参见表 10-4。

表 10-4　我国关于老龄工作的政府部门及主要职责（部分）

机关司（局）、协会	主（代）管单位	主要职责
人口监测与家庭发展司 1)	国家卫生健康委员会	承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度
老龄健康司 2)	国家卫生健康委员会	组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担全国老龄工作委员会的具体工作
中国老龄协会 3)	国家卫生健康委员会（2018 年 3 月起代管）	对我国老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和老龄工作中的问题，进行调查研究，提出建议；开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动，参与有关国际活动；承办国务院交办的其他事项和有关部门委托的工作
养老服务司	民政部	承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作

资料来源：国家卫生健康委员会和民政部官方网站

1）机构设置，http://www.nhc.gov.cn/rkjcyjtfzs/pjgsz/lists.shtml [2020-12-31]

2）机构设置，http://www.nhc.gov.cn/lljks/pjgsz/lists.shtml[2020-12-31]

3）机构设置，http://www.cncaprc.gov.cn/nsjg/index.jhtml[2020-12-31]

2013 年，党的十八届三中全会明确提出“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”①，这一表述成为建设社会主义现代化国家的制度和机制保障。2017 年，党的十九大报告提出，从二〇二〇年到二〇三五年，现代社会治理格局基本形成，社会充满活力又和谐有序，到本世纪中叶，实现国家治理体系和治理能力现代化，打造共建共治共享的社会治理格局②。魏礼群（2019）认为关于理解社会治理的内涵，最需要把握两点：一是社会治理的“多元主体”；二是公众参与公共事务的权利。同时，社会治理的外延突出了包容性，旨在促进社会良性发展，改善社会关系和生活方式。有效治理和精准治理一定是需要根据人口数量与结构变化、国内的社会经济发展、复杂严峻的国际形势等所进行相应的综合治理、动态治理。

在我国已经步入老龄社会的现实背景下，相关制度安排与涉老政策尚未形成管理闭环和完整体系。我们研究老龄社会，不仅仅要从生物学角度认识老龄化所导致的一整套生理上的虚弱和衰弱，而且要在社会学层面探讨老龄化所触发的一系列社会秩序和运行体系的变革，尤其是这些变化还是相互影响的。从社会学的角度来考察，老龄化可视为由对社会环境的反馈所触发的改变（渥兹涅克，2019）。

① 《授权发布：中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议公报》，http://www.xinhuanet.com//politics/2013-11/12/c_118113455.htm[2020-12-31]。

② 《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm[2020-12-31]。

就国内而言，社会成员与资源要素之间发生互动，衍生出新的社会治理关注点，如人口老龄化问题、生态文明建设等（冯猛，2020）。我国实现社会主义现代化需要稳步地推进国家治理体系和治理能力现代化建设，这也是积极应对人口老龄化治理选择的前提和保障，既要把制度优势充分发挥出来，又要研究和解决新的问题，在文化和制度传承的基础上更新理念与创新制度，在现代化治理和可持续发展基础上构建兼顾整体性和动态性的社会经济支持体系（胡湛和彭希哲，2018）。

10.2　老年友好型社会治理共同体的基本内涵

1847 年，马克思在《哲学的贫困：答蒲鲁东先生的“贫困的哲学”》（*The Poverty of Philosophy*）著作中写道：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽机产生的是工业资本家为首的社会。”隐喻了在人类社会历史的发展进程中，生产力和社会关系紧密相关，生产力的发展会导致生产方式的转变，进而引发社会关系的变迁。我们也常常用技术革新来划分社会时代，如（旧、新）石器时代、青铜时代、铁器时代、蒸汽时代、电气时代和信息（数字）时代等，不同的时代改变着人们以往的思维习惯和生活方式，也重塑着原有的文化生态、社会规范和公共秩序。

德国社会学家斐迪南·滕尼斯较早提出了相对于社会（gesellschaft）的另一种概念——共同体（gemeinschaft），二者（社会、共同体）均呈现出最朴素的意义，后者在本质上包含着“真实的与有机的生命”，而前者则抽象出“想象的与机械的构造”，在论述“共同体”时，滕尼斯既保留了其“协同性”原意，又为其新注入了“历史观”的意涵（滕尼斯，2019）。在滕尼斯看来，共同体所衍生出的血缘、地缘和精神等关系，都植根于家庭这一先天属性，处于其中的人际互动更多表现为在一个确定时间段内充满了共同意志，所谓均坚持一个既定的意志方向的事实，也就是我们常常所理解的“习惯”（gewohnheit）；而社会则是与自然纽带无关联的后天属性，处于其中的任何人彼此间都准备好了为其他人提供相对应的效用或防备，故将其置于现代市民社会的视野之中考察更加合适。

在社会治理层面，Wilks 和 Wright（1987）从政策共同体内部或若干政策（治理）共同体之间的相互关系和资源互换角度来理解共同体。Rhodes（1986）将政策网络定义为一个由不同组织构成的集群或者复合体。其中的组织是通过资源依赖而相互连接在一起的，并且可以根据网络中组织间的相互依赖关系，从紧密到松散程度依次分为政策共同体（地域共同体）、专业网络、政府间网络、生产者网络和问题网络（罗兹，2020）。这种分类的优点是，将组织间对资源的依赖程度和相互结构关系作为一种连续的统一体较为直观地呈现出来；而其可能存在的不足是，难以将政策网络中组织间的社会网络、身份地位和资源占有等关系体现其中；Rhodes（1988）还从识别政策网络中的利益集团、成员资格、相互依赖及

占有资源的变动情况来动态地阐释政策共同体。

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）提出，“必须加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保人民安居乐业、社会安定有序，建设更高水平的平安中国”①。《决定》指出的社会治理共同体中的“人人”应当作为泛化和抽象的概念来理解，既可用来具体指代社会成员个体，也可用作分别代表政府、企业、社区、群团组织或行业协会等（表 10-5），正如费孝通先生所提出的“美人之美、美美与共”，其不仅表示个体，也可指代文化、文明等。

表 10-5　治理模式、政府角色及政策工具的类型（列举）

治理模式	政府角色	相关特征	政策工具
管控式治理 （command and control）	政府是具体政策的设计者，在政策网络中处于主导地位	指令	规章、制度等
框架式治理 （governance along main policy lines）	政府是政策框架的制定者，为其他行动者设定了活动的方针、权限和范围	框架	路线、方针等 （垂直型）
选择性治理 （selective governance）	政府仅对重大和关键性议题进行宏观把握，其他行动者需遵守并积极配合	干预	议题、政策等 （扁平化）
督促式治理 （facilitating governance）	政府能够较好地理解其他行动者所面临的问题，并提供必要和激励的工具	促进	激励、福利等

资料来源：Ringeling（2004）

注：上表仅为了理解治理模式、政府角色与政策工具之间的关系而进行部分列举，三者之间并非严格的对应关系或绝对联系，它们在具体实践中通常是协同和组合的关系

虽然学术界对“共同体”这一概念至今尚未形成较统一的定义或较一致的阐释，但是哲学、社会学、政治学等都在其各自的研究领域内大量地使用这一概念。其既有抽象层面，如精神共同体（家园），又应用于具体的实践当中，如政策共同体、治理共同体和命运共同体。笔者认为，不论对于哪一类共同体的探讨，都至少围绕的一个核心要素，即“我们”。不论这种形式或归于制度或发于自觉，其在某一特定的时空和场域下，不同的个体、群体或组织对于共同问题而形成高度一致的关注度和认知度，身处共同体中的成员有自我归属感与相互认同感，为了达成共同的目标和信念，彼此依存、协同合作。

具体到建设老年友好型社会的治理共同体，笔者认为至少应该具备以下三方

① 《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，http://www.12371.cn/2019/11/05/ARTI1572948516253457.shtml[2021-03-24]。

面内涵。

（1）治理共同体是由与具体议题或政策目标相关的多元行动主体共同构成的非正式组织关系，他们有主观能动性和社会认同感，具备角色责任和伦理道德，通过有效互动与密切协作，在正和博弈过程中达成共同治理愿景。

老年友好型社会治理的融合创新要找准切入点、把握着力点，以我国养老服务体系建设为例，现阶段最关键、最紧迫的一环当数着力解决最困难、最需要帮助的失能失智老年人的照护，而其中照护人员队伍的建设、技能的培训、专业的培养和市场的培育、长期照护保障制度的实施和完善又是当务之急。通过科学规划选址、客观宣传利弊、合理补偿损失、有效参与治理等一系列民生举措，让社会成员真正认识到诸如养老院、护理院、敬老院等涉老设施是与本人和家庭、现在和未来息息相关的便民、利民、惠民、为民工程，工作人员被邀请走进家门、服务设施较顺利嵌入社区，让治理共同体的意识和老年友好型社会的价值观念深入人心。要整合社区资源，为居家养老的老年人提供高品质、多样化的服务，构建“社区养老生活共同体”[①]。在提高政府的公信力与执行力的同时，扩大公众的知情权和参与度，尽快健全法治、德治、自治有机结合的社会治理体系，不断提升源头治理、协同治理与综合治理能力（王凯民和檀榕基，2014；王奎明，2019；刘智勇和陈立，2020）。充分调动政府、市场、社会、家庭等各方主体应对人口老龄化的积极性，建设老年友好型社会，打造共建共治共享的老龄社会治理共同体，打牢应对人口老龄化国家战略的坚实社会基础（李纪恒，2020）。

（2）治理共同体既是相关政策实施的对象也是政策制定的主体，如在涉老政策中，老年群体是主要的政策对象和政策受益方，同时在政策的制定和实施过程中，也应当作为治理共同体之一，成为政策的积极参与者和行动者。

根据治理理论，由最了解治理对象的社会主体实施治理，则社会治理的效果突出，这一命题构成不断向下授权、降低治理层级的理论基础（冯猛，2020）。老年群体一定是老年友好型社会治理共同体的重要组成部分，老年人最关注自身发展、最了解本身需求，也最愿意亲身参与老年友好型社会的治理，因此，在涉老政策运行过程中，老年群体既是主要的政策对象，也是重要的政策主体，这两种身份的有机交织，不论对老龄事业的建设、对老年产业的发展，还是对老年友好型社会的建设都将起到积极的促进作用。

（3）治理共同体需要在民主与科学、道德与法律、融合与创新的社会治理框架下互动和协作。虽然治理共同体之间处于非正式组织关系，共同体的组成也会因政策目标的不同而各异，但并不代表其形式和行动的无序与失范。

① 《吴玉韶：整合社区资源，构建“社区养老生活共同体”》，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11779080[2021-08-30]。

2019 年 7 月 24 日，中央全面深化改革委员会第九次会议审议通过《国家科技伦理委员会组建方案》，会议指出“科技伦理是科技活动必须遵守的价值准则。组建国家科技伦理委员会，目的就是加强统筹规范和指导协调，推动构建覆盖全面、导向明确、规范有序、协调一致的科技伦理治理体系。要抓紧完善制度规范，健全治理机制，强化伦理监管，细化相关法律法规和伦理审查规则，规范各类科学研究活动”①。以人工智能、基因编辑和人造器官为代表的科学技术，可以帮助人类改善生活质量、修复遗传疾病和延长平均寿命，但是也会基于大数据建模对我们的日常经济和社会生活方式进行特征分析与行为预测，甚至进行过程干预和决策替代。生命尊严、科技伦理和社会秩序的重构议题不仅考验着传统的社会行为规范，更期待着现代化的社会治理创新。为此，在科学技术发生突破与变革的同时，更需要我们时刻对伦理道德保持敬畏谨慎之心，这不仅需要给技术的需求方（普通用户）进行必要的指导和示范，还应该对技术的供给方（新兴企业、科研机构等）实行必需的引导和规范。

10.3　老年友好型社会治理下政策工具的选择

10.3.1　政策工具的特征、分类与研究路径

政策工具（policy instruments 或 policy tools）、政府工具（government instruments 或 government tools）和治理工具（governing instruments 或 governing tools）这三个概念在西方公共行政和公共政策学界的研究学理上是有一定差别的，但是在实践运用中的差异并不明显。

20 世纪 50 年代，达尔和林德布洛姆（2021）是较早开始研究政策工具的学者，他们在《政治、经济与福利》一书中论述了现代国家中政治与经济技术的关系，并具体提出了政治科学意义上的政策工具概念。其他学者在随后展开的研究中，逐渐分成两种路径：一种强调政治秩序属性，另一种遵循结构功能的传统。豪利特和拉米什（2006）认为政策工具是政府推行其政策而赖以生存的手段。Owen E. Hughes 在《公共管理导论》中将政策（政府）工具定义为：“政府干预的方式，在某种程度上也是政府行为正当化的应用机制。”该书的译者之一张成福对此的理解为：“政府将其实质目标转化为具体行动的路径和机制。”从这两个对政策工具的定义中可以看出“机制”是关键词，即强调的是政策各要素之间结构功能及政策工具在其中的协调作用。萨拉蒙（2008）是对政策（政府）工具进行较为

① 《习近平主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议》，http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/24/content_5414669.htm[2019-07-24]。

全面和详细阐述的一位学者，他将政策工具与公共行动联系起来考量，认为政策工具是一种明确的方法，利益群体运用该方法的目标是解决公共问题，因此他又将政策工具称为公共行动工具（a tool of public action）或手段；根据萨拉蒙的理解，政策工具主要指一种可辨识的方法，集体行动可通过它被调动起来用于解决公共问题；该工具是政策实现目标的一种手段或方法，一项政策需要一种或多种政策工具去实现其目标，同一类政策工具又可以应用于不同的政策，由此便延伸出了政策工具箱的理念，即由多种政策工具同时或依次服务于同一政策目标（萨拉蒙，2016）。

国内学者陈振明（2003，2015）将政策工具定义为“人们为解决某一社会问题或达成一定政策目标而采取的具体手段或方式”。政策工具是各种治理主体尤指政府为了实现和满足公众对公共物品的需要与美好生活的追求，通过一系列的制度安排和政策实施，采取一整套的供给方式和实现机制。毛寿龙（2003）认为所谓的政府治理工具就是政府实现其职能的手段。王满船（2004）根据政策环境的条件要求和适用情形将政策工具分为规制性、经济性、信息性、组织性与志愿性五类。陈庆云（2006）认为政策工具不仅是实现政策目标所运用的手段，而且是连接目标和结果的桥梁。毛寿龙和李文钊（2008）认为政府治理工具就是政府实现其职能的手段。朱春奎等（2011）从政策目标和行动过程进行思考，认为政策工具就是政策目标和政策行动之间的连接机制。赵德余（2011）将政策工具理解为一种抽象的分析单元，即解决问题以实现某个具体或特定政策目标的方式或机制，每一种政策工具可能更适合于某一特定方向或意义的目标。综上，国内外学者关于政策工具的研究主要集中在两个方向：①实现政策目标的方法与手段；②政策目标与政策实施之间的连接。同时，学界对于政策工具的研究，也大都是围绕不同的政策目标和各级治理层面而相应展开的（表 10-6），脱离社会治理，研究政策工具没有实践意义。

表 10-6　治理的三个层面及其对应政策工具

治理层面	政策工具	特征
操作层面	沟通型工具 激励型工具 多边政策工具	目标设定 接受原网络结构 结构与过程的偶发性
战术层面	慢与快的治理 一般治理与微调 双边和多边的治理	目标设定 网络结构的探讨 结构与过程的偶发性
战略层面	独立性工具 多元一致性工具 相互依赖型工具	目标搜索 典型元治理 改变结构与过程

资料来源：布鲁金和坦霍伊维尔霍夫（2007）

最为典型和基本的政策工具是法律法规，截至 2020 年，我国关于积极应对人口老龄化的法律只有一部《中华人民共和国老年人权益保障法》（1996 年实施，2018 年修正），而且该法更多地侧重于将老年人视为弱势群体而在法律层面进行保障以保护其正当权益，但其中并未对就业年龄歧视进行规定。《中华人民共和国就业促进法（草案）》最初曾经在列举歧视类型中对年龄歧视进行了规定，但在正式法律中，年龄歧视的规定最终被删去。从老年人作为社会群体一部分的视角来看，老年人的合法权益包括两部分内容：一是作为公民应该享有的普遍权益，二是作为老年人应该享有的特殊权益（邬沧萍，1999）。《中华人民共和国民法典》（2020 年通过，2021 年实施）中明确规定了保护老年人的合法权益、依法设立老年人组织，以及对家庭照护者的权益补偿，即“夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿”。

除了法律法规，政府部门出台的政策也是最常见的政策工具。敬乂嘉（2020）通过对我国 1982～2015 年老龄政策文本进行梳理和分析，将相关政策工具归纳为行政工具、准市场工具、市场工具、社会工具四大类，每类又细分为提供补贴、购买服务、家庭支持、社区协同等九种具体表现形式；研究发现，随着时间推移，在老龄政策领域中“行政工具”的使用呈下降趋势，并在 2010 年后淡出老龄政策工具的主体，取而代之的是“准行政工具”、“市场工具”和“社会工具”等应用的不断增加（敬乂嘉，2020）。第 8 章老年友好型社会的智慧养老发展中所提到的技术赋能、网络嵌入等，都是具体的政策工具在老年友好型社会中运用中的互动与博弈。

在借鉴其他学者关于政策工具研究的基础上，笔者在本章中将政策工具理解为具有明确价值取向和清晰目标定位的政策行动方案与步骤。首先，政策工具一定是具体的政策行动或实施方案，而不是抽象的概念，它是具有实践性和应用性的；其次，政策工具是可以根据政策的运行过程而灵活调整的，而不是僵化的应用，因此政策工具是具有一定韧性和张力的；最后，政策工具既可以单独使用，也能够组成模块或工具箱以形成合力，它是具有机动性和系统性的。所以，政策工具有族类和谱系的特点，应该贯穿于政策全过程。政策工具与政策过程中的其他组成部分（如政策目标、政策对象等）需要匹配和协调，他们之间是双向选择和互动的过程，政策工具的灵活性和稳定性都应以明确的价值取向与清晰的目标定位为背景和前提。总之，政策工具既需要对应于特定的政策项目，也需要适应于一定的政策场域，在众多条件的约束下，不同类型的政策工具形成了自身的特征和适用的边界（彼得斯和冯尼斯潘，2007）。基于对政策工具的理解，在老龄社会中政府为了达成应保尽保的公共服务目标，如在养老产业等领域就需要通过财税支出政策工具进行回应，补足当前我国与此相关政策工具在特性提炼、组合

配置、潜能挖掘等方面存在的欠缺（杨复卫和张新民，2017）。

10.3.2　融合治理模式与创新政策工具的思路

积极应对人口老龄化作为国家战略、建设老年友好型社会作为《国家积极应对人口老龄化中长期规划》的具体工作任务，结合前文所述，笔者认为在融合治理模式与创新政策工具上至少应当具备以下几点基本思路。

首先，要深刻理解“积极应对”和“老年友好”的含义，完善老龄工作思路和相关政策，提高应对人口老龄化工作水平（国务院发展研究中心公管所，2018）。从治理模式中表达融合的理念、在政策工具上体现创新的实践。

其次，从政策科学的角度看，老龄政策既属于社会政策，又属于公共政策。它具有以下几点特征：以年龄为标识、以伦理为基础、以差异为特点、以变化为要领、以福利为主要内容（邬沧萍和姜向群，2015）。

最后，老年友好型社会的治理模式并无太多经验可参照，政策工具也没有太多类型可借鉴，需要结合我国的实际国情以及各地区的具体情况融合与探索治理模式、创新和设计政策工具。

在 20 世纪 70 年代到 80 年代，随着社会发展的多样性和政策行动体的多元化，社会治理面对变化和复杂的环境遇到了挑战，过去政府完全采用垂直型的政策工具进行自上而下的推行已经在不少公共事务上表现出失灵的情况，只有政策行动体间更好的协同合作、关系紧密、彼此依赖才能达成政策目标，相应地，政策工具的选择也更加倾向于多元化与扁平化（林格林，2016）。在全球治理体系深刻变革的大背景下，国家为适应经济全球化、文明多样化、社会信息化的深入发展，政策工具作为公共物品和服务的供给方式与实现机制，是创新政府服务方式的重要途径（陈振明和张敏，2017）。图 10-1 反映的是在一般社会中，以老年人为政策对象，以维护老年人的独立、发展与融合为政策目标，协调家庭、社会、市场和非政府组织等政策资源，选用垂直型政策工具对老年人的健康、经济和家庭状况，以及社会参与、文化参与等进行综合治理。

但是，老年友好型社会的治理和相关政策工具的选择，不仅要着重关注老年群体，而且要政策惠及全体社会成员，能够让现在的老年人感到幸福、未来的老年人看到希望。世界卫生组织发布的《全球老年友好城市建设指南》，提出了判断城市是否对老年人友好的八条标准，除测评空间、建筑、交通、住所等硬件指标外，占更大比重的是社会参与、信息交流、老年人就业、尊老与社会包容等软性指标，即社会文化环境。杨燕绥和妥宏武（2017）提出以抑制老年贫困、实现老年人自立、参与、照护以及自我充实和尊严五大原则作为建设老年友好型社会的框架。张凤宝（2019）建议从推进宜居环境、完善养老保障体系、消除老年歧

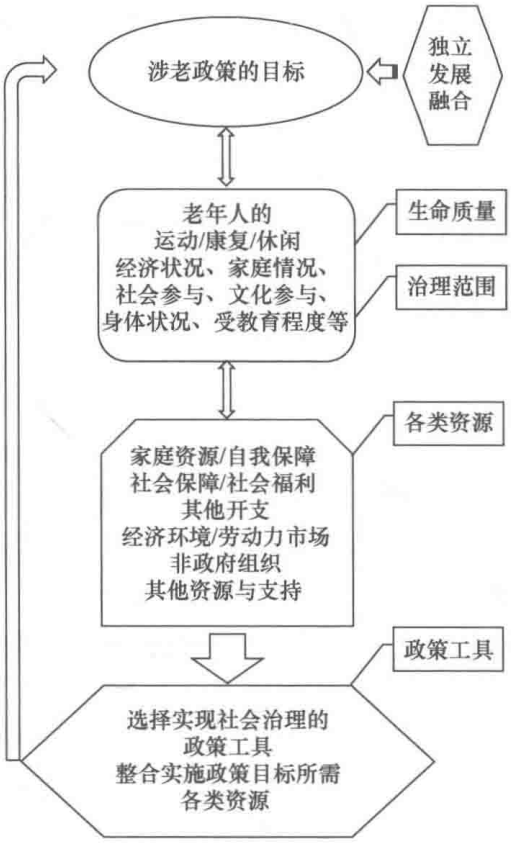


图 10-1　老年社会政策的目标、资源及工具

资料来源：渥兹涅克（2019）

视、畅通老年人社会参与渠道等方面推动老年友好型社会均衡发展。笔者在第 2 章老年友好型社会观念及治理理念转型的思考基础上，结合全球老年友好城市建设体系理念，将该理念中部分的维度和指标进行微调后，拓展为老年友好型社会治理的基本框架。如图 10-2 所示，老年友好型社会治理主要是在物理环境、社会氛围和公共服务的政策场域下，通过环境评估和指标重设、适老化改造及其新建等具体政策工具的创新运用，经过短期、中期和长期的融合治理，达成建设老年友好型社会和完善社会治理体系的政策目标。

基于第 1 章、第 2 章对老年友好型社会的再认识以及对其观念及治理理念转型的思考，综合其他章节中对老年友好型社会相关专题的具体研究，笔者认为在老年友好型社会治理基本框架下（图 10-2），老年友好型社会治理中政策工具的设计、选择和创新至少需要涵盖全社会参与、全区域统筹和全场景应用三个范畴。

1. 全社会参与

老龄社会已然成为每位社会成员生活的时代背景，人人身处其中，无人置身事外。因此，建设老年友好型社会是为我们每个人创建和营造友好的社会环境与

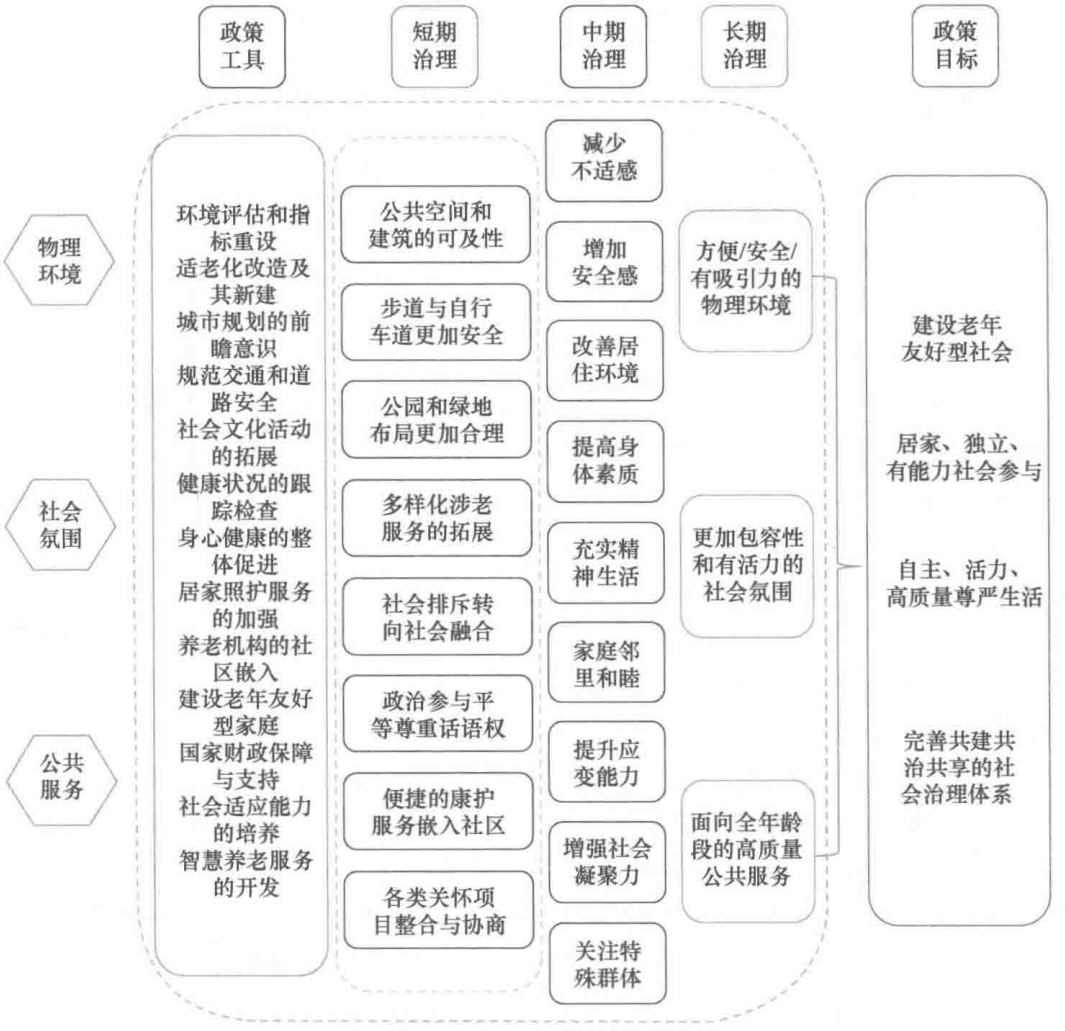


图 10-2　老年友好型社会治理基本框架

资料来源：Jackisch 等（2015）、杨一帆（2018）

生存空间，自然需要全社会成员的主动参与，才能真正地积极应对人口老龄化。传承和弘扬“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”的中华优秀传统文化，培育和营造孝亲敬老、尊老爱幼、邻里互助、睦邻友好的社会氛围，助推全社会树立正确的家庭道德观和社会价值观，在新的社会背景和技术条件下，积极探索实践多代屋、时间银行等互助养老新模式，推动居家、社区和机构养老融合发展。

老年友好型社会的治理，需要形成老年人、家庭、单位、社会、政府等共同参与治理的友好型社会格局，需要老龄事业、老年产业、新闻媒体、法律援助、教育机构等全领域形成合力。老年友好型政策工具的设计要以家庭整体为基本治理单元，加强家庭文明建设、创新表彰奖励机制，向全社会弘扬爱老慈幼风尚，夯实居家养老的基础。在老龄社会下，政府为了达成其弱势群体帮扶的目标需综合运用经济、社会等政策工具，但当前我国与此相关政策工具在特性提炼、组合

配置、潜能挖掘等方面仍有欠缺（杨复卫和张新民，2017）。为此，治理实践要深入到基层、嵌入进社区和融入于家庭，政策工具要智能、灵活和精准。例如，以居民日常生活半径为重点区域，提供固定和流动的便民助老服务驿站，对重点老年人（如失能失智）实行定期健康状况寻访（可参考第 6 章中的家庭医生制度），提倡邻里之间互留紧急联系方式等；在充分保护隐私的前提下，充分合理利用智能设备，监测老年人身体健康状况、反馈老年人基本生活情况等。

2. 全区域统筹

改革开放以来，我国流动人口规模持续增长，人口流动保持活跃，乡城流动仍然是城镇化发展的主要驱动力。大量年轻农村剩余劳动力的转移，虽然在经济上提升了赡养老年人和抚育子女的能力，但在情感上减少了对空巢老年人和留守儿童的关怀与陪伴，形成了新的社会问题。人口在城乡间的流动至少形成了三类老年群体：农村空巢老年人、城市随迁老年人（以继续在非户籍地生活和工作为主）、城市流动老年人（以继续非正规就业为主）。以城市随迁老年人为例，他们不仅需要调节好家庭内部的生活方式、消费观念、教育理念和代际关系等，还需要适应城市节奏、融入生活社区、重构社会网络等一系列新的变化。城市随迁老年人与农村空巢老年人相比，他们虽然在空间距离上与子女及孙辈一步之遥，但是在心理距离上却不一定近在咫尺，新的环境也可以形成精神空巢；另外，城市随迁老年人和城市流动老年人还共同面临着因人户分离而产生医保异地结算难、城市养老入院难等现实问题。随着新型城镇化建设和城乡融合发展的加快推进、中心城市和城市群带动作用的充分发挥，老年友好型社会的治理需要在全区域范围内进行统筹与协调，同时在政策工具的设计和选择上还要兼顾城乡差别和情境差异。

3. 全场景应用

数字时代下的老年友好型社会治理不应过分依赖和追求技术化、自动化与智能化，而更应着重思考科技推动下的治理工具变革与传统治理实践的融合创新（贾开，2020）。建立同国家治理体系和治理能力现代化相适应的积极应对人口老龄化的法律法规体系，是实施这一国家战略的首要战略任务。此外，全社会还要在整合协同、全面发展、全民行动、科学精准等方面达成共识，从而在更大程度上阐释智慧治理的逻辑与机制、探索治理的模式与路径、释放治理的效能与潜力。在全场景中融合创新治理理念、灵活有效地运用政策工具。

（1）适老化改造和友好型治理要“软硬兼施”，不仅需要在如厨卫设施、加装电梯等硬实体方面改造，还需要在如新闻媒体、社交平台、支付软件等软实力方面改进。重点关注失能失智老年人及家庭的承载力和现实需求，总结喘息服务

项目试点经验，多渠道疏解正式与非正式照护家庭成员的经济负担和心理压力。

（2）继续传承好、发扬好建立在血缘、地缘和亲缘关系上的农村邻里守望传统，鼓励和创新农村邻里互助、帮扶重点老年人，形成农村互助养老的新模式。同时，扎实做好农村日间照料中心和乡镇敬老院的供需调研与功能应用，坚决杜绝借乡村振兴之名兴建形象工程、政绩工程，坚决查处以养老惠民为由套取国家补贴、挪用爱心捐赠等违法违纪行为。

（3）充分宣传好、设计好、运行好社区睦邻中心，规范使用制度、延伸服务半径、拓展服务项目、承接公益活动等，以共享共建激发社区自治活力；总结时间银行的经验教训、创新时间银行的回馈机制、拓展时间银行的兑付方式、缩短时间银行的心理预期，如联合社区志愿服务站、参考个人无偿献血直系亲属受益的规定、探索将为老服务时长纳入居住证积分和个人诚信体系等。

（4）开展专业临终关怀服务，守护生命最后的质量与尊严是社会文明和进步的标志，客观认识现代医学的困境，充分尊重本人及家人的意愿，通过专业医护团队和社工的介入，严格遵守医学伦理和法律道德，借助规定药物与精神信仰，从哲学的角度看待生存与死亡、从善治的思维理解人性和社会。

综上，本章主要从老年友好型社会治理的理论支撑、老年友好型社会治理共同体的基本内涵、老年友好型社会治理下政策工具的选择这三个方面对老年友好型社会的治理进行了初步的思考与探讨，随着全球人口持续增长但增速逐渐放缓，各国先后进入老龄社会是历史的必然，也是在相当长的一段时期难以逆转的大趋势。对此，我们应当深刻认识、主动适应、全局谋划和积极应对人口老龄化所带来的经济与社会变革。历史的经验不断表明，挑战往往与机遇并存，在人口老龄化带来诸多挑战的同时，我们更应该把握时代机遇、彰显制度优势、释放改革红利、珍惜发展局面，紧紧抓住政策窗口期、融合治理理念、创新政策工具，与时俱进地构建老年友好型社会的治理框架，形成多模块、可复制、易推广的政策工具箱，加快推进我国老年友好型社会治理体系建设和与之相适应的制度安排。

第 11 章　总结与展望

朱　勤

老年友好型社会的建设是个复杂的系统工程，涉及的领域多、范围广，全面论述的难度大。本书在认知和实践层面选取了多个视角切入，力图从不同侧面展现老年友好型社会的特征、内涵和操作化要义，为老年友好型社会的创新与实践提供借鉴。

认知是实践的基础，引导着实践的价值取向与操作要务。本书认为，当前不少研究将老年人视为一种负担和将老龄化视为一种危机，大量的政策探讨过度聚焦于养老压力以及针对老年人的各类支助措施上，这可能导致我们对于老龄社会发展路径的误判。书中列举了研究实践中几种常见的对老年人和老龄社会的认知误区，包括对老年人和老龄化的固有刻板印象，忽视或漠视人口老龄化的常态化，将老龄问题等同于老年人问题乃至养老问题，过度推崇西方发达国家的治理经验，等等。进一步地，从认识论角度分析对于老龄化的消极认知，探讨社会价值观变迁对老年观或老龄观的影响，对传统生死观及其影响进行文化伦理分析，努力厘清这些误区与偏差的主要认知机制。在厘清认知偏差及其机制的基础上，本书提出了老年友好型社会观念及治理理念转型的对策建议。首先，支持和引导“积极老龄观”的构建，在全社会倡导积极应对老龄社会、积极看待老年人、积极面对老年生活的认知氛围。其次，转变主流观念对老年人的刻板认识，将老年人置于一个更宽泛的生命周期谱系中予以重新审视。再次，在借鉴传统并立足现实的基础上构建与时俱进的现代孝伦理体系，以谨慎冷静的姿态重新审视传统文化。最后，推动新型生命观和死亡观的形成，实现从“贵生轻死”到“优生优死”的转型。从厘清误区与偏差，到剖析认知机制，再到政策应对建议，本书初步构建起老年友好型社会认知层面的理论框架，为后续实践层面的铺陈奠定了认识论基础。

本书对老年友好型社会在实践层面的阐释涵盖了环境建设、社区服务创新、家庭政策、基层卫生政策、老年社会参与、智慧养老、数字融入、社会治理等议题。

环境建设对于实现健康老龄化具有重要意义。本书阐述了环境的概念及其对健康的影响，老年友好型环境的特征、建设路径及其评估。环境是人类赖以生存

与发展的物质基础，可以分为自然环境、生活和生产环境、社会环境。就社区环境而言，其影响居民健康的途径主要包括健康政策和卫生资源的分布情况、健康行为、居民对社区环境的主观感受、物质环境特征。根据世界卫生组织提出的健康老龄化概念模型，促进老年人功能发挥有两个基本途径：一是建立和保持内在能力；二是提供环境支持，即优化构成个体生活背景的外界因素，包括建成环境、社会交往、社会政策和其他支持系统。基于“人—环境适应”理论的“老年友好型环境”则指通过在整个生命全程中促进和保持内在能力，以及帮助具有一定能力水平的人实现其更大的能力发挥，来促进健康和积极老龄化的环境。其主要特征包括以下几点：促进健康，在整个生命过程中促进和保持其内在能力；促进老年人做他们希望做的事情；识别老年人的各种能力和资源；预测并灵活地应对老年人相关的需求和偏好；尊重老年人的决定和生活方式选择；消除不公平、保护脆弱人群；促进老年人融入社区生活的各个领域并为社区生活做出贡献。老年友好型环境的建设内容分为物质环境、社会环境和老年服务三个方面，其建设步骤则分为参与、规划、实施和评估四个阶段。老年友好型环境的评价指标覆盖八个维度，包括室外环境，公共交通和活动性，住房，社会参与，社会融入和非歧视，公民参与和就业，交流和信息，以及社区和卫生服务。由于各地区或国家的实际情况不同，开展的老年友好型环境建设的内容、方法和策略也可能不同，在开展指标评价和具体测量时，不但要考虑到指标对衡量的系统或工作主要目标的相关性，而且要考虑到这些指标必须是可衡量的、技术上可靠的并对目标受众有意义。老年友好型环境的构建是老年友好型社会的基础性工作，在实践层面起着统领全局的作用。

在社区层面，老年友好型社会的构建需要不断创新社区服务实践。本书以社区养老服务体系的构建为例，诠释老年友好型社会的社区服务创新。社区养老是我国解决人口老龄化问题的重要举措和必然趋势，在社区层面构建整体性的养老服务体系是发展社区养老和福利社区化的必然路径。现有体制下不同的政府部门由于各自的职能与功能定位不同，出现不同部门出台的养老政策之间有权责交叉、界限不明确、资源投入的重叠与缝隙并存等现象。“整合式”社区养老服务体系整合各部门投放到社区的养老服务资源，统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的养老服务功能，以“整合式”服务平台精准对接养老服务的供需双方，综合各种社会力量为社区老年人提供全方位、多层次、专业化和精准化的养老服务，使社区成为养老服务资源的链接和组织平台。其主要目标包括资源整合、多元协同、供需匹配和数据融合。“整合式”社区养老服务体系及平台的构建遵循“四化”与“四助”相结合的基本理念。“四化”是指简行政化、重专业化、原居老化和政产学研一体化；“四助”则指公助、共助、互助和自助，“四助”结合要求将体制内资源和体制外资源通过协同合作机制实现资源整合。“整合式”社区

养老服务体系的社区实践包括三点要义：居家健康照护机构的社区嵌入，社区为老服务数据平台的信息整合，老年社工对于社区为老服务的全程导引。本书阐述了作为社区养老服务资源链接者的老年社工的制度设计，给出了社区养老服务数据平台的设计方案，为进一步完善社区养老服务的政策设计和体系构建提供理论与实践支撑。

在家庭层面，本书认为，中国家庭如何在超越传统局限性的同时注重传统的延续性，这不仅关乎老年友好型社会的构建与发展，也关系到中国社会能否顺利完成传统与现代的历史转换。当代中国家庭表现出一种“家庭形态核心化”与“家庭功能网络化”的创造式结合。随着人口老龄化程度的加深，家庭中有多个老年人、高龄低龄老年人共存、老年空巢等现象日趋显著，给传统的家庭养老格局带来更多挑战，也对老年友好型社会的构建提出了更高的要求。在人口转变与社会转型的过程中，当代中国家庭的规模、结构以及家庭关系和功能都发生了显著的变化，但却缺乏有效的制度支持家庭自身的发展。基于此，本书提出老年友好型社会的家庭政策重构要点，即将生育政策调整与家庭政策完善协调起来，通过投资于“人的全面发展”保证人口和家庭的可持续发展，实现从“多生”到“善养”的过渡；明确以家庭整体作为政策对象，推进家庭政策适度普惠性的同时也强化对特定家庭的援助;将重视和支持家庭作为中国应对老龄社会的一个重点及特点；扶持家庭服务业，并将其与社区建设、社会组织培育紧密结合。书中呼吁，在关注“民生”的总体政策导向中实施家庭政策，提高家庭政策的行政效率，最终形成一个政府、市场、社区和社会组织都有责任、动力与行动来帮助家庭承担应有责任的制度框架。而家庭作为当代社会的基本细胞，将在老年友好型社会的建设中发挥独特的、难以替代的作用。

以初级保健为核心的基层卫生系统是老年友好型社会的有力保障。初级卫生保健倡导医疗服务的可及性、可负担性及经济适宜性，并且倡导医疗卫生服务就发生在人群所居住的社区内。本书从中国特色的家庭医生模式的发展、困境与创新探索展开论述，并从供给侧与需求侧两个方面对当前基层卫生服务的基本成效进行分析评估。家庭医生制度提供的全科医疗被称为最经济、最适宜的医疗卫生保健服务模式，其发挥巨大作用依赖四个基本要素，即强大的人才队伍与严格的培养系统，有效的激励手段与控费方式，畅通的转诊机制与有序医疗，以及居民需求与满意度的服务导向。我国家庭医生制度的本土化实践在这四方面进行了积极探索。以上海市虹口区为例，其家庭医生制度的试点改革从全科团队入手，着眼于组织形态的重组，通过组织形态的创新实现服务形态的转变与体制机制的变革，形成了具有鲜明特色的服务模式。其主要特征包括以下几项：构建以家庭医生为核心的单元；围绕单元进行机构功能调整；单元协商分工共同提供签约服务，实现防治结合；整合政府部门协作支撑，从专科科室入手医疗协同；转变绩效激

励考核机制，从而形成以组织形态创新为突破口的良性循环系统。以家庭医生为代表的初级卫生保健制度和基层卫生系统是老年友好型社会健康保障的基石，维系着满足基本医疗保健公共服务需求的生命线，有待在进一步提升服务质量、提高服务效率、扩大服务可及性等方面进行改革创新。

老年人积极的社会参与是老年友好型社会的应有之义。老年人通过个人以各种角色的扮演和介入，实现和保持个体与社会的互动，进而实现社会资源的共享。老年人通过社会参与不仅创造了经济价值，也产生了积极的社会意义。本书对我国老年群体目前的社会参与现状进行定量描述，探讨制约我国低龄老年人力资源开发利用的困境，以及老年人社会参与的影响因素，并对如何有效开发老年人口红利，如何在理念、政策和制度层面做出调试和回应提出对策建议。总体而言，现阶段，我国低龄老年人力资源开发仍处于初级阶段，低龄老年群体的社会经济参与主要是自发行为，政府的顶层设计基本空白，尚未形成相对完整的政策安排和制度体系。老年人社会参与面临的困境主要表现为传统观念与思维定式制约老年社会参与的多元化，相关政策法律发展滞后，互联网时代带来新挑战，老年教育存在认知偏差。其影响因素包括个体层面的性别、年龄、健康状况、受教育水平等方面，以及环境层面的社区人际关系、社区基础设施情况、社区组织和社会保障政策等方面。本书提出，我国亟须辩证地认识老年人力资源，引导形成理性的老年群体社会经济参与观念，科学设置低龄老年群体社会经济参与的制度体系，从而提高我国低龄老年人社会经济参与水平。具体的对策建议包括推广终身学习理念，提升低龄老年群体适应互联网时代的能力和素质，推行灵活的弹性退休制度，推进公务员退休群体人力资源开发先行先试等。

智慧养老技术与产品的应用和推广是建设老年友好型社会的重要抓手。目前，养老服务产品的研发和商业模式的探索仍处于初级阶段，老年群体对智慧养老产品的接纳度和对智能社会发展的适应度仍需要时间与过程。第一，应合理界定中国智慧养老的发展在当前养老服务体系中的定位问题，了解老年人可以接受多大程度的行为改变，以及其行为如何随着独立程度的改变而改变，使信息通信技术的应用达到辅助延长独立生活、提高生活质量的目的。第二，智能技术的发展需充分考虑老龄化过程中不同的生命周期阶段。应充分考量老年人不同迭代之间的信息习得能力与需求差别，充分考虑产品使用对象的特点和使用偏好，充分考虑不同年代老年人的生活需求和原来的生存背景。第三，应充分了解智能技术参与者之间的关系互动与博弈，促使老年人将服务成本视为“明智的投资”而不是“负担”，进一步扩大智慧养老技术的适用范围。第四，养老护理服务人才紧缺倒逼智慧养老技术的发展，技术赋能的养老服务供给可逐渐改变老年服务的传统模式，为养老服务人员提供辅助，并提高服务效率和质量。第五，在智能城市试点中嵌入老龄社会信息通信技术创新的基础设施建设。智慧养老是养老服务模式不可阻

挡的发展方向，未来发展的重点应该在技术的先进性、产品的可用性和服务的可及性之间寻求平衡。

“数字鸿沟”的区隔是老年友好型社会在移动互联网时代面临的新挑战。现有研究发现，“数字鸿沟”的形成及影响因素包括经济因素、年龄和性别因素、教育因素、地理因素等。本书基于大量的调查与统计数据分析，提出中老年群体数字能力提升路径与策略。首先，政府发挥主导作用。政府应将贯彻技术创新作为积极应对人口老龄化的第一动力和战略支撑思想，加强顶层设计和政策引领，将老年友好科技发展纳入老龄事业与科技事业的发展规划中；应努力构建政府主导、多方参与的老年“数字鸿沟”社会支持体系，提升老年人数字素养，逐步缩小老年群体和年轻群体之间的“数字鸿沟”；大力倡导并建立终身教育体系，为老年人能够继续进行各类学习提供设施和机会；应优化公共服务，兼顾传统和新兴生活方式，为老年群体留出专门服务通道。其次，老年个体积极参加学习和培训。老年人应克服守旧思想、更新观念，主动了解和学习互联网及相关智能产品的使用技能，克服对于互联网的焦虑情绪。再次，社会和家庭提供协助。家人特别是子女的教育反哺能够为老年父母提供最直接有效的支持；可拓展青年志愿服务内容，将提升老年人学习和运用智能手机、互联网等现代信息科技知识与能力作为志愿服务的重要内容。最后，相关数字化企业优化产品。完善市场供给，引导企业充分考虑老年人需求，开发更多优质适老化数字产品；加强老年友好型的页面设计，使页面内容更加符合老年人的视力特征；加强老年人专属智能重点产品的开发设计，满足老年人的个性化需求。“数字鸿沟”的弥合和跨越需要全社会共同参与，政府、家庭、社区、企业之间加强协作，尤其是代际有效沟通形成合力，让每一位老年人都能分享科技进步带来的社会发展成果。

老年友好型社会的治理需要融合创新。这意味着要有机结合传统与现代的理念建设老年友好型社会，将其融合到具体的共建、共治、共享、社会治理实践当中，营造开放包容的社会环境、建立全面长远的政策体系和结成良性互动的治理共同体。本书认为，建设老年友好型社会的治理共同体至少应具备三方面内涵：一是具有主观能动性、社会认同感、角色责任和伦理道德，通过有效互动与密切协作，在正和博弈过程中达成共同治理远景；二是具有相关政策的实施对象与政策制定的参与方的双重角色；三是需要在民主与科学、道德与法律、融合与创新的社会治理框架下互动和协作。基于此，老年友好型社会治理的融合创新要找准切入点、把握着力点；老年群体应当作为治理共同体的成员，成为政策的积极参与者和行动主体；对老龄社会治理共同体应实行必要的引导和规范，以规避其组织形式和行动的无序与失范；老年友好型社会治理中政策工具的设计与选择应涵盖全社会参与、全区域统筹和全场景应用三个范畴。人口老龄化的有效应对是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，探索适合我国的老年友好型社会

的有效治理方案是政、产、学、研各界的共同责任。

需要说明的是，虽然建设老年友好型社会的初衷是应对人口老龄化的挑战，但其建设理念并非只针对老年人，而是“全龄友好”。在社区层面，“全龄化”社区以社区中各个年龄段的居住人群为基本组成，在传统社区的基础上更加突出对老年群体的关注，通过对社区的整体规划空间设计、配套设施设计和包括助老服务在内的各种社区服务的配置，打造“全龄友好”的活力社区。在城市层面，老年友好型城市的范畴被拓展至关注个体的全生命周期、覆盖社会经济生活的方方面面。世界卫生组织编写的《全球老年友好城市建设指南》指出，老年友好型城市不仅仅是“老年友好”，从中受惠的应该是所有人。残疾人可以从无障碍建筑物和街道中获益，方便其行动，促进其独立性；儿童、年轻女性和老年人可以在安全的社区环境中放心地自由活动，增强社会连接；家庭可以得到其所需的社会健康服务的支持，缓解照护压力；老年人的社会参与以及对老年消费者的保护，最终也会有效推动地方经济发展，促进社会的全面和谐。

老年友好型社会的建设是复杂和长期的过程。在一定意义上，本书内容是对课题组前期有关老年友好型社会研究的一个阶段性总结。以此为基础，未来还有一些相关的研究领域有待进一步探索。比如，老年友好型社会与经济系统的互动关系研究。人口老龄化改变了传统的生产函数中关于劳动力无限供给的假设，也给传统的消费函数增加了随年龄结构变动的消费模式的变数，老年友好型社会的经济发展有哪些异于传统社会的特征与规律，发展趋势怎样，如何有效干预，等等，都是有待发掘的研究领域。又如，老年友好型社会的建设中政府角色的研究。一方面，老年友好型社会的建设需要发挥政府的主导作用；另一方面，也要调动各类社会主体的积极性，引导市场、社会组织和家庭共同发力，形成福利供给的多元主体格局。在此过程中，政府需要制定规则、加强监管，有时还需作为采购服务的资金提供方；同时，又要明确界定政府与市场、社会及家庭的边界，充分保护市场与社会的创新活力。因此，在老年友好型社会的建设中政府应扮演何种角色、发挥何种作用，如何兼顾公平与效率的价值取向，也是有待进一步探讨的重要议题。再如，老年友好型社会中良性互动的代际关系的研究中，代际冲突是社会转型过程中难以回避的议题，老龄社会中的代际关系又与人口结构、特定历史阶段的社会经济及文化环境的变动密切相关。代际财富流的转移趋向、“文化堕距”引发的代际隔阂、后喻社会背景下的文化反哺等，对这些问题的深入研究将有助于丰富我们对老年友好型社会的科学认知，为推进老年友好型社会的建设提供理论与实证支撑。

2020 年末，本书接近完稿之际，欣闻国家卫生健康委员会和全国老龄工作委员会办公室发文决定在全国开展示范性老年友好型社区创建工作，提出到 2025 年在全国建成 5000 个示范性城乡老年友好型社区，到 2035 年，全国城乡实现老

年友好型社区全覆盖的工作目标，同时发布了全国示范性城乡老年友好型社区的试行标准，涉及居住环境、出行设施、社区服务、社会参与、孝亲敬老、科技助老、管理保障等七个方面。社区是缩小的社会，社会是放大的社区。成千上万个老年友好型社区的建设汇成洪流，无疑会有力推动老年友好型社会向纵深发展，不断促进老年友好型社会的全面完善。诚如是，本书的编辑出版可谓适逢其时，愿能为老年友好型社区的创建、老年友好型社会的创新与实践助一臂之力。

参 考 文 献

鲍勇, 杜学礼, 张安, 等. 2012. 基于社区健康管理的上海市家庭医生制度发展战略与策略. 上海医药, 33(12): 12-16.

比尔基埃 A, 克拉比什-朱伯尔 K, 雪伽蓝 M, 等. 1998. 家庭史——现代化的冲击. 袁树仁, 等译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

彼得斯 B G, 冯尼斯潘 F K M. 2007. 公共政策工具: 对公共管理工具的评价. 顾建光译. 北京: 中国人民大学出版社.

波斯曼 N. 2007. 技术垄断: 文化向技术投降. 何道宽译. 北京: 北京大学出版社.

布鲁金 H A D, 坦霍伊维尔霍夫 E F. 2007. 对政策工具背景性探讨//彼得斯B G, 冯尼斯潘F K M. 公共政策工具: 对公共管理工具的评价. 顾建光译. 北京: 中国人民大学出版社: 75.

蔡景泉, 李文秀. 2018. 北京海淀区基层医务人员职业倦怠现况调查. 中国健康心理学杂志, 26(1): 82-85.

曹静, 徐崇凯, 顾芙蓉, 等. 2010. 以社区健康服务中心全科医生为主体的糖尿病管理模式. 中国医药导报, 7(17): 113-114.

柴一凡, 郭森. 2020. 主观年龄对老年人公益活动参与的影响——基于 CLASS2014 年数据分析. 西北大学学报(哲学社会科学版), 50(3): 167-178.

陈功, 高羽. 2014. 北京城市老年人社会参与的态度和行为变动趋势. 北京: 北京大学.

陈茗, 林志婉. 2004. 城市老年人参与社会公益活动的意愿及其影响因素. 人口学刊, (3): 30-34.

陈庆云. 2006. 公共政策分析. 北京: 北京大学出版社.

陈荃, 代涛, 李新伟. 2012. 英国卫生决策支持系统发展与启示. 中国循证医学杂志, 12(4): 371-373.

陈映芳. 2010. 国家与家庭、个人: 城市中国的家庭制度(1940—1979). 交大法学, 1(1): 145-168.

陈友华. 2012. 关于人口老龄化几点认识的反思. 国际经济评论, (6): 110-123,7.

陈振明, 张敏. 2017. 国内政策工具研究新进展: 1998—2016. 江苏行政学院学报, (6): 109-116.

陈振明. 2003. 公共政策分析. 北京: 中国人民大学出版社.

陈振明. 2015. 政策科学教程. 北京: 科学出版社.

程志凯. 2014. 老年人交通安全问题研究. 辽宁警专学报, 16(6): 71-75.

达尔 R A, 林德布洛姆 C E. 2021. 政治、经济与福利. 蓝志勇译. 北京: 中国人民大学出版社.

戴利 H E, 汤森 K N. 2001. 珍惜地球——经济学、生态学、伦理学. 马杰, 钟斌, 朱又红译. 北京: 商务印书馆.

戴卫东. 2011. 老年长期护理需求及其影响因素分析——基于苏皖两省调查的比较研究. 人口研究, 35(4): 86-94.

德克尔 D L. 1986. 老年社会学. 沈健译. 天津: 天津人民出版社.

段世江, 张辉. 2008. 老年人社会参与的概念和理论基础研究. 河北大学成人教育学院学报, (3): 82-84.

范向民, 范俊君, 田丰, 等. 2019. 人机交互与人工智能: 从交替浮沉到协同共进. 中国科学: 信息科学, 49(3): 361-368.
费正清. 1999. 美国与中国. 4 版. 张理京译. 北京: 世界知识出版社.
冯猛. 2020. 社会治理变迁: 路径转型与秩序构建//李友梅. 中国社会变迁(1949～2019). 北京: 社会科学文献出版社: 92, 94.
傅华, 李洋, 彭伟霞, 等. 2012. 转变思维模式积极应对我国慢性病“井喷”的挑战. 复旦学报(医学版), 39(4): 331-334.
高鉴国, 豪厄尔, 梅陈玉婵. 2011. 老龄生产性参与: 全球视野. 北京: 中国社会出版社.
葛蔼灵, 冯占联. 2019. 中国养老服务的政策选择. 北京: 中国财政经济出版社.
葛运运, 徐静, 周亚夫, 等. 2013. 我国全科医学发展历史与现状分析. 中国全科医学, 16(25): 2201-2203.
桂小海, 王洪波, 刘慧, 等. 2018. 基于家庭医生服务制度的弹性薪酬模型构建研究. 中国全科医学, 21(25): 3038-3043.
国家卫生计生委家庭司. 2016. 中国家庭发展报告 2016. 北京: 中国人口出版社.
国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所“我国社会治理创新发展研究”课题组. 2018. 我国社会治理的制度与实践创新. 北京: 中国发展出版社.
国务院发展研究中心公管所. 2018. 社会治理的理论与实践探索. 北京: 中国发展出版社.
海德格尔 M. 1999. 存在与时间. 陈嘉映, 王庆节译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.
韩青松. 2007. 老年社会参与的现状、问题及对策. 南京人口管理干部学院学报, (4): 41-44.
豪利特 M, 拉米什 M. 2006. 公共政策研究：政策循环与政策子系统. 庞诗, 等译. 北京：生活·读书·新知三联书店.
何毅平, 褚宏言, 韶红, 等. 2007. 社区医务人员离职意愿与工作满意度和组织承诺的关系. 中国全科医学, (1): 49-51.
贺小林, 梁鸿. 2012. 推进家庭责任医生制度改革的理论探讨与政策建议. 中国卫生政策研究, 5(6): 3-8.
胡宏伟, 郑翩翩, 袁水苹. 2018. 积极老龄化: 构建老年社会参与促进与保障综合体系. 中国社会工作, (17): 24-25.
胡静超, 陶红, 刘晓虹. 2007. 上海市部分社区护士工作满意度的调查与分析. 解放军护理杂志, (13): 22-23, 42.
胡文琦, 裴晓梅. 2014. 生产性老龄化背景下“老年精英”社会参与的实证研究——以北京市离退休老干部为例. 老龄科学研究, 2(12): 36-44.
胡霞, 黄文龙. 2014. 社区居民家庭医生签约意愿影响因素实证研究. 南京中医药大学学报(社会科学版), 15(3): 178-183.
胡湛. 2018. 传统与超越: 中国当代家庭变迁与家庭政策. 北京: 社会科学文献出版社.
胡湛, 彭希哲. 2012. 家庭变迁背景下的中国家庭政策. 人口研究, 36(2): 3-10.
胡湛, 彭希哲. 2014. 中国当代家庭户变动的趋势分析: 基于人口普查数据的考察. 社会学研究, 29(3): 145-166, 244.
胡湛, 彭希哲. 2018. 应对中国人口老龄化的治理选择. 中国社会科学, (12): 134-155, 202.
黄蛟灵, 梁鸿, 张宜民, 等. 2016. 家庭医生制度本土化困境与策略: 以上海市虹口区为例. 中国卫生政策研究, 9(8): 37-43.
姬军生, 刘刚, 陈虹, 等. 2014. 国外全科医生培养概况及其对我国全科医学教育的启示. 中华

医学教育杂志, 34(3): 474-477, 480.
贾开. 2020. 数字治理的反思与改革研究: 三重分离、计算性争论与治理融合创新. 电子政务, (5): 40-48.
江立华, 沈洁, 等. 2008. 中国城市社区福利. 北京: 社会科学文献出版社.
姜向群. 1999. 人口老龄化与社会政治. 中国人民大学学报, (1): 49-54.
敬乂嘉. 2020. 老龄社会的复合治理体系: 对 1982—2015 年老龄政策变迁的分析. 中国行政管理, (5): 63-70.
李驰, 刘毅, 戢秋明. 2014. 武汉市青山区社区医务人员心理健康状况调查. 中国民康医学, 26(5): 82-83, 86.
李红艳. 2006. 培养全科医生在社区卫生服务中的重要性. 社区医学杂志, (20): 4-5.
李纪恒. 2020-12-17. 实施积极应对人口老龄化国家战略. 光明日报, 6 版.
李娟, 于保荣, 孟庆跃, 等. 2008. 山东、宁夏农村居民 5 种常见慢性病的疾病经济负担分析. 中国卫生经济, (3): 63-65.
李开复. 2018. 365 种工作的未来消亡概率图谱. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620919495155383969&wfr=spider&for=pc[2019-05-05].
李立国. 2016. 国务院关于研究处理老年人权益保障法执法检查报告及审议意见情况的反馈报告——2016 年 8 月 31 日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议上. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2016-10/12/content_1999017.htm[2016-10-12].
李梦嘉. 2009. 城市老年人的非经济性社会参与研究——基于山西省太原市的实证调查. 湖北: 华中科技大学.
李艳. 2018. 浅谈老龄事业发展人才建设规划. 现代经济信息, (20): 26-27.
李永斌, 王芳, 刘利群, 等. 2013. 社区卫生服务机构医务人员对绩效工资制度实施的满意度和反应性分析. 中国卫生事业管理, 30(3): 172-175, 215.
李宗华, 李伟峰, 高功敬. 2011. 城市老年人社区参与意愿的影响因素分析. 山东社会科学, (3): 112-117.
梁鸿, 贺小林. 2012. 医保支付方式改革政策演进路径的前瞻分析. 中国医疗保险, (3): 38-40.
梁鸿, 余兴, 仇育彬. 2010. 新医改背景下社区卫生服务若干政策问题的探讨. 中国卫生政策研究, 3(7): 2-8.
梁万年. 2007. 全科医生的素质和任务及其在社区卫生服务中的作用. 中国全科医学, (3): 173.
林 N. 2020. 社会资本：关于社会结构与行动的理论. 张磊译. 北京: 社会科学文献出版社.
林格林 A B. 2016. 政治工具的欧洲经验//萨拉蒙 L M. 政府工具: 新治理指南. 肖娜, 等译. 北京: 北京大学出版社: 507-514.
刘虹丽, 张帆, 戴亚丽, 等. 2012. 两种糖尿病管理模式下患者血糖及费用的比较. 中国医药导报, 9(16): 47-49.
刘吉成. 2004. 英国卫生服务“守门人”模式的启示——中国卫生服务实行“守门人”模式的构想. 中国卫生经济, (2): 77-78.
刘骥. 2008. 阶级分化与代际分裂: 欧洲福利国家养老金政治的比较分析. 北京: 北京大学出版社.
刘琦. 1999. 国文珍品文库——论语. 长春: 吉林文史出版社.
刘姗姗, 李明, 黄煊, 等. 2016. 浦东新区社区医务人员工作满意度调查研究. 中国卫生质量管理, 23(1): 62-66.
刘颂. 2007. 老年社会参与对心理健康影响探析. 南京人口管理干部学院学报, (4): 38-40.

刘晓梅. 2012. 我国社会养老服务面临的形势及路径选择. 人口研究, 36(5): 104-112.
刘燕, 纪晓岚. 2014. 老年人社会参与影响因素的 Logistic 回归分析——基于 311 份个案访谈数据. 华东理工大学学报(社会科学版), 29(3): 98-104.
刘志彪, 张晔. 2018. 提高生育率: 新时代中国人口发展的新任务. https://www.sohu.com/a/246775665_701468[2018-08-14].
刘智勇, 陈立. 2020. 从有限参与到有效参与: 邻避冲突治理的公众参与发展目标. 学习论坛, (10): 84-90.
卢杉. 2016. 上海计划借助互联网 推动分级诊疗. http://www.21jingji.com/2016/1-20/wNMDAzMzdfMTM4NjcwNg.html?[2016-01-20].
陆杰华, 李月, 郑冰. 2017. 中国大陆老年人社会参与和自评健康相互影响关系的实证分析——基于 CLHLS 数据的检验. 人口研究, 41(1): 15-26.
陆学艺. 2010. 当代中国社会结构. 北京: 社会科学文献出版社.
罗素 B. 1982. 我的哲学的发展. 温锡增译. 北京: 商务印书馆.
罗兹 R A W. 2020. 理解治理: 政策网络、治理、反思与问责. 丁煌, 丁方达译. 北京: 中国人民大学出版社.
马良, 丁璐. 2017. 北京市某区社区医务人员职业倦怠状况及心理干预需求调查. 职业与健康, 33(14): 1885-1889.
马斯洛 A. 2008. 马斯洛的人本哲学. 刘烨译. 海拉尔: 内蒙古文化出版社.
麦克卢汉 M. 2012. 理解媒介：论人的延伸. 何道宽译. 南京: 译林出版社.
毛寿龙. 2003. 公共行政学. 北京: 九州出版社.
毛寿龙, 李文钊. 2008. 政府职能和管理方式研究. 第一届中美公共管理学术研讨会.
孟庆跃. 2014. 全民健康覆盖: 从理念到行动. 中国卫生政策研究, 7(2): 1-4.
莫海韵. 2017. 广东省不同地区家庭医生签约服务现状及对策研究. 广州: 广州医科大学.
穆光宗. 2002. 老年发展论: 21 世纪成功老龄化战略的基本框架. 人口研究, (6): 29-37.
帕斯卡尔 B. 1985. 思想录. 何兆武译. 北京：商务印书馆.
彭希哲. 2018. 改革开放 40 年 | 彭希哲: 人口模式变化下的中国老龄化. http://baijiahao.baidu.com/s?id=1601311531537561426&wfr=spider&for=pc[2018-05-25].
彭希哲, 郭德君. 2016. 孝伦理重构与老龄化的应对. 国家行政学院学报, (5): 35-41,142.
彭希哲, 郭德君. 2018. 老龄化应对与当代社会基础性孝伦理体系的构建——基于传统“二十四孝”的批判性分析. 探索, (2): 159-165.
彭希哲, 胡湛. 2011. 公共政策视角下的中国人口老龄化. 中国社会科学, (3): 121-138,222-223.
彭希哲, 胡湛. 2015. 当代中国家庭变迁与家庭政策重构. 中国社会科学, (12): 113-132,207.
彭希哲, 胡湛, 张震. 2019. 上海论坛 | 老龄化①2055—2060 年人口老龄化将达峰值. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3489001[2019-05-21].
彭希哲, 邬民乐. 2009. 养老保险体系可持续性与劳动生产率增长. 人口与经济, (2): 92-96.
齐晓琳, 李士雪, 张英洁, 等. 2006. 我国社区卫生服务发展的障碍与对策研究. 医学与哲学(人文社会医学版), (4): 20-22.
邱德星, 杨灶金, 庞金成, 等. 2007. 社区卫生服务医务人员工作现况及满意度调查. 中国农村卫生事业管理, (3): 237-239.
萨拉蒙 L M. 2008. 公共服务中的伙伴——现代福利国家中与非营利组织的关系. 田凯译. 北京: 商务印书馆.

萨拉蒙 L M. 2016. 新治理与公共行动工具//萨拉蒙 L M. 政府工具: 新治理指南. 肖娜, 等译. 北京: 北京大学出版社: 15.
森 A. 2002. 以自由看待发展. 任赜, 于真译. 北京: 中国人民大学出版社.
沈洁. 2007. 从国际经验透视中国社区福利发展的课题. 社会保障研究(北京), (1): 53-75.
沈序英, 史玲, 王路昌, 等. 2010. 高血压患者全科团队式社区健康管理效果评估. 中国全科医学, 13(8): 873-875.
沈奕斐. 2013. 个体家庭 iFamily: 中国城市现代化进程中的个体、家庭与国家. 上海: 上海三联书店.
世界卫生组织卫生发展中心. 2015. 衡量城市关爱老人的程度: 核心指标使用指南. 神户
孙博文, 伍新木, 李雪松. 2018. 非正式制度与健康养老: 社会资本的健康促进效应研究//厉以宁. 中国道路与人口老龄化. 北京: 商务印书馆: 175-194.
孙常敏. 2010. 完善和创新家庭政策统筹解决人口问题. 社会学(智库报告), (1): 1-7.
唐灿, 陈午晴. 2012. 中国城市家庭的亲属关系: 基于五城市家庭结构与家庭关系调查. 江苏社会科学, (2): 92-103.
唐灿. 2010. 家庭现代化理论及其发展的回顾与评述. 社会学研究, 25(3): 199-222, 246.
唐钧. 2018. 社会治理与社会保护. 北京: 北京大学出版社.
滕尼斯 F. 2019. 共同体与社会. 张巍卓译. 北京: 商务印书馆.
万丽华, 蓝旭. 2006. 孟子. 北京: 中华书局.
王凯民, 檀榕基. 2014. 环境安全感、政府信任与风险治理——从“邻避效应”的角度分析. 行政与法, (2): 10-15.
王奎明. 2019. “价值冲击”与“现实困境”的双重叠加: 嵌入式养老院的建设困局与路径选择. 上海城市管理, 28(1): 60-66.
王丽敏. 2005. 我国城市社区卫生服务人力资源的现状分析. 齐齐哈尔医学院学报, (7): 800-801.
王莉莉. 2011a. 中国老年人社会参与的理论、实证与政策研究综述. 人口与发展, 17(3): 35-43.
王莉莉. 2011b. 中国老年人闲暇活动参与状况及其影响因素分析. 西北人口, 32(3): 35-42.
王满船. 2004. 公共政策制定: 择优过程与机制. 北京: 中国经济出版社.
王苏中, 吴永浩, 于石成, 等. 2000. 社区高血压“合作管理”干预效果评估. 中国全科医学, (4): 291-294.
王英, 谭琳. 2009. “非正规”老年教育与老年人社会参与. 人口学刊, (4): 41-46.
王跃生. 2010. 个体家庭、网络家庭和亲属圈家庭分析——历史与现实相结合的视角. 开放时代, (4): 83-99.
王志良. 2017. 国家推进智慧养老的政策措施. 中国社会工作, (17): 30.
尉敏琦, 周热娜, 严华美, 等. 2015. 上海市某区社区健康咨询服务点服务状况评估. 中国卫生资源, 18(3): 223-225.
魏礼群. 2019. 中国社会治理通论. 北京: 北京师范大学出版社.
温福星. 2009. 阶层线性模型的原理与应用. 北京: 中国轻工业出版社.
渥兹涅克 Z. 2019. 老年社会政策的新视野. 陈昫译. 北京: 社会科学文献出版社.
邬沧萍. 1999. 社会老年学. 北京: 中国人民大学出版社.
邬沧萍. 2007. 邬沧萍自选集. 北京: 中国人民大学出版社.
邬沧萍, 姜向群. 2015. 老年学概论. 3 版. 北京: 中国人民大学出版社.
邬沧萍, 穆光宗. 1997. 健康的老龄社会. 人口与经济, (1): 18-20, 56.

吴帆. 2008. 认知、态度和社会环境：老年歧视的多维解构. 人口研究, (4): 57-65.
吴海燕, 孙昕, 许强, 等. 2015. 新疆克拉玛依市社区卫生服务综合改革成效分析. 中国卫生资源, 18(5): 342-345.
吴淑琼, 庄坤洋. 2001. 在地老化：台湾二十一世纪长期照护的政策方向. 台湾公共卫生杂志, 20(3): 192-201.
吴小英. 2012. 公共政策中的家庭定位. 学术研究, (9): 50-55, 159.
线福华, 路孝琴, 吕兆丰. 2012. 全科医生培养模式及其实施中相关问题的思考. 中国全科医学, 15(22): 2498-2501.
肖群忠. 2001. 孝与中国文化. 北京：人民出版社.
肖筱, 袁立, 周昌明, 等. 2015. 推行家庭医生签约对社区卫生服务利用的影响. 中国卫生资源, 18(1): 64-67.
肖子华. 2018. 人口流动与社会融合：理论、指标与方法. 北京：社会科学文献出版社.
谢立黎, 汪斌. 2019. 积极老龄化视野下中国老年人社会参与模式及影响因素. 人口研究, 43(3): 17-30.
徐江荣, 郭化山, 乌建平. 2011. 专科层次的全科医学教育与国情. 中国全科医学, 14(28): 3254-3255.
徐静, 周亚夫, 葛运运, 等. 2013. 国内外全科医生的覆盖范围及待遇和相应支付方式. 中国全科医学, 16(30): 2787-2789.
徐勇. 2013. 中国家户制传统与农村发展道路——以俄国、印度的村社传统为参照. 中国社会科学, (8): 102-123,206-207.
徐越, 韵卓敏, 王婧媛, 等. 2020. 智能化背景下, 老年人数字鸿沟的影响因素及其形成过程分析. 智能计算机与应用, 10(2): 75-82.
薛慧英, 张铁英, 葛鑫, 等. 2003. 社区医务人员心理健康状态调查与分析. 健康心理学杂志, (4): 317-319.
薛艳. 2016. 基于分层线性模型的流动人口社会融合影响因素研究. 人口与经济, (3): 62-72.
燕继荣. 2015. 社会资本与国家治理. 北京：北京大学出版社.
杨复卫, 张新民. 2017. 支持养老产业发展的财税政策工具选择与应用研究. 西南大学学报(社会科学版), 43(6): 49-59, 193-194.
杨菊华. 2016. 论社会融合. 江苏行政学院学报, (6): 64-72.
杨团. 2000. 中国的社区化社会保障与非营利组织. 管理世界, (1): 111-120.
杨燕绥, 妥宏武. 2017. 为什么要构建老年友好型社会. 人民论坛, (19): 60-61.
杨一帆. 2018. 健康老龄化蓝皮书：中国大中城市健康老龄化指数报告(2017—2018). 北京：社会科学文献出版社.
杨一帆, 潘君豪. 2019. 老年数字鸿沟治理的一个分析框架. 老龄科学研究, 7(10): 58-67.
杨宗传. 2000. 再论老年人口的社会参与. 武汉大学学报(人文社会科学版), (1): 61-65.
殷德生. 2001. 社会资本与经济发展：一个理论综述. 南京社会科学, (7): 28-31.
由晓柳, 徐凌中, 杨平, 等. 2007. 威海市社区卫生服务人力资源现状及满意度研究. 中国卫生经济, (3): 30-33.
于一凡. 2020. 建成环境对老年人健康的影响：认识基础与方法探讨. 国际城市规划, 35(1): 1-7.
于一凡, 胡玉婷. 2017. 社区建成环境健康影响的国际研究进展——基于体力活动研究视角的文献综述和思考. 建筑学报, (2): 33-38.

俞可平. 2000. 治理与善治. 北京: 社会科学文献出版社.
袁立, 周昌明, 江萍, 等. 2014. 上海市长宁区居民家庭医生制服务的需求情况调查. 中国全科医学, 17(32): 3860-3864.
原新, 万能. 2006. 缓解老龄化压力, 推迟退休有效吗?. 人口研究, 30(4): 47-54.
翟振武. 2019-07-29. 关注“新一代”老年人口的新特点. 北京日报, 14 版.
翟振武, 李建新. 2005. 中国人口: 太多还是太老. 北京: 社会科学文献出版社.
张蓓燕, 黄蛟灵, 贺小林, 等. 2013. 上海某社区糖尿病不同干预方式效果比较. 中国卫生资源, 16(4): 276-278.
张恩宇, 陈娟. 2011. 北京市某城区社区卫生服务医务人员满意度分析. 中国卫生政策研究, 4(8): 44-47.
张凤宝. 2019-03-25. 探索老年友好型社会均衡发展之路. 人民政协报, 6 版.
张建, 朱庆云, 朱建锋, 等. 2018. 上海市青浦区社区卫生服务中心医务人员职业紧张状况调查. 职业卫生与应急救援, 36(5): 415-417.
张凯, 刘继同. 2010. 我国城市社区卫生服务体制困境与全科医师收入现状实证研究. 中国全科医学, 13(34): 3837-3838, 3841.
张恺悌, 郭平, 王海涛. 2010. 对人口老龄化研究的反思. 上海论坛. 应对老龄化社会的挑战研讨会论文集. 上海: 复旦大学出版社.
张双德, 郝海. 2005. 我国社区卫生服务的现状分析. 中国卫生事业管理, (2): 91-93.
张双棣, 张万彬, 殷国光, 等. 1987. 吕氏春秋译注(上). 长春: 吉林文史出版社.
张玮. 2011. 开展家庭医生制服务的可行性分析与对策研究. 中国全科医学, 14(19): 2136-2138.
张文娟. 2010. 中国老年人的劳动参与状况及影响因素研究. 人口与经济, (1): 85-89,92.
张文娟, 刘瑞平. 2016. 中国老年人社会隔离的影响因素分析. 人口研究, 40(5): 75-91.
张秀兰, 徐月宾. 2003. 建构中国的发展型家庭政策. 中国社会科学, (6): 84-96, 206-207.
张学标, 莫希兰, 高福群, 等. 2010. 家庭医生服务团队对社区糖尿病 41 例健康教育效果分析. 社区医学杂志, 8(22): 66-67.
张学标, 王启, 周立志, 等. 2011. 社区家庭医生服务团队对高血压患者健康教育方法和效果分析. 社区医学杂志, 9(7): 62-63.
张雪, 杨柠溪. 2015. 英美分级诊疗实践及对我国的启示. 医学与哲学(A), 36(7): 78-81.
张一飞, 冯学山. 2013. 英国全科医生制度建设对我国的启示. 中国初级卫生保健, 27(11): 10-12.
张跃红, 张拓红, 王志锋. 2013. 北京市德胜地区居民家庭医生式服务的签约现状及影响因素调查. 中国全科医学, 16(37): 3715-3718.
赵德余. 2011. 公共政策：共同体、工具与过程. 上海: 上海人民出版社.
赵德余. 2017. 政策科学方法论. 上海: 上海人民出版社.
赵娜, 邝木子. 2018. 新媒体时代老年人数字融入机制研究. 传媒, (22): 91-94.
赵阳, 李潇, 张亚超, 等. 2010. 我国双向转诊运行现状与效果的系统综述. 中国全科医学, 13(31): 3500-3503.
赵玉峰, 扈新强. 2019. 流动人口社会参与的民族差异——基于 2014 年流动人口动态监测的实证研究. 西北人口, 40(2): 25-35.
郑杭生. 2017. 社会学概论新修. 5 版. 北京: 中国人民大学出版社.
中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局. 2009. 马克思恩格斯文集（第 10 卷）. 北

京: 人民出版社.
中华人民共和国国家统计局. 2009. 中国统计年鉴 2009. 北京: 中国统计出版社.
中投产业研究院. 2018. 2018—2023 年中国智慧养老产业市场前景及投资机会研究报告. 深圳: 深圳市中投顾问股份有限公司.
周湘涛, 杨同卫, 张新庆. 2009. 城市社区医务人员工作满意度调查分析. 中国卫生政策研究, 2(11): 34-36.
周裕琼. 2018. 数字弱势群体的崛起: 老年人微信采纳与使用影响因素研究. 新闻与传播研究, 25(7): 66-86, 127-128.
朱春奎, 等. 2011. 政策网络与政策工具: 理论基础与中国实践. 上海: 复旦大学出版社.
朱浩, 易龙飞. 2015. 社会保险对城乡低龄老年人再就业的影响——基于 CHARLS 数据的实证分析. 西北人口, 36(3): 53-58.
朱勇. 2018. 中国智能养老产业发展报告. http://www.360doc.com/content/18/1207/21/59320440_800085110.shtml[2018-03-07].
左美云. 2018. 智慧养老的含义与模式. 中国社会工作, (32): 26-27.
左美云, 薄夷帆. 2014. 基于需求层次理论的智慧养老产品游戏化设计. 中国信息界, (6): 60-65.
沈潔, 澤田ゆかり. 2016. ポスト改革期の中国社会保障はどうなるのか. ミネルヴァ書房.
Antonio A, Tuffley D. 2014. The gender digital divide in developing countries. Future Internet, 6(4): 673-687.
Attewell P. 2001. The first and second digital divides. Sociology of Education, 74, 252-259.
Baltes P B, Dittmann-Kohli F, Kliegl R. 1986. Reserve capacity of the elderly in aging-sensitive tests of fluid intelligence: replication and extension. Psychology and Aging, 1(2), 172-177.
Barker E, MacFarlane A. 1979. The origins of English individualism: the family property and social transition. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, (33): 11-12.
Bohlin E, Rohman I K. 2011. An assessment of mobile broadband access in Indonesia: a demand or supply problem?. Internetworking Indonesia Journal, 3(2): 15-22.
Bourdieu P. 1985. Social space and the genesis of groups. Theory and Society, 14: 723-744.
Bourdieu P.1986. The forms of capital, in Richardson//John G. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press: 241-258.
Brandtzæg P B, Heim J, Karahasanović A. 2011. Understanding the new digital divide—a typology of Internet users in Europe. International Journal of Human-Computer Studies, 69(3): 123-138.
Briar-Lawson K, Lawson H A, Hennon C B, et al. 2001. Family-Centered Policies and Practices: International Implications. Warrenton: Columbia University Press.
Bukov A, Maas I, Lampert T. 2002. Social participation in very old age: cross-sectional and longitudinal findings from BASE. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57(6): 510-517.
Butler R N, Gleason H P. 1985. Productive aging: enhancing vitality in later life. New York: Springer.
Chinn M D, Fairlie R W. 2007. The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and Internet penetration. Oxford Economic Papers, 59(1): 16-44.
Cohen S, Wills T A. 1985. Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2): 310-357.

Costa P, McCrae R R. 1980. Still stable after all these years: personality as a key to some issues in adulthood and old age. Life Span Development & Behavior, 3: 65-102.

Cruz-Jesus F, Oliveira T, Bacao F. 2012. Digital divide across the European Union. Information & Management, 49(6): 278-291.

Czaja S J, Lee C C. 2007. The impact of aging on access to technology. Universal Access in the Information Society, 5(4): 341-349.

Daniel K M, Cason C L, Ferrell S. 2009. Emerging technologies to enhance the safety of older people in their homes. Geriatric Nursing, 30(6): 384-389.

Davis D, Harrell S. 1993. Chinese Families in the Post-Mao Era. Berkeley: University of California Press.

Demoussis M, Giannakopoulos N. 2006. Facets of the digital divide in Europe: determination and extent of Internet use. Economics of Innovation and New Technology, 15(3): 235-246.

Desrosiers J, Noreau L, Rochette A. 2004. Social participation of older adults in Quebec. Aging Clinical & Experimental Research, 16(5): 406-412.

Edwards P K, Edwards J N, Watts A D. 1984. Women, work, and social participation. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 13(1): 7-22.

Farber N, Shinkle D, Lynott J, 2011. Aging in Place: A State Survey of Livability Policies and Practices. Washington DC: Public Policy Institute.

Fei H T. 1939. Peasant Life in China. London: George Routledge and Sons, Ltd.

Friemoth J. 2014. The health consequences of adverse childhood experiences: role of the family physician. American Family Physician, 90(12): 822-824.

Gallardo-Peralta L P, Conde-Llanes D, Córdova-Jorquera I. 2016. Association between successful aging and social participation among elderly chilean people. Gerokomos, 27(3): 104-108.

Giddens A. 2006. Sociology. 5th ed. Cambridge: Polity Press.

Goll J C, Charlesworth G, Scior K, et al. 2015. Barriers to social participation among lonely older adults: the influence of social fears and identity. PLoS One, 10(2): e0116664.

Goode W. 1963. World Revolution and Family Patterns. New York: Free Press of Glencoe.

Haight M, Quan-Haase A, Corbett B A. 2014. Revisiting the digital divide in Canada: the impact of demographic factors on access to the Internet, level of online activity, and social networking site usage. Information Communication and Society, 17(4): 503-519.

Harry J. 1970. Family localism and social participation. American Journal of Sociology, 75(5): 821-827.

Harvey A, Koopman S J, Shephard N. 2004. State Space and Unobserved Component Models: Theory and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Havighurst R J. 1961. Successful aging. The Gerontologist, (1): 8-13.

He W, Goodkind D, Kowal P. 2016. An Aging World: 2015. Washington DC: U.S. Government Printing Office.

Helsper E J. 2010. Gendered Internet use across generations and life stages. Communication Research, 37(3): 352-374.

Hsieh J, Rai A, Keil M. 2008. Understanding digital inequality: comparing continued use behavioral models of the socio-economically advantaged and disadvantaged. MIS Quarterly, 32(1): 97-126.

Jackisch J, Zamaro G, Green G, et al. 2015. Is a healthy city also an age-friendly city?. Health Promotion International, 30: i108-i117.

Jan K. 1999. Social-political governance social-political governance overview, reflections and design. Public Management Review, 1(1): 67-92.

Kamerman S B, Kahn A J. 1978. Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries. New York: Columbia University Press.

Kaye H S, Harrington C, LaPlante M P. 2010. Long-term care: who gets it, who provides it, who pays, and how much? Health Affairs, 29(1): 11-21.

Keenan T A. 2010. Home and community preferences of the 45+ population. http://assets.aarp.org/rgcenter/general/home-community-services-10. pdf[2020-12-28].

Lee C. 2014. Adoption of smart technology among older adults: challenges and issues. Public Policy & Aging Report, 24(1): 14-17.

Lee C, Myrick R, d'Ambrosio L A, et al. 2013. Older adults' experiences with technology: learning from their voices. Communications in Computer & Information Science, 373: 251-255.

Lee R, Mason A. 2011. Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Lee Y, Jeon M, Kang J. 2010. Strategies and implications for the social integration of the digital age. IT & Society, 20: 1-29.

Lenoir R. 1975. Les exclus: un Français sur dix. Population (French Edition), 30(1): 180-181.

Lin N. 2001. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. New York: Cambridge University Press.

Lindley D V, Smith A F M. 1972. Bayes estimates for the linear model. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 34(1): 1-41.

Manyika J, Chui M, Miremadi M, et al. 2017. A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity. San Francisco: McKinsey Global Institute.

Mariën I, Prodnik J A. 2014. Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical perspective. Info, 16(6): 35-47.

Mason A, Lee R. 2004. Reform and support systems for the elderly in developing countries: capturing the second demographic dividend. GENUS, (2): 11-35.

Mcconnaughey J W. 1998. Falling through the Net Ⅱ: new data on the digital divide. Washington DC: National Telecommunications and Information Administration.

Mcconnaughey J, Everette D, Reynolds T, et al. 1999. Falling Through the Net: Defining the Digital Divide. Cambridge : The MIT Press.

Midgley J, Tang K L. 2001. Introduction: social policy, economic growth and developmental welfare. International Journal of Social Welfare, 10(4): 244-252.

Mishra R. 1984. The Welfare State in Crisis. Brighton: Wheatsheaf.

Morrow-Howell N, Hinterlong J, Sherraden M W. 2001. Productive Aging: Concepts and Challenges. Baltimore : Johns Hopkins University Press.

Morrow-Howell N, Putnam M, Lee Y S, et al. 2014. An investigation of activity profiles of older adults. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(5): 809-821.

Mumporeze N, Prieler M. 2017. Gender digital divide in Rwanda: a qualitative analysis of socioeconomic factors. Telematics and Informatics, 34(7): 1285-1293.

Newman L, Browne-Yung K, Raghavendra P, et al. 2017. Applying a critical approach to investigate barriers to digital inclusion and online social networking among young people with disabilities. Information Systems Journal, 27(5): 559-588.

O'Connell P J, Esping-Anderson G. 1991. The three worlds of welfare capitalism. Social Forces, 70(2): 532.

OECD. 2001. Understanding the digital divide. OECD Digital Economy Papers, 19(4), 333-336.

Parkin F. 1979. Frank: Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique, New York: Columbia University Press.

Parsons C, Hick S F. 2008. Moving from digital divide to digital inclusion. Currents: New Scholarship in the Human Services, 7(2): 1-16.

Pick J B, Nishida T. 2015. Digital divides in the world and its regions: a spatial and multivariate analysis of technological utilization. Technological Forecasting and Social Change, 91: 1-17.

Pifer A, Bronte L. 1986. Our Aging Society: Paradox and Promise. New York: W. W. Norton & Company.

Prensky M. 2001. Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5): 1-6.

Puspitasari L, Ishii K. 2016. Digital divides and mobile Internet in Indonesia: impact of smartphones. Telematics and Informatics, 33(2): 472-483.

Quibria M G, Ahmed S N, Tschang T, et al. 2003. Digital divide: determinants and policies with special reference to Asia. Journal of Asian Economics, 13(6): 811-825.

Raschke H J. 1977. Family structure, family happiness, and their effect on college students' personal and social adjustment. Family Court Review, 15(2), 30-33.

Rhodes R A W. 1986. The National World of Local Government. London: Allen & Unwin.

Rhodes R A W. 1988. Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Government of Britain. London: Allen & Unwin.

Riggins F J, Dewan S. 2005. The digital divide: current and future research directions. Journal of the Association for Information Systems, 6(12): 298-337.

Ringeling. 2004. Instruments in four: the elements of policy design//Eliadis P, Hill M M, Howlett M, et al. Designing Government: From Instruments to Governance. Montreal: McGill-Queen's University Press: 185-202.

Robles J M, Torres-Albero C, Marco S D. 2011. Spanish e-government and the third digital divide: a sociological view. Journal of US-China Public Administration, 8(4): 401-412.

Rose R. 1986. Common Goals but Different Roles: the State's Contribution to the Welfare Mix. Oxford: Oxford University Press.

Rosow. 1974. Socialization to Old Age. Berkeley: University of California Press.

Rothman A A, Wagner E H. 2003. Chronic illness management: what is the role of primary care?. Annals of Internal Medicine, 138(3): 256-261.

Schultz T P. 2001. Population Matters: Demographic Change, Economic Growth, and Poverty in the Developing World. Journal of Economic History, 63(3): 165.

Schultz T W. 1961. Investment in human capital. The American Economic Review, 51:1-17.

Shinkle D, Tassin L. 2011. Aging in place: a state survey of livability policies and practices. Saturday Evening Post, 2(3):17-26.

Sparrow R, Sparrow L. 2006. In the hands of machines? The future of aged care. Minds and Machines, 16(2): 141-161.

Stock C, Ellaway A. 2013. Neighbourhood Structure and Health Promotion. New York: Springer.

Stokes J P. 1983. Predicting satisfaction with social support from social network structure. American Journal of Community Psychology, 11(2): 141-152.

The Commission on Global Governance. 1995. Our Global Neighborhood. Oxford: Oxford University Press.

Tsutsui T, Muramatsu N. 2007. Japan's universal long-term care system reform of 2005: containing costs and realizing a vision. Journal of the American Geriatrics Society, 55(9): 1458–1463.

UNDP. 2005. Human Development Report 2005, International Cooperation at a Crossroads: Aid. Trade and Security in an Unequal World. New York: UNDP.

van Dijk J A G M. 2006. Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34(4-5): 221-235.

Vedung E. 1998. Policy instruments: typologies and theories//Bemelmans-Videc M L, Rist R C, Vedung E. Carrots, Sticks & Sermons: Policy Instruments & Their Evaluation. New Brunswick: Transaction Publishers: 21-58.

Vicente M R, López A J. 2011. Assessing the regional digital divide across the European Union-27. Telecommunications Policy, 35(3): 220-237.

Wasserman I M, Richmond-Abbott M. 2005. Gender and the Internet: causes of variation in access, level, and scope of use. Social Science Quarterly, 86(1): 252-270.

Weeks J R. 1999. Population: An Introduction to Concepts and Issues. Cambridge: Wadsworth Publishing Company.

Wei K K, Teo H H, Chan H C, et al. 2011. Conceptualizing and testing a social cognitive model of the digital divide. Information Systems Research, 22(1): 170-187.

Welford C, Murphy K, Wallace M, et al. 2010. A concept analysis of autonomy for older people in residential care. Journal of Clinical Nursing, 19(9-10): 1226-1235.

WHO Regional Office for Europe. 2018. Age-friendly environments in Europe: indicators, monitoring and assessments (2018). Copenhagen.

WHO. 2002. Active ageing: a policy framework. Geneva: WHO.

WHO. 2009. Health financing strategy for the Asia Pacific region (2010-2015). WHO.

WHO. 2015. World report on ageing and health. Geneva: WHO.

WHO. 2018. The global network for age-friendly cities and communities: looking back over the last decade, looking forward to the next. Geneva: WHO.

Whyte M K. 2005. Continuity and change in urban Chinese family life. The China Journal, 53: 9-33.

Wilks S, Wright M. 1987. Comparative Government-Industry Relations: Western Europe, the United States, and Japan. Oxford: Clarendon Press.

Wilson K R, Wallin J S, Reiser C. 2003. Social stratification and the digital divide. Social Science Computer Review, 21(2): 133-143.

Wolff J L, Kasper J D, Shore A D. 2008. Long-term care preferences among older adults: a moving

target?. Journal of Aging & Social Policy, 20(2): 182-200.

Yu B Y, Ndumu A, Liu J Q, et al. 2016. E-inclusion or digital divide: an integrated model of digital inequality. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 53(1): 1-5.

Yu B Y, Ndumu A, Mon L M, et al. 2018. E-inclusion or digital divide: An integrated model of digital inequality. The Journal of Documentation, 74(3): 552-574.

Yusif S, Soar J, Hafeez-Baig A. 2016. Older people, assistive technologies, and the barriers to adoption: a systematic review. International Journal of Medical Informatics, 94: 112-116.

Zborowski M, Eyde L D. 1962. Aging and social participation. Journal of Gerontology, 17(4): 424-430.

Zhao F, Collier A, Deng H P. 2014. A multidimensional and integrative approach to study global digital divide and e-government development. Information Technology & People, 27(1): 38-62.

(C-0049.01)

应对老龄社会的基础科学问题研究丛书

老年友好型社会的创新与实践

www.sciencep.com

ISBN 978-7-5088-5

9 787508 858

科学出版社互联网入口
经管分社：(010)64012800 销售：(010)64031535
E-mail：jingguanfa@mail.sciencep.com

定 价：160.0

[General Information]
书名=老年友好型社会的创新与实践
页数=239
SS号=15085077